

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO

MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO

**LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE:
diagnóstico para uma cidade acolhedora
a partir do olhar da pessoa idosa**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO

MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO

**LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE:
diagnóstico para uma cidade acolhedora
a partir do olhar da pessoa idosa**

Área de concentração: Desenvolvimento Urbano.

Linha de Pesquisa: Planejamento e Gestão.

Orientadora: Profa. Dra. Lúcia Leitão Santos.

Coorientadora: Profa. Dra. Ana Paula de Oliveira Marques.

Recife

2026

Catálogo de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Carvalho Neto, Manoel Raymundo de.

Longevidade no espaço urbano do Recife-PE: diagnóstico para uma cidade acolhedora a partir do olhar da pessoa idosa / Manoel Raymundo de Carvalho Neto. - Recife - PE, 2026.
197f.: il.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, 2026.

Orientação: Lúcia Leitão Santos.

Coorientação: Ana Paula de Oliveira Marques.

Inclui Referências, Apêndice e Anexo.

1. Cidade Saudável; 2. Envelhecimento Saudável; 3. Planejamento de Cidades; 4. Política Pública; 5. Justiça Social.
I. Santos, Lúcia Leitão. II. Marques, Ana Paula de Oliveira. III. Título.

UFPE-Biblioteca Central

MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO

LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE: diagnóstico para uma
cidade acolhedora a partir do olhar da pessoa idosa

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Urbano
da Universidade Federal de Pernambuco,
como requisito à obtenção do Título de
Doutor em Desenvolvimento Urbano.

Aprovada em: 27/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Lúcia Leitão Santos (Orientadora)
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Profa. Dra. Dayse Luckwu Martins (Examinadora Interna)
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Profa. Dra. Fábiana Maria de Lima (Examinadora Externa)
Universidade de Pernambuco – UPE

Prof. Dr. Hugo Moura de Albuquerque Melo (Examinador Externo)
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Dra. Márcia Carréra Campos Leal (Examinador Externo)
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Dedico, uma vez mais, os esforços deste trabalho aos amigos pesquisadores e gestores da saúde pública, dos direitos da pessoa idosa e do desenvolvimento urbano — do Recife ao Brasil — que se empenham na construção de espaços e serviços melhores para o nosso coletivo. À minha filha, Letícia Carvalho, e à minha sobrinha, Julya Tassinari, dedico este fruto com um recado: não há limite para a nossa autoqualificação, especialmente quando ela serve como ferramenta de transformação social.

AGRADECIMENTOS

Ao final desta etapa acadêmica, e não do meu percurso de estudos, reverencio meus ancestrais, pais, e a “energia criadora”, pelas possibilidades. Companheira, filha, e demais colaboradores, externalizo minha profunda gratidão para aqueles que participaram comigo, direta ou indiretamente, até o momento da finalização desta escrita.

Inicialmente, agradeço minha estimada orientadora Profa. Dra. Lúcia Leitão Santos, por ter aceitado enfrentar este desafio, pelas suas generosas orientações, firmeza e determinação para seguirmos em frente. A minha amada coorientadora Profa. Dra. Ana Paula de Oliveira Marques, grande referência para o mundo acadêmico e para a vida, juntamente com a Profa. Márcia Carréra Campos Leal, que eu possa comungar de vossa presença e continuar o aprendizado, por muitos e muitos anos.

A eterna orientadora Profa. Dra. Adriana Falângola Benjamim e membros do Grupo de Pesquisa de Economia da Saúde da UFPE/ Instituto Aggeu Magalhães-Fiocruz/PE, Profa. Dra. Islândia Maria e Profa. Dra. Camila Aquino.

Ao Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes do Espírito Santo, tutor e amigo, que sempre acreditou e primeiro incentivou esta caminhada acadêmica, ao lado também, da Profa. Dra. Heloísa Maria Mendonça de Moraes. A Profa. Dra. Albanita Gomes, Profa. Dra. Solange Laurentino dos Santos, Carlos Neves Filho e Marco Antônio Dantas (secretários) e todos amigos do antigo Departamento de Medicina Social/UFPE.

No Programa de Pós-Graduação em Gerontologia – PPGERO/UFPE, agradeço a Profa. Dra. Maria das Graças Coriolano, Profa. Dra. Carla Cabral, Prof. Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Profa. Dra. Maria Lúcia Gurgel, Profa. Dra. Eliane Vasconcelos, Profa. Dra. Anna Karla Tito, Profa. Dra. Vanessa Lima e Silva, Profa. Dra. Conceição Lafayette, Profa. Dra. Isolda Belo da Fonte (*in memoriam*), demais docentes e amigos da secretaria do Programa.

Aos docentes do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE pelas contribuições em sala de aula e por suas valiosas críticas e sugestões (qualificação e defesa), que alteraram de modo definitivo a condução da pesquisa. Ao Prof. Dr. Ruskin Freitas (*in memoriam*), pelo carinho e todos ensinamentos. A Profa. Dra. Mônica Louise Seabra, pelas diversas contribuições e atenção.

Aos professores integrantes da banca de defesa e aos suplentes. A equipe técnica de servidores do MDU, sobretudo a Sra. Renata Albuquerque, exemplo no suporte das questões administrativas e pela humanidade do tratamento em sua função na UFPE.

Aos amigos e irmãos de jornada acadêmica, Jonas Lima e Silva, Osmar Faustino de Oliveira e Erika Vieira, pela eterna parceria e por nunca desistirem de seus sonhos acadêmicos. O querido Arnaldo Souza pela disponibilidade e apoio de sempre. O querido amigo Alisson do Carmo e tantos outros da Turma DO22 do MDU.

Aos membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIR), do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI-PE) e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) de Pernambuco, em especial a Sra. Sônia Alten e a Sra. Margarida Santos.

Aos “TOP Friends - PPGGES”, Vanessa, Mariana Fragoso, Maria Rosa Fragoso, pela presença, parceria, carinho e amizade, desde o período de nosso Mestrado de Gestão e Economia da Saúde/UFPE (2ª turma do Brasil / 2014-2016).

Ao amigo Marcone César Tabosa, in memoriam, que se presente conosco, também estaria comemorando a conquista do seu título de Doutor em Economia da Saúde, em uma valorosa Instituição Federal de Ensino Superior, como sempre almejou, desde o início de nossa amizade. Ao amigo e irmão de todos às horas, Diego Oliveira de Carvalho, pelas incontáveis contribuições e incentivos. O amigo Filipe Oliveira, pela parceria de sempre, pelas possibilidades de crescimento profissional e vivências.

Por fim, ao CNPq pelo apoio à nossa Universidade e ao nosso Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (PPGMDU).

RESUMO

A presente tese investiga a interseção entre o acelerado envelhecimento populacional e a urbanização em um contexto de desigualdade social, com ênfase nas políticas públicas municipais do Recife. Adota-se uma abordagem diagnóstica e exploratória, de caráter quantitativo, ancorada nos oito domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI): ambiente físico, transporte, moradia, participação social, respeito e inclusão social, comunicação e informação, oportunidades de aprendizagem, e apoio, saúde e cuidado. A questão central indaga como os idosos residentes no Recife percebem as ações municipais de acolhimento à luz desses domínios. Parte-se da premissa de que a eficácia das políticas urbanas é limitada por falhas no planejamento e desigualdades históricas, criando um hiato entre as normas legais e a percepção dos idosos. A hipótese principal afirma a existência de um distanciamento significativo entre a efetivação legal e a percepção idosa, com benefícios desigualmente distribuídos. A metodologia fundamenta-se no método hipotético-dedutivo, utilizando questionários em escala Likert aplicados a uma amostra de 163 idosos (selecionados de um universo de 336 participantes após filtragem de consistência). A análise estatística, via IBM SPSS Statistics®, abrangeu testes descritivos e inferenciais: correlação de Spearman, teste t de Student e ANOVA *one-way*. Os resultados classificaram os domínios por nível de insatisfação, revelando melhor desempenho em “Respeito e Inclusão Social” (mediana 2,80) e falhas graves em “Transporte” e “Ambiente Físico” (notas mínimas de 1,00 em segurança no transporte e 1,33 em banheiros públicos). A escolaridade emergiu como determinante-chave (ANOVA: $p < 0,001$ em “Comunicação e Informação”), enquanto a renda não apresentou influência significativa ($p > 0,05$), indicando uma percepção de precariedade universal. As análises por Regiões Político-Administrativas (RPAs) confirmam desigualdades socioespaciais: a RPA 3 apresentou índices críticos em “Ambiente Físico”, enquanto as RPAs 1 e 2 percebem melhor a dimensão “Moradia”. O perfil predominante da amostra — 81% mulheres, com longa residência no município e restrições de mobilidade — reforça a demanda por infraestrutura acessível. Conclui-se pela confirmação do hiato entre políticas e percepção, limitando a universalidade do acolhimento. Importa destacar que os achados decorrem de uma amostra não probabilística de 163 idosos, selecionada por critérios de elegibilidade e completude das informações, os achados são diagnósticos/analíticos e não estimativas populacionais do Recife. Embora essa amostra permita um diagnóstico robusto das percepções captadas, seus resultados não são estatisticamente representativos de toda a população idosa do Recife, devendo ser entendidos como evidências analíticas e indicativas de tendências, e não como estimativas populacionais estritas. A contribuição central é a hierarquização de indicadores para o monitoramento e reordenamento das prioridades do planejamento urbano rumo a um Recife amigável ao envelhecimento.

Palavras-chave: Cidade Saudável. Envelhecimento Saudável. Planejamento de Cidades. Política Pública. Justiça Social.

ABSTRACT

The present thesis investigates the intersection between rapid population aging and urbanization within a context of social inequality, with an emphasis on municipal public policies in Recife. A quantitative, diagnostic, and exploratory approach is adopted, anchored in the eight domains of the Age-Friendly Brazil Strategy (EBAPI): physical environment, transportation, housing, social participation, respect and social inclusion, communication and information, learning opportunities, and support, health, and care. The central question examines how elderly residents in Recife perceive municipal inclusion actions in light of these domains. It is premised on the idea that the effectiveness of urban policies is limited by planning failures and historical inequalities, creating a gap between legal standards and the perception of the elderly population. The main hypothesis asserts the existence of a significant distance between legal enforcement and elderly perception, with benefits being unequally distributed. The methodology is based on the hypothetical-deductive method, utilizing Likert-scale questionnaires applied to a sample of 163 elderly individuals (selected from a universe of 336 participants after consistency filtering). Statistical analysis, via IBM SPSS Statistics®, encompassed descriptive and inferential tests: Spearman's correlation, Student's t-test, and one-way ANOVA. The results classified the domains by level of dissatisfaction, revealing better performance in "Respect and Social Inclusion" (median 2.80) and severe failures in "Transportation" and "Physical Environment" (minimum scores of 1.00 in transportation safety and 1.33 in public restrooms). Education emerged as a key determinant (ANOVA: $p < 0.001$ in "Communication and Information"), while income showed no significant influence ($p > 0.05$), indicating a perception of universal precariousness. Analysis by Political-Administrative Regions (RPAs) confirms socio-spatial inequalities: RPA 3 presented critical indices in "Physical Environment," while RPAs 1 and 2 perceive the "Housing" dimension better. The predominant profile of the sample — 81% women, with long-term residence in the city and mobility restrictions — reinforces the demand for accessible infrastructure. The study concludes by confirming the gap between policies and perception, limiting the universality of inclusion. It is important to highlight that the findings derive from a non-probabilistic sample of 163 elderly people, selected based on eligibility criteria and completeness of information. The findings are diagnostic/analytical and not population estimates for Recife. Although this sample allows for a robust diagnosis of the captured perceptions, its results are not statistically representative of the entire elderly population of Recife, and should be understood as analytical evidence and indicative of trends, rather than strict population estimates. The central contribution is the hierarchy of indicators for monitoring and reordering urban planning priorities toward an age-friendly Recife.

Keywords: Healthy City. Healthy Aging. City Planning. Public Policy. Social Justice.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localização do município do Recife-PE.

Figura 2 - Relação Hierárquica e Funcional dos Conceitos de Envelhecimento.

Figura 3 - Fluxograma das fases do processo metodológico.

Figura 4 - Desenho do Problema de Pesquisa no Recife-PE e questão norteadora.

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 – Distribuição espacial da amostra por RPAs no município do Recife.

Mapa 2 – Predomínio de gênero no território (Feminização da velhice).

Mapa 3 – Tempo de residência no município dos participantes da pesquisa.

Mapa 4 – Distribuição do nível de escolaridade por Regiões Administrativas.

Mapa 5 – Situação laboral dos idosos participantes (Aposentados x Ativos).

Mapa 6 – Arranjos domiciliares: idosos que residem sós no território.

Mapa 7 – Distribuição espacial dos níveis de renda da população idosa.

Mapa 8 – Restrições de mobilidade e condições gerais de saúde.

Mapa 9 – Distribuição espacial segundo a realização de acompanhamento médico.

Mapa 10 – Dispersão geográfica conforme o uso contínuo de medicamentos.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Matriz de Síntese Metodológica da Pesquisa.

Quadro 2 - Estrutura Teórica Integrada: Pilares Macro e Micro

Quadro 3 - Determinantes e sua área de influência do modelo do envelhecimento ativo.

Quadro 4 - Marcos históricos internacionais que favoreceram as estratégias no âmbito das cidades amigas das pessoas idosas e do desenvolvimento urbano sustentável

Quadro 5 - Marcos Legais das Políticas Públicas para Idosos no Brasil.

Quadro 6 - Componentes e fontes de informação para o diagnóstico

Quadro 7 - Hierarquia de Acolhimento Percebido

Quadro 8 - Matriz de Confronto entre Percepção Social e Governança Municipal no Recife.

Quadro 9 - Perfil sintético do envelhecimento por RPA – Recife.

Quadro 10 - Matriz de Ruptura: Urbanismo da Produção ao Urbanismo do Cuidado

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=336).

Tabela 2 - Dados laborais e de saúde dos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=336).

Tabela 3 - Pontuação de cada domínio do EBAPI informada pelos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

Tabela 4 - Pontuação de cada domínio do EBAPI informada pelos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

Tabela 4.1 - Classificação dos subitens de cada domínio do EBAPI informada pelos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

Tabela 5 - Pontuação de cada domínio do EBAPI por região político-administrativa (RPA) do município de Recife-PE informada pelos idosos participantes da pesquisa.

Tabela 5.1 - Classificação dos domínios do EBAPI por RPA pelos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

Tabela 6 - Análises de correlação de Spearman entre idade e os domínios do EBAPI dos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

Tabela 7 - Associação entre a escolaridade dos idosos com os domínios Participação, Respeito e Inclusão Social e Comunicação e Informação do EBAPI (n=163).

Tabela 8 - Associação entre Variáveis Sociodemográficas/Condição de Saúde e a Percepção dos 08 Domínios da EBAPI (n=163).

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
APS – Atenção Primária em Saúde
CEP – Comitê de Ética e Pesquisa / Código de Endereçamento Postal
CF – Constituição Federal
CNS – Conselho Nacional de Saúde
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CTTU – Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano
EBAPI – Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa
EMLURB – Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana
FMI – Fundo Municipal do Idoso
IBEU – Índice de Bem-estar Urbano
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos
MDU – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano
MPAS – Ministério da Previdência e Assistência Social
NPI – Núcleo da Pessoa Idosa
OMS – Organização Mundial da Saúde
ONU – Organização das Nações Unidas
PCR – Prefeitura da Cidade do Recife
PNDU – Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
PNI – Política Nacional do Idoso
PROExC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
PROIDOSO – Programa do Idoso
RPA – Região Político-Administrativa
SDSDHJPD – Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
SNIPH – Instituto Nacional Sueco de Saúde Pública
SPSS – *Statistical Package for the Social Sciences*
SUS – Sistema Único de Saúde
TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco
UnAPI – Universidade Aberta à Terceira Idade
USF – Unidade de Saúde da Família
WHOQOL – *World Health Organization Quality of Life*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	17
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA	17
1.2 PREMISSA E HIPÓTESES DA TESE	27
1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO PROPOSTO	31
1.4 OBJETIVOS	33
1.4.1 Objetivo Geral	33
1.4.2 Objetivos Específicos	33
2 REFERENCIAL TEÓRICO	36
2.1 ENVELHECIMENTO ATIVO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL: DO DETERMINISMO CONTEXTUAL À CRÍTICA DA CULPABILIZAÇÃO INDIVIDUAL	43
2.1.2 O Envelhecimento no Contexto do Planejamento e Gestão Urbana: Perspectivas e Desafios	50
2.2 A PERCEPÇÃO SOBRE A PESSOA IDOSA EM ESPAÇOS URBANOS: HOSTILIDADE VERSUS ACOLHIMENTO	54
2.3 CONCEITOS E IMPLICAÇÕES DA DÉCADA DO ENVELHECIMENTO PARA MELHOR ENTENDER O CONTEXTO DAS CIDADES AMIGAS DA PESSOA IDOSA	56
2.4 IMPLICAÇÕES DO ENVELHECIMENTO	63
2.4.1 Implicações Sociais	63
2.4.2 Implicações Econômicas	67
2.4.3 Implicações do Urbano	68
2.5 AS ESTRATÉGIAS GLOBAIS PARA O ATENDIMENTO AOS LONGEVOS	72
2.6 O ENVELHECIMENTO NO BRASIL: MARCOS LEGAIS, POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO AO ETARISMO	79
2.6.1 Caracterização do Município do Recife-PE: Análise Temporal Pós-Estatuto do Idoso (2003-2025)	90
2.6.2 Governança Intersetorial e o Desafio da Efetivação: A Reprodução das Políticas Nacionais na Estrutura Municipal de Recife-PE	92
2.6.3 A Produção Social da Velhice Urbana: Uma Abordagem Crítica Multidimensional	95
3 METODOLOGIA UTILIZADA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA	98
3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO: MÉTODO E TIPO DE PESQUISA	98
3.2 DESENHO DO PROBLEMA DE PESQUISA	99
3.3 POPULAÇÃO ALVO E LOCAL DO ESTUDO	101
3.3.1 População Alvo	101
3.3.2 Local do Estudo	101
3.3.3 Amostra	102
3.4 ETAPAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA	104
3.4.1 Etapa 01 – Estruturação das Informações e Coleta de Dados	104
3.4.2 Etapa 02 – Processamento de Dados	107
3.4.3 Etapa 03 – Análise de Dados	108
3.5 ASPECTOS ÉTICOS	109
3.6 RISCOS, BENEFÍCIOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS	110

4 RESULTADOS	111
4.1 DADOS DESCRITIVOS DA POPULAÇÃO DO ESTUDO POR VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS	111
4.2 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SEGUNDO OS DOMÍNIOS DA ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA (EBAPI)	122
4.2.1 A Cidade Percebida: Avaliação dos Domínios da EBAPI, Classificação Geral e Ranking de Satisfação	123
4.3 ANÁLISE INFERENCIAL E TESTE DAS HIPÓTESES DA TESE	129
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	135
5.1 O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: A ELITE CRÍTICA, A FEMINIZAÇÃO E A CIDADANIA TENSIONADA	136
5.2 ENTRE O ACOLHIMENTO DOMÉSTICO E A HOSTILIDADE PÚBLICA: O DIAGNÓSTICO DA CIDADE	141
5.3 TERRITÓRIO E DESIGUALDADE: AS NUANCES REGIONAIS E A GEOGRAFIA DO ENVELHECIMENTO	144
Diferenças regionais nos domínios EBAPI: Do Centro à Periferia	145
Implicações da Segregação Socioespacial: A Fragmentação do Envelhecer	149
Conclusões Sobre Desigualdade Territorial: A Síntese da Injustiça Espacial	150
A Democratização da Hostilidade: Limites do Capital Econômico e a Supremacia do Saber	158
5.5 A UNIVERSALIDADE DA PRECARIÉDADE E O FATOR IDADE: A CIDADE COMO AGENTE INCAPACITANTE	160
Precariedade Estrutural Universal: A Cidade Como Barreira Totalitária	163
Idade Como Determinante Universal da Vulnerabilidade: O Corpo Como Fronteira Final	164
5.6 SÍNTESE E CONTRIBUIÇÕES PARA A "CIDADE AMIGA DA PESSOA IDOSA": DA RETÓRICA À JUSTIÇA ESPACIAL	166
A Dicotomia Entre Esfera Privada e Pública: O Lar Como Refúgio e a Rua Como Ameaça	167
Territorialidade e Desigualdade Urbana: A Geografia Como Destino e a Justiça Espacial	167
Escolaridade Como Determinante de Inclusão: A Supremacia do Capital Cultural	168
Idade e Vulnerabilidade Estrutural: A Biologia Como Fronteira e a Resignação Como Estratégia	168
Contribuições e Diretrizes Estratégicas: Da Práxis Transformadora ao Urbanismo do Cuidado	169
6 CONSIDERAÇÕES	170
REFERÊNCIAS	173
APÊNDICE	180
INFORMAÇÕES PESSOAIS	187
ANEXO II	192
CARTAS DE ANUÊNCIA	192

1 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Na atualidade, os dois fenômenos demográficos mais evidentes e sem precedentes no mundo, a urbanização e o envelhecimento populacional, têm sido alvos de estudos interdisciplinares, dada a necessidade de se identificar e minimizar o impacto de ambientes urbanos que não refletem igualdade e qualidade, na capacidade de apropriação da cidade por parte de sua população de maneira universal, bem como de gerar políticas públicas adequadas aos diversos segmentos da sociedade (Miranda; Mendes; Silva, 2016).

Silvana Maria Escorsim (2021), em seu estudo sobre o envelhecimento, entendendo que a velhice não ocorre de modo linear e homogênea, nos coloca a necessidade de contextualizá-la no marco das relações sócio-históricas, políticas e econômicas, porque transcende a questão biológica condicionada no tempo, para ser entendida como um fenômeno humano e social que nos conectam a determinantes de ordem econômica e produtivista.

Para tornar os países mais preparados para as pessoas mais velhas e suas demandas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) contabilizou 900 milhões de pessoas idosas em 2020, número que, segundo as projeções revisadas da ONU (2024), já ultrapassa 1,2 bilhão em escala global no presente biênio (2025-2026) e estima uma expectativa de vida global de 72 anos em 2050, ressaltando a necessidade de três principais mudanças: (I) tornar as cidades lugares mais amigáveis para os idosos; (II) alinhar os sistemas de saúde às necessidades deles e (III) desenvolver sistemas de cuidados de longo prazo para reduzir o uso inadequado dos serviços de saúde.

Vale ressaltar que, embora os dados da Década do Envelhecimento Saudável apontassem para 900 milhões, as projeções revisadas da ONU (2024) indicam que este contingente já ultrapassa 1,2 bilhão em 2026, reforçando a escala global do fenômeno aqui estudado.

Entre as dificuldades para se alcançar os objetivos da OMS, Aguiar (2020) ressalta que a persistência de uma urbanização fragmentada e a desorganização espacial de cidades brasileiras — marcadas por baixos índices de qualidade de vida — agem como modeladores de um ambiente hostil à convivência social, constituindo um problema relevante a ser considerado. A urbanização acelerada, a migração de jovens

em busca de trabalho e as mudanças na estrutura familiar (famílias menores e maior inserção da mulher no mercado formal) resultam em uma menor disponibilidade de redes de apoio presencial para o cuidado com os idosos. A qualidade de vida na senescência depende não apenas dos riscos e oportunidades experienciados ao longo do curso da vida, mas também da eficácia dos sistemas de ajuda mútua e suporte geracional estabelecidos no território (OMS, 2023).

Mello (2004), nos traz que a problemática do cenário que se vive não está apenas conectado por extensão, articulação e conexão da rede urbana e densidade populacional, mas também pela intensidade de informação, imagens e representações, assim como uma diversidade de lugares, diferenciações espaciais e a constante complexidade cultural e social. Os autores ainda indicam que os fatores negativos menos perceptíveis aos olhos dos usuários dessa urbanização, são os que normalmente trazem uma maior vulnerabilidade:

Não podemos nos proteger do que não conhecemos. Nesta categoria podemos incluir a poluição sonora, as contaminações químicas e radioativas, os problemas ocupacionais, os trajetos perigosos, os impactos psicológicos e emocionais do “ritmo” urbano contemporâneo, a redução da capacidade perceptiva pela massificação das formas de comunicação e até mesmo o risco de contrair infecções ou doenças graves ainda não diagnosticadas ou desconhecidas (Mello, 2004, p. 10).

No Brasil o aumento progressivo da atividade urbana tem alterado o clima e piorado as condições do solo, tanto pela intensidade de veículos, o adensamento das edificações, o processo de verticalização, a dominância das superfícies de ruas e avenidas cobertas por asfalto, assim como pela diminuição de áreas verdes, entre outros fatores (Mascaró, 2009). Os impactos ambientais causados pelos seres humanos em prol de uma vida “confortável” nas cidades levaram a população a repensar os seus atos. Hoje, buscam-se alternativas para minimizar esses danos, tornando as cidades mais sustentáveis. [...] O ambiente urbano e seus impactos ambientais incluem impermeabilização dos solos e poluição do ar (Pasqualotto; Sena, 2018).

O agravamento dessa condição provoca uma sensação de desconforto e impacta sobre diversos aspectos sensoriais que alteram a percepção de bem-estar no espaço físico. Essa percepção está relacionada às necessidades do indivíduo e sua inserção no ambiente imediato. Envolve não apenas a consideração de critérios térmicos, acústicos e visuais, mas também a experiência de emoção e prazer, conferindo ao ambiente um

caráter holístico, já que, conforme afirma Schmid (2005), “... o ambiente construído é um anteparo existencial, sendo abrigo para o corpo e para a alma” (Schmid, 2005).

Por outro lado, a tendência cada vez maior de viver e trabalhar em ambientes artificiais tornou a doença uma fatalidade associada a esta opção, visto que a vida nestas condições implica em elementos fortemente aceitos como responsáveis pela fragilização e pelo adoecimento, conforme também evidenciado por estudos sobre o impacto dos ambientes artificiais na saúde (Lefevre & Lefevre, 2004; Silva; Santos, 2021).

Compreender como ocorrem estas relações entre cidadãos em espaços públicos, especialmente considerando as percepções do usuário idoso, mostra ser um caminho necessário para maior efetividade nas ações empreendidas pelo Estado e municípios. Portanto, a possibilidade de construir espaços amigáveis não se limita apenas à escuta de idosos de hoje, mas também se estende na compreensão das necessidades daqueles que chegarão à velhice. A discussão baseada na visão holística da saúde e, portanto, nos aspectos biopsicossociais presentes nas atividades e nos relacionamentos que ocorrem no ambiente construído, trata do encontro dos sujeitos e de suas relações afetivas e materiais. Os espaços compartilhados ou partilhados, ou seja, os que visam a utilização integrada do espaços públicos, podem ser um fator de envelhecimento saudável se forem humanizados, o que os tornam acolhedores e resolutivos quando os seus cidadãos se apropriam desse território e dos serviços e equipamentos nele contidos (Baptista; Bestetti, 2012).

Castello (2007) refere-se aos espaços criados como lugares feitos pelas pessoas, que os frequentam e utilizam, possibilitando experiências existenciais gratificantes e essas mesmas pessoas, segundo Jacobs (2011), podem fadar estes espaços ao fracasso, quando estes são ignorados, negligenciados e mal administrados.

O direito de viver numa cidade envolve tratar as pessoas e protegê-las contra as doenças, num meio ambiente que não seja gerador de sofrimento, dor, violência ou morte prematura. A doença não pode ser entendida como sendo algo semelhante ao frio, à fome, à necessidade de locomoção e de abrigo, que são eventos permanentes dos seres humanos. Em um relacionamento mais humano e menos competitivo com seus semelhantes, assim como com seu meio ambiente natural, é preciso apoiar, propor e implementar políticas de desenvolvimento econômico que não sejam socialmente excludentes e geradoras de desigualdade na distribuição de benefícios (Lefevre & Lefevre, 2004).

Neste sentido, Lefevre & Lefevre (2004) já propunha uma ampliação do conceito de saúde e o desempenho de um novo papel do Estado perante a sociedade, pela concepção de políticas públicas saudáveis e o compromisso técnico de intervir nos fatores determinantes do processo saúde-doença. No mesmo período, Mello (2004), colocava a importância da dimensão espacial e sua abordagem nos meios acadêmicos e institucionais como importante viés de análise, utilizada nas pesquisas de Arquitetura e Urbanismo, Geografia e Ciências Sociais, incorporando o espaço edificado como categoria interativa dos processos sociais.

De acordo com o grupo WHOQOL (World Health Organization Quality of Life) criado em 1995 pela OMS, a definição de qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. De acordo com Fleck (1998), os instrumentos de avaliação da qualidade de vida foram desenvolvidos com a premissa de que esta é uma construção subjetiva, multidimensional, que engloba tanto elementos positivos, como a mobilidade, quanto negativos, como a dor.

A qualidade de vida é uma avaliação multifacetada do bem-estar geral de um indivíduo na sociedade, que transcende a mera ausência de doença. Ela é intrinsecamente ligada à percepção pessoal no contexto cultural e de valores em que se vive, englobando fatores como saúde física e mental, equilíbrio socioeconômico, relações interpessoais e satisfação com a rotina. Alcançar uma boa qualidade de vida reflete-se na capacidade de lidar com situações diversas e é influenciada por políticas públicas coerentes e uma efetiva articulação intersetorial (Bortoloti; Pavoski; Vesoloski, 2024).

Um aspecto crucial para o bem-estar e conforto nas cidades é a adequação do sistema de espaços públicos, que facilitam e dão acesso ao uso e provisão da vida cotidiana, a exemplo da “cidade de 15 minutos”, conceito de planejamento urbano onde moradores podem acessar suas necessidades diárias em até 15 minutos. No que se refere ao mobiliário urbano, objeto de estudo da Ergonomia e do Design, ambientes e equipamentos devem ser pensados e adequados para se adequarem às capacidades, limitações e necessidades humanas, visando aprimorar o desempenho e reduzir desconfortos, acidentes, danos e doenças, que podem acelerar o processo de declínio da pessoa idosa (Vitta, 2006).

John (2012) reforça que a utilização do mobiliário urbano deve estar alinhada à satisfação de funções essenciais, considerando aspectos ergonômicos e de

acessibilidade. Essa visão converge com o princípio da Ergonomia de conceber ambientes e equipamentos que otimizem o desempenho humano e minimizem o desconforto, conforme também estabelecido pela legislação nacional, especificamente a NBR 9050 (ABNT, 2015).

No contexto brasileiro, a terminologia "mobiliário urbano" é a designação formalmente adotada para uniformizar o debate acerca do tema (Mourthé, 1998). Conforme estabelecido pela legislação nacional, especificamente a Lei 10.098/2000 (com as atualizações da Lei nº 13.146 de 2015) e a norma ABNT NBR 9050:2015, o mobiliário urbano compreende um conjunto de componentes dispostos em vias e espaços públicos. Tais elementos são sobrepostos ou integrados a estruturas de urbanização ou edificação, de modo que sua alteração ou deslocamento não acarrete modificações substanciais nesses elementos. Ilustrativamente, incluem-se semáforos, postes de sinalização, lixeiras, bancos e itens de natureza análoga (ABNT, 2015, p.4).

Uma perspectiva popular, apresentada por Bellini (2008), concebe o mobiliário urbano, no Brasil, como o "Abrigo de Ônibus", aludindo a um ponto de parada dotado de estrutura de proteção. De fato, o mobiliário urbano desempenha um papel multifacetado nas cidades contemporâneas, abrangendo dimensões como funcionalidade, apelo estético, ergonomia, reforço da identidade local, promoção da interação social, oferta de abrigo, provisão de iluminação, garantia de segurança e promoção do conforto (Oliveira; Toledo Filho, 2025).

Complementando essa discussão Montenegro (2017) demonstra a necessidade de o mobiliário urbano evoluir com as transformações sociais. Assim, ele passou a incorporar novos materiais, tecnologias, formatos e funções, tornando-se um símbolo dos costumes locais ou da história. O mesmo ainda defende um "design centrado no homem, na ecologia e na ética", enfatizando a responsabilidade do projetista em atender às reais necessidades da sociedade, em contraposição a apelos publicitários ou modismos. Os mesmos, sublinham que a sustentabilidade do mobiliário urbano se manifesta em todo o seu ciclo de vida, desde a concepção até o pós-uso, contribuindo para a experiência e a identidade dos espaços públicos.

Essas considerações sobre o mobiliário urbano tornam-se ainda mais relevantes diante da revolução demográfica brasileira. A expectativa de vida aumentou quase 130% de 1900 para 2009, de 33,5 anos para 73 anos, resultando no crescimento da população idosa para 22 milhões, superando a de muitos países europeus. Houve um destaque para o aumento de 47,8% entre indivíduos com mais de 80 anos (Minayo,

2012).

Essas mudanças exigem políticas públicas e novas formas de organização social que considerem a autonomia e a contribuição dos idosos para a sociedade, ao mesmo tempo em que enfrentam os desafios financeiros e de saúde, especialmente após os 80 anos. Segundo Minayo (2012), a promoção da autonomia e da saúde dos idosos, juntamente com atenção especializada, é crucial, pois essa população continuará a crescer até, pelo menos, até 2050.

Por estes motivos de ordem demográfica, os pesquisadores da UFRJ, Veras e Oliveira (2018), destacados pesquisadores sobre o envelhecimento, enfatizam:

[...] este é um dos desafios atuais: escassez e/ou restrição de recursos para uma demanda crescente. O idoso consome mais serviços de saúde, as internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do leito é maior quando comparado a outras faixas etárias. Esse fato é decorrência do padrão das doenças dos idosos, que são crônicas e múltiplas, e exigem acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicação contínua e exames periódicos (Veras; Oliveira, 2018, p. 10).

Sobre as demandas relacionadas ao envelhecimento populacional e a saúde da pessoa idosa, estudos revisados mostram que, no Brasil, as desigualdades regionais influenciam diretamente a capacidade de resposta do sistema de saúde. Regiões com menor infraestrutura assistencial e oferta reduzida de serviços especializados, como Norte e Nordeste, enfrentam maiores barreiras de acesso, resultando em piores desfechos em saúde (Melo; Nickel; Pureza, 2025, p. 3). Estas questões são reflexos diretos de um desenvolvimento urbano desigual e que não prioriza as necessidades de toda a população.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira estimada em 2025 é de 213,4 milhões de habitantes. Pernambuco, por sua vez, ultrapassa 9,5 milhões de habitantes e ocupa o décimo terceiro lugar dos estados brasileiros, por coeficiente de Gini de 0,536, que é utilizado para calcular a desigualdade de distribuição de renda. Em 2024, 40,3% dos habitantes do estado estavam em situação de pobreza e 6,3% em extrema pobreza.

Recife, capital do estado, tem uma população estimada em 1.588.376 pessoas em 2025, e mantém-se entre as capitais brasileiras com elevado índice de envelhecimento. No cenário nordestino, embora Salvador (BA) e Fortaleza (CE) possuam contingentes absolutos maiores de idosos devido ao tamanho de suas

populações, o Recife destaca-se proporcionalmente, apresentando uma das maiores concentrações relativas de pessoas idosas da região.

O Município do Recife-PE, em estudos no ano de 2005, abrangia áreas com realidades sociais visivelmente desiguais, onde o IDH dos bairros de melhores condições de vida se assemelhava ao de países como Finlândia, Noruega e Japão, enquanto os bairros com baixa condição de vida apresentaram valores equivalentes aos de países africanos e asiáticos, tais como Mongólia e São Tomé e Príncipe (Bitoun, 2005).

Mais recentemente, dados de 2023 e 2024 continuam a evidenciar essa disparidade: Recife concentra a maior população das classes D e E entre as capitais do Nordeste, com 62,5% dos moradores tendo renda domiciliar mensal de até R\$ 3.500 (Portal da Prefeitura, 2025). A Região Metropolitana do Recife (RMR) também registrou, em 2024, a maior desigualdade do Brasil, com os 10% mais ricos ganhando, em média, 17,6 vezes mais do que os 40% mais pobres (JC, 2025). Além disso, em 2022, mais de 1 milhão de pernambucanos viviam em extrema pobreza, com menos de US\$ 2,15 por dia, e metade da população do estado estava abaixo da linha da pobreza (Diário de Pernambuco, 2023).

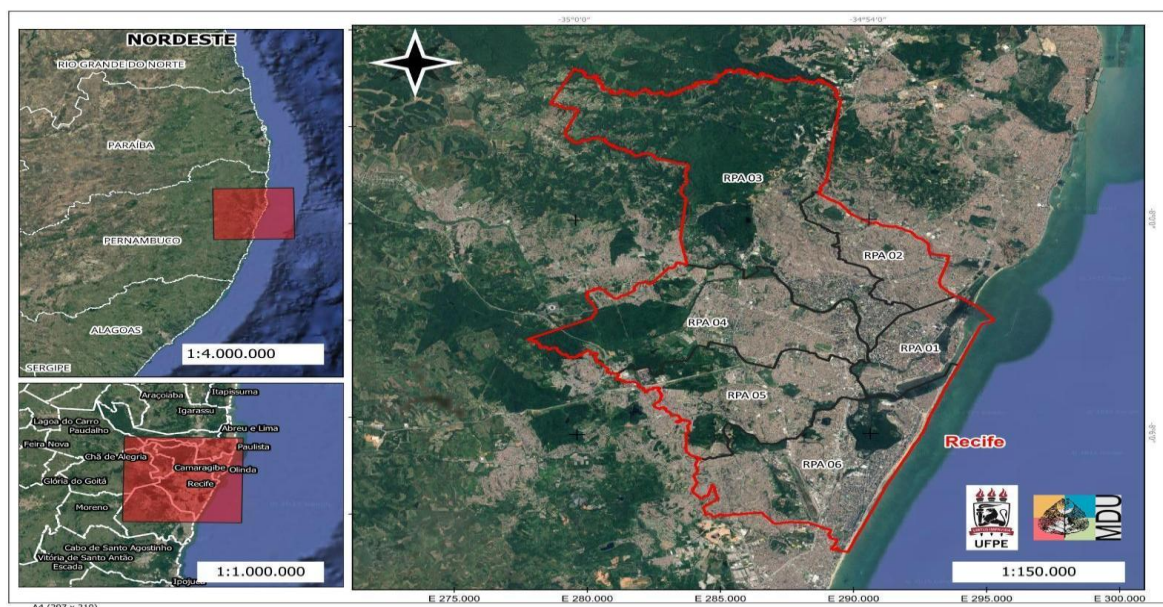


Figura 1 - Localização do município do Recife-PE.

Segundo o censo demográfico de 2022, estima-se que um terço da população brasileira será idosa até 2050, visto que o número de pessoas com 65 anos ou mais no Brasil aumentou 57,4% nos últimos 12 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 66,5 milhões de brasileiros (29,3% da

população) terão mais de 60 anos na metade do século, trazendo uma série de preocupações, demandas sociais e de mercado, para o acolhimento da pessoa idosa nas cidades.

O protagonismo dos municípios nesta seara é inegável, uma vez que cabe ao Poder Público Municipal, por expressa determinação constitucional (CF, Art. 182), o planejamento e a execução da política de desenvolvimento urbano, no entanto, percebe-se uma fragilidade na integração de políticas públicas formuladas no âmbito federal, em perspectiva intersetorial, orientadas para ação local, a exemplo da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU).

Entre os diplomas normativos voltados ao estabelecimento das diretrizes gerais da Política Urbana destacam-se: o Estatuto da Cidade, editado em 2001 na forma da Lei Federal 10.257, o Estatuto da Metrópole, editado em 2015 na forma da Lei Federal 13.089 e os Planos Diretores de cada cidade, pois estes contemplam o conjunto de dados que representa a realidade do espaço a ser analisado.

Reforçamos que o planejamento urbano é um processo que compreende sucessivas melhorias voltadas para a qualidade de vida das populações e o envelhecimento populacional traz desafios específicos à gestão urbana, particularmente em cidades marcadas por desigualdades socioespaciais históricas, como Recife. Contudo, a insuficiência de políticas integradas e de infraestrutura adequada evidencia a limitação do planejamento local no enfrentamento das vulnerabilidades que afetam, de forma acentuada, a população idosa (Albuquerque, 2023).

Para que as políticas de atendimento à pessoa idosa sejam realizadas de maneira articulada nas esferas governamentais e não governamentais, os Conselhos dos Direitos do Idoso e as políticas setoriais existentes nos municípios, precisam somar forças e atuar conjuntamente, buscando conhecer a realidade da população idosa e transformá-la.

Entretanto, nos deparamos com eventos que vão de encontro ao desenvolvimento urbano em uma perspectiva sustentável e impactam no adequado planejamento urbano e seus diagnósticos, dada a fragilidade dos aspectos de ordem política, econômica e socioambiental. O desenvolvimento urbano contemporâneo enfrenta uma série de desafios decorrentes da falta de integração entre políticas setoriais e da ausência de planejamento estratégico. A fragmentação entre os setores de transporte, habitação e infraestrutura compromete a coesão territorial e dificulta a gestão eficiente do espaço urbano, visto que as ações públicas deveriam ser pensadas de maneira articulada e sistêmica (Souza, 2004; Rolnik, 2009).

A expansão urbana descontrolada é um dos principais reflexos desse processo, resultando na ocupação desordenada do solo, na supressão de áreas naturais e no aumento da pegada ecológica das cidades (Santos, 2013). Esse crescimento não planejado agrava problemas de acessibilidade e sobrecarrega a infraestrutura existente, ampliando as desigualdades territoriais. Além disso, quando o desenvolvimento urbano ocorre sem considerar as comunidades locais, há risco de deslocamento forçado de populações, o que representa violação de direitos humanos e fragiliza os vínculos sociais e econômicos das famílias afetadas (Maricato, 2011).

Outro desafio diz respeito à falta de acesso a serviços e infraestrutura básica, como saneamento, energia, mobilidade e habitação adequada, o que aprofunda disparidades urbanas e compromete a qualidade de vida (Harvey, 2012). Paralelamente, observa-se a ausência de planejamento resiliente às mudanças climáticas, o que torna as cidades vulneráveis a eventos extremos, como enchentes, secas e desastres naturais (Onu-Habitat, 2020). A exploração ineficiente dos recursos naturais e o consequente desperdício ambiental também são problemas recorrentes, manifestando-se no uso excessivo de recursos hídricos e energéticos, bem como na degradação de ecossistemas urbanos (Fernandes, 2008).

A baixa participação pública nos processos de tomada de decisão compromete a legitimidade das políticas urbanas, resultando em projetos que não refletem as reais necessidades das comunidades (Lefebvre, 2001). Ademais, a priorização do lucro sobre o bem-estar social e ambiental intensifica processos de gentrificação e exclusão, gerando desequilíbrios territoriais e sociais (Harvey, 2012). Por fim, a exclusão social e a reprodução de desigualdades permanecem como consequências estruturais de políticas urbanas que não incorporam uma perspectiva de justiça socioespacial (Corrêa, 2005).

Em síntese, o desenvolvimento urbano sustentável requer a integração intersetorial, a equidade social e a participação cidadã, de modo a garantir que o crescimento das cidades ocorra de forma planejada, inclusiva e ambientalmente responsável.

Todos estes fatores representam desafios que podem se opor ao que se pretende desenvolver dentro do espaço urbano, destacando a necessidade da manutenção de processos permanentes e qualificados de diagnóstico e de planejamento, que possam fundamentar propostas de ação, necessárias e consistentes, cuja execução deverá estar prevista nos orçamentos municipais e demais instrumentos de planejamento urbano.

Porém, passados mais de 10 anos da instituição do Estatuto do Idoso, a sua implementação tem sido extremamente morosa e desigual no país, fazendo com que a violação de direitos dos idosos seja bastante evidente e a qualidade dos serviços prestados questionável.

A baixa adesão do município às estratégias nacionais e internacionais, na década do envelhecimento saudável 2021-2030, quando associada a escassez dos recursos que são investidos, fortalecem o pressuposto do beneficiamento de áreas privilegiadas, contribuindo para aumentar a percepção da desigualdade social, além de nos remeter a reflexão de Dardot e Laval (2016), sobre a tendência da racionalidade política de expressão mundial, que impõe seus governos, sobre a economia, a sociedade e o próprio Estado, à lógica do capital.

A reconfiguração da estrutura etária e demográfica implica no redimensionamento das demandas sociais, dos serviços destinados ao atendimento da pessoa idosa, na avaliação dos mecanismos de operacionalização das agendas sociais e nas evidências de sua efetividade, bem como, as características dos “atores-chave” participantes deste processo, levando em consideração as especificidades regionais (Brasil, 2018).

Uma cidade amiga do idoso ou que favorece o envelhecimento ativo, é aquela que no fomento de suas políticas públicas entende, as dinâmicas de transformação de sua população e procura atender às demandas sociais para a construção de espaços capazes de adaptarem suas estruturas e serviços, de modo a serem acessíveis e promoverem a inclusão de todas as faixas etárias em suas diferentes necessidades; promotoras de oportunidades em diversos segmentos; e comprometidas em proporcionar o aumento da qualidade de vida, principalmente durante o envelhecimento (OMS, 2007).

Por esse motivo, a OMS procura oferecer através de suas estratégias, subsídios para a construção de cidades onde seja possível envelhecer em condições ambientais positivas, garantindo que idosos mais saudáveis sejam pessoas inseridas socialmente em quaisquer comunidades, afastando o medo da velhice frágil e da dependência irreversível (Plouffe; Kalache, 2010).

No Brasil, ações estão sendo desenvolvidas para fortalecer o envelhecimento resiliência, como a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI) de 2018, que faz uma avaliação norteadas por 08 diretrizes consolidadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - (1) ambiente físico; (2) transporte; (3) moradia; (4) participação; (5)

respeito e inclusão social; (6) comunicação e informação; (7) oportunidades de aprendizagem; e (8) apoio, saúde e cuidado – para poder trazer um diagnóstico que venha servir como ponto de partida para o atendimento de agendas em prol do envelhecimento da localidade que o estudo foi realizado.

Esta estratégia vem sendo expandida nacionalmente nos municípios brasileiros (Projeto de Lei 402/2019), estimulando ações de adequação no planejamento urbano, que deve estar cada vez mais integrado em termos de intersectorialidade política, na perspectiva de materializar, no espaço, o que é decodificado dos anseios e demandas sociais, nas cidades do país.

Para organização da implementação da Estratégia, esta foi adaptada para a realidade brasileira, sob a orientação das dimensões propostas pela OMS e considerando a realidade local.

Diante deste preâmbulo e da necessidade de compreender a efetividade das ações que estão sendo desenvolvidas, surge a seguinte questão norteadora desta tese: **Como pessoas idosas residentes no Recife-PE percebem as ações municipais voltadas para o acolhimento deste segmento da população, considerando os domínios propostos pela Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI)?**

Portanto, no que se refere a justificativa e relevância, podemos dizer que essa pergunta é central e sua resposta nos fornecerá dados concretos que possibilitem hierarquizar indicadores de monitoramento urbano, que poderão reorientar investimentos municipais em áreas prioritárias, fortalecendo a articulação intersectorial necessária para que Recife se constitua como cidade verdadeiramente amiga da pessoa idosa.

1.2 PREMISSE E HIPÓTESES DA TESE

A exposição do problema nos leva a uma suposição inicial que fundamenta essa hipótese e orienta os objetivos da pesquisa. Nesse contexto, nossa premissa pode ser formulada da seguinte maneira: diante das acentuadas desigualdades sociais e históricas que caracterizam o espaço urbano do Recife-PE, postula-se que a eficácia das políticas públicas urbanas destinadas ao acolhimento da pessoa idosa é comprometida devido a lacunas no planejamento e gestão urbana. Essa realidade gera um hiato significativo entre a formalização legal de direitos e a percepção dos idosos sobre a materialização

de um ambiente urbano verdadeiramente amigável e adaptado às suas necessidades.

Nossa hipótese, que é uma proposição a ser verificada empiricamente, parte da ideia de um distanciamento entre a efetivação das previsões legais e a percepção dos idosos, ou seja, que existe um distanciamento significativo entre a efetivação das previsões legais de assistência e amparo às pessoas idosas em Recife-PE e a percepção dessas políticas pelos próprios idosos. Argumenta-se que este hiato é potencializado pela ausência ou subutilização de indicadores locais no planejamento e gestão urbana, em conjunto com as desigualdades históricas do município, resultando em:

1. **Ineficácia das Políticas Públicas Urbanas:** Uma baixa produtividade e ineficácia na implementação das políticas públicas destinadas aos idosos.
2. **Percepção Desigual de Benefícios:** A percepção dos benefícios dessas políticas é restrita majoritariamente a idosos em condições menos vulneráveis, enquanto a maioria da população idosa não acessa ou não percebe tais vantagens.

Esses fatores, em conjunto, impedem que o Recife seja efetivamente reconhecido como uma “cidade amiga da pessoa idosa” sob a ótica da ação pública percebida e implementada. Porém, quando pensamos em uma perspectiva globalizada, ainda podemos enumerar outras circunstâncias complementares, que também podem influenciar no cenário do estudo:

1. O modelo econômico mundial produtivista e financeirizado tende a priorizar o crescimento econômico e a maximização dos lucros em detrimento do bem-estar das pessoas idosas, resultando em políticas urbanas que não são adequadamente adaptadas às necessidades desse grupo populacional, dificultando a criação de “cidades amigas das pessoas idosas”. Alves, Magalhães (1987), Escorsim (2021), Teixeira (2010), Escorsim (2021), Tavares (2020), Paula (2016), são autores que discutem como a sociedade capitalista e o modelo produtivista desvalorizam o idoso que não gera lucro, levando a desigualdades sociais e à exclusão, impactando diretamente a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos.
2. A não sensibilização e compreensão sobre as necessidades e direitos das pessoas idosas contribui para a falta de priorização das políticas e

iniciativas voltadas para a criação de “cidades amigas das pessoas idosas”, abrindo uma lacuna entre as previsões legais existentes e sua efetiva implementação no ambiente urbano. O Estatuto da Pessoa Idosa de 2003, nesta questão, pode ser citado como um marco legal que visa garantir direitos, mas a efetivação depende da sensibilização e compreensão das necessidades dos idosos. Outros autores também tratam desta temática, como: Faleiros (2023) e Debert (2004) que aborda a "reprivatização do envelhecimento", que retira os idosos do espaço público levando-os a uma menor visibilidade e participação dos idosos na vida social e urbana;

3. A falta de coordenação e integração entre diferentes setores e atores envolvidos na formulação e implementação de políticas para pessoas idosas, pode dificultar a criação de cidades acolhedoras ao envelhecimento, principalmente pela falta de colaboração entre agências governamentais, organizações da sociedade civil e setor privado, podendo resultar em abordagens fragmentadas e lacunas na implementação de iniciativas relevantes. Manguiera (2016), Veiga e Bronzo (2014), Motta, Aguiar e Caldas (2011), Souza e Machado (2018), Oliveira et al. (2014), Cavalcante; Carvalho e Medeiros (2012), Faustino (2016), Calazans et al. (2020). Esses estudos abordam a intersetorialidade e a governança em políticas públicas para idosos, destacando os desafios e a importância da colaboração entre diferentes esferas para a efetivação dos direitos e a criação de redes de atenção;
4. A percepção e a compreensão das necessidades e preferências das pessoas idosas podem variar entre diferentes grupos demográficos, culturas e contextos socioeconômicos. Essas diferenças podem levar a desafios na definição de políticas e práticas que atendam às necessidades específicas de cada grupo, levando a variações na materialização de “cidades amigas das pessoas idosas”. Wu et al. (2022), Carmona et al. (2014), Hernández et al. (2020), Silva (2019), Jaccoud (2024), Nakagomi et al. (2023), Campbell et al. (2023). A pesquisa de Wu et al. (2022) investiga a desigualdade de renda e o bem-estar em idosos em diferentes países. Outros autores destacam como a solidão e o isolamento social variam com a idade e as

condições socioeconômicas, e como as intervenções intergeracionais podem ser eficazes;

5. A falta de financiamento adequado e de recursos suficientes pode representar uma barreira significativa para a implementação de políticas e iniciativas voltadas para as pessoas idosas, visto que, a restrição de recursos pode limitar a capacidade das autoridades municipais em criar e manter um ambiente urbano adaptado às necessidades das pessoas idosas. IEPS (2023), Sousa et al. (2021), Pinheiro e Areosa (2019), Faleiros (2016), Alcântara et al. (2016). O estudo do IEPS (2023) aponta que idosos de menor renda têm piores indicadores de saúde e menos acesso a cuidados, e que a disponibilidade de profissionais especializados é baixa. Sousa et al. (2021) e Pinheiro e Areosa (2019) reforçam que a promoção do envelhecimento ativo exige o combate às desigualdades sociais e que políticas públicas eficazes dependem de recursos. Alcântara et al. (2016) discutem a Política Nacional do Idoso e os desafios de sua implementação;
e
6. A resistência a mudanças e a falta de vontade política podem ser obstáculos para a materialização de cidades acolhedoras ao envelhecimento de sua população. A falta de comprometimento por parte dos governantes e outras partes interessadas pode resultar em atrasos ou até mesmo na rejeição de medidas destinadas a promover a inclusão e a qualidade de vida das pessoas idosas. Litvak (2024), Cervera e Schmidt (2022), Teixeira et al. (2018), Goldani (2010a), Couto et al. (2009), Daniel et al. (2015), Butler (1969), Dórea (2020), Neri (2007). Litvak (2024) discute a resistência à mudança e o preconceito etário no mercado de trabalho. Cervera e Schmidt (2022) e Teixeira et al. (2018) abordam o "ageísmo" como uma forma de discriminação que impede a inclusão e a qualidade de vida dos idosos, muitas vezes internalizada e socialmente aceita, o que reflete a falta de vontade política em combater essas barreiras. Para Butler (1969) podemos atribuir o crédito do termo "ageismo".

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO PROPOSTO

Diagnosticar a percepção dos cidadãos idosos sobre os domínios propostos para uma "cidade amiga do idoso" ou acolhedora ao envelhecimento, no município do Recife-PE, revelou-se de fundamental importância para o fomento de políticas públicas urbanas efetivas. Este diagnóstico foi essencial para contrastar a realidade local com parâmetros de municípios que já possuem políticas setoriais consolidadas.

O presente estudo produziu dados primários e conhecimentos inéditos sobre a realidade do território, por meio de uma investigação diagnóstica pioneira, subsidiando o debate sobre políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Ademais, o trabalho respondeu, sob a ótica do diagnóstico realizado, a indagações centrais de caráter investigativo: 1) Verificou-se que é possível avaliar o desempenho municipal frente às demandas do envelhecimento populacional a partir das bases de dados disponíveis, embora estas apresentem lacunas de integração; 2) Identificou-se a premência de um modelo técnico sistematizador validado no município que contribua com diagnósticos capazes de instrumentalizar políticas e programas voltados à longevidade; 3) Analisou-se de certa forma, com base na percepção de cada idoso investigado, o estágio das ações municipais para a adequação do Recife à nova realidade demográfica e ao reconhecimento como uma cidade acolhedora.

Ao enfrentar essas questões, o estudo demonstrou sua relevância ao oferecer subsídios para a formulação de diretrizes mais eficazes, visando a promoção da qualidade de vida das pessoas idosas e o aprimoramento do planejamento e da gestão urbana.

Por fim, reitera-se que, embora a amostra utilizada não tenha objetivado a generalização estatística para a totalidade do contingente idoso do Recife, ela logrou oferecer um panorama consistente das percepções de grupos diversos no território.

Tal abordagem favoreceu a consolidação de um diagnóstico analítico robusto, que se replicado em larga escala, pode contribuir significativamente ao reordenamento das prioridades do planejamento urbano e das políticas públicas municipais. A relevância deste estudo consolida-se através de sua tríplice aplicabilidade, oferecendo subsídios teóricos, práticos e estratégicos estruturados em três agrupamentos fundamentais:

Contribuição Acadêmica e Teórica

A presente tese preenche uma lacuna documental e científica ao realizar o primeiro diagnóstico empírico da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI) no município do Recife. A pesquisa avança teoricamente ao integrar as macroanálises da Justiça Espacial, sob as lentes de Lefebvre, Harvey e Soja, às microanálises da Teoria da Pressão Ambiental de Lawton e Nahemow. Ao validar a escolaridade — e o consequente capital cultural — como o principal determinante social da percepção urbana, o trabalho oferece um novo arcabouço analítico para a Gerontologia Urbana. Esta abordagem permite compreender como o ambiente construído atua como um agente incapacitante em metrópoles desiguais.

Contribuição para a Gestão Municipal

No âmbito da governança local, esta pesquisa fornece um mapeamento de precariedades hierarquizadas por território. Ao identificar que domínios estruturantes como "Transporte" e "Ambiente Físico" apresentam níveis críticos de insatisfação, a tese entrega aos gestores dados objetivos para a priorização de investimentos públicos. A constatação da homogeneidade da precariedade entre as diversas RPAs oferece subsídio técnico para a revisão de instrumentos urbanísticos, como o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade, permitindo que a Prefeitura do Recife direcione ações de acessibilidade e segurança viária baseadas em evidências coletadas diretamente com o usuário final do espaço público.

Contribuição para Políticas Intersetoriais

Finalmente, a pesquisa propõe a superação da visão fragmentada das políticas públicas ao defender a transição para o Urbanismo do Cuidado. A recomendação de um Comitê Gestor Intersetorial de Gerontologia no Plano Diretor oferece um modelo de integração entre as pastas de Desenvolvimento Urbano, Saúde e Assistência Social. Esta contribuição visa garantir que o envelhecimento seja tratado de forma transversal, onde o desenho da cidade e o suporte social colaborem para a manutenção da autonomia e independência da pessoa idosa, consolidando o Recife como um território resiliente e acolhedor à longevidade.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Avaliar a percepção de pessoas idosas residentes no município de Recife-PE, sobre o acolhimento aos mais velhos, a partir dos domínios propostos na Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), de modo a realizar um diagnóstico com vistas à orientação de boas práticas de acolhimento no espaço urbano.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar a amostra do estudo segundo as variáveis sociodemográficas, acompanhamento médico/periodicidade, uso de medicamentos, deficiência autodeclarada e mobilidade reduzida;
- Identificar a percepção de usuários idosos quanto aos 08 domínios: ambiente físico; transporte; moradia; participação; respeito/inclusão social; comunicação/informação; oportunidades para aprendizagem; apoio, saúde e cuidado propostos na EBAPI;
- Verificar a associação entre a percepção por domínios e as demais variáveis sociodemográficas investigadas;
- Formular diretrizes estratégicas para o planejamento urbano, fundamentados no diagnóstico da percepção dos usuários, visando institucionalizar boas práticas de acolhimento e cuidado à pessoa idosa no espaço público.

Visando conferir maior clareza operacional e demonstrar a exequibilidade desta tese, os objetivos propostos foram sistematizados em uma matriz metodológica. O Quadro 1, apresentado a seguir, sintetiza a correlação entre as dimensões de análise, os objetivos específicos, as fontes de dados coletadas no Recife e os resultados esperados para a construção do diagnóstico de longevidade urbana.

Quadro 1 – Matriz de Síntese Metodológica da Pesquisa.	
Temática	Políticas públicas urbanas voltadas para o envelhecimento e o acolhimento das pessoas idosas.
Título do Trabalho	LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE: diagnóstico para uma cidade acolhedora a partir do olhar da pessoa idosa.
Objeto Empírico	São os dados coletados diretamente das pessoas idosas de Recife-PE, através do questionário quantitativo que foi aplicado, que avalia a percepção delas em relação aos domínios da EBAPI.
Objeto Teórico	Conceitos que tangem as cidades acolhedoras, ao envelhecimento e as políticas públicas de desenvolvimento urbano sustentável voltadas para a longevidade.
Problema de Pesquisa	O impacto da desigualdade social, urbanização e envelhecimento na oferta de serviços e políticas públicas para idosos, que sejam capazes de promover a construção de um ambiente urbano amigável e adaptado às necessidades percebidas por este segmento da população, sem a priorização e beneficiamento de áreas privilegiadas, tendo em vista a universalidade destas.
Premissa	A eficácia das políticas públicas urbanas para idosos em Recife-PE é limitada por um hiato entre sua implementação e a percepção dos idosos sobre o acolhimento urbano, agravado pelas desigualdades históricas, impedindo uma experiência universal de cidade amiga.
Hipótese da Tese	Existe um distanciamento significativo entre a efetivação das previsões legais de assistência e amparo às pessoas idosas em Recife-PE e a percepção dessas políticas pelos próprios idosos, resultando em uma experiência de acolhimento urbano desigual, onde apenas idosos não vulneráveis percebem benefícios substanciais.
Justificativa e Relevância	A pesquisa é de grande importância para a formulação de políticas públicas urbanas eficazes que contemplem as necessidades dos idosos, favorecendo uma sociedade mais justa e igualitária. Ao focar na percepção dos próprios idosos, esta análise metodologicamente robusta pode oferecer uma contribuição significativa para a academia e para os formuladores de políticas, ajudando no processo para entender e melhorar a interface entre urbanização, desigualdade e envelhecimento populacional, contribuindo para a criação de cidades mais amigáveis aos idosos.
Objetivo Geral	Avaliar a percepção de pessoas idosas residentes no município de Recife-PE, sobre o acolhimento aos mais velhos, a partir dos domínios propostos na Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), de modo a realizar um diagnóstico com vistas à orientação de boas práticas de acolhimento no espaço urbano.
Objetivos Específicos	Caracterizar a amostra do estudo segundo as variáveis sociodemográficas, acompanhamento médico/ periodicidade, uso de medicamentos, deficiência autodeclarada e mobilidade reduzida; Identificar a percepção de usuários idosos quanto aos 08 domínios propostos na EBAPI; Verificar a associação entre a percepção por domínios e as demais variáveis investigadas; e Propor a hierarquização de indicadores de monitoramento, baseados na percepção dos usuários idosos, com vistas à orientação de boas práticas de acolhimento no espaço urbano; Formular diretrizes estratégicas para o planejamento urbano, com base na percepção dos usuários, visando institucionalizar boas práticas de acolhimento e cuidado à pessoa idosa no espaço público.
Marco Teórico	Conceitos e teorias que abordam a qualificação do ambiente urbano no contexto do envelhecimento, sendo as mais utilizadas no estudo: Envelhecimento Ativo e Teoria do Desenvolvimento Urbano Sustentável.
Método	Método hipotético-dedutivo
Tipo de Pesquisa	Pesquisa de abordagem diagnóstica e exploratória, de caráter quantitativo.
Etapas Metodológicas	03 etapas metodológicas, onde: 1) investigações teórico-documentais e coleta de dados; 2) distribuição e estruturação dos dados adquiridos na fase anterior e a 3) cruzamento das informações.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

A fim de conferir uma visão panorâmica da investigação, a presente tese está organizada em seis capítulos, estruturados de modo a articular a fundamentação teórica, o rigor metodológico e a análise empírica do diagnóstico realizado:

O **Capítulo 1** (Introdução) apresenta o objeto de estudo, o problema de pesquisa e os objetivos, estabelecendo as premissas e hipóteses que nortearam a investigação.

O **Capítulo 2** (Referencial Teórico) estabelece o aporte conceitual da pesquisa, discutindo a produção do espaço urbano, o envelhecimento populacional e as políticas de longevidade, com foco nas especificidades históricas e socioespaciais do município do Recife.

O **Capítulo 3** (Metodologia) detalha o percurso metodológico adotado, fundamentado no método hipotético-dedutivo e na abordagem quantitativa, descrevendo os instrumentos de coleta, os critérios de filtragem da amostra e as técnicas estatísticas utilizadas via IBM SPSS Statistics.

O **Capítulo 4** (Resultados) expõe o diagnóstico obtido através dos oito domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), apresentando as variáveis sociodemográficas e a percepção dos idosos sobre o acolhimento municipal.

O **Capítulo 5** (Análise e Discussão dos Resultados) promove o cruzamento entre os dados empíricos e a base teórica, discutindo o hiato entre a legislação e a percepção vivida pelos idosos, além de analisar as disparidades observadas entre as diferentes Regiões Político-Administrativas (RPAs).

O **Capítulo 6** (Considerações Finais e Diretrizes) sintetiza as principais conclusões do estudo, validando ou refutando as hipóteses iniciais, e apresenta a proposta da Constelação de Estruturas Urbanas Polinucleada (EUP) como diretriz estratégica para um planejamento urbano verdadeiramente acolhedor à longevidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo estabelece o arcabouço conceitual da tese, fundamentado em duas dimensões essenciais – Macro e Micro – cruciais para a compreensão do envelhecimento no contexto urbano do Recife. A estrutura inicia com a contextualização da gerontologia e sua especialização nos aspectos ambientais (Modelo de Lawton e Nahemow) como base para analisar a percepção dos idosos sobre o acolhimento urbano. Em seguida, o capítulo articula teorias, conceitos e estratégias, confrontando-os com as condicionantes estruturais da desigualdade.

A contextualização da discussão teórico-metodológica concentra-se, em grande parte, na confrontação dos modelos de reestruturação produtiva e de multipolarização financeira de ordem internacional, os quais repercutem na urbanização das cidades e instituem uma lógica produtivista e privatista em larga escala.

As disparidades socioeconômicas, manifestas em pobreza e desigualdade territorial, atuam como fatores limitadores de oportunidades e bem-estar, suscitando indagações fundamentais e pertinentes, tais como: por que desenvolver "cidades amigas dos idosos" em contextos marcados por desigualdades históricas e exclusões estruturais? Tais proposições poderiam inadvertidamente negligenciar outros segmentos populacionais, como jovens e indivíduos com deficiência permanente ou temporária.

Paralelamente, uma tendência globalizada de individualismo, agravada pela insuficiência de redes de apoio social robustas e de espaços públicos adequados para a interação comunitária, fomenta o isolamento social dos idosos. A inadaptabilidade crônica das infraestruturas urbanas, frente à transição demográfica mundial, evidencia-se na carência de acessibilidade universal — calçadas inadequadas, transporte público não adaptado, moradias inacessíveis ou a própria ausência de moradia — que constroem a mobilidade e a autonomia no processo de envelhecimento urbano.

Ademais, questiona-se a própria viabilidade de implementação dessas ideias, considerando os obstáculos financeiros, políticos e técnicos, particularmente em municípios como Recife-PE. Neste modelo hegemônico, que privilegia a produtividade e o crescimento econômico, torna-se premente a necessidade de se compreenderem as deficiências nas políticas públicas urbanas direcionadas à população idosa.

Em suma, a inadaptabilidade crônica das infraestruturas urbanas e o risco de isolamento social para a pessoa idosa – temas centrais neste campo de estudo –

sublinham a urgência de uma abordagem teórica crítica e instrumental, fazendo-nos ajustar nossa indagação anterior, condicionada ao interesse de materializar soluções, para: como desenvolver "cidades amigas dos idosos" em contextos marcados por desigualdades históricas, exclusões estruturais, considerando os obstáculos financeiros, políticos e técnicos?

Para responder à questão central de forma abrangente, a tese estrutura seu diagnóstico em dois níveis interconectados, conforme detalhado no Quadro 02. O nível Macro examina as condicionantes estruturais sob as perspectivas do Desenvolvimento Urbano Sustentável e da Justiça Socioespacial. O nível Micro aplica o Modelo da Pressionabilidade Ambiental e Competência (de Lawton e Nahemow), que serviu de base para guias e modelos estratégicos internacionais destinados à medição e verificação de cidades amigáveis ao envelhecimento, como é o caso da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI).

Quadro 02 - Estrutura Teórica Integrada: Pilares Macro e Micro.

PILAR TEÓRICO	NÍVEL DE ANÁLISE	TEORIA RECOMENDADA	FOCO ANALÍTICO	CONTRIBUIÇÃO
MACRO	Contexto urbano e políticas públicas.	Desenvolvimento Urbano Sustentável + Justiça Socioespacial	Desigualdade histórica, expansão urbana descontrolada, priorização do lucro sobre bem-estar.	Explicar ineficácia das políticas públicas e reprodução de desigualdades em Recife-PE.
MICRO	Percepção individual e bem-estar.	Modelo da Pressionabilidade Ambiental e Competência (Lawton & Nahemow, 1973) + Envelhecimento Socioambiental	Interação dinâmica entre capacidades individuais do idoso e demandas do ambiente físico/social.	Fundamentar análise dos 8 domínios EBAPI; explicar variações no bem-estar urbano.

Fonte: Elaboração própria (2026).

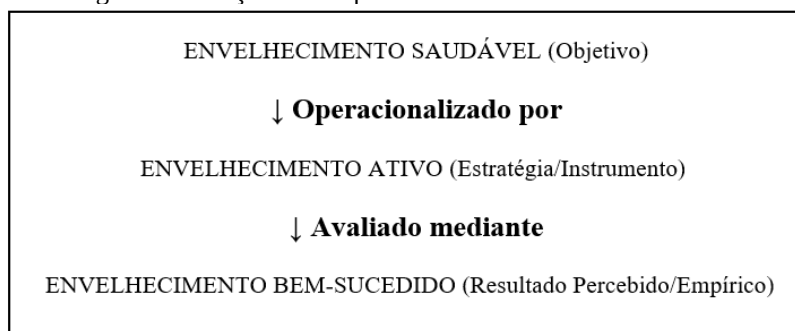
Na análise macro, fatores estruturais como a expansão urbana descontrolada, gentrificação, exclusão social e fragilidade do planejamento local, podem configurar-se como elementos que comprometem a infraestrutura urbana e a coesão territorial. Compreender a reprodução de desigualdades e a provisão deficiente de infraestrutura básica como consequências diretas de políticas urbanas que não incorporam a equidade distributiva, fornece subsídios para as respostas das hipóteses complementares desta investigação.

No nível micro, o Modelo da Pressionabilidade Ambiental e Competência (Environmental Press and Competence Model), proposto por M. Powell Lawton e Lester Nahemow em 1973, constituiu a base teórica fundamental da Gerontologia Ambiental para determinar a capacidade global do indivíduo de adaptação ou de desempenho adequado em ambientes exigentes. Este modelo foi a base da sustentação lógica do Guia Global de Cidades Amigas da Pessoa Idosa, desenvolvido pela OMS.

Neste sentido, a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), que orienta esta pesquisa como instrumento diagnóstico, representa a operacionalização dos princípios de Lawton e Nahemow no contexto brasileiro, funcionando como adaptação das 8 diretrizes da OMS para cidades amigas do idoso. A presente pesquisa prioriza, portanto, as abordagens do Envelhecimento Ativo e do Desenvolvimento Urbano Sustentável como marcos conceituais estruturadores.

No entanto, as abordagens relacionadas ao envelhecimento articulam-se em torno de três conceitos complementares e hierarquicamente ordenados, que abordaremos posteriormente: o Envelhecimento Saudável, o Envelhecimento Ativo e o Envelhecimento Bem-Sucedido.

Figura 2 - Relação Hierárquica e Funcional dos Três Conceitos.



Fonte: Elaboração própria (2026).

A Gerontologia e a Gerontologia Ambiental

A Gerontologia é uma disciplina científica multidisciplinar que estuda o processo de envelhecimento humano em suas múltiplas dimensões (Papaléo Netto, 2007). Ela abrange aspectos biológicos, psicológicos, sociais e econômicos do envelhecimento, buscando compreender as transformações que ocorrem no indivíduo idoso e na sociedade (Veras, 2009). Como campo de conhecimento, a Gerontologia se constitui como fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e intervenções que promovam um envelhecimento bem-sucedido e ativo.

No contexto contemporâneo, surge a Gerontologia Ambiental como uma subdisciplina que enfatiza a relação entre o ambiente — tanto físico quanto social — e a qualidade de vida das pessoas idosas (Lawson, 1986). Essa abordagem reconhece que o processo de envelhecimento não ocorre isoladamente, mas em constante interação com o contexto em que o idoso está inserido.

A Gerontologia Ambiental, portanto, propõe que ambientes adequados e acessíveis podem potencializar a autonomia, a independência e o bem-estar da população idosa (Gitlin; Schulz, 2012).

A teoria que relaciona o envelhecimento com o ambiente social e físico é amplamente discutida no campo da Gerontologia Ambiental. Não há uma única teoria universalmente denominada "Teoria do Envelhecimento Socioambiental", mas sim um conjunto de modelos e estruturas conceituais, sendo o precursor e o mais influente o Modelo da Pressionabilidade Ambiental e Competência (Environmental Press and Competence Model), proposto por Lawton e Nahemow (Lawton; Nahemow, 1973).

Este modelo sugere que o bem-estar e a adaptação de uma pessoa idosa resultam da interação entre suas competências individuais (capacidades físicas, cognitivas e sociais) e a pressionabilidade ambiental (demandas, desafios ou suportes do ambiente físico e social). Em resumo, o conceito de envelhecimento socioambiental está intrinsecamente ligado à Gerontologia Ambiental e à aplicação do Modelo da Pressionabilidade Ambiental e Competência para desenvolver políticas e espaços urbanos acolhedores como as “Cidades Amigas da Pessoa Idosa”, que venham a corresponder às necessidades da população idosa (Organização Mundial da Saúde, 2007).

O Modelo da Pressionabilidade Ambiental e Competência, proposto pelos gerontólogos M. Powell Lawton e Lester Nahemow, é a teoria mais influente e fundamental no campo da Gerontologia Ambiental (Rubinstein; Parmelee, 1992). Ele busca explicar como a interação entre um indivíduo e seu ambiente influencia o comportamento e o bem-estar da pessoa idosa. A essência do modelo reside no conceito de adaptação ótima, que ocorre quando há um equilíbrio entre as capacidades do indivíduo e as demandas do ambiente.

Os componentes chave do modelo referem-se à capacidade global de um indivíduo funcionar em quatro áreas principais:

- Capacidade Biológica: Saúde física, força, mobilidade e resistência.
- Capacidade Sensorial/Motora: Habilidades de percepção (visão, audição) e coordenação motora.
- Capacidade Cognitiva: Habilidades mentais, como memória, raciocínio e capacidade de resolução de problemas.
- Competência do Ego ou Social: Capacidade de se adaptar socialmente, manter relacionamentos e lidar com emoções.

Quanto maior a competência individual, maior é a capacidade da pessoa de se adaptar a ambientes mais exigentes. Do ponto de vista ambiental, temos as demandas, desafios ou forças que o ambiente impõe ao indivíduo que podem ser:

- Baixa: Um ambiente que oferece pouco estímulo ou desafio, resultando em tédio e subutilização da capacidade.
- Moderada (Ótima): Um ambiente que oferece desafios na medida certa, promovendo o envolvimento e o desenvolvimento máximo.
- Alta: Um ambiente que é muito exigente, complexo ou não acessível, levando a estresse, frustração, inadaptação e até mesmo desorientação ou comportamentos negativos.

Exemplos de pressão ambiental incluem a complexidade da mobilidade urbana (calçadas irregulares, falta de rampas, espaços arborizados), a dificuldade em usar a tecnologia ou a ausência de transporte público acessível.

Percebe-se que o modelo interage com dois fatores, a zona de adaptação e o comportamento, que é o que vai definir o resultado no comportamento e no bem-estar do indivíduo:

- Zona de Adaptação: É a área em que a Competência e a Pressionabilidade Ambiental estão equilibradas. Nela, o comportamento é adaptativo, e o bem-estar subjetivo é positivo.
- Zona de Desempenho Máximo: Uma subárea da Zona de Adaptação onde a pressão é ligeiramente mais alta do que a competência. Essa leve exigência promove o desempenho e o crescimento do indivíduo, pois estimula o uso máximo das suas capacidades.

O resultado negativo desta interação, ou seja, a inadaptação, resulta em:

- Baixo Bem-estar: Ocorre quando a pressão é muito alta (sobrecarga) ou muito baixa (tédio).
- Comportamento Negativo: Acontece quando a pressão ambiental é desproporcional à competência. Por exemplo, uma pessoa com baixa competência que vive em um ambiente de alta pressão pode desenvolver comportamentos de evitação ou dependência.

Ao analisar o referido modelo, que trata da pressionabilidade ambiental, percebemos o quão crucial este é para o entendimento e construção da base teórica do

estudo e do conceito de "Cidade Amiga da Pessoa Idosa" (Organização Mundial da Saúde, 2007). Este modelo sustenta a necessidade e a lógica do guia global da OMS, que propõe intervenções em diversos domínios para criar ambientes mais inclusivos e acessíveis.

Por sua vez, a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI) atua diretamente sobre a "Pressionabilidade Ambiental" ao propor intervenções em domínios que apresentam características que podem comprometer o bem-estar e o comportamento do indivíduo, fechando o ciclo da pressionabilidade e competência e nos mostrando a relação entre fundamento teórico e aplicação prática (Brasil, 2020).

No contexto local, a implementação dessas diretrizes vincula-se à estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD) do Recife. Entretanto, observa-se que a governança voltada à pessoa idosa ainda enfrenta o desafio da intersetorialidade, uma vez que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIR) atua majoritariamente na esfera da assistência social, possuindo baixa incidência nas decisões de desenho urbano e infraestrutura conduzidas por autarquias como a EMLURB e a CTTU.

O objetivo das políticas públicas, sob a ótica de Lawton e Nahemow, é justamente reduzir a pressão ambiental para os idosos com baixa competência (os mais frágeis) e manter uma pressão moderada e ótima para os idosos mais competentes (os mais ativos), garantindo que o ambiente urbano promova a saúde, a autonomia e o máximo bem-estar para toda a população idosa (Veras; Oliveira, 2018).

Em suma, a adequação ambiental é mais importante para aqueles com menores capacidades individuais (baixa competência), pois um pequeno aumento na pressão ambiental pode levar rapidamente à inadaptação e à exclusão social (Gitlin; Schulz, 2012).

Como fechamento desta fundamentação, cabe sintetizar de que maneira o arcabouço teórico mobilizado orienta a expectativa analítica sobre os domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI) no Recife. A integração entre o Direito à Cidade e a Teoria da Pressão Ambiental permite antever que a percepção do idoso não é um fenômeno isolado, mas o resultado do tensionamento entre a competência individual e as barreiras impostas pelo urbanismo.

Do ponto de vista teórico, o que se espera observar nos domínios da EBAPI fundamenta-se em três pilares integradores:

1) A Materialização da Pressão Ambiental nos Domínios Estruturantes

À luz de Lawton e Nahemow, pressupõe-se que nos domínios Ambiente Físico e Transporte, a pressão urbana do Recife atue como um agente incapacitante. Teoricamente, a precariedade de elementos básicos de infraestrutura deve elevar o esforço de adaptação a níveis que comprometem a autonomia, transformando a hostilidade do espaço público em um fator de exclusão e recolhimento doméstico.

2) O Capital Cultural como Filtro da Cidadania

Com base na perspectiva crítica de Lefebvre, espera-se que a percepção sobre os domínios de Participação, Comunicação e Respeito seja diretamente mediada pela escolaridade. Do ponto de vista teórico, o idoso com maior capital cultural detém os códigos da cidadania, o que deve resultar em um olhar mais crítico e rigoroso sobre o hiato existente entre a norma jurídica (Estatuto do Idoso/EBAPI) e a eficácia das políticas públicas municipais.

3) A Justiça Espacial e a "Loteria do CEP"

Sob a ótica de Harvey e Soja, a expectativa teórica é que a percepção de acolhimento não seja homogênea no território. Espera-se que o diagnóstico revele disparidades estatísticas entre as RPAs, onde o investimento histórico desigual em infraestrutura e serviços básicos se traduza em uma "hierarquia de precariedades", penalizando de forma mais aguda os idosos residentes em territórios de maior vulnerabilidade urbana.

Esta síntese prepara o caminho para a etapa empírica desta tese, na qual as hipóteses levantadas a partir do diálogo entre o Urbanismo e a Gerontologia serão testadas frente à realidade tátil e cotidiana dos idosos recifenses.

2.1 ENVELHECIMENTO ATIVO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL: DO DETERMINISMO CONTEXTUAL À CRÍTICA DA CULPABILIZAÇÃO INDIVIDUAL

Para uma compreensão aprofundada da temática das cidades acolhedoras ao envelhecimento, esta tese fundamenta-se principalmente em duas abordagens teóricas complementares: o Envelhecimento Ativo e o Desenvolvimento Urbano Sustentável.

Embora possuam focos distintos, a intersecção entre elas é crucial para analisar a percepção dos idosos sobre o acolhimento urbano no Recife-PE.

Envelhecimento Ativo

O conceito de Envelhecimento Ativo, promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), centra-se na otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, a fim de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Esta teoria transcende a visão puramente biológica da velhice, propondo uma modificação da imagem individual e social do sujeito idoso. Caldas e Thomaz (2010) afirmam que, embora a velhice represente um declínio biológico e a perda de estatuto econômico e social, surge uma nova tendência de encarar e se relacionar com o envelhecimento, o envelhecimento ativo.

Em oposição à teoria do desengajamento, formulada por Elaine Cumming e William Henry no livro *Growing Old* (1961), que preconizava a diminuição das interações entre o idoso e os membros da sua sociedade (Cumming; Henry, 1961; Doll, 2007) a teoria da atividade, rastreada até os anos 1960 nos EUA (Hutchison, 2006), afirmou que a chave para o envelhecimento bem-sucedido era a atividade física e o sucesso financeiro. Numa visão mais ampla, o envelhecimento ativo foi avançado em 2002 pela OMS, reconhecendo que, para além da saúde, os aspectos socioeconômicos, psicológicos e ambientais atuam como preditores de um envelhecimento com qualidade de vida (Ribeiro; Paúl, 2011; OMS, 2009, p.5). O modelo de envelhecimento ativo, conforme a OMS (2002), depende de uma diversidade de fatores designados por "determinantes", agrupados nas seguintes ordens (Quadro 3):

Quadro 3 - Determinantes e sua área de influência do modelo do envelhecimento ativo.

Determinante	Área de Influência
Ordem pessoal	Fatores biológicos, genéticos e psicológicos;
Ordem comportamental	Estilos de vida saudáveis e participação ativa no cuidado da própria saúde;
Ordem econômica	Rendimento, proteção social e oportunidade de trabalho digno;
Ordem ambiental	Acessibilidade a serviços de transporte, moradias e vizinhança seguras e apropriadas, água limpa, ar puro e alimentos seguros;
Ordem social	Apoio social, educação e alfabetização, prevenção da violência e abuso;
Ordem dos Serviços sociais	Acessibilidade, qualidade, e com capacidade de promover a saúde e a prevenção de doenças.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), adaptado da OMS (2002).

Para a OMS (2009), esses determinantes devem ser encarados segundo uma perspectiva de ciclo de vida, reconhecendo que as pessoas idosas não são um grupo homogêneo e que a diversidade individual aumenta com a idade. Paúl, Ribeiro e Teixeira (2012) entendem que a qualidade de vida no idoso é, em grande parte, determinada pela capacidade de manter a independência e autonomia, senão física, pelo menos psicológica e social, ou seja, a capacidade de decisão e controle do idoso sobre a sua vida. Ribeiro (2012) complementa que o envelhecimento ativo constitui, atualmente, um conceito científico complexo, um propósito para a maioria das pessoas e um indiscutível objetivo político.

O termo “ativo” traz subjacente o caráter de mútua responsabilidade que, num balanço de deveres e obrigações, postula a autorresponsabilização individual no atingir de níveis de funcionamento mais elevado no usufruto das oportunidades de saúde, segurança e participação social que lhes são otimizadas pelos decisores políticos (Ribeiro; Paúl, 2011).

Já para Almeida (2007, p. 20), o conceito de envelhecimento ativo surge como resposta a objetivos e preocupações da sociedade, nomeadamente as que se ligam ao aumento de custos associados ao envelhecimento demográfico. Boudiny (2013) reconhece que a difusão do conceito de envelhecimento ativo poderá ter sido significativa para os idosos mais jovens e saudáveis, apoiando-os a permanecer ativo, e proporcionando-lhes a oportunidade de fazê-lo.

Desenvolvimento Urbano Sustentável

A Teoria do Desenvolvimento Urbano Sustentável busca conciliar o desenvolvimento económico, social e ambiental nas áreas urbanas, garantindo a preservação dos recursos naturais e o bem-estar das gerações presentes e futuras. Conforme Sachs (2020), "desenvolvimento sustentável é um paradigma de desenvolvimento que integra as dimensões económica, social e ambiental, com o objetivo de garantir que o progresso atual não comprometa a capacidade das gerações futuras de alcançar suas próprias necessidades e aspirações". Este conceito ganhou destaque com o relatório "Nosso Futuro Comum" (1987), também conhecido como Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, definindo-o como "aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas

próprias necessidades" (WCED, 1987).

Este conceito abrange três pilares principais:

- **Ambiental:** Envolve a proteção dos ecossistemas e a utilização racional dos recursos naturais, garantindo que estes recursos permaneçam disponíveis para as gerações futuras.
- **Econômico:** Implica um crescimento econômico que proporcione oportunidades de emprego e riqueza, de forma equitativa e justa, sem causar danos ambientais.
- **Social:** Refere-se à promoção de uma sociedade justa, onde todos tenham acesso igualitário aos recursos básicos, como educação, saúde, habitação e emprego.

Quando tratamos de desenvolvimento urbano sustentável, temos uma aplicação específica do conceito mais amplo. Simon (2021) define-o como "uma abordagem para o planejamento e gestão das cidades que busca garantir que o desenvolvimento urbano seja conduzido de maneira a ser ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente inclusivo". Este conceito enfatiza a necessidade de inovação nas infraestruturas urbanas, políticas habitacionais justas e a promoção de práticas que reduzam o "discurso das boas intenções ecológicas das cidades", ou seja, que adota uma abordagem mais substancial e eficaz, que associe a implementação de medidas concretas e políticas sustentáveis para reduzir efetivamente o impacto ambiental das cidades.

O desenvolvimento urbano sustentável, por sua vez, busca equilibrar as necessidades humanas com a preservação ambiental nas cidades, e inclui os seguintes aspectos:

- **Planejamento Urbano Integrado:** Implica a criação de planos urbanos que considerem a sustentabilidade desde o início, integrando transporte, habitação, infraestrutura e espaços verdes de maneira coerente e sustentável (Newman; Kenworthy, 1999).
- **Transporte Sustentável:** Foca na promoção de sistemas de transporte eficientes e menos poluentes, como transporte público de alta qualidade, ciclovias e calçadas seguras (Litman, 2011).
- **Construção Sustentável:** Envolve a construção de edifícios que utilizam menos energia, água e outros recursos, ao mesmo tempo em que geram menos resíduos e poluição. Exemplo, uso de tecnologias de construção verde (Kibert, 2016).
- **Gestão de Resíduos:** Implementação de sistemas eficazes para a coleta,

reciclagem e disposição de resíduos, minimizando o impacto ambiental (Hoornweg; Bhada-Tata, 2012).

- **Justiça Social e Inclusão:** Busca assegurar que toda população urbana tenham acesso aos benefícios, incluindo moradia adequada, serviços de saúde, educação e oportunidades de emprego (ONU, 2016).

Convergências e Divergências

A distinção fundamental entre as duas teorias reside, inicialmente, na escala de observação e no foco analítico. Enquanto o **Envelhecimento Ativo** prioriza a dimensão ontológica e subjetiva — concentrando-se no indivíduo e nas condições que potencializam sua participação e bem-estar (o 'quem' e o 'como' se vive) —, o **Desenvolvimento Urbano Sustentável** debruça-se sobre a dimensão estrutural e coletiva, planejando a cidade como uma plataforma de suporte à vida (o 'onde' e o 'como' o espaço é gerido).

Entretanto, essa aparente distância epistemológica dissolve-se na práxis urbana. O paralelismo entre ambas revela que são esferas interdependentes que se encontram no seu produto final: a garantia do direito à cidade. Não há envelhecimento ativo sem um suporte biofísico que o sustente, assim como não há desenvolvimento urbano sustentável que ignore a transição demográfica de seus habitantes. Portanto, o encontro dessas teorias transmuta a cidade de mero cenário em um determinante social da saúde, onde a eficácia do planejamento urbano passa a ser medida pela capacidade de promover a autonomia e o protagonismo da pessoa idosa.

Sendo assim, essas teorias convergem de forma significativa na construção de "cidades amigas das pessoas idosas". O ambiente urbano é o elo crucial, pois para que o Envelhecimento Ativo seja plenamente realizado, é imperativo que a cidade seja planejada de forma sustentável. Aspectos do Desenvolvimento Urbano Sustentável, como acessibilidade, segurança, transporte eficiente e espaços verdes, impactam diretamente a "ordem ambiental" e a "ordem dos serviços sociais" do Envelhecimento Ativo. Ambas as teorias também compartilham o objetivo de promover a justiça social e a inclusão, garantindo que as políticas públicas beneficiem todos os segmentos da população, incluindo os idosos.

A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), ao se basear nos domínios da OMS (Guia Mundial de Cidades Amigas - 2005), já integra os princípios do

Envelhecimento Ativo. A avaliação da percepção dos idosos sobre domínios como "ambiente físico", "transporte", "moradia" e "apoio, saúde e cuidado" (conforme proposto pela EBAPI) será diretamente influenciada pela eficácia do Desenvolvimento Urbano Sustentável do Recife. Assim, a compreensão clara da distinção e intersecção dessas teorias é fundamental para analisar como as políticas e o planejamento urbano se traduzem na experiência de acolhimento dos idosos na cidade.

É importante salientar que a escolha e adequação da teoria do envelhecimento que mais se adequou ao estudo, dada a operacionalidade e abrangência, foi a do envelhecimento ativo. A abordagem do envelhecimento saudável e bem-sucedido, apresentaram um direcionamento mais restrito, subjetivo e individualizado, porém, ambos conceitos podem configurar como resultados almejados do envelhecimento ativo e compõem a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), baseados nos domínios da OMS.

Os Domínios Norteadores e sua Relação com o Planejamento e a Gestão Urbana

A avaliação da percepção dos idosos sobre domínios como "ambiente físico", "transporte", "moradia" e "apoio, saúde e cuidado" (conforme proposto pela EBAPI) são diretamente influenciados pela eficácia do Desenvolvimento Urbano Sustentável.

Assim, a compreensão clara da distinção e intersecção dessas teorias é fundamental para analisar como as políticas e o planejamento urbano se traduzem na experiência de acolhimento dos idosos na cidade do Recife-PE.

Os oito domínios propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para cidades e comunidades amigas das pessoas idosas — espaços exteriores e edifícios; transporte; habitação; participação social; respeito e inclusão social; participação cívica e emprego; comunicação e informação; apoio comunitário e serviços de saúde — constituem uma base fundamental para orientar o planejamento e a gestão urbana comprometidos com o envelhecimento ativo e saudável.

Estes domínios são indissociáveis, pois atuam de forma integrada sobre as condições de vida dos idosos e refletem diretrizes que ultrapassam a mera infraestrutura física, abrangendo dimensões sociais, culturais e relacionais do ambiente urbano. A OMS destaca que “uma cidade ou comunidade amiga das pessoas idosas é um lugar que adapta seus serviços e estruturas físicas para ser mais inclusivo e receptivo às necessidades de sua população para melhorar sua qualidade de vida à medida que

envelhecem... Incentiva o envelhecimento saudável, otimizando recursos para saúde, segurança e inclusão das pessoas idosas na comunidade” (PAHO/OPAS, 2025).

Nespolo (2025) reforça que “a implementação dos domínios propostos pela OMS para cidades amigas dos idosos só é efetiva quando se traduz em práticas urbanas intersectoriais, envolvendo saúde, assistência, transporte, ambiente, cultura e participação, priorizando a escuta dos próprios idosos e o respeito à diversidade de necessidades e desejos. Tais práticas promovem não só qualidade de vida, mas o sentimento de pertencimento e protagonismo social dos idosos.”

As evidências apontam que políticas urbanas de sucesso partem da integração entre setores e da incorporação de ações como: a promoção de acessibilidade universal por meio de calçadas seguras, rampas, transporte adaptado e moradias acessíveis; participação social através da criação e fortalecimento de conselhos municipais e de instâncias de deliberação e controle com a presença ativa dos idosos; disseminação de informações claras e acessíveis sobre direitos, serviços e oportunidades de participação, valorizando mídias inclusivas; e articulação de serviços de saúde, assistência e apoio comunitário, promovendo o cuidado integral e integrado.

Em síntese, internalizar os domínios da OMS nas práticas urbanas brasileiras apresenta-se como caminho fundamental para avançar na construção de cidades verdadeiramente inclusivas, seguras e acolhedoras. Como destaca o Guia Global da OMS (2018; 2024), “a melhoria em um dos domínios impacta positivamente os demais, mostrando que a abordagem integrada é capaz de ampliar os ganhos para a pessoa idosa e para a cidade como um todo.

Instrumentos de Planejamento Urbano e seus Atores

Os instrumentos de planejamento urbano constituem o arcabouço de mecanismos legais e técnicos voltados à organização e ao desenvolvimento equilibrado das cidades. Segundo Villaça (1999), esse processo transcende a técnica, configurando-se como um embate político que busca orientar o uso e a ocupação do solo sob a égide da função social da propriedade e do bem-estar coletivo. No Brasil, o marco regulatório que sustenta essa engenharia é o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que define ferramentas para assegurar o direito à cidade e a gestão democrática, estabelecendo o Plano Diretor como o instrumento básico da política de desenvolvimento municipal.

Conforme Souza (2004), o Plano Diretor deve refletir as diretrizes para o crescimento ordenado, orientando as dimensões físicas, econômicas e sociais. Ele é complementado pelo Zoneamento Urbano, que, ao definir áreas residenciais, comerciais ou de preservação, busca equilibrar os interesses de mercado com as necessidades sociais (Santos, 2013). Nessa engrenagem, o Código de Obras e Edificações e o Código de Posturas Municipais desempenham papéis de micro-regulação essenciais; enquanto o primeiro garante segurança e salubridade às construções, o segundo disciplina a convivência urbana e o uso dos logradouros públicos (Rolnik, 1997).

Todavia, a eficácia desse aparato depende de uma gestão fiscal e jurídica ativa. Instrumentos como a Outorga Onerosa do Direito de Construir e o IPTU Progressivo permitem, como aponta Maricato (2011), que o poder público regule o mercado imobiliário e redistribua os ônus e benefícios da urbanização. Essa complexidade exige uma governança multiescalar e intersetorial, envolvendo desde o Ministério das Cidades em nível federal até as secretarias municipais de Planejamento e Mobilidade (Brasil, 2021). O Estatuto da Cidade prevê que essa gestão seja democrática, por meio de conselhos e audiências, sob a premissa de Lefebvre (2001) de que o Direito à Cidade é um direito coletivo exercido através da participação nas decisões que moldam o espaço.

Entretanto, observa-se que o fortalecimento da governança local e a presença de atores como universidades e movimentos sociais (Harvey, 2012) nem sempre garantem a efetividade das políticas de forma inclusiva. É neste ponto que esta tese fixa sua posição crítica: embora o arcabouço legal brasileiro seja um dos mais robustos do mundo, existe uma lacuna de "legibilidade" e sensibilidade gerontológica nesses instrumentos.

Sob o olhar da pessoa idosa, o planejamento urbano muitas vezes se reduz a um urbanismo da produção, que prioriza a circulação de fluxos e capitais em detrimento do Urbanismo do Cuidado. O hiato identificado nesta pesquisa sugere que a intersetorialidade pregada por Corrêa (2005) — que deveria conciliar economia, inclusão e sustentabilidade — falha ao não considerar o idoso como o "termômetro" da eficácia urbana. Conclui-se, portanto, que a resiliência de uma cidade como o Recife não deve ser medida apenas pela existência formal de Planos Diretores ou Códigos de Postura, mas pela capacidade desses instrumentos de mitigar a pressão ambiental e garantir a autonomia de seus cidadãos mais longevos no cotidiano das ruas.

2.1.2 O Envelhecimento no Contexto do Planejamento e Gestão Urbana: Perspectivas e Desafios

A crescente longevidade populacional impõe ao planejamento e à gestão urbana um desafio complexo e multifacetado: o de conceber cidades que não apenas acomodam, mas ativamente promovem a qualidade de vida e a autonomia das pessoas idosas. Este imperativo transcende a mera adaptação de infraestruturas, exigindo uma reorientação das políticas e instrumentos urbanísticos para a criação de ambientes verdadeiramente inclusivos.

As desigualdades regionais no Brasil, que impactam diretamente a capacidade de resposta do sistema de saúde e resultam em piores desfechos para a pessoa idosa, encontram um cenário concreto na realidade demográfica e socioeconômica das cidades(Melo; Nickel; Pureza, 2025).

No entanto, é crucial aprofundar a análise para além das macro-regiões, reconhecendo as desigualdades intraurbanas que se manifestam drasticamente em grandes centros. Estudos revelam que, mesmo dentro da mesma cidade, a expectativa de vida saudável para idosos pode variar significativamente entre áreas mais ricas e favelas, evidenciando que as condições de moradia, saneamento, segurança e acesso a serviços básicos em nível de bairro são determinantes para a saúde e bem-estar dos idosos (Souza, 2023).

Isso sublinha a necessidade de um planejamento urbano que foque nas micro-regiões e bairros, onde as disparidades são mais agudas.O acesso a serviços de saúde, especialmente para a população idosa, é fortemente condicionado por fatores sociais, econômicos e, de forma crucial, pelo transporte urbano por exemplo.

Em metrópoles brasileiras, observa-se que indivíduos de baixa renda podem ter maior acessibilidade à atenção primária, enquanto a atenção de alta complexidade é substancialmente mais acessível para os de alta renda (Pereira; Silva, 2024).

Essas desigualdades raciais e de renda no acesso à saúde são evidentes e demonstram a urgência do planejamento da mobilidade urbana, de forma a garantir a equidade no acesso a todos os níveis de cuidado, permitindo que os idosos se desloquem com segurança e eficiência para consultas, terapias e atividades sociais (Lima, 2024).

As raízes dessas desigualdades regionais no Brasil, que repercutem no desenvolvimento urbano e na saúde dos idosos, são historicamente profundas. Elas se consolidaram na primeira metade do século XX, com o processo de industrialização e

integração econômica do país, que replicou uma divisão geográfica do trabalho. Isso acentuou as disparidades entre regiões industrializadas e aquelas predominantemente produtoras de matéria-prima, com consequências duradouras para o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida, incluindo a da população idosa (Furtado, 1959; Oliveira, 1977).

Compreender essa gênese histórica é fundamental para desvendar os desafios contemporâneos do planejamento urbano. Em contextos de infraestrutura de saúde limitada, como em algumas áreas rurais ou periféricas de países de baixa e média renda — cenário que encontra paralelos em regiões desfavorecidas do Brasil —, estudos mostram que idosos demonstram resiliência e criatividade ao buscar cuidados, frequentemente utilizando redes de apoio informais e instituições comunitárias (Fernandes, 2023).

Essa observação sugere que as políticas de desenvolvimento urbano e de saúde devem ir além da imposição de soluções padronizadas. É essencial que elas considerem e apoiem as estratégias locais de enfrentamento, valorizando o conhecimento e a capacidade de organização das comunidades e dos próprios idosos. A dificuldade em mitigar as desigualdades regionais e intraurbanas no Brasil, que se reflete no desenvolvimento urbano e na saúde dos idosos, é agravada pela falta de consenso sobre as causas e a essência das ações necessárias.

Em um ambiente político e institucional marcado pela instabilidade, descontinuidade de políticas públicas e fragmentação de esforços, a ausência de cooperação efetiva entre os órgãos governamentais dificulta a formulação de teorias mais sólidas e a implementação de ações articuladas e de longo prazo (Santos, 2024).

Essa fragmentação impede uma abordagem holística e integrada que é indispensável para construir cidades verdadeiramente acolhedoras ao envelhecimento. O planejamento urbano, por meio de seus diversos instrumentos, possui um papel fundamental na promoção de cidades acolhedoras.

O Plano Diretor, enquanto lei municipal que orienta o desenvolvimento e a expansão urbana, deve incorporar diretrizes específicas que considerem as necessidades da população idosa, como zoneamento que favoreça a proximidade entre moradia, serviços e áreas de lazer, e a promoção de usos mistos do solo (Rolnik, 2017).

A legislação urbanística, incluindo códigos de obras e posturas, deve ser revisada para garantir a acessibilidade universal em edificações e espaços públicos, conforme preconizado por normas técnicas como a ABNT NBR 9050 (ABNT, 2015).

Instrumentos de gestão do solo, como o IPTU progressivo no tempo ou as operações urbanas consorciadas, podem ser direcionados para incentivar a requalificação de áreas urbanas, priorizando a criação de infraestruturas e serviços adaptados aos idosos (Maricato, 2001).

A morfologia urbana, ou seja, a forma física da cidade, exerce um impacto significativo na experiência do envelhecimento. Cidades com alta densidade, boa conectividade de transporte público e uma rede de espaços públicos de qualidade tendem a favorecer a mobilidade e a interação social dos idosos (Jacobs, 2011).

O desenho urbano de calçadas amplas e bem conservadas, iluminação adequada, bancos e mobiliário urbano ergonômico, e a presença de áreas verdes acessíveis são elementos cruciais para a segurança, conforto e bem-estar dessa população (Gehl, 2010).

A ausência desses atributos pode gerar barreiras físicas e psicológicas, contribuindo para o isolamento e a exclusão social dos idosos. Críticas ao modelo econômico produtivista, já presentes nesta tese, ressaltam como a priorização do crescimento econômico em detrimento do bem-estar social pode resultar em políticas urbanas que negligenciam as necessidades dos idosos (Escosim, 2021).

Nesse contexto, modelos de desenvolvimento urbano que enfatizam a equidade, a sustentabilidade e a participação cidadã, como o urbanismo tático ou as cidades inteligentes com foco humano, emergem como alternativas promissoras. Tais abordagens buscam criar ambientes mais adaptáveis e responsivos às demandas de diferentes grupos populacionais, incluindo os idosos, promovendo a intersetorialidade e a colaboração entre diversos atores (Sánchez; López, 2015).

A presente pesquisa, ao diagnosticar a percepção dos idosos de Recife-PE sobre o acolhimento urbano, oferece subsídios práticos e valiosos para a qualificação das intervenções urbanísticas e das políticas de planejamento. Ao identificar as fragilidades e as necessidades percebidas por essa população, o estudo contribui para informar a formulação de estratégias que transcendam a mera adaptação, buscando um desenvolvimento urbano que seja intrinsecamente inclusivo e promotor de um envelhecimento ativo e digno para todos os cidadãos.

Para a qualificação da discussão, é imprescindível detalhar a Estrutura Global das Cidades Amigas do Idoso da Organização Mundial da Saúde (OMS), cujos domínios servem como referencial teórico e operacional para a tese, alinhando-se com a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI). Essa abordagem permitirá que o diagnóstico transcenda a análise macro, fornecendo um arcabouço conceitual sólido para a avaliação

da percepção do idoso recifense sobre o acolhimento urbano.

Adicionalmente, a aplicação dos instrumentos de planejamento urbano deve ser analisada criticamente. Embora a ABNT NBR 9050, de 2015, seja um marco legal essencial para a acessibilidade universal, a mera existência da norma não garante sua efetivação. É fundamental incorporar estudos que debatem a eficácia e as limitações da aplicação prática da NBR 9050 no enfrentamento das desigualdades socioespaciais.

Isso permite discutir como a discrepância entre a legislação técnica e a realidade urbana impacta diretamente a mobilidade, a segurança e a autonomia da pessoa idosa no cotidiano, complementando a discussão sobre a morfologia urbana e o mobiliário urbano.

2.2 A PERCEPÇÃO SOBRE A PESSOA IDOSA EM ESPAÇOS URBANOS: HOSTILIDADE VERSUS ACOLHIMENTO

A percepção da pessoa idosa, frisada no estudo, foi abordada priorizando sua importância em relação ao ambiente construído e a maneira com que os idosos se apropriam. A percepção é um processo cognitivo através do qual os indivíduos organizam e interpretam as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu ambiente. O processo envolve a seleção, organização e interpretação de informações sensoriais, permitindo que os seres humanos compreendam e respondam ao mundo ao seu redor. Este processo é influenciado por diversos fatores, incluindo experiências vividas, expectativas, contextos culturais e ambientais, e características individuais (Goldstein, 2014).

Porém, a forma que iremos abordar a percepção, levará em conta os estudos sociais que tratam da referida temática, tendo como foco diagnosticar como as ações públicas que procuram atender demandas sociais, preferencialmente associadas ao envelhecimento ativo no espaço urbano, agregando novos conhecimentos e iniciativas que venham a promover cidades mais acolhedoras que as qualifiquem como “cidades amigas do idoso”.

O conceito de percepção, central nos estudos sociais, comumente procura trazer avaliações como a eficácia de políticas públicas e a qualidade de vida é percebida por grupos específicos da população. No contexto da gerontologia, a percepção dos idosos sobre seu ambiente pode influenciar significativamente seu bem-estar e qualidade de

vida (Joshi, 2015).

De acordo com Vygotsky (2001), esse não é apenas um processo passivo de recebimento de estímulos, mas envolve ativamente a interpretação e a construção de significados a partir das experiências individuais e sociais coletivas.

Gibson (1986), argumenta que a percepção é fundamental para a interação dos indivíduos com o meio ambiente, influenciando suas ações e comportamentos. Como processo cognitivo, envolve a interpretação e a atribuição de significado a estímulos externos (Slimáková, 2019).

Nas pesquisas sociais, aferir a percepção dos indivíduos nos permite compreender suas opiniões, satisfações e necessidades em relação a diferentes aspectos do ambiente vivido (Bardin, 2011). Nestes estudos, ela desempenha um papel crucial no entendimento de como as pessoas experienciam e interpretam suas realidades.

Berger e Luckmann (2004) afirmam que a percepção está intrinsecamente ligada à construção social da realidade, onde os indivíduos constroem suas visões de mundo, com base nas interações socioculturais, representando um elemento chave para análises de diferentes grupos sociais, incluindo os idosos, que vivenciam e avaliam as políticas públicas e os ambientes urbanos.

Assim, a avaliação das políticas públicas está ligada intrinsecamente à percepção dos cidadãos sobre a eficácia e a relevância dessas políticas. Lima (2010) destaca que a percepção dos beneficiários de políticas públicas é um indicador relevante para medir o sucesso e a aceitação dessas políticas.

No contexto do envelhecimento, a percepção dos idosos sobre as políticas públicas voltadas para eles pode revelar tanto os pontos fortes quanto as deficiências dessas iniciativas. No presente estudo, a percepção dos idosos sobre o ambiente urbano e as políticas públicas é crucial para entender suas necessidades e expectativas, que se almejam materializar no espaço urbano vivido.

Neste sentido, Flick (2014) aponta que a percepção dos idosos sobre a acessibilidade, segurança, e serviços urbanos influencia diretamente sua qualidade de vida e bem-estar, o que reforça nossa estratégia utilizando os domínios propostos da EBAPI. Fonseca e Souza (2015), por sua vez, enfatizam que a percepção dos idosos, nos aspectos de segurança e mobilidade urbana, estão diretamente relacionados com a inserção social e sua independência. Assim, avaliar essas percepções pode nos proporcionar conhecimentos valiosos para a formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

2.3 CONCEITOS E IMPLICAÇÕES DA DÉCADA DO ENVELHECIMENTO PARA MELHOR ENTENDER O CONTEXTO DAS CIDADES AMIGAS DA PESSOA IDOSA

O envelhecimento é um processo biológico natural, caracterizado pela progressiva acumulação de alterações moleculares e celulares que resultam em redução gradual da capacidade funcional e maior vulnerabilidade a doenças e à morte, segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2025).

Envelhecer é um processo complexo que afeta as pessoas de diferentes maneiras, dependendo de fatores genéticos, do estilo de vida e das condições ambientais. No âmbito psicológico e social, o envelhecimento envolve mudanças nos papéis sociais, na identidade e nas relações interpessoais. Para a gerontologia, o envelhecimento humano é um fenômeno que deve ser apreendido em nível biopsicossocial (Paúl; Ribeiro, 2012; Fernández-Ballesteros, 2009; Sant'Anna, 2003; Fontaine, 2000; Zimmerman, 2000; McMullin, 2000; Okuma, 1998).

O envelhecimento biológico pode ser caracterizado por uma série de alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo, à medida que as pessoas envelhecem. Essas mudanças incluem a diminuição da capacidade regenerativa dos tecidos, a perda de massa muscular e óssea, a redução da função imunológica e alterações nos sistemas cardiovascular e nervoso. Essa abordagem se apoia em estudos sobre genética do envelhecimento, mecanismos celulares e moleculares, doenças relacionadas à idade (como Alzheimer e osteoporose) e intervenções médicas que podem retardar o processo de envelhecimento ou tratar doenças associadas à idade, ao estilo de vida e às exposições ambientais ao longo da vida (Kirkwood, 2005).

Barbosa et al. (2025) contextualizam o envelhecimento como fenômeno biopsicossocial ao mostrar que o processo de envelhecer não se limita às alterações biológicas do organismo. Os autores identificam, por meio dos discursos de profissionais de saúde, que o envelhecimento resulta de uma interação dinâmica entre fatores biológicos (mudanças fisiológicas e funcionais), psicológicos (emoções, comportamento, adaptação) e sociais (relações familiares, contexto comunitário, acesso a serviços e políticas públicas).

Portanto, o envelhecimento é visto como um processo heterogêneo e multifatorial, em que o bem-estar da pessoa idosa depende da integração dessas diferentes dimensões, reafirmando a complexidade e a particularidade do envelhecer

enquanto fenômeno biopsicossocial (Barbosa et al., 2025).

O envelhecimento é também um fator crucial para o bem-estar global, impactando áreas como trabalho, economia, governo, família e saúde. Por essa razão, líderes mundiais têm priorizado a garantia da saúde e do bem-estar dos idosos, que representam a faixa etária em maior crescimento na atualidade (Fernandes et al., 2025).

Com o envelhecimento das populações, surgem as distinções entre envelhecimento individual e coletivo. O envelhecimento individual resulta de fatores biopsicológicos e do envelhecimento cronológico, e se caracteriza pela maior longevidade dos indivíduos e consequente aumento da esperança média de vida. Segundo Fernández-Ballesteros (2013), apenas 25% do modo como se envelhece é resultado de aspectos genéticos, sendo cerca de 75% influenciados pelo ambiente e por aspectos comportamentais.

Assim, o envelhecimento individual não é um fenômeno aleatório; o indivíduo é um agente ativo na sua determinação. O envelhecimento coletivo, por sua vez, relaciona-se ao envelhecimento demográfico e social, caracterizando-se pelo aumento da proporção de pessoas idosas na população total (Rosa, 2012).

Em 1961, Cumming e Henry deslocam a problemática do envelhecimento do plano individual para o plano do sistema social, ao formularem a teoria da desvinculação. Consideram a desvinculação como uma retirada inevitável e mútua entre a pessoa idosa e a sociedade, e ressaltam que o processo de envelhecimento não é indiferente às características dos sistemas sociais em que é vivenciado.

Do ponto de vista histórico e cultural, a velhice – ou a forma como é percebida – varia de cultura para cultura, de época para época e de lugar para lugar, não existindo uma concepção única ou definitiva, mas concepções incertas, por vezes opostas e variadas ao longo da história (Lemos, 2014).

O processo de envelhecimento é influenciado por uma complexa interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais, além de ser dinâmico e individual. Cada pessoa envelhece de maneira distinta, influenciada por suas experiências de vida, sua genética e seu ambiente. Os fatores de risco e as intervenções eficazes variam ao longo do curso de vida e entre diferentes contextos culturais e socioeconômicos.

Assim, compreender o processo de envelhecimento em sua complexidade é essencial para o desenvolvimento de políticas e práticas que promovam o envelhecimento saudável e ativo. As preocupações com o envelhecimento vão além dos aspectos físicos do meio ambiente e abrangem determinantes econômicos, sociais e

psicológicos, bem como serviços sociais, comunicação, informação, participação social, atividade física, envolvimento cívico, fatores pessoais e educação (Steels, 2015; Kerbler, 2016; Morris, 2011; Scharlach et al., 2014).

Durante o processo de envelhecimento, ocorrem importantes modificações físicas que reduzem a velocidade e a qualidade das funções de órgãos e sistemas corporais, tais como os sistemas musculoesquelético, nervoso, endócrino, cardiovascular e respiratório, de modo que os tecidos vão perdendo flexibilidade e capacidade de recuperação (Santos; Uller, 2013).

O envelhecimento provoca redução progressiva de medidas antropométricas e da força muscular, bem como da função cardiovascular, da flexibilidade articular e da função dos órgãos dos sentidos e da função cerebral, levando em conta sintomas de senilidade e diferenças individuais (Iida, 2005). Esse nível de progressão das perdas de capacidades físicas e do aumento das doenças, denominado senescência, modifica a capacidade de adaptação do indivíduo ao ambiente, ocasionando maior incidência de processos patológicos (Machado, 2007; Netto, 2004).

O processo de envelhecimento, em si, não significa um problema nem para o indivíduo nem para a comunidade; porém, quando as funções começam a deteriorar-se, os problemas tendem a emergir (Kalache, 1987).

Nesse sentido, o envelhecimento é concebido como uma conquista e um desafio de desenvolvimento, cuja implicação central não é a idade em si, mas a forma como a sociedade se organiza – ou deixa de se organizar – para acolher uma população que vive mais tempo (Kalache; Kickbusch, 1997; WHO, 2015).

O envelhecimento psicológico refere-se às mudanças cognitivas e emocionais que ocorrem com o avanço da idade. Essas mudanças podem incluir diminuição da velocidade de processamento cognitivo, dificuldades de memória e maior vulnerabilidade a condições como depressão e ansiedade. No entanto, muitos idosos também demonstram maior resiliência emocional e melhor capacidade de lidar com o estresse, em virtude da vasta experiência de vida acumulada (Baltes, P. B.; Baltes, M. M., 1990).

Em nível psicológico, associam-se ao envelhecimento modificações das atividades intelectuais e motivacionais e, em nível social, mudanças de estatuto decorrentes, por exemplo, da aposentadoria (Paúl, 2005; Fontaine, 2000). Ainda segundo Fontaine (2000), o envelhecimento humano não é um estado, mas um processo de degradação progressiva e diferencial que afeta todos os seres vivos, cujo termo

natural é a morte do organismo.

Dessa forma, é impossível datar com precisão o início do envelhecimento, uma vez que ele varia de indivíduo para indivíduo e depende do nível em que se situa, de sua velocidade e gravidade. Em termos psicológicos, uma das grandes preocupações recai sobre a demência e a perda de autonomia, entendida como a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deseja viver diariamente, de acordo com regras e preferências próprias (Fontaine, 2000).

O envelhecimento social envolve a adaptação a novos papéis sociais e a renegociação das relações interpessoais. A aposentadoria, a viuvez e a mudança de residência são eventos comuns que podem afetar sua integração social.

O suporte social – tanto de familiares quanto de amigos e da comunidade – é fundamental para um envelhecimento bem-sucedido. A teoria da atividade, inicialmente formulada por Vygotsky (1920) e posteriormente ampliada por Leontiev (1972) e Engeström (2002), sugere que a manutenção de atividades e papéis sociais ativos é essencial para o bem-estar dos idosos.

O envelhecimento deve ser visto como uma conquista. Contudo, muitas pessoas não desejam envelhecer e nem tornarem-se dependentes de outras para tomar decisões e desempenhar atividades cotidianas. Pessoas idosas não devem ser vistas como indivíduos inúteis ou que perderam sua utilidade social; ainda que mais vulneráveis, merecem dignidade, amor e respeito (Teixeira, 2002; Lemos; Medeiros, 2014).

Por outro lado, Camarano e Kanso (2013) entendem que as pessoas idosas compõem um grupo populacional que vive a última fase da vida, embora não haja um marco claro para a transição a essa fase. Podem ser considerados elementos definidores os processos biológicos, a aparência física, o surgimento de doenças crônicas, a perda de capacidades físicas e mentais, a perda de papéis sociais, o nascimento de netos, entre outros. Muitos desses processos não possuem delimitação precisa de início, pois são afetados por condições sociais, econômicas, regionais, culturais, étnicas e de gênero.

Essa heterogeneidade é acentuada pela constatação de que esse segmento populacional experimentou trajetórias diferenciadas, que afetam suas condições de vida, fortemente marcadas pelas desigualdades sociais, regionais e raciais em curso no país. As políticas sociais podem reforçar ou atenuar essas desigualdades, bem como criar mitos, estereótipos e preconceitos em relação à população idosa (Camarano; Kanso, 2013).

Mais uma vez, evidencia-se que a organização social determina significados

atribuídos à idade e ao processo de envelhecer. A idade biológica, de acordo com Fraiman (2004), não se confunde com a idade cronológica, pois, para uma mesma idade cronológica, existem diferenças entre as pessoas. A idade biológica considera, por exemplo, trabalhos desgastantes, que fazem as pessoas envelhecerem mais rapidamente. “A audição, a visão, a circulação, todos os nossos órgãos e sistemas amadurecem em estágios distintos da vida” (Fraiman, 2004, p. 15), de modo que o envelhecimento, sob a ótica da idade biológica, ocorre desde o nascimento.

Como destaca Beauvoir (2018), “no plano biológico, a noção de declínio tem um sentido claro”, isto é, o organismo humano começa a declinar quando suas chances de subsistir se reduzem.

A idade social, segundo Fraiman (2004), é determinada por regras e expectativas sociais, pelas quais as pessoas são categorizadas em termos de direitos e deveres, com tarefas a serem desempenhadas ao longo do curso de vida. O autor, destaca que a idade existencial, por sua vez, “a menos levada em consideração para fins sociais, econômicos e administrativos dentro do nosso sistema de política social”, refere-se à “somatória de experiências pessoais e de relacionamentos, da riqueza vivenciada, refletida e acumulada ao longo dos anos”.

A idade cronológica não leva em conta aspectos como existência, personalidade, intelectualidade, produtividade, energia vital, dimensão mental e experiência acumulada. A identidade se modifica a cada instante, razão pela qual “a pessoa é mais do que a simples expressão de suas atuais condições físicas e de saúde” (Fraiman, 2004, p. 15).

As abordagens do envelhecimento referem-se aos diferentes modos de compreender, estudar e responder ao processo de envelhecimento humano. Elas variam amplamente, dependendo do foco da pesquisa ou da intervenção, e abrangem perspectivas biológicas, psicológicas, sociais, econômicas, políticas e interdisciplinares (Bengtson; Gans; Putney; Silverstein, 2008).

A seguir, descrevemos sucintamente algumas das principais abordagens do envelhecimento, que procuram integrar múltiplas perspectivas para uma compreensão holística do fenômeno, reconhecendo-o como complexo e multifacetado.

A) Envelhecimento Bem-Sucedido

A teoria do envelhecimento bem-sucedido, proposta por Rowe e Kahn (1997), destaca três componentes principais: a baixa probabilidade de doença e incapacidade,

um alto nível de funcionamento cognitivo e físico e o envolvimento ativo na vida. Este modelo sugere que o envelhecimento bem-sucedido não é simplesmente a ausência de doenças, mas sim a manutenção de uma vida ativa e significativa.

Desde os anos sessenta, os gerontologistas tentam conceptualizar o termo envelhecimento bem-sucedido, com base nas teorias da gerontologia social (Iwamasa; Iwasaki, 2011; Motta, 2005). Este termo é frequentemente atribuído a Robert J. Havighurst, através de seu artigo publicado na primeira edição da revista *The Gerontologist*, em 1961, sugerindo que: (...) o envelhecimento bem-sucedido pode ser interpretado como uma adesão continuada do indivíduo para atividades e atitudes próprias da meia-idade e na substituição de papéis, perdidos por mudanças associadas com o envelhecimento, a fim de manter um senso positivo de si mesmo. Para Baltes e Carstensen (1996), o conceito de envelhecimento bem-sucedido se refere à capacidade de resistência de pessoas que conseguem alcançar um equilíbrio positivo entre ganhos e perdas durante o envelhecimento.

O estudo desenvolvido pela fundação MacArthur, cujos principais resultados foram sintetizados por Rowe e Kahn na obra “Successful Aging” de 1997, aborda o envelhecimento numa perspectiva de valorização dos aspetos biológicos, psicológicos e sociais, na tentativa de ultrapassar a visão negativa do envelhecimento, centrada em aspetos relacionados a doenças e incapacidades.

Segundo Fonseca (2005), para Rowe e Kahn, o envelhecimento bem-sucedido depende das escolhas e dos comportamentos individuais de cada pessoa, sendo alcançado pela combinação de um desenvolvimento sem patologias, com bom funcionamento cognitivo e físico e uma atitude de compromisso com a vida.

Nos estudos, percebe-se que os dados da literatura sugerem que a experiência do envelhecimento bem-sucedido valoriza a percepção dos próprios idosos, protagonistas de intervenções e dotados de julgamentos sobre bem-estar e qualidade de vida. Mesmo na presença de comorbidades e diminuição da funcionalidade, é possível identificar idosos que referem altos níveis de satisfação e boa qualidade de vida.” (Lima; Silva; Galhardoni, 2025).

A teoria de envelhecimento bem-sucedido de P. Baltes e M. Baltes se baseia em três princípios fundamentais que são utilizados pelo ser humano ao longo do seu curso de desenvolvimento. São os mecanismos de regulação da adaptação do indivíduo ao meio (SOC), seleção, otimização e compensação (Paúl, 2005).

A seleção, segundo Paúl (2005), diz respeito às escolhas que articulam

capacidades individuais e recursos do ambiente. A otimização busca potencializar o desenvolvimento nas áreas selecionadas, enquanto a compensação, mais evidente na velhice, procura suprir déficits decorrentes de declínios biocomportamentais. Em perspectiva transversal, esses três mecanismos são acionados ao longo de todo o ciclo de vida, sustentando o ajuste contínuo entre indivíduo e meio.

Porém o conceito de envelhecimento bem-sucedido não ficou isento de críticas: pois o próprio termo “sucesso”, e suas representações sociais não condizem com uma fase crítica do desenvolvimento humano associada a noções de perda, declínio e aproximação da morte (Tomasini; Alves, 2007).

Segundo Hutchinson (2006, p.7), “a abordagem do envelhecimento bem-sucedido foi criticada por ser demasiada idealista, colocando expectativas irreais sobre os indivíduos na perspectiva dos idosos terem que manter níveis de atividades associadas com a meia-idade sem levar em conta fatores como deficiências, doenças, fragilidades, questões interculturais, obesidade, drogas ou álcool ou uma vida sedentária”. O conceito de envelhecimento bem-sucedido foi assim criticado por fazer generalizações sobre o processo de envelhecimento e homogeneização das pessoas idosas.

Porém, de acordo com Fonseca (2005, p. 287), “autores como Schroots, Fernández Ballesteros e Rudinger reconhecem que a visão salutogénica do modelo de Rowe e Kahn é incontestável”.

B) Envelhecimento Saudável

Para o Instituto Nacional Suéco de Saúde Pública (Swedish National Institute of Public Health - SNIPH), o envelhecimento saudável é: O processo de otimização das oportunidades de saúde física, social e mental de modo a permitir que as pessoas mais velhas possam ter um papel ativo na sociedade, sem discriminação e possam desfrutar de uma boa e independente qualidade de vida (SNIPH, 2006).

Segundo Hansen-Kyle (2005, p. 46), “o envelhecimento saudável centra-se na capacidade do indivíduo continuar a funcionar mental, física, social e economicamente à medida que o corpo diminui seus processos biológicos”. Portanto, para a autora, envelhecer com saúde refere-se a um conceito pessoal cujo planejamento deve ser focalizado na história, nos atributos físicos e nas expectativas individuais, constituindo-se, portanto, numa jornada e não num fim.

A utilização do termo envelhecimento saudável na literatura, segundo Almeida (2007, p.17), parece ser, “muitas vezes limitada ou direcionada para aplicação das

perspetivas de saúde ao envelhecimento”. Para a autora, esta visão de envelhecimento assenta nas seguintes dimensões de saúde: fatores de risco, doenças, condições de saúde e deficiências, perda funcional, incapacidade e morte. Este modelo, ainda segundo a autora, traduz uma visão do envelhecimento como um problema, centrado na doença, na dependência e na morte, sendo pouco promissora para uma compreensão e intervenção abrangentes.

Atualmente, o termo mais utilizado e adequado para designar tal processo, é o do envelhecimento ativo. No final dos anos 90, as políticas da ONU, OMS, OCDE e União Europeia substituíram a expressão envelhecimento saudável por ativo, estando este devidamente caracterizado nos parágrafos supracitados de nossa pesquisa (Oliveira Teixeira; Neri, 2008; Hutchison , 2006; ONU, 2003).

2.4 IMPLICAÇÕES DO ENVELHECIMENTO

2.4.1 Implicações Sociais

Quanto às implicações sociais do envelhecimento é importante considerar que o envelhecimento da população traz consigo diversas implicações sociais que precisam ser compreendidas e abordadas adequadamente. Uma dessas implicações é o etarismo, ou ageísmo, que é o preconceito e a discriminação com base na idade. Assim como o racismo e o sexismo, o etarismo envolve estereótipos negativos e atitudes depreciativas que podem levar à marginalização e exclusão de pessoas devido à sua idade (Butler, 1969).

À medida que a proporção de idosos na população aumenta, há uma necessidade crescente de adaptar as estruturas sociais e comunitárias para acomodar essa mudança demográfica. As famílias, que tradicionalmente fornecem a maior parte do cuidado aos idosos, podem enfrentar pressões adicionais. As relações intergeracionais também são impactadas, com a necessidade de repensar o papel dos idosos na sociedade e promover a inclusão e participação ativa deles em diversas atividades sociais.

Por este motivo, o Estado, em conjunto com as comunidades, deve se organizar na prestação de seus serviços, providenciando segurança, transporte, moradia, inclusão social, informação, apoio comunitário e serviços de saúde, além de outros aspectos importantes para a manutenção de uma vida digna.

Segundo Lima, Silva e Galhardoni (2025), “Mesmo na presença de

comorbidades e diminuição da funcionalidade, é possível identificar idosos que referem altos níveis de satisfação e boa qualidade de vida, principalmente quando contam com estruturas de apoio e integração social.” Esses autores ressaltam que políticas públicas e redes de apoio são essenciais para tornar o envelhecimento mais bem-sucedido no coletivo, especialmente quando as famílias enfrentam limites para fornecer o cuidado integral.

Além disso, Oliveira et al. (2025) destacam que “fatores psicossociais como suporte social e relações interpessoais positivas auxiliam na manutenção da capacidade funcional dos idosos, enquanto o isolamento social pode aumentar o risco de declínio físico e mental.”

A saúde mental dos idosos também emerge como uma variável determinante no processo de envelhecimento saudável, mostrando que transtornos como depressão e ansiedade têm impacto direto na funcionalidade e qualidade de vida.

Em uma perspectiva biopsicossocial, “a construção de ambientes inclusivos e o estímulo à participação ativa dos idosos em diferentes espaços sociais são fundamentais para promover o envelhecimento bem-sucedido. A articulação de políticas públicas que garantam autonomia, segurança, acesso à saúde, cultura e lazer, além de favorecer o diálogo entre as gerações, contribui para a valorização do idoso como agente ativo na sociedade, reduzindo estigmas e fortalecendo o sentimento de pertencimento.” (Barbosa et al., 2025)

Esta abordagem de perceber os idosos como um grupo vulnerável, entretanto, cria uma dependência e, frequentemente, tira do indivíduo e/ou de uma classe de indivíduos, o sentido de autonomia e independência pessoal. Para se manter independência, autonomia e dignidade, os idosos não podem ser somente objeto de compaixão e serviços diferenciados. Ambos, tanto o indivíduo como o grupo de cidadãos idosos, devem ser envolvidos na tomada de decisões que afetam suas próprias vidas e a comunidade em que vivem (Teixeira, 2002; Lemos; Medeiros, 2014).

Os autores Buffel e Phillipson (2016) apontaram que o envelhecimento da população tem previsão de representar dois terços do total da população mundial até o ano de 2030. Isso sugere a ideia de uma nova geração, chamada de 4ª geração, composta por uma parcela de cidadãos idosos que ultrapassam os oitenta anos de vida, fato que resultará em diferentes e específicas necessidades a serem atendidas pelas cidades.

A capacidade de atenção das pessoas idosas é dificultada pela natureza complexa dos assuntos e pelo fato da dificuldade, pelo envelhecimento, do processamento de

estímulos. A memória no processo de envelhecimento é afetada pela diminuição da identificação de novas informações a serem memorizadas, refletindo na dificuldade de relembrar de fatos e acontecimentos. A cognição possui duas características gerais de atenção: atenção seletiva e a capacidade de atenção. Uma é restrita ao foco e ao processo de restrição a alguma informação quando não é importante, e a outra é a capacidade de trabalho mental, sendo que essas, com o processo de envelhecimento, são mais lentas (Salvendy, 2012).

No que se refere às perspectivas históricas e sociais, Beauvoir nos auxilia na historicização da noção de velhice numa sociedade capitalista que constituía mecanismos de proteção social, ainda que timidamente voltadas à sua população idosa. Assim, um dos primeiros desafios para se entender a problemática da velhice é justamente definir a “velhice”, palavra e conceito. Enquanto palavra, não é fácil circunscrevê-la, pois envolve vários fatores, sendo eles biológicos, psicológicos, dentre outros.

Desse modo, “ela tem uma dimensão existencial: modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com sua própria história.” (Beauvoir, 2018, p.13).

A velhice se tornou uma questão para o capitalismo, que vem construindo “soluções” para os problemas da velhice, já que, neste momento da vida, a capacidade de produção de mais-valia por parte dessas pessoas seria limitada. Cada sociedade cria seus próprios valores: é no contexto social que a palavra “declínio” pode adquirir um sentido preciso (Beauvoir, 2018, p.17). Ou seja, para Beauvoir, a discussão a respeito da velhice necessita ser compreendida em sua totalidade e historicidade, pois engloba fatores biológicos, culturais e, para completar, as questões de classe.

Para Fraiman (2004, p.14), em consonância com a visão de Beauvoir, velhice e envelhecimento são termos distintos que merecem atenção ao serem mencionados, sendo o velho aquele que tem muitos anos de vida e uma grande experiência acumulada, sendo que o envelhecer “não é somente um ‘momento’ na vida de um indivíduo, mas um ‘processo’ extremamente complexo e pouco conhecido, com implicações tanto para quem o vivencia, como para a sociedade que o suporta ou assiste a ele”.

Envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais no indivíduo, cujas alterações são naturais ou gradativas. Sendo assim, “é importante salientar que essas transformações são gerais, podendo se verificar em idade mais precoce ou mais avançada e em maior ou menor grau, de acordo com as características genéticas de cada

indivíduo e, principalmente, com o modo de vida de cada um.” (Zimerman, 2000, p.21).

De acordo com Debert (1999), um novo ideal de produtividade emerge de um conjunto de orientações que ensinam, àqueles que não querem se sentir velhos, como conduzir suas vidas e participar de atividades preventivas.

Dessa forma, os que não se encaixam nesse paradigma são considerados problemáticos e necessitam de motivação. Para resolver problemas relacionados à velhice, agências estatais e organizações privadas elegeram programas para a terceira idade, que seguem uma lógica do produtivismo e sua "política de vigilância", uma ação racional para reduzir os custos de manutenção dos idosos.

Entretanto, as pesquisas interessadas em analisar os significados desses programas revelam experiências positivas para os participantes, uma vez que os programas são apresentados como uma oportunidade de ampliação do círculo social de amizade e de criação de novos espaços para a ação, configurando uma nova qualidade de vida para os indivíduos envolvidos.

As imagens desses programas são amplamente divulgadas pela mídia, que projeta idosos mais felizes e realizados, contribuindo positivamente para o humor e a saúde física e mental. Embora visem proporcionar um envelhecimento mais saudável e feliz, não são o fator principal para uma vida mais longa e melhor. Esses programas geralmente atraem idosos ainda ativos, embora o envelhecimento seja caracterizado pela "perda progressiva da eficiência funcional" (Zimerman, 2000, p.35).

O envelhecimento também impulsiona o mercado de consumo, e as revistas retratam essa fase de maneira positiva, evitando associações com abandono ou desdém. As revistas tratam de criar um novo ator, definindo um novo mercado de consumo em que a promessa da eterna juventude é o subtexto através do qual um novo vestuário, novas formas de lazer e de relação com o corpo, com a família e com amigos são oferecidos. Nestas imagens, não há espaço para doença, decadência física ou dependência. O mercado de consumo busca "definir a última etapa da vida, trata-se de impor estilos de vida, criando uma série de regras de comportamento e de consumo de bens específicos, que indicam como aqueles que não se sentem velhos devem proceder". Assim, a velhice tende a ser vista como "consequência do descuido pessoal, da falta de envolvimento em atividades motivadoras, da adoção de formas de consumo e estilos de vida inadequados" (Debert, 1999, p.213).

Por isto, a necessidade de se compreender o envelhecimento populacional através de uma abordagem multifacetada que inclui a adaptação das estruturas sociais,

a promoção da autonomia e inclusão dos idosos, em uma análise crítica que leve em consideração as influências do mercado de consumo e dos estereótipos midiáticos.

2.4.2 Implicações Econômicas

Para Lemos (2014), percebe-se que ocorrem ciclos ao longo da história, relacionados à valorização seguidos por desvalorização da pessoa idosa e isso pode estar relacionado a diversos fatores. Do ponto de vista econômico, o envelhecimento tem significativas implicações e à medida que a população envelhece, aumentam as demandas por serviços de saúde, cuidados de longo prazo e apoio social, o que pode pressionar os orçamentos públicos e privados. A sustentabilidade dos sistemas de previdência e a necessidade de adaptação do mercado de trabalho são desafios que exigem atenção para este segmento da população.

Como percebe Lima (2001), “a velhice, vista como representação coletiva, tem passado por mudanças significativas no que se refere ao estilo de vida adotado pelos idosos, que ao invés de ficarem isolados, estão a sair em busca do lazer e prazer, em diversas escalas”. Uma parcela economicamente ativa da população idosa está impulsionando mercados diversos, a exemplo do turismo e serviços especializados para o seguimento (OMS, 2005). Para o autor, esse movimento emerge com uma força ainda desconhecida por aqueles que o vivenciam, tirando os rótulos e contestando os mitos.

Segundo Walker (1997), o envelhecimento ativo tem promovido a manutenção da produtividade e a inclusão dos trabalhadores idosos no local de trabalho, através de políticas de flexibilização de horários e programas de requalificação profissional.

Após duas décadas de seu estudo sobre a inclusão de trabalhadores idosos, Walker (2018), ao abordar o envelhecimento ativo no contexto do trabalho, afirma:

“O envelhecimento ativo no emprego envolve possibilitar que as pessoas permaneçam mais tempo em atividade, não apenas elevando as idades mínimas de aposentadoria, mas tornando o trabalho mais atraente e acessível para trabalhadores mais velhos, melhorando a saúde e reduzindo a discriminação por idade. O envelhecimento ativo diz respeito à otimização de oportunidades para saúde, participação e segurança, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem” (Walker, 2018, p. 38).

De acordo com Wagnild e Young (1993), estratégias que promovem a resiliência, como o fortalecimento dos laços sociais e o incentivo à participação ativa em atividades comunitárias e econômicas, são essenciais para o bem-estar dos idosos, e

quando associadas a um sistema de aposentadoria robusto e adaptável, segundo Barr (2001), é fundamental para garantir a segurança financeira dos idosos nesta fase da vida.

Fatores tais como o apoio social, a integração comunitária e o acesso a oportunidades de participação são determinantes para a resiliência durante o envelhecimento. Além disso, as políticas de proteção social e sistemas de previdência flexíveis contribuem decisivamente para o sentimento de segurança e autonomia financeira na velhice. A conjugação dessas estratégias potencializam não apenas a resiliência individual, mas também o envelhecimento ativo e saudável da população idosa” (Fonseca; Magalhães; Neri, 2023).

2.4.3 Implicações do Urbano

As cidades têm um papel crucial na promoção do envelhecimento, podendo o ambiente urbano influenciar significativamente a qualidade de vida dos idosos, afetando sua mobilidade, acesso a serviços e interação social. Martins et al. (2025) analisam que “o envelhecimento populacional é um tema primordial nas sociedades contemporâneas e reflete avanços nas políticas de urbanização. A construção de cidades mais inclusivas exige ações governamentais que considerem a mobilidade, acessibilidade e a integração social dos idosos como prioridades, promovendo espaços urbanos mais acolhedores e seguros.”

As políticas públicas desempenham um papel crucial na adaptação das cidades para uma população envelhecida. Isso inclui também a implementação do desenho urbano, de leis e regulamentos que promovam a acessibilidade e a inclusão, bem como o desenvolvimento de programas e serviços que apoiem os idosos. Segundo Phillipson (2011), a integração de políticas de envelhecimento no planejamento urbano pode ajudar a criar ambientes mais amigáveis e sustentáveis para todos.

Segundo Hough (2004), políticas urbanas que promovem a acessibilidade e materiais adequados, são essenciais para garantir que os idosos possam se mover livremente e com segurança, como exemplo temos calçadas largas e bem iluminadas, rampas de acesso e transporte público adaptado.

Os princípios do desenho urbano inclusivo envolvem a criação de ambientes que sejam acessíveis, utilizáveis e agradáveis para todos os usuários, levando em consideração aspectos como: ergonomia, segurança e conforto, que segundo Gehl (2013), para se promover um espaço urbano que seja funcional e acolhedor, o foco das

ações deve ser canalizado para as pessoas e nas suas interações.

A criação de espaços verdes, áreas de lazer e pontos de encontro comunitários podem promover um ambiente mais inclusivo e saudável para os idosos e toda a população. Jacobs (1961) já destacava a importância de espaços públicos vibrantes e acessíveis para fomentar a coesão social e a interação comunitária.

Para adaptar as cidades a uma população envelhecida, é necessário um planejamento urbano que considere a acessibilidade, a segurança e a inclusão. Isto envolve desde a modificação de edifícios e espaços públicos para serem mais acessíveis, até a implementação de programas de transporte que atendam às necessidades dos idosos. As cidades devem ser projetadas com um enfoque centrado no usuário, considerando as necessidades dos idosos em todas as etapas do planejamento (OMS, 2007).

Existem várias boas práticas de políticas urbanas que foram implementadas com sucesso em diferentes partes do mundo. Estas práticas demonstram como as cidades podem se tornar mais inclusivas e sustentáveis, atendendo às necessidades de suas populações idosas, entendendo que cada cultura e localidade tem sua especificidade.

O processo de urbanização tem proporcionado oportunidades de melhoria de vida e tem contribuído para os esforços de erradicação da pobreza no mundo, dependendo do contexto e das políticas que são implementadas. A urbanização, tem potencial de proporcionar melhorias na qualidade de vida e na economia, mas também pode exacerbar desigualdades se não for acompanhada por políticas adequadas. Glaeser (2011), argumenta que as cidades são motores de inovação e crescimento econômico. A concentração de pessoas em áreas urbanas facilita a troca de ideias e a inovação, o que pode levar a oportunidades de emprego e melhorias na qualidade de vida. O autor ainda traz que "as cidades são nossos maiores inventos" e que a urbanização tem contribuído para o aumento da produtividade e do crescimento econômico global.

No entanto, Davis (2006) adverte que a urbanização descontrolada pode levar ao crescimento de favelas e ao aumento das desigualdades. Em "Planet of Slums", Davis argumenta que a rápida urbanização em muitos países em desenvolvimento tem resultado em um aumento da pobreza urbana, com milhões de pessoas vivendo em condições precárias sem acesso a serviços básicos.

A urbanização tem aumentado a pressão sobre a base de recursos naturais, com aumento na demanda por energia, água e saneamento, bem como para os serviços públicos, educação e cuidados de saúde. Em 2007, mais de metade da população

mundial passou a viver em centros urbanos e estima-se que esta proporção ultrapassará os 70% até 2050. Além disso, 80% da população urbana mundial viverá em regiões em desenvolvimento, especialmente em cidades da África e da Ásia (UN, 2013).

As cidades aumentam as possibilidades de desenvolvimento econômico, inovação e interação social. São o centro da atividade cultural, social e política e, para poderem ser sustentáveis, têm de providenciar estruturas e serviços que permitam o bem-estar e a produtividade dos seus habitantes (OMS, 2009).

Dada a diversidade de realidades urbanas em todo o mundo, não há um padrão mundial que define uma cidade, pois cada país define cidade de acordo com seus próprios critérios. Também deve-se notar que as lacunas nas questões relacionadas com a disponibilidade de dados urbanos limitam a precisão das projeções e comparações internacionais de níveis de urbanização e tamanhos das populações das cidades (UN, 2013, p.54).

Para as Nações Unidas (UN, 2013), a dicotomia “urbano/rural” tradicional tornou-se cada vez mais inadequada para a distinção entre assentamentos urbanos e rurais. O aumento do comércio, a mobilidade do trabalho e a inovação em comunicações espalharam funções urbanas e influência sobre amplas áreas geográficas, incluindo as rurais. Segundo Haub (2009), há uma grande diferença em como as populações experimentam as diferenças “urbano/rural”.

Nas nações em desenvolvimento, as disparidades urbanas são acentuadas: expressivas parcelas da população residem em assentamentos informais marcados pela precariedade infraestrutural, com acesso restrito a redes de transporte, saneamento básico, água potável e energia elétrica. Em contraste, nos países desenvolvidos, observa-se uma maior homogeneidade territorial, onde as populações rurais frequentemente usufruem de níveis de acessibilidade, serviços e comodidades equivalentes aos dos grandes centros urbanos.

A premissa subjacente ao conceito de “Cidade Amiga do Idoso” é a de que uma cidade amiga dos idosos não é simplesmente amiga das pessoas mais velhas, mas de todos, principalmente os grupos mais vulneráveis. Uma vizinhança segura permite que crianças, mulheres e idosos se sintam confiantes para sair à rua e participar em atividades sociais e de lazer. Toda a comunidade se beneficia da participação de pessoas mais velhas em trabalho voluntário ou remunerado. Por último, a economia local lucra com a clientela constituída pelos consumidores adultos mais velhos (OMS, 2009, p. 10).

Os dois últimos tópicos, comunicação e informação, e apoio comunitário e

serviços de saúde, englobam ambientes sociais e determinantes de saúde e serviços sociais.

O diagnóstico e a monitoração das ações devem ser feitos a partir do desenvolvimento de indicadores baseados no conceito de envelhecimento ativo. Para Buffel (2014), as cidades precisam de uma estratégia mais integrada na operacionalização do conceito “Age-friendly”. Para os autores, uma solução seria tornar o conceito “Age-friendly” como parte central da formulação de políticas para a promoção do desenvolvimento urbano sustentável em suas dimensões ambientais, sociais e econômicas.

Outros aspetos críticos incluem a segurança financeira, bem como um ambiente social caracterizado por oportunidades para se manter ativo por meio de redes sociais informais e organizações formais de apoio. Alley et al. (2007, p. 4) descrevem que uma comunidade amiga do idoso é aquela em que “os idosos estão ativamente envolvidos, valorizados e apoiados com infraestrutura e serviços que efetivamente atendem às suas necessidades.”

Segundo Buffel (2012), embora as cidades sejam cada vez mais vistas como fatores chave de sucesso econômico e cultural de uma nação, ela é planejada, muitas vezes, em detrimento dos que estão fora do mercado de trabalho, especialmente aqueles com baixo nível socioeconômico. Alcançar o reconhecimento das necessidades de diferentes gerações dentro das cidades e explorar o potencial da cidade para grupos de todas as idades será um dos desafios centrais para o processo de tornar as cidades mais amigas dos idosos.

2.5 AS ESTRATÉGIAS GLOBAIS PARA O ATENDIMENTO AOS LONGEVOS

Desde o final do século passado que o envelhecimento populacional acentuado, resultado da redução das taxas de fecundidade e do aumento da expectativa de vida em escala mundial, tem trazido diversas reflexões e demandado ações para melhorar a organização das cidades com vistas ao atendimento das necessidades das pessoas idosas.

Em conjunto com o processo acelerado de urbanização global, tem impulsionado políticas e iniciativas voltadas para a criação de cidades mais inclusivas e sensíveis às demandas desse grupo. Cidades amigas do idoso ampliam o acesso a serviços, incentivam a participação social e promovem o bem-estar dos mais velhos, tornando-se

referência na busca por qualidade de vida na velhice” (Plouffe & Kalache, 2024).

Santos & Cavalcante (2025), também reforçam que o avanço da urbanização evidencia a urgência de reconfigurar os espaços urbanos para garantir inclusão, acessibilidade e promoção da cidadania a idosos.

No entanto, esta preocupação não é de agora. Nasce como consequência do movimento de promoção da saúde, denominado “Nova Saúde Pública”, que gerou a proposta das “Cidades Saudáveis”. Seu início se deu com o Relatório Lalonde (1974) e sua formalização com a Carta de Ottawa em 1986 (Organização Mundial de Saúde, 1986). O Canadá foi o primeiro país a utilizar a estratégia das Cidades Saudáveis e modelo em sua difusão. Uma Cidade Saudável é aquela que articula um grande conjunto atores sociais, ou seja, governo, partidos políticos, instituições públicas e privadas, sindicatos, associações, ONGs, famílias e indivíduos, objetivando a orientação de suas ações direcionadas à produção coletiva da saúde, visando à construção de uma rede de solidariedade com o objetivo comum de otimizar a qualidade de vida da população da cidade (Organização Mundial de Saúde, 1986).

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em 1986, foi um marco inicial na promoção da saúde como um processo intersetorial. A Carta de Ottawa estabeleceu que a promoção da saúde deve ser entendida como uma responsabilidade compartilhada entre todos os setores da sociedade, não se limitando ao setor da saúde, destacando a necessidade de se criar ambientes que a promovam juntamente com bem-estar para todos os cidadãos, incluindo os idosos.

Posteriormente, em 1991, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a iniciativa “Cidades Saudáveis”, que visava criar ambientes urbanos que promovessem a saúde e o bem-estar de seus habitantes, sendo essa iniciativa essencial para incentivar as cidades a desenvolverem políticas e programas que favorecessem a saúde da população, incluindo a adaptação de espaços urbanos para atender as demandas específicas das pessoas idosas.

Quase uma década depois, em 1999, a OMS introduziu o conceito de “Envelhecimento Ativo”, trazendo a necessidade de se otimizar as oportunidades de saúde, participação e segurança para melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Essa iniciativa destacou a importância de promover a inclusão social e a participação ativa dos idosos na sociedade, visando não apenas a longevidade, mas também a melhoria de sua qualidade de vida no ambiente em que o idoso está

inserido. Segundo a OMS (2002), o envelhecimento ativo surge na sequência do envelhecimento saudável estendendo-se para além da saúde, com a pretensão de ser mais abrangente, ou seja, englobando os aspectos socioeconômicos, psicológicos e ambientais, integrados num modelo multidimensional que se aplica aos resultados do envelhecimento.

A Constituição Federal de 1988 garante os direitos sociais e a saúde dos idosos no Brasil, conforme o Artigo 230, que responsabiliza a família, a sociedade e o Estado. O Artigo 194 institui a Seguridade Social, abrangendo saúde, previdência e assistência social. Os Artigos 196 a 200 detalham a saúde como direito universal e dever do Estado, com o Sistema Único de Saúde (SUS) garantindo atendimento integral e sem discriminação para a população idosa. (Brasil, 1988)

Com a implementação desses fatores determinantes, para novos estudos e desenvolvimento de medidas que viessem a promover o envelhecimento, os indivíduos passaram a ter um maior conhecimento sobre os benefícios de atitudes e comportamentos que melhoram sua autonomia, independência e expectativa de vida, tal como sua qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida incorpora a saúde física, o estado psicológico, o nível de dependência, as relações sociais, as crenças pessoais e as características do ambiente em que a pessoa se encontra inserida, reconhecendo a importância dos direitos humanos dos indivíduos idosos e dos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização. (Fleck, 1998; OMS, 2002).

Neste sentido, cabe ao Estado a garantia do acesso às oportunidades de melhoria das condições de vida das pessoas em processo de envelhecimento, em particular pela implementação de políticas sociais que promovam o envelhecimento ativo, nomeadamente aqueles relacionados com os determinantes: econômicos, ambientais, sociais e de saúde.

Na sequência, em 2002, decorreu em Madrid a segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o envelhecimento, em que se elaborou um Plano de Ação Internacional sobre o envelhecimento. Esta Assembleia Mundial alertou os diversos países envolvidos para uma poupança orçamental significativa, ao promover o envelhecimento ativo e os estilos de vida saudáveis, tais como: os cuidados de saúde ao longo da vida e as medidas preventivas que ajudam a manter baixos os níveis de incapacidade relacionados à senilidade. Nas orientações prioritárias do plano para a “promoção da saúde e bem-estar”, reconhece-se a necessidade de medidas especiais nas

seguintes áreas: acesso aos cuidados de saúde e a eliminação das desigualdades, a prestação de cuidados de saúde primários, a formação de profissionais de saúde, a formação e o desenvolvimento da saúde ao longo da vida, a autorrealização e a atualização (OMS, 2002).

Finalmente, em 2005, na sessão inaugural do XVIII Congresso da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria (AIGG) que ocorreu no Rio de Janeiro, Brasil, a OMS lançou o projeto global “Cidades Amigas dos Idosos”, desenvolvido por Alexandre Kalache e Louise Plouffe da sede da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Genebra, Suíça (OMS, 2008; Plouffe; Kalache, 2010).

O protocolo de investigação foi implementado em 33 cidades de todo o mundo, com a participação de entidades governamentais, não-governamentais e grupos académicos. Com este trabalho de pesquisa surge o Guia das Cidades Amigas do Idoso da OMS. Esta iniciativa visava adaptar as estruturas e serviços urbanos para torná-los mais adequados às pessoas idosas, pela implementação de políticas e programas que promovessem a inclusão e a qualidade de vida dos idosos.

A publicação do "Guia Global: Cidade Amiga do Idoso" em 2006, ofereceu diretrizes práticas para ajudar as cidades a se tornarem mais acolhedoras para os idosos, facilitando que outras regiões aderissem a essa iniciativa, a exemplo da Europa, que lançou a iniciativa de Cidades Amigáveis da União Europeia em 2007.

O guia global, em suas diretrizes práticas, identifica 08 áreas da vida urbana reconhecidas como sendo fundamentais para o bem-estar dos idosos. Essa identificação permitiu a elaboração de uma lista de verificações das diversas lacunas, fragilidades e potencialidades existentes nas cidades, assim como espaço para sugestões de melhoria, já que cada região possui suas peculiaridades. As áreas estão divididas em:

1. Áreas de circulação e prédios públicos;
2. Transporte;
3. Moradia;
4. Participação social;
5. Respeito e inclusão social;
6. Participação cívica e emprego;
7. Informação e comunicação;
8. Apoio comunitário.



Através de uma lista de verificação de características amigas dos idosos, permite-se às cidades procederem à sua autoavaliação e registarem os progressos

efetuados, permitindo aplicar-se de igual modo a cidades menos ou mais desenvolvidas.

Através da comparação com outras cidades podem-se encontrar características existentes de uma cidade amiga do idoso, que possam ser adotadas e dependendo dos casos, adaptadas à cidade em estudo. No entanto, é importante realçar que cada cidade possui a sua história e as suas próprias características ambientais, como afirma o Guia das Cidades Amigas da Pessoa Idosa “nenhuma cidade preenche todos os requisitos em todas as áreas” (OMS, 2007).

Segundo o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento (ONU, 2003, p.29) são necessárias mudanças das atitudes, das políticas e das práticas em todos os níveis e setores, para que possam se concretizar o envelhecer com segurança e dignidade e que os idosos possam continuar participando em suas respectivas sociedades como cidadãos com plenos direitos.

Espera-se em uma cidade amiga do idoso, que suas políticas públicas, serviços, ambientes e estruturas, devam dar apoio e capacitar as pessoas a envelhecer ativamente ao reconhecer a ampla gama de capacidades e recursos neste segmento populacional; prever e responder, de maneira flexível, às necessidades e preferências relacionadas ao envelhecimento; respeitar as decisões dos idosos e o estilo de vida que escolheram; proteger aqueles que são mais vulneráveis e promover a sua inclusão e contribuição a todas as áreas da vida comunitária (OMS, 2008).

A efetivação do envelhecimento ativo e amigável, possibilita a criação de espaços públicos inclusivos e acessíveis, que são oriundos de um planejamento urbano capaz de materializar no espaço as necessidades e capacidades diversas dos mais velhos, o objetivo central das cidades acolhedoras ao envelhecimento (Silva, 2019).

Todos esses fatores, individualmente e combinados uns com os outros, exercem um papel importante sobre o envelhecimento de cada indivíduo. Muitos aspectos do ambiente urbano e dos serviços refletem esses determinantes e fazem parte das características de uma cidade amiga do idoso.

O conceito de Cidade Amiga do Idoso tem alinhamento com as perspectivas da Atenção Primária em Saúde (APS), expressas pela Organização Pan-Americana de Saúde que considera que a APS deve ser parte integral do desenvolvimento dos sistemas de saúde, apontando a necessidade de se estabelecer um marco conceitual sustentado por valores que oferecem uma base moral para as políticas e programas (direito à saúde, equidade, solidariedade). Estes princípios que servem de ponte entre os valores e os elementos estruturais e funcionais do sistema de saúde (OPAS, 2008).

Os países podem custear o envelhecimento se os governos, as organizações internacionais e a sociedade civil implementarem políticas e programas de “envelhecimento ativo” que melhorem a saúde, a participação e a segurança dos cidadãos mais velhos. Assim, o termo “envelhecimento ativo” soma, na sua especificidade, uma política e programas que busca eliminar a discriminação de idade, reconhecer a diversidade das populações idosas (OMS, 2007; Baptista, 2012).

Elencamos abaixo, os principais marcos históricos internacionais que tangem as principais ações e estratégias desenvolvidas no âmbito das cidades amigas das pessoas idosas e do desenvolvimento urbano sustentável, ambos abordados neste estudo.

Quadro 4 - Marcos históricos internacionais que favoreceram as estratégias no âmbito das cidades amigas das pessoas idosas e do desenvolvimento urbano sustentável				
Data	Local	Autor/Organização	Evento/Ação	Produção/Resultado
1986	Ottawa, Canadá	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde	Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde, que estabelece a promoção da saúde como um processo intersectorial.
1991	Global	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Lançamento da iniciativa "Cidades Saudáveis"	Criação de ambientes urbanos que promovam a saúde e o bem-estar.
1999	Global	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Introdução do conceito de "Envelhecimento Ativo"	Definição do envelhecimento ativo como a otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança.
2002	Madrid, Espanha	Nações Unidas	Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento	Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento.
2005	Global	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Criação da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigáveis às Pessoas Idosas	Adaptação das estruturas e serviços urbanos às necessidades dos idosos.
2006	Global	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Publicação do "Guia Global: Cidade Amiga do Idoso"	Estrutura para ajudar cidades a se tornarem mais amigáveis às pessoas idosas.
2007	União Europeia	União Europeia	Iniciativa de Cidades Amigáveis da União Europeia	Implementação de políticas para tornar cidades mais amigáveis para idosos.
2010	Rio de Janeiro, Brasil	Nações Unidas	Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)	Declaração do Rio sobre o Desenvolvimento Sustentável.

2013	Global	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Plano de Ação Global para a Prevenção e Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2013-2020	Metas específicas para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas idosas.
2015	Global	Nações Unidas	Adoção da Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	ODS 11: "Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis."
2016	Quito, Equador	Nações Unidas	Conferência das Nações Unidas sobre Habitação/ Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III)	Nova Agenda Urbana para o desenvolvimento urbano sustentável para os próximos 20 anos.
2017	Vancouver, Canadá	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Declaração de Vancouver sobre o Envelhecimento Ativo	Reafirmação da importância do envelhecimento ativo e saudável.
2018	Estados Unidos	American Association of Retired Persons (AARP)	Iniciativa de Cidades Amigas dos Idosos	Apoio às comunidades americanas na adaptação aos desafios do envelhecimento populacional.
2020	Global	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030	Foco global em melhorar a vida dos idosos em quatro áreas de ação: como se pensa o envelhecer; comunidades amigas; cuidados integrados a saúde a assistência social; e apoio a pesquisa e a coleta de dados nesta temática
2021	Lisboa, Portugal	Conferência Internacional	Declaração de Lisboa sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis e Resilientes	Compromisso com a implementação de estratégias que promovam cidades mais sustentáveis e resilientes.
2023	2023	São Paulo, Brasil	Organização Mundial da Saúde (OMS)	Certificação da cidade como Cidade Amiga do Idoso
2025	2025	São Paulo, Brasil	Longevidade Expo + Fórum / OMS / OPAS	1ª Conferência Internacional Cidades Amigas do Idoso

2025	2025	Portugal (Lisboa)	Conferência Internacional	Continuidade da Declaração de Lisboa
2025	2025	Global	OMS / OPAS	3º Congresso Mundial de Cidades e Comunidades Amigas dos Idosos
2025	2025	Global	Nações Unidas	Circuito Urbano 2025

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Sobre aspectos ligados à vivência do idoso no ambiente urbano, a participação ativa de indivíduos e das diversas comunidades, será determinante para o sucesso e o fracasso dessas ações que estão sendo desenvolvidas (Bodstein, 2009).

2.6 O ENVELHECIMENTO NO BRASIL: MARCOS LEGAIS, POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO AO ETARISMO

Durante a contemporaneidade, dois fatores foram essenciais para o reconhecimento dos idosos como um grupo social: o surgimento de disciplinas que estudam o corpo senil e a criação das pensões e aposentadorias (Dardengo, Mafra, 2018).

A Gerontologia, por exemplo, segundo Monteiro e Silva (2020) surge em meio a esse contexto de acelerado envelhecimento populacional e da necessidade de valorização da qualidade de vida relacionada à longevidade. Tal disciplina é uma ciência multi e interdisciplinar que pesquisa o processo de envelhecimento em diversos aspectos para melhor compreender as demandas, características desta fase da vida, tendo como base os conhecimentos das ciências humanas, biológicas e exatas (Papaléo-Netto, 2016).

No Brasil, como em outros países em desenvolvimento, o aumento da expectativa de vida tem sido evidenciado pelos avanços tecnológicos relacionados à área da saúde nos últimos 60 anos, que tornaram possível a prevenção e a cura de muitas doenças (Mendes; Gusmão; Faro; Leite, 2005).

Uma das grandes dificuldades encontradas na formulação de políticas públicas mais efetivas, é a necessidade de se adequar as estratégias criadas às condições de vulnerabilidades socioeconômicas e aos problemas relacionados às questões

biopsicossociais que esta fase da vida ocasiona, para maioria das pessoas nessa faixa etária (Geib, 2012; Camarano & Kanso, 2011).

Com relação às fragilidades socioeconômicas dos idosos, compreende-se que existe uma privação de grupos populacionais aos benefícios e direitos que deveriam ser comuns e isonômicos à toda a sociedade (Aith; Scalco, 2015).

Ainda sobre essa questão, dados mostram que a população de sessenta anos ou mais, em sua vasta maioria são dependentes das políticas públicas de assistência, saúde e previdência social para sua sobrevivência. O Sistema da Seguridade Social, estabelecido nos artigos 194 e seguintes da Constituição Federal de 1988, é responsável por garantir o acesso universal à saúde e à assistência social aos cidadãos socialmente vulneráveis. Estima-se que 80% dos idosos do Brasil vivem com um salário-mínimo, provenientes de suas aposentadorias, pensões ou do benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social conjugado na lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde dão conta de que 70% dos idosos brasileiros possuem alguma doença crônica. Além disso, a proporção de pessoas com 60 anos de idade ou mais que dependem exclusivamente dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, representa 75,3% deste contingente etário (Valêncio; Oliveira, 2020). Nesse aspecto, o comprometimento social tem importante representatividade no envelhecimento saudável minimizando as alterações decorrentes do processo de envelhecimento, caracterizando uma longevidade socialmente ativa e saudável (Gorjas, 2011).

Portanto, essa busca por qualidade de vida do idoso é muito bem sintetizada no trabalho de Carvalho (2011) que nos reforça o fato de que envelhecer é migrar para uma nova etapa da vida, que deve ser encarada de forma natural, positiva, saudável e proativa. A velhice não deve ser encarada como uma doença, mas sim uma fase na qual o ser humano fica mais suscetível a doenças (Zimerman, 2000).

Tal cenário exige garantias que preservem os direitos dessa população em ascensão demográfica, mesmo com o Brasil tendo avançado em sua legislação, no que tange os cuidados à população idosa, assegurando seus direitos sociais em prol da autonomia, integração e participação efetiva do idoso na sociedade (Resende, 2018).

Ao considerar que a idade avançada é responsável por um aumento de limitações que podem ser mitigadas com o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas e universais, percebe-se que estas só poderão ser implementadas se condizentes com as necessidades do público em ênfase (Amanajás; Klug, 2016, p. 36).

O envelhecimento ativo está pautado na participação ativa público idoso, que envolve sua atuação em diversos cenários que compõe o lugar onde vive, perpassando por atividades culturais, recreativas, políticas, religiosas etc., que despertam o sentimento de realização e sentido de pertencimento impactando os vínculos afetivos e sentido de pertencimento (Resende; da Costa; Manso, 2018).

A prestação de assistência específica à pessoa idosa, no Brasil, iniciou-se com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS no ano de 1975, o qual contemplava questões pertinentes à saúde, renda e a prevenção do asilamento das pessoas idosas. Em 1976 foi instituído o primeiro documento que determinava normativas para a política social voltada para a população idosa, este documento foi denominado “Diretrizes para uma Política Nacional para a Terceira idade” (Brasil, 1988).

Em 1982, a I Assembleia Mundial sobre Envelhecimento realizada em Viena, Áustria, promovida pela ONU, propôs iniciar um programa internacional de ação que visasse garantir a segurança econômica e social das pessoas de idade e que oportunizassem a contribuição destas para o desenvolvimento de seus países, propondo a utilização do conceito de envelhecimento saudável.

Os marcos legais na área do envelhecimento brasileiro foram constituídos a partir do final da década de 1980 e já apresentavam a incorporação do referido conceito, no caso, a Constituição Federal (CF) de 1988; a Política Nacional do Idoso de 1994 (regulamentada somente em 1996); e posteriormente o Estatuto do Idoso de 2003 (Lei 10.741), que já mostrava uma maior intenção de se regular e garantir os direitos assegurados para às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos (Brasil, 2003). O Estatuto assegura ao idoso todas as possibilidades que lhes garantam condições de liberdade e dignidade, sendo obrigação da família, poder público, comunidade e sociedade proporcionar-lhes oportunidades de aperfeiçoamento na educação, momentos de lazer, convivência familiar e comunitária como efetivação dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

Ao refletirmos sobre o fomento de um envelhecimento ativo, relacionamos esse conceito ao envelhecer mantendo a capacidade funcional e autonomia, suportados pela abordagem do cumprimento dos direitos dos idosos, na dignidade, assistência e autorrealização (WHO, 2019).

Nessa lógica, Barbosa (2014) afirma que ao considerar o idoso como um ator social, com políticas públicas pautadas em sua autonomia, se incentiva a elaboração de políticas mais próximas à heterogeneidade dos idosos brasileiros, prezando pelo envelhecimento ativo e saudável.

As mudanças em decorrência de processos políticos e culturais, tem feito com que a sociedade mude a forma como se percebe o idoso e o processo do envelhecer. Atribuindo à velhice um valor singular e um olhar desvinculado de ideias associadas apenas à dependência ou fragilidade, como ressalta Beauvoir (1970), que é preciso romper o silêncio opressor que opera na velhice, dando atenção às vozes que foram silenciadas ao longo do tempo.

Diante desse cenário e considerando a trajetória dos avanços na elaboração das políticas públicas brasileiras voltadas aos interesses da população idosa do país, apresentamos o Quadro 5 contendo uma síntese das principais ações ou eventos históricos que influenciaram o contexto das políticas públicas voltadas aos interesses das pessoas idosas no Brasil.

Quadro 5 - Marcos Legais das Políticas Públicas para Idosos no Brasil.			
Ano	Política/Ação	Nº da Lei/Decreto	Previsão
1974	Renda Mensal Vitalícia	6.179	Criação da Renda Mensal Vitalícia, através do então Instituto Nacional de Previdência Social – INPS e de decretos, leis, portarias, referentes, principalmente, à aposentadoria.
1975	Ministério da Previdência e Assistência Social		Referenciou questões voltadas à saúde, à renda, e prevenção do asilamento
1982	Plano de Ação Mundial sobre o Envelhecimento	-	Realização da I Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento (ONU 19), em Viena, que traçou as diretrizes do Plano de Ação Mundial sobre o Envelhecimento. Esse Plano de Ação buscou sensibilizar os governos e sociedades do mundo todo para a necessidade de direcionar políticas públicas voltadas para os idosos, bem como alertar para o desenvolvimento de estudos futuros sobre os aspectos do envelhecimento.
1988	Constituição Federal do Brasil	Constituição Federal de 1988	Artigos 230, 194, 196-200: Garantia de direitos sociais e saúde para os idosos
1993	Lei Orgânica Assistencial	8.742/93	Regulamenta o capítulo II da Seguridade Social da Constituição Federal, que garantiu à Assistência Social o status de política pública de seguridade social, direito ao cidadão e dever do Estado. A LOAS prevê o benefício de prestação continuada, que consiste na garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com setenta anos ou mais e que comprovem não possuir

			meios de prover o próprio sustento e nem de tê-lo provido por sua família
1994	Política Nacional do Idoso (PNI)	Lei nº 8.842/1994	Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso
1996	Regimento Interno do Conselho Nacional do Idoso	Decreto nº 1.948/1996	Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional do Idoso
1997	Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI)	Portaria MS nº 1.395/1997	Estabelece diretrizes para a atenção integral à saúde do idoso
1999	Política Nacional de Saúde do Idoso	Portaria 1.395/1999	Implantada pelo Ministério da Saúde (MS), estabelece as diretrizes essenciais que regem a definição dos programas, planos, projetos e atividades do setor na atenção integral à população idosa. Essas diretrizes são: promoção do envelhecimento saudável, prevenção de doenças, manutenção da capacidade funcional, assistência à saúde dos idosos, reabilitação da capacidade funcional comprometida, capacitação de recursos humanos, apoio ao desenvolvimento de cuidados informais, e apoio aos estudos e pesquisas
2003	Estatuto do Idoso	Lei nº 10.741/2003	Assegura direitos específicos para pessoas com 60 anos ou mais
2004	Política Nacional da Assistência Social (PNAS)	Resolução 145	Universalização dos direitos sociais, a dignidade dos cidadãos, o direito a benefícios e serviços e defende a igualdade de direitos. A PNAS apresenta as diretrizes para efetivação da assistência social como direito à cidadania e responsabilidade do Estado
2006	Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa	Portaria MS nº 2.528/2006	Atualiza as diretrizes da PNSI de 1997 e implementa novas ações de saúde para a pessoa idosa
2010	Fundo Nacional do Idoso	Lei 12.213	Financiar programas e ações voltadas à pessoa idosa, com vistas a assegurar seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva nas sociedades
2011	Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	Decreto nº 7.508/2011	Regulamenta a Lei nº 8.080/1990 sobre a organização do SUS, incluindo diretrizes para a saúde do idoso
2013	Programa Viver Sem Limite	Decreto nº 7.612/2011 (reforçado em 2013)	Programa de inclusão social para pessoas com deficiência e idosos, com várias ações intersetoriais
2013	Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo	Decreto 8.114	Dar continuidade à política sobre envelhecimento humano com qualidade de vida.

2018	Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI)	Portaria 2.528/2018	nº	Diretrizes para a implementação de cidades e comunidades amigáveis para a pessoa idosa
2020	Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa	Decreto 10.557/2020	nº	Estabelece medidas de prevenção e combate à violência contra a pessoa idosa
2021	Nova Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa	Portaria MS 2.284/2021	nº	Atualiza a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa com novas diretrizes e estratégias
2022	Estatuto da Pessoa Idosa (atualização terminológica)	Lei 14.423/2022		Mudança de nome: de Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa e atualização de terminologias de inclusão e diversidade.
2023	Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família (SNCF)	-		Instituição da SNCF no MDS, atenção a pessoas idosas como demandantes e provedoras de cuidado.
2023	Guia de Cuidados para a Pessoa Idosa	MS		Lançamento pelo Ministério da Saúde; orientações e estratégias de cuidado.
2024	Política Nacional de Cuidados	Lei Federal 15.069/2024		Política abrangente para cuidados a todos, incluindo idosos; aprovada por lei federal.
2024	Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Alzheimer e Demências	Lei Federal 14.878/2024		Institui atenção especial a idosos com Alzheimer e demais demências.
2025	Atualização/ampliação dos benefícios da Carteira da Pessoa Idosa	Em tramitação/implementação		Redução da idade mínima para acesso, integração digital da Carteira, ampliação de benefícios e reconhecimento de ILPIs como entidades de saúde.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

As políticas públicas e a legislação desempenham um papel crucial na proteção dos direitos dos idosos e na promoção da igualdade de tratamento. Leis que proíbem a discriminação por idade e políticas que promovem a inclusão dos idosos são fundamentais para combater o etarismo. Segundo Palmore (2001), a implementação de políticas antidiscriminatórias pode reduzir significativamente os efeitos do etarismo. A educação e a conscientização social são essenciais para mudar as atitudes e comportamentos em relação ao envelhecimento. Programas educativos que abordam o envelhecimento positivo e promovem a empatia intergeracional podem ajudar a reduzir o etarismo. Kampfe e Mitte (2009) destacam que campanhas de conscientização podem desmistificar os estereótipos sobre o envelhecimento e promover uma maior aceitação social dos idosos.

O enfrentamento ao etarismo requer articulação entre políticas públicas e

iniciativas educativas desde a infância, promovendo uma cultura de respeito e inclusão. Estudos atuais destacam que programas intergeracionais têm apresentado resultados positivos na redução de preconceitos, ao estimular o diálogo e a colaboração entre diferentes faixas etárias, fortalecendo laços sociais e a valorização da experiência acumulada das pessoas idosas (Figueiredo & Oliveira, 2023).

Com o movimento de urbanização das cidades, novos modelos de ações no espaço urbano, mais comprometidos para manutenção de uma vida digna foram buscados, culminando em uma junção de expectativas, promessas, conflitos de interesses e visões de mundo.

Contudo, mesmo em meio a essas mudanças, ainda existem inúmeros desafios e dificuldades a serem superadas, principalmente diante do modelo de ordem internacional, dos mercados cada vez mais financeirizados e distantes do equilíbrio social, reforçando a fala de Haddad (2016), que destaca que a energia gasta por parte do Estado e demais governantes, em sua maioria, escondem a sua verdadeira intenção no atendimento das demandas sociais, ou seja, pensam no impacto destas "ações" sobre os cofres públicos.

Apesar do incremento de políticas urbanas inclusivas, observa-se que muitas iniciativas acabam condicionadas a lógicas econômicas e interesses políticos, o que frequentemente limita avanços reais na promoção do direito à cidade e à vida digna para grupos vulneráveis, como os idosos. A busca pelo equilíbrio entre desenvolvimento urbano e justiça social permanece um desafio central diante das tendências de financeirização e priorização do capital nas estratégias governamentais contemporâneas (Almeida & Costa, 2024).

A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI)

A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI) foi criada como uma política pública de inclusão e proteção dos direitos das pessoas idosas no Brasil, visando melhorar a qualidade de vida e promover um envelhecimento ativo e saudável, estimulando ações de adequação no planejamento urbano pela intersectorialidade política, na perspectiva de materializar no espaço, o que é decodificado dos anseios e demandas sociais.

Inspirada pela iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) de criar cidades e comunidades amigáveis para pessoas idosas, a EBAPI busca adaptar e implementar no contexto brasileiro práticas e diretrizes internacionais voltadas para a

promoção do bem-estar das pessoas idosas.

Foi implementada oficialmente no Brasil em 2018, tendo como base as diretrizes da OMS e a Estratégia Global e Plano de Ação sobre Envelhecimento e Saúde (2016-2020). A proposta da EBAPI envolve a colaboração entre diferentes esferas de governo, incluindo municípios, estados e o governo federal, além da participação de organizações não-governamentais e da sociedade civil. Seu objetivo principal é desenvolver políticas e ações intersetoriais que promovam a inclusão social, a participação ativa e a melhoria das condições de vida das pessoas idosas.

Sabe-se que o marco orientador, na possibilidade de se gerar dados para criação de indicadores, foi o “Guia global: Cidade Amiga do Idoso (2008)”, que se originou do “Projeto Mundial Cidade Amiga do Idoso (2005)”, com protocolo de pesquisa implementado em 33 cidades do mundo e de todos os continentes.

A influência internacional na criação e desenvolvimento da EBAPI é evidente, principalmente pelas diretrizes e recomendações da OMS sobre envelhecimento ativo e saudável. A iniciativa *Global Age-Friendly Cities and Communities* da OMS, lançada em 2007, serviu de modelo para a EBAPI e por haver grande participação acadêmica internacional e de consultores especializados, nas áreas do envelhecimento humano e do espaço urbano, o formato de avaliação das determinantes investigadas, não foram alteradas ou no máximo adaptadas a realidade de cada localidade, adaptando seus princípios às realidades e necessidades brasileiras.

Até Setembro de 2020, segundo em Oliveira (2022), existiam aproximadamente 1018 cidades (18,27%) com pré-cadastro na EBAPI, das de 5570 cidades brasileiras. Em 2018, foram 355 cidades cadastradas, em 2019 mais 540 cidades cadastradas e mais 123 cidades em 2020. Dos 26 Estados apenas 05 capitais aparecem registradas: Porto Velho-RO, Teresina-PI, Fortaleza-CE, Belo Horizonte-MG e Rio de Janeiro-RJ.

Das regiões do Brasil: Nordeste 40,17% (409), Sudeste 28,68% (292), Centro-Oeste 8,34% (85), Sul 17,97% (183) e Norte 4,81% (49), apesar do maior percentual de municípios cadastrados na EBAPI serem da Região Nordeste, os municípios que mais se destacaram como “amigos da pessoa idosa” foram das regiões Sul e Sudeste, onde se pressupõe que a desigualdade social entre estas regiões contribua para o resultado observado. Outra possibilidade que justifica o quantitativo de cadastros na estratégia nacional na Região NE é a intenção de captação de recursos que venham auxiliar os orçamentos municipais no atendimento destas demandas.

No Nordeste, o estado que mais se destacou foi o do Ceará, seguidos dos estados

da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Alagoas e Sergipe. No Sudeste, o estado de maior concentração de cidades cadastradas na estratégia foi o de Minas Gerais, seguido de São Paulo. No Centro-Oeste, Goiás detém 94,11% de todos os cadastros da região. No Sul, o Paraná lidera, seguido de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por fim, na região Norte, o estado que mais apresentou interesse nas inscrições, foi o estado do Pará.

Com o intuito de gerar maiores ações e adesões a própria estratégia, ainda em andamento, o Plenário do Senado Federal aprovou em agosto de 2019, o projeto de lei (PL 402/2019) que cria o Programa Cidade Amiga do Idoso, com o objetivo de incentivar municípios a adotarem medidas para o envelhecimento saudável e para aumentar a qualidade de vida da pessoa idosa.

O projeto determina que o município só poderá aderir ao programa se tiver Conselho Municipal do Idoso em funcionamento e deverá apresentar plano com ações para beneficiar e melhorar a condição de vida de pessoas idosas em aspectos como: transporte, moradia, participação social, respeito, inclusão social, participação cívica, emprego, comunicação, informação, apoio comunitário, serviços de saúde e mobilidade. A cidade que conseguir resultados exitosos nesses aspectos poderá receber o título de Cidade Amiga do Idoso.

Para exemplificar como as estratégias de acolhimento à longevidade se materializam no desenho urbano, este estudo selecionou práticas que personificam o conceito de 'Cidade Amiga da Pessoa Idosa'. A análise dessas iniciativas — que abrangem tanto o cenário internacional quanto intervenções locais já identificadas no Recife — permite visualizar o planejamento urbano como indutor de um envelhecimento resiliente. Assim, como forma de ilustrar a transição da norma para a prática em cidades que assumiram o protagonismo desenvolvendo ações que resultaram no reconhecimento dos municípios como colaboradores para o envelhecimento resiliente e saudável, citamos:

- a) No Rio Grande do Sul, Porto Alegre, apesar de só em 2018 ter tido aprovada sua política municipal da pessoa idosa, vinha se preocupando com a capacidade da cidade em proporcionar um envelhecimento saudável e ativo, para a maior população de idosos do país. Para poder se certificar junto a OMS, fez um diagnóstico sobre os trabalhos de suas secretarias governamentais e de entidades que atendem seus idosos. Em 2011 teve

como sua grande ação a criação do Fundo Municipal do Idoso e 2015 foi certificada primeira capital e cidade brasileira amiga da pessoa idosa;

- b) Esteio-RS, preocupada com seus idosos criou o Fundo Municipal do Idoso em 2014 e o Centro do Idoso de Esteio em 2019, o espaço fica na Vila Olímpica, e oferece a possibilidade de inserção social, pois neste local os idosos podem brincar, jogar, assistir televisão e compartilhar momentos com outros idosos do município e da região;
- c) Veranópolis-RS, considerada a terra da longevidade no Brasil, e também uma das primeiras cidades a receber o título de “Cidade Amiga do Idoso” no Brasil. Uma carta-compromisso possuindo um plano de ações, oriundo do diagnóstico da população idosa da cidade, onde foram ouvidos 836 veranenses com mais de 60 anos, foi a grande iniciativa que levou a o reconhecimento do município pela OMS, além do trabalho contínuo de avaliações e aprimoramento, especialmente ligado às ações do poder público;
- d) Em 2018, Pato Branco, é o terceiro município do Brasil e o primeiro no Paraná a receber essa certificação, com base em ações permanentes voltadas para a qualidade de vida da pessoa idosa e longevidade de seus habitantes. Criou o Fundo Municipal do Idoso e fortaleceu ações integradas entre as secretarias municipais, para atender as áreas mais deficientes da EBAPI;
- e) Balneário Camboriú – SC em 2019/2020, estava entre as cinco cidades brasileiras no mundo certificadas com o registro de Cidade Amiga do Idoso, (Selo Bronze) e foi certificada por estar adaptando suas estruturas e serviços ao público da terceira idade, escutando a população idosa, promovendo inclusão e ações destinadas ao envelhecimento ativo, principalmente no segmento mais vulnerável. Aprovou o plano de lei municipal de apoio ao envelhecimento ativo após a realização dos diagnósticos na cidade em parceria com o Instituto Federal Catarinense.
- f) No Estado de São Paulo em 2019, Jaguariúna se destacou por ter enfatizado suas ações de maneira intersetorial favorecendo a: assistência social, saúde, educação, moradia, segurança, transporte, cultura, esporte e lazer do município;
- g) Campos – RJ em 2020: assistência médica, atividades de cultura, esporte e lazer, casas de convivência foram reabertas, jogos da maturidade foram

realizados e durante a pandemia, uma equipe técnica da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Ativo, ofereceu canais pela internet “Canal Envelhecimento Ativo”, no Youtube, com aulas de diversas atividades.

Segundo a Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), rede não hierarquizada, de natureza colaborativa, solidária e integrada, voltada para geração, análise e disseminação de dados aplicados às políticas públicas de saúde no Brasil, se faz necessário a realização de diagnósticos, criação de indicadores ou a melhoria dos mecanismos existentes, caso já estejam sendo aplicados, para permitir o conhecimento sobre a realidade local, inclusive para identificar o potencial do poder público e do setor privado, na contribuição da melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas e suas demandas juntamente com o restante da população.

Uma diferença significativa entre os mecanismos de medição e avaliação da EBAPI e os internacionais, é o uso de ferramentas tecnológicas específicas, como o Sistema da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (SISBAPI), lançado em 2022.

Este sistema facilita a comunicação entre governos municipais e federais, permitindo um acompanhamento mais eficiente das políticas públicas voltadas para os idosos. Com base nesta escuta e diagnósticos, as ações são desenvolvidas procurando atender o setores mais frágeis, dada a intersetorialidade política e dentro das dimensões que são propostas pela EBAPI/OMS e recomendadas pelas políticas públicas, temos(1) ambiente físico, (2) transporte/acessibilidade, (3) moradia, (4) inclusão social e saúde, como sendo os segmentos que mais recebem ações dos municípios para melhoria dos aspectos da vida social do idoso.

Este atendimento às necessidades supracitadas, passa a ser questionado quando encontramos informações divergentes nos indicadores que são pouco utilizados ou negligenciados, e que poderiam dar uma maior contribuição nas medidas preventivas de tais ocorrências, como das internações e óbitos de idosos por acidentes de transporte ou por falta de saneamento, mesmo em municípios caracterizados amigo da pessoa idosa.

Embora o projeto tenha avançado em diversas comissões, incluindo a de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, até o momento (11/2025) ele aguarda votação final no Plenário da Câmara para ser definitivamente sancionado e implementado nacionalmente. Entre as atualizações, o programa passou a contemplar a promoção do envelhecimento ativo, a obrigatoriedade de acessibilidade e a instituição de Conselhos Municipais do Idoso com planos de ação abrangendo transporte, moradia,

saúde e inclusão social.

Os municípios participantes ainda poderão ter prioridade no recebimento de recursos federais destinados ao desenvolvimento urbano, reforçando o compromisso com ambientes mais inclusivos para o envelhecimento. O fator que mais dificulta a celeridade das medidas que são tomadas e traz uma lenta resposta das ações desenvolvidas é a desigualdade social da população. Mesmo que diferente nos países, este agrava este segmento da população idosa carente que apresenta demandas diferenciadas, necessitando de medidas transversais e intersetoriais que respeitem os direitos humanos em toda e qualquer estratégia de ação e políticas públicas.

2.6.1 Caracterização do Município do Recife-PE: Análise Temporal Pós-Estatuto do Idoso (2003-2025)

O município do Recife, capital de Pernambuco, emerge como um estudo de caso emblemático das transformações demográficas, sociais e econômicas que marcam o Brasil nas últimas duas décadas, período que coincide com a vigência do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), publicado em 1º de outubro de 2003.

A análise da evolução temporal, com base nos dados do Censo de 2022 e comparativos anteriores, revela um cenário de rápido envelhecimento populacional e seus múltiplos desdobramentos nos aspectos demográficos, econômicos, sociais, culturais e epidemiológicos, em um contexto em que a implementação do referido estatuto tem sido um desafio.

A seguir, a complexidade do cenário de Recife é detalhada sob três ângulos de análise: demográfico, socioeconômico e epidemiológico. O município do Recife, capital de Pernambuco, emerge como um estudo de caso emblemático das transformações demográficas, sociais e econômicas que marcam o Brasil nas últimas duas décadas, período que coincide com a vigência do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

A análise da evolução temporal, com base nos dados do Censo de 2022 e comparativos anteriores, revela um cenário de rápido envelhecimento populacional e seus múltiplos desdobramentos, em um contexto em que a implementação do referido estatuto tem sido um desafio. A complexidade do cenário de Recife é detalhada a seguir sob três ângulos de análise: demográfico, socioeconômico e epidemiológico.

No que se refere aos aspectos demográficos, o processo de envelhecimento populacional é uma das características mais proeminentes da demografia brasileira, e o Recife não é exceção. A cidade reflete e, em muitos aspectos, intensifica essa tendência, mesmo com a existência de um marco legal voltado para a proteção e garantia de direitos dos idosos desde 2003.

Conforme demonstram os dados mais recentes, a população idosa do município vem crescendo expressivamente: em Pernambuco, o número de pessoas com 65 anos ou mais, por exemplo, mais que dobrou em 42 anos, registrando um crescimento de 57,4% somente entre 2010 e 2022.

O Recife, nesse contexto, se posiciona entre as 10 capitais brasileiras com o maior número relativo de idosos. Em 2022, 10,2% da população de Pernambuco já se encontrava na faixa etária idosa, um indicativo claro da transição demográfica em curso, que se acentuou significativamente após a publicação do Estatuto do Idoso. O índice de envelhecimento, crucial para o planejamento urbano, saltou em Pernambuco de 28,8 em 2010 para 48,7 em 2022 (para a faixa de 65 anos ou mais em relação a 0-14 anos), evidenciando a inversão progressiva da pirâmide etária.

Contudo, ao observarmos o cenário consolidado da capital no biênio 2025-2026, nota-se que o Recife apresenta um envelhecimento ainda mais acentuado que a média estadual, com a população de 60 anos ou mais atingindo patamares próximos a 16%, o que intensifica as demandas sobre o planejamento urbano local.

Paralelamente, a esperança de vida ao nascer em Pernambuco apresentou um aumento notável, atingindo 75,3 anos em 2023, o que, embora positivo e alinhado com o espírito do Estatuto, demanda um sistema de apoio robusto e uma implementação efetiva das diretrizes legais. O crescimento da população centenária no estado, que quase dobrou entre 2000 e 2022 (de 1.121 para 2.141), com predominância feminina (razão de sexo de 91,2 em 2022), ressalta a necessidade de atenção a um grupo com necessidades muito específicas e, muitas vezes, de alta dependência, cujos direitos deveriam ser plenamente garantidos.

Dentro dos aspectos econômicos e sociais, o envelhecimento populacional do município se desenrola em um cenário complexo de desafios socioeconômicos, onde as desigualdades históricas continuam a moldar a experiência dos seus habitantes. O avanço no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,772 em 2010 esconde profundas disparidades, como a clivagem racial significativa (IDHM da população negra em 0,723 contra 0,831 da branca).

Além disso, o aumento do Índice de Gini (que mede a concentração de renda) de 0,67 em 1991 para 0,68 em 2010 indica que o crescimento econômico não foi acompanhado por uma redução na desigualdade. Este cenário é um dos fatores que dificultam a universalização dos direitos previstos no Estatuto do Idoso, concentrando os benefícios em áreas ou grupos mais privilegiados.

A vulnerabilidade social persiste: a dependência de idosos em domicílios vulneráveis à pobreza era de 3,41% em 2010, destacando a interconexão entre o envelhecimento e a pobreza, um problema que o Estatuto busca combater. Contudo, o envelhecimento da força de trabalho e a necessidade de requalificação profissional para idosos são questões crescentes que demandam atenção e que deveriam ser amparadas por políticas de inclusão e valorização do trabalho.

Ao abordar os aspectos culturais e epidemiológicos, a maior longevidade, impulsionada pela queda nas taxas de mortalidade infantil e fecundidade, implica uma demanda crescente por serviços de saúde, especialmente para doenças degenerativas e crônicas. O crescimento da população idosa, que em 2008 era responsável por 19,2% das internações hospitalares em Recife (embora representasse 9,4% da população geral), pressiona o sistema de saúde por serviços mais caros e especializados.

A implementação do Estatuto do Idoso tem sido extremamente morosa e desigual no país, o que contribui para a precariedade dos serviços prestados. A rapidez do envelhecimento populacional torna urgente a elaboração de políticas públicas que promovam um ambiente urbano acolhedor e inclusivo. A lacuna entre a formalização legal de direitos e a percepção dos idosos sobre a materialização de um ambiente urbano verdadeiramente amigável é um ponto crítico a ser abordado, e a análise temporal evidencia que essa lacuna persistiu e se acentuou no período pós-estatuto.

2.6.2 Governança Intersetorial e o Desafio da Efetivação: A Reprodução das Políticas Nacionais na Estrutura Municipal de Recife-PE

Este item tem como objetivo central analisar o ecossistema institucional e normativo no Município do Recife-PE, no que concerne à articulação entre as diretrizes do envelhecimento ativo e as políticas de desenvolvimento urbano. A premissa fundamental da tese reside no diagnóstico de que a reprodução das políticas nacionais – como a Política Nacional do Idoso (PNI), o Estatuto da Pessoa Idosa e, mais

recentemente, a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI) – no nível municipal, encontra barreiras significativas, principalmente devido à histórica desigualdade socioespacial de Recife e à fragilidade da governança intersetorial.

A construção de cidades verdadeiramente acolhedoras à pessoa idosa é alicerçada em um sólido arcabouço legal que disciplina e direciona as ações do poder público. No contexto brasileiro, esta base normativa é estabelecida no nível federal, atuando como alicerce para a criação e implementação de políticas urbanas inclusivas. O marco federal estrutura-se em dois pilares: Políticas Específicas para Idosos (Lei 8.842/1994 e Estatuto da Pessoa Idosa) e Política Urbana e Direito à Cidade (Constituição Federal, Art. 182, e Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001). A Constituição Federal confere ao Município o papel protagonista no planejamento e na execução da política de desenvolvimento urbano, o que implica uma responsabilidade direta na adaptação do espaço e dos serviços às demandas do envelhecimento populacional.

No Recife, a governança relativa à pessoa idosa e ao urbanismo está distribuída em diferentes esferas. A Política da Pessoa Idosa encontra seu ponto focal em órgãos como o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIR) e na estrutura da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), sendo a porta de entrada para a fiscalização e promoção dos direitos legais do idoso. Já a Política de Desenvolvimento Urbano é regida por instrumentos como o Plano Diretor do Recife (Lei nº 17.511/2008, atualizado pela Lei nº 18.770/2020) e executada por secretarias de Urbanismo, Mobilidade e Infraestrutura. Tais instrumentos são responsáveis por materializar os preceitos de acessibilidade (como a NBR 9050) e bem-estar urbano.

A eficácia da reprodução das políticas nacionais de envelhecimento no espaço urbano de Recife está, contudo, intrinsecamente ligada à capacidade destes setores deixarem de atuar em silos e estabelecerem uma intersetorialidade robusta. Historicamente, observa-se que as pautas de saúde e assistência social, voltadas ao idoso, não dialogam de forma efetiva com as pautas de planejamento urbano e vice-versa.

O conceito de “Cidade Amiga da Pessoa Idosa” exige que o ambiente urbano seja adaptado para promover a inclusão em seus 8 domínios (OMS/EBAPI). No entanto, a implementação desses domínios esbarra na polarização social e territorial do Recife, um dos municípios mais desiguais do país (como evidenciado pelo coeficiente de Gini e pelos dados de renda apresentados na introdução). A reprodução das políticas nacionais tende a ser desigual, manifestando-se na:

1. Concentração de Benefícios: Investimentos em acessibilidade, mobiliário urbano (como a adequação de abrigos de ônibus e bancos em praças) e oferta de serviços de lazer/saúde tendem a se concentrar em áreas de maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), perpetuando o ciclo de privilégio especial.
2. Invisibilidade Territorial: Os idosos em áreas periféricas ou de baixa renda (população majoritária nas classes D e E) enfrentam a ineficácia das políticas, pois a infraestrutura básica (saneamento, mobilidade, iluminação) é cronicamente deficitária. Nesses contextos, a preocupação com os domínios da EBAPI de "apoio, saúde e cuidado" se sobrepõe à de "participação" e "oportunidades", dada a prioridade da sobrevivência e da segurança.

Em um quadro de recursos escassos, as escolhas de investimento do poder público municipal, influenciadas pela racionalidade política de expressão mundial (Dardot e Laval, 2016), priorizam projetos que geram retorno econômico (e.g., verticalização, grandes obras viárias) em detrimento da infraestrutura social e do combate às desigualdades. A reprodução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) em Recife, quando desvinculada de uma perspectiva de justiça socioespacial, falha em transformar o marco legal do Estatuto da Cidade em um instrumento de equidade.

Essa priorização do lucro sobre o bem-estar social (Harvey, 2012) gera consequências diretas: a Fragmentação Orçamentária, onde os orçamentos municipais não refletem a prioridade constitucional do idoso, e a Exclusão e Injustiça Socioespacial, na qual projetos de renovação urbana podem levar ao deslocamento forçado de populações idosas de baixa renda (Maricato, 2011). É crucial, portanto, enquadrar a falha na reprodução das políticas como uma questão de Justiça Socioespacial, onde o direito à cidade (Lefebvre, 2001) não é garantido de forma equânime à população idosa.

Em suma, a estrutura de governança do Recife, embora legalmente aparelhada pelos marcos nacionais e estaduais (incluindo a Política Estadual do Idoso e o Plano Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável), demonstra fragilidade na sua capacidade de reproduzir de forma justa e equânime as políticas voltadas para o envelhecimento. Essa falha, materializada na desigualdade socioespacial, se manifesta na percepção do

idoso sobre o acolhimento urbano, que foi o foco do diagnóstico empírico detalhado nos capítulos subsequentes desta tese.

2.6.3 A Produção Social da Velhice Urbana: Uma Abordagem Crítica Multidimensional

Embora a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI) e o protocolo da OMS forneçam a matriz normativa e os indicadores fundamentais para a avaliação da amigabilidade urbana, a complexidade socioespacial de uma metrópole desigual como o Recife exige um aporte teórico que transcenda a análise puramente funcionalista.

Para compreender as nuances da percepção do idoso, esta tese dialoga com vertentes da sociologia urbana, geografia crítica e da teoria social, estabelecendo um tripé analítico focado na justiça espacial, sem esquecer do capital simbólico e da interação corpo-ambiente, de maneira contextualizada, porque não estamos realizando um debate teórico e sim direcionando uma melhor forma de olhar nosso diagnóstico e possibilitar uma discussão que responda aos nossos anseios.

Primeiramente, a compreensão da precariedade física da cidade não pode ser dissociada da crítica à economia política da urbanização. Apoiando-se em Henri Lefebvre (2001) e David Harvey (2012; 2014), compreende-se aqui o "Direito à Cidade" não apenas como o direito de acesso a equipamentos, mas como o direito de não ser segregado pelos processos de produção do espaço.

No contexto brasileiro, essa leitura é complementada por Ermínia Maricato (2010; 2014) e Flávio Villaça (2001), que denunciam a produção de cidades duais, onde a "cidade legal" (dotada de infraestrutura) convive com a "cidade ilegal" ou precária, reservada às classes populares. Essa perspectiva é essencial para analisar as discrepâncias territoriais que emergem nas Regiões Político-Administrativas (RPAs), entendendo a calçada quebrada não como um acidente de gestão, mas como sintoma de uma estrutura de segregação.

Em segunda instância, a investigação sobre os determinantes da inclusão social e do acesso à informação ancora-se na sociologia de Pierre Bourdieu (1986; 1989). A hipótese de que a escolaridade (Capital Cultural) pode ser mais determinante do que a renda (Capital Econômico) na navegação urbana baseia-se na compreensão de que a cidade moderna é um sistema de códigos complexos.

O conceito de *habitus* permite entender como a desigualdade educacional se converte em desigualdade de mobilidade e participação: o idoso sem letramento urbano sente-se "fora de lugar" nos espaços burocráticos e digitais, sofrendo uma violência simbólica que o silencia.

Essa assimetria informacional, lida sob a ótica de Bourdieu, justifica por que a escolaridade emergiu em nossos resultados como um determinante de percepção mais agudo que a própria renda, uma vez que o domínio do código urbano e o acesso à informação tornam o cidadão mais crítico frente às omissões do Estado. Adicionalmente, a relação entre o corpo envelhecido e o espaço físico é lida sob a ótica da Pressão Ambiental proposta por Lawton e Nahemow (1973).

Esta teoria postula que, à medida que a competência individual declina (devido ao envelhecimento biológico), a demanda exercida pelo ambiente físico aumenta desproporcionalmente. Em um ambiente hostil como o do Recife, essa pressão ambiental torna-se incapacitante.

Dialoga-se aqui também com o Modelo Social da Deficiência (Oliver, 1990; Shakespeare, 2006), que desloca o problema da "falha" do corpo individual para a "falha" da sociedade em acomodar a diversidade corporal, conceito fundamental para interpretar a universalidade das barreiras físicas encontradas na pesquisa.

Por fim, a análise da exclusão e da marginalidade urbana incorpora as reflexões de Loïc Wacquant (2008) sobre a "marginalidade avançada" e a estigmatização territorial, bem como o conceito de Justiça Espacial de Edward Soja (2010).

Tais autores fornecem o estofo teórico para interpretar como a geografia do Recife, marcada por morros e áreas de risco, atua como um vetor ativo de desigualdade no envelhecimento, transformando o território em um determinante social de saúde.

Assim, este referencial teórico multidimensional não busca apenas aplicar normas técnicas, mas investigar como a intersecção entre espaço, saber e corpo, "tripé analítico" (justiça espacial, capital simbólico/cultural, corpo-ambiente), produz a experiência concreta de envelhecer no Recife.

De forma sintética, a articulação deste arcabouço teórico com a parte empírica da tese se dá em três eixos. Em primeiro lugar, a crítica da produção do espaço em Lefebvre, Harvey, Maricato e Villa orienta a leitura das desigualdades entre as RPAs e sustenta a interpretação da hierarquização dos domínios da EBAPI como expressão de um urbanismo seletivo.

Em segundo lugar, Bourdieu contribui para compreender a centralidade da

escolaridade e do capital cultural nas diferenças de percepção observadas em Comunicação e Informação e Participação, explicitadas nas análises estatísticas de correlação.

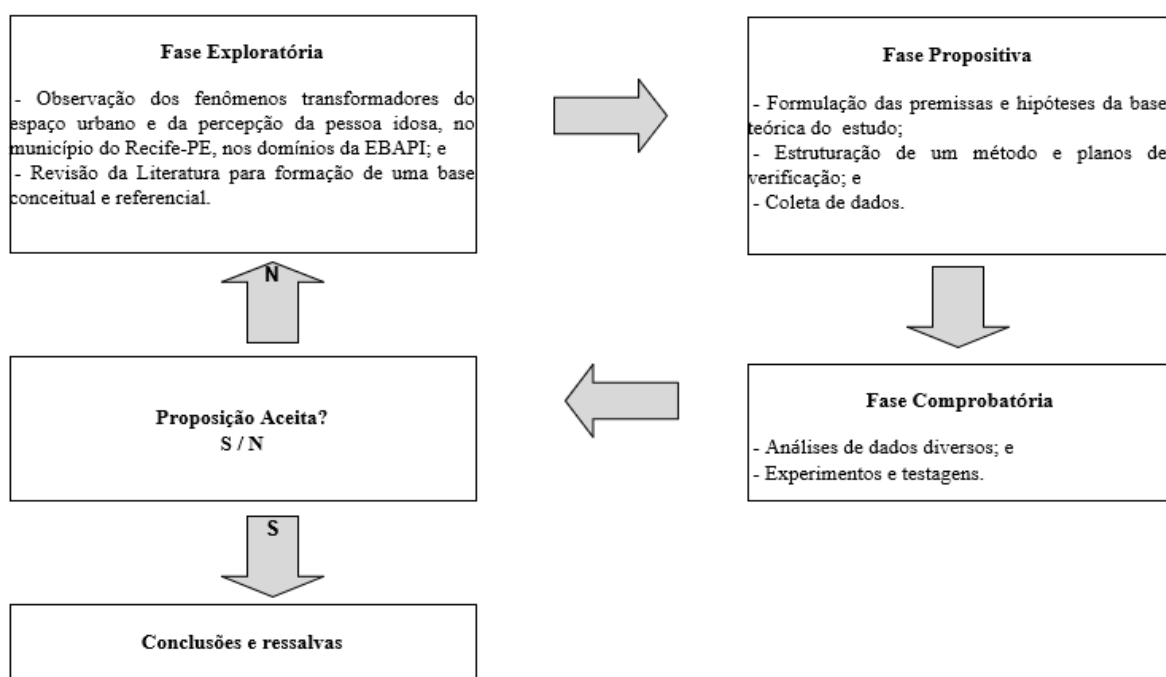
Por fim, Lawton e Nahemow, aliados ao Modelo Social da Deficiência, oferecem a chave para interpretar a elevada insatisfação com Ambiente Físico e Transporte como resultado de uma pressão ambiental que ultrapassa as capacidades funcionais do corpo envelhecido, especialmente em territórios marcados por precariedades históricas.

3 METODOLOGIA UTILIZADA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO: MÉTODO E TIPO DE PESQUISA

No processo de construção da presente tese, utilizamos o método hipotético-dedutivo, desenvolvido por Karl Raymond Popper (1959), filósofo crítico do indutivismo que propunha um método que visava superar a dualidade entre o empirismo versus racionalismo. Sendo assim, podemos dizer que a referida metodologia elege proposições hipotéticas, que possuem certa viabilidade, para responder a um problema, para em seguida serem testadas por falseabilidade, com o objetivo de comprová-las (Marconi; Lakatos, 2010).

Figura 3 - Fluxograma das fases do processo metodológico até a fase de testagem da hipótese.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

É um método amplamente utilizado em pesquisas quantitativas, facilitando a realização de diagnósticos, o que determinou nossa escolha. A pesquisa teve uma abordagem diagnóstica e exploratória, de caráter quantitativo, sendo norteada pela fundamentação teórica do desenvolvimento urbano sustentável e das teorias que promovem atenção e ações diferenciadas para o envelhecimento, em suas múltiplas implicações.

Esse tipo de pesquisa é comum em contextos onde há necessidade de identificar problemas ou necessidades em uma população específica, ao mesmo tempo em que se deseja obter uma visão mais abrangente sobre o tema em estudo.

Ao optar prioritariamente por instrumentos quantitativos padronizados, esta tese privilegia a mensuração comparável de percepções sobre domínios específicos da EBAPI. Essa escolha metodológica, por outro lado, limita a apreensão de dimensões subjetivas mais finas – como medos, estratégias cotidianas de enfrentamento, redes informais de apoio e narrativas de vida – que poderiam enriquecer a compreensão da experiência urbana do envelhecimento. Tal limite é reconhecido e apontado como horizonte para investigações futuras com abordagens qualitativas complementares, pois ainda que a referida estratégia e o protocolo da OMS ofereçam uma base normativa consolidada para avaliar a amigabilidade urbana, reconhece-se que essa matriz não esgota a complexidade do envelhecimento em contextos socioespaciais desiguais.

Pelo fato de ser exploratória e quantitativa, podemos identificar tendências em relação às variáveis estudadas mesmo sem a existência de uma hipótese prévia, além da viabilidade na produção de dados estatísticos que nos proporcione maior conhecimento acerca de fenômenos que estão sendo estudados.

A principal característica da pesquisa diagnóstica está na análise de sujeitos afetados por sua relação com o meio ambiente e com outros sujeitos. Esta, para poder atingir os seus objetivos investigativos, propõe uma série de etapas e técnicas, que se iniciam com a seleção da população e da amostra do estudo (Kaisik, 2018).

Esta metodologia permite, uma análise conjunta da realidade e das experiências vividas do lugar, trazendo um diagnóstico sobre as prioridades locais do município que foram percebidas (Tuan, 1983; Dardel, 2011).

A pesquisa diagnóstica fornecerá dados quantitativos que poderão ser analisados e interpretados para identificar padrões, tendências e desafios específicos enfrentados, neste caso, pelos idosos no contexto do Recife.

3.2 DESENHO DO PROBLEMA DE PESQUISA

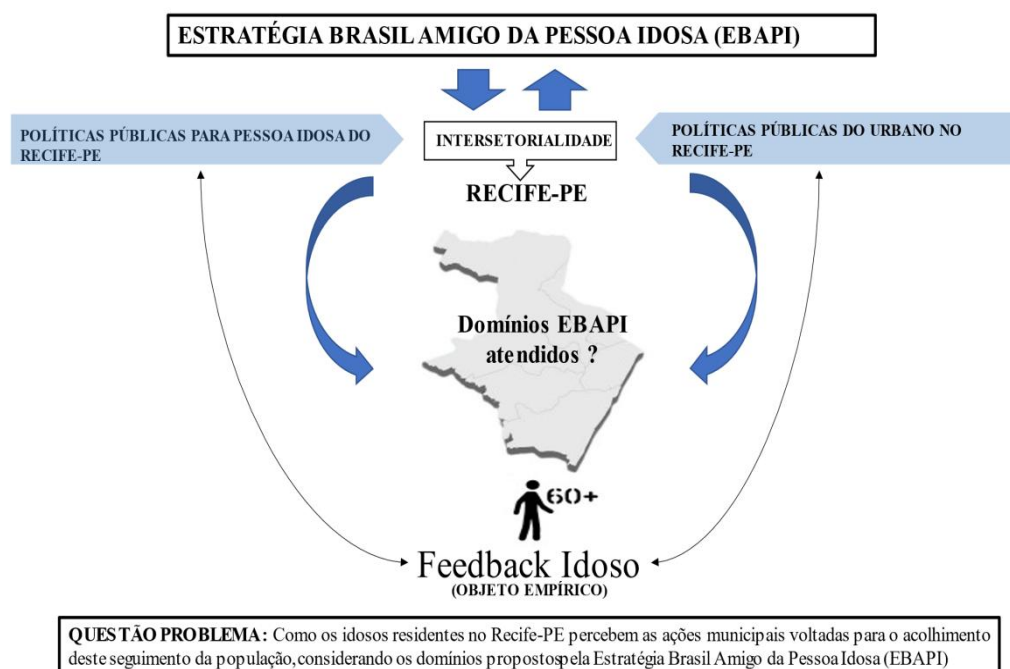
O desenho do problema de pesquisa é uma etapa crucial no desenvolvimento de qualquer estudo científico. Ele envolve a definição clara e precisa do problema a ser investigado, o que orienta toda a pesquisa subsequente.

Segundo Marconi e Lakatos (2010), "o desenho de pesquisa é o plano ou estrutura concebida para responder às perguntas de pesquisa e testar as hipóteses formuladas". Esse processo inclui a formulação de perguntas de pesquisa específicas, a determinação dos objetivos do estudo e a identificação das variáveis envolvidas.

Um bom desenho de problema de pesquisa não apenas define o que será estudado, mas também como e por que a pesquisa será conduzida, assegurando que os métodos e técnicas escolhidos sejam apropriados para a coleta e análise de dados. O desenho do problema de pesquisa, em uma perspectiva gráfica, nos mostra o cenário da pesquisa e as variáveis que estão envolvidas para o entendimento dos pressupostos na condução da construção de nossa pergunta condutora, se baseando inicialmente pela busca do conhecimento sobre a realidade local percebida.

Para melhor ilustrar nosso problema, a figura 3 nos traz o desenho do problema de pesquisa e a questão norteadora do estudo.

Figura 4 - Desenho do Problema de Pesquisa no Recife-PE.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.3 POPULAÇÃO ALVO E LOCAL DO ESTUDO

3.3.1 População Alvo

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, caracterizados e entrevistados segundo faixa etária, escolaridade (alfabetizados), estado civil, saúde autopercebida e condição previdenciária. Os participantes do estudo residiam no município de Recife-PE e expressaram intenção de colaborar por meio de anuência expressa no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.

3.3.2 Local do Estudo

O estudo inicialmente foi realizado no Núcleo da Pessoa Idosa (NPI), onde são ofertados cursos da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI - antigo PROIDOSO/UnATI), que é um local de ações extensionistas, da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Implantada na UFPE desde agosto de 1996 e regulamentada pela Portaria Normativa nº 01 de 17 de janeiro de 2002 (BO. UFPE), tem como finalidade a promoção e o incentivo de ações para melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, mediante a realização de cursos que facilitem a aquisição de novos conhecimentos e integração social. No Campus da Universidade Federal de Pernambuco, a UnAPI fica localizada na Av. Jornalista Anibal Fernandes, s/n, Cidade Universitária, Recife-PE – CEP: 50740-560.

Para que suas atividades sejam realizadas com frequência, são mobilizados docentes, técnicos, voluntários externos à Instituição, alunos de graduação e pós-graduação para a realização de cursos e outras atividades dirigidas ao segmento da pessoa idosa.

Representa, portanto, um espaço de convivência em grupo, com estímulo à participação ativa do idoso, valorização de suas potencialidades e talentos, além de se constituir em um espaço de prática para o estudo do envelhecimento, nas diversas áreas do conhecimento.

Após a qualificação da pesquisa, por sugestão de membros da banca avaliadora, no intuito de melhor espacializar o estudo, flexibilizar e possibilitar a ampliação da amostra, novos locais foram incluídos para coleta de dados. A seleção e inclusão desses

novos locais, nesta fase final, foram baseadas na contemplação de alguns dos eixos investigados pela EBAPI, além de considerar a facilidade de acesso, logística e a disponibilidade de participantes.

Todos esses espaços foram acessados mediante anuência comprovada da instituição (ver anexos), o que acrescentou a compreensão das percepções dos idosos em diferentes contextos urbanos do Recife-PE, em vez de depender de apenas uma seleção estrita, como foi feito no início da pesquisa.

Apresentamos a seguir, o novos espaços que foram agregados para otimizar a nossa amostra e ao estudo: O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (Eixo Saúde); A Biblioteca Estadual de Pernambuco (Eixo Informação); O Hospital Geral de Areias - Sony Santos (Eixo Saúde); UFPE/UFRPE (Eixo Aprendizagem); e Centros de Convivência do Recife, sorteados um por cada Região Político Administrativa (RPA), totalizando 06 centros (Eixo Inclusão Social).

3.3.3 Amostra

A amostra inicial foi determinada, a partir do quantitativo de idosos inscritos ($N = 293$) nos cursos ofertados pela UnAPI no primeiro semestre de 2025, ordenados em listagem única e selecionados por sorteio aleatório.

Para a determinação do tamanho amostral foi adotado o valor de 50% esperada para o evento investigado - percepção de idosos que frequentam a UnAPI/UFPE, sobre as ações de acolhimento urbano em Recife-PE, com base nos domínios EBAPI.

Optou-se por esse valor, apesar de maximizar o tamanho amostral, por não haver consenso na literatura especializada, em termos de magnitude dessa prevalência. Com nível de confiança de 95% e um erro máximo aceitável de 5%, utilizou-se a seguinte fórmula para o cálculo amostral:

$$n = \frac{N \times p \times q \times \left(Z_{\frac{\alpha}{2}}\right)^2}{p \times q \times \left(Z_{\frac{\alpha}{2}}\right)^2 + (N-1) \times E^2}$$

Onde:

n = Número de indivíduos na amostra;

N = Número total de idosos matriculados na UnAPI/UFPE (2025.1), até o início da pesquisa = 293;

p = Proporção populacional de idosos a serem investigados na UnAPI/UFPE, que percebem acolhimento urbano na cidade do Recife-PE ($p = 50,0$);

q = Proporção populacional de idosos a serem investigados na UnAPI/UFPE, que não percebem acolhimento urbano na cidade do Recife-PE ($q = 50,0$);

$Z_{\alpha/2}$ = Quantil da normal padrão (1,96; considerando um coeficiente de confiança de 95%);

E = Margem de erro (5%).

Foi adotado o nível de confiança de 95% e erro máximo aceitável de 5%. Para os **Critérios de Inclusão**, tivemos: pessoas de ambos os sexos, com idade equivalente ou superior a 60 anos, consideradas idosas segundo o Estatuto do Idoso (lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003), residir no município do Recife-PE e concordar em participar do estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A expansão dos locais de pesquisa, conforme anteriormente explicitado, viabilizou a representatividade da amostra em diferentes contextos socioeconômicos do município. Essa diversificação contribuiu para reduzir a fragilidade de limitar o estudo a um único local, o que poderia restringir a compreensão da realidade social dos idosos.

A referida ação, enriqueceu significativamente a pesquisa, proporcionando uma compreensão mais abrangente das realidades e percepções dos idosos da cidade sobre o acolhimento urbano. Embora não tenha representatividade estatística para toda a população idosa do município, a amostra utilizada enfatizou a importância qualitativa das experiências e visões em diversas situações, o que mitiga a limitação da não generalização estatística. Embora a coleta tenha alcançado um montante de 336 respondentes, optou-se por um rigoroso filtro de qualidade para a composição da amostra final desta tese.

Foram selecionados apenas os questionários que apresentavam preenchimento completo e inequívoco das variáveis de localização (RPAs) e escolaridade, resultando em um corpus de 163 idosos. Tal exclusão não representa uma perda aleatória, mas um procedimento de limpeza de base para assegurar a integridade estatística, uma vez que a integridade dessas variáveis é condição essencial para assegurar a precisão do p-valor nas análises estatísticas e a confiabilidade das correlações georreferenciadas apresentadas no diagnóstico.

Em função da estratégia de seleção e das perdas inerentes ao rigor do critério de adotado, a amostra final caracteriza-se como não probabilística. Contudo, o montante de 163 respondentes atingiu a robustez necessária para a detecção de correlações significativas, garantindo que as tendências identificadas reflitam com precisão as disparidades de percepção entre as diferentes RPAs. Desse modo, os resultados devem ser interpretados como um retrato qualificado e analiticamente denso das percepções dos idosos investigados, fornecendo evidências sólidas para o diagnóstico do acolhimento urbano no município. As exclusões não foram aleatórias e podem sub-representar perfis com maior vulnerabilidade informacional; os achados devem ser lidos como diagnóstico dos respondentes válidos.

3.4 ETAPAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA

O estudo foi estruturado em 03 etapas metodológicas, onde a primeira caracteriza-se pelas investigações teórico-documentais e pela coleta de dados, que abrangeram: anotações, esquemas, registros diversos e aplicação de entrevistas; a segunda pela distribuição e estruturação dos dados adquiridos na fase anterior e a terceira pelo cruzamento das informações de onde surgiram as interpretações para os resultados apresentados.

3.4.1 Etapa 01 – Estruturação das Informações e Coleta de Dados

A primeira etapa se iniciou com os procedimentos de investigação teórica; caracterização do município e coleta de dados, com as pessoas idosas participantes do estudo. Para a obtenção dos dados foram desenvolvidas 03 ações essenciais, distribuídas da seguinte forma: a) Revisão de literatura e bibliográfica; b) Caracterização do município no que se refere a aspectos demográficos, econômicos, sociais e culturais; e c) Entrevista com os usuários idosos para registro de informações que permitam posterior avaliação, com base nos domínios propostos pela EBAPI (ambiente físico (1) ; transporte (2); moradia (3); participação (4); respeito e inclusão social (5); comunicação e informação (6); oportunidades de aprendizagem (7); e (8) apoio, saúde e cuidado).

O registro das informações somente iniciava após leitura, aceite e assinatura dos Termos de Consentimento de Participação como Livre e Esclarecido - TCLE e o

Consentimento da Participação como Voluntário, que ficam em posse do Programa de origem do discente e seus orientadores.

A fim de possibilitar a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos validados e adaptados para esse estudo, sendo estes: um questionário sociodemográfico e um questionário estruturado.

O questionário sociodemográfico caracterizou os usuários entrevistados segundo faixa etária, escolaridade, estado civil, saúde autopercebida e condição previdenciária, sendo necessário todos os participantes residirem no município de Recife-PE; e o um questionário estruturado, abordando as dimensões propostas pela EBAPI, para obtenção de dados por meio de entrevistas individuais. Procurou-se manter o rigor sobre as perguntas formuladas, possibilitando a comparação dos resultados e análise das respostas. Estes dois instrumentos também foram desenvolvidos no formato digital para o maior atingimento do público investigado.

Para o questionário estruturado, foi adotado um protocolo de avaliação urbana, destinado à orientação de consulta aos idosos em relação a oito aspectos da vida que foram adaptados para a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, oriundo do Protocolo de Vancouver - Vancouver Protocol - Age-Friendly Cities Project Methodology da World Health Organization - (Brasil, 2018).

Os questionários aplicados contemplaram os seguintes eixos: ambiente físico; transporte; moradia; participação; respeito e inclusão social; comunicação e informação; oportunidades para aprendizagem; e apoio, saúde e cuidado, de acordo com as diretrizes de avaliação da EBAPI, no qual a cidade desenvolve suas ações e atividades de gestão.

A metodologia de coleta utilizada, permitiu que o participante da pesquisa, ao avaliar as variáveis presentes nesse estudo, identificasse com clareza as fragilidades das questões centrais e específicas do estudo, dentro de cada dimensão apresentada, em 06 possíveis níveis de resposta (péssimo = 1; ruim = 2; regular = 3; bom = 4; ótimo = 5; não se aplica = N/A), o que auxiliou na proposição da hierarquização dos possíveis indicadores de monitoramento, em nível de importância para saúde e a longevidade, dos usuários do estudo.

Na ocasião, os participantes receberam as devidas instruções para responder às questões e assinaram o TCLE. É importante ressaltar que os participantes tinham total liberdade de responder no momento em que recebiam o formulário ou poderiam levar para responder em casa, para posterior entrega ao pesquisador ou ao responsável do

local ao qual o mesmo teve conhecimento da pesquisa. O tempo médio de aplicação foi de mais de quarenta e cinco minutos para cada participante, quando respondido no local da pesquisa. É importante salientar, que o instrumento passou por um pré-teste com 10 idosos na UNAPI/UFPE e só foi aplicado formalmente, após ajustes que trouxeram uma melhor compreensão dos conteúdos apresentados, sem perda da essência do questionário original.

Diversas metodologias podem ser empregadas para medir a percepção, sendo a escala Likert, uma das mais comuns. Esta escala permite que os respondentes expressem seus níveis de concordância ou satisfação em uma série de declarações relacionadas ao objeto do estudo, variando de "péssimo" a "ótimo", em uma escala ordinal. Geralmente varia de 5 a 7 pontos, permitindo capturar detalhes na percepção dos respondentes. Segundo Likert (1932), essa escala é eficaz para quantificar atitudes e percepções, oferecendo dados que podem ser analisados estatisticamente.

A utilização de questionários estruturados com escalas de Likert permite a coleta de dados consistentes sobre a percepção dos indivíduos. Malhotra (2006), sugere que a aplicação de escalas de Likert é particularmente útil em estudos exploratórios e diagnósticos, como os que visam avaliar a percepção de idosos sobre as condições urbanas e políticas públicas. A coleta teve início em maio de 2025, com o consentimento do Comitê de Ética e Pesquisa - CEP e após os ajustes sugeridos na qualificação do trabalho no final de 2024. O tratamento estatístico dos dados ocorreu em novembro de 2025.

Quadro 6 – Componentes e fontes de informação para o diagnóstico		
DIAGNÓSTICO	FINALIDADE	FONTE DE INFORMAÇÃO
Caracterização do município do Recife-PE	Levantamento de dados para caracterizar o município no que se refere a aspectos demográficos, econômicos, sociais, culturais e epidemiológicos do envelhecimento.	FONTES OFICIAIS DE ACESSO LIVRE / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL
Escuta das pessoas idosas do Recife-PE	Identificar a partir da percepção dos usuários idosos, as necessidades e condições materiais atendidas, por parte do município	POPULAÇÃO IDOSA

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.4.2 Etapa 02 – Processamento de Dados

Nesta etapa, os dados coletados por meio dos instrumentos de pesquisa (questionários com idosos) foram submetidos ao processo de tratamento e organização, para garantir a qualidade e a confiabilidade necessárias à análise.

Entrada de Dados e Codificação

Software de Processamento: Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel® e posteriormente foram importados e salvos no IBM (SPSS) Statistics®, versão 20.

Codificação de Variáveis: As respostas aos questionários foram codificadas e para as questões abertas, foi realizada uma análise de conteúdo por categoria, seguida da atribuição de códigos numéricos para permitir a análise quantitativa.

Tratamento e Limpeza de Dados

Consistência e Qualidade: Foi realizada a verificação da base de dados quanto a erros de digitação, valores omissos e inconsistências lógicas.

Tratamento de Dados Ausentes: Foi definida e aplicada a estratégia para o tratamento de dados ausentes (exclusão de casos incompletos, imputação por média ou mediana), com a devida justificativa metodológica.

Identificação de valores extremos: Foi realizada a identificação e o tratamento (ou a justificativa para a manutenção) de valores extremos que pudessem distorcer as análises.

Indicadores e Escores

Estruturação da EBAPI: As variáveis brutas foram transformadas para compor os indicadores e as pontuações relativas aos 08 domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), conforme o protocolo de avaliação.

Cálculo de Escores: Foram calculados os escores finais para cada domínio e o escore global de acolhimento urbano percebido pelo idoso, permitindo a operacionalização das variáveis de pesquisa.

É importante salientar que o protocolo de pesquisa já estava adaptado à realidade nacional, e por se tratar de uma pesquisa quantitativa, em que se analisam ações com pressuposto de universalidade, não houve a priorização de indivíduos que necessariamente participem de Programas Sociais ou que recebam algum tipo de benefício governamental, o que possibilita incluir usuários de diferentes realidades socioeconômicas do município.

3.4.3 Etapa 03 – Análise de Dados

A terceira fase consistiu na análise dos dados, realizada com o objetivo de testar a hipótese proposta e responder à questão norteadora. Foram utilizadas estatísticas descritivas (distribuição de frequências, médias, desvios-padrão) para caracterizar o perfil da amostra e a percepção geral em cada um dos 8 domínios da EBAPI. Para a análise inferencial e a verificação da associação entre as variáveis, foram empregados testes, conforme a natureza dos dados e sua distribuição.

Os dados do presente estudo foram tabulados anteriormente no programa Microsoft Excel® e posteriormente foram importados e salvos no IBM SPSS Statistics®, versão 20, para a realização das análises descritivas e inferenciais.

A análise descritiva foi apresentada por meio de números absolutos e relativos das respectivas variáveis nominais estudadas e as variáveis numéricas foram exibidas por meio de medidas de tendência central (média ou mediana) e respectivas medidas de dispersão (desvio padrão ou intervalo interquartil), em conformidade com o padrão de distribuição da curva de normalidade após a verificação por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Sminorv. Desta forma, foram utilizados a média e o desvio padrão para variáveis com a distribuição paramétrica e mediana e intervalo interquartil para variáveis com um padrão não-paramétrico da curva de normalidade.

Foram realizadas as análises inferenciais por meio de testes de hipóteses, segundo o tipo de variável a ser analisada, considerando um nível de significância de 5% ($p\text{-valor} < 0,05$).

Utilizou-se o teste rho de Spearman para avaliar correlação entre a variável numérica idade e cada um dos 8 domínios do Instrumento EBPI. A escolha do teste ocorreu devido algumas variáveis apresentarem uma distribuição não paramétrica, sendo um teste mais robusto e preciso que a correlação de Pearson neste caso (Field, 2018).

O teste t de student para amostras independentes foi utilizado quando testadas as variáveis numéricas com variáveis nominais dicotômicas e a análise de variância de uma via (ANOVA-One Way) quando as variáveis numéricas foram testadas com variáveis nominais politômicas, ou seja, com mais de duas categorias. Para ambos os testes, a normalidade dos dados foi avaliada por meio dos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk e o pressuposto de homogeneidade de variância foi avaliado por meio do teste de Levene (Field, 2018).

Tanto para o teste t de student quanto para a ANOVA-One Way, realizaram-se procedimentos de bootstrapping (1000 re-amostragens; 95% IC BCa) para se obter uma maior confiabilidade dos resultados, para corrigir desvios de normalidade da distribuição da amostra e diferenças entre os tamanhos dos grupos e, inclusive, para apresentar um intervalo de confiança de 95% para as diferenças entre as médias que seja mais preciso (Haukoos; Lewis, 2005; Field, 2018).

A fim de considerar o peso da influência de cada variável independente sobre as variáveis dependentes foram interpretados os respectivos tamanhos de efeitos para o teste estatístico utilizado nas análises, em que o próprio valor de r gerado pela correlação apresenta classificações de tamanho de efeito, sendo elas: nula = 0,0; fraca = |0,10-0,39|; moderada = |0,40-0,69|; forte = |0,70-0,89|; muito forte = |0,90-0,99| e perfeita = |1,00| (Schober; Boer; Schwarte, 2018).

3.5 ASPECTOS ÉTICOS

A pesquisa seguiu as diretrizes e normas encontradas na Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta a pesquisa em seres humanos, bem como teve Cartas de Anuência para realização de todas as entrevistas. O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, recebeu o projeto de pesquisa para análise por meio do sistema Plataforma Brasil. Todas as ações de pesquisa só foram iniciadas após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra em nossos anexos. Os dados coletados na pesquisa foram armazenados com segurança e permanecerão sob os cuidados do pesquisador. **Aprovação do Comitê de Ética, sob o registro de nº. 6.578.637.**

3.6 RISCOS, BENEFÍCIOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O projeto não apresentou riscos de operacionalização e não envolveu procedimentos de alta complexidade que pudessem demandar custos que inviabilizaram a execução das atividades de pesquisa, com exceção de casos fortuitos ou de força maior, a exemplo da Pandemia da COVID-19, que veio a comprometer o prazo regulamentar do curso e da defesa do referido trabalho.

Todos os custos que se apresentaram durante o desenvolvimento da pesquisa, foram arcados pelo próprio pesquisador, incluindo as publicações que foram fruto do estudo. Existe uma expectativa que os resultados, possam contribuir no fomento de projetos de acolhimento à pessoa idosa do município diante da apresentação dos dados às diversas entidades participantes, na perspectiva de incentivar melhores práticas em favor de seus usuários idosos. No que diz respeito a devolutiva da pesquisa aos participantes, os resultados serão apresentados em encontros para que os mesmos possam compreender o valor de sua contribuição para pesquisa e para o município pesquisado.

Concluídas as etapas metodológicas e resguardados os preceitos éticos que balizaram esta investigação, os dados resultantes da análise estatística são apresentados a seguir. A exposição estrutura-se de modo a evidenciar o cumprimento dos objetivos propostos, permitindo o teste das hipóteses sobre o acolhimento urbano no Recife por meio da espacialização dos achados nas Regiões Político-Administrativas (RPAs) e do confronto com a realidade da gestão municipal.

4 RESULTADOS

A análise dos dados coletados revela o perfil demográfico e as percepções das pessoas idosas sobre o espaço urbano do Recife, estruturando o diagnóstico a partir das frequências descritivas e das correlações inferenciais. Os achados aqui expostos permitem identificar as áreas de maior vulnerabilidade e os domínios da EBAPI que demandam intervenção prioritária da gestão pública municipal. A interpretação desses resultados inicia-se pela caracterização da amostra final de 163 idosos, seguindo para as análises de variância e correlação espacial.

4.1 DADOS DESCRITIVOS DA POPULAÇÃO DO ESTUDO POR VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS

Este subcapítulo apresenta o perfil sociodemográfico da amostra, cumprindo o primeiro objetivo específico do estudo. A descrição detalhada dessas variáveis é fundamental para contextualizar e fundamentar as análises dos resultados subsequentes.

No contexto da tese, que postula a influência das desigualdades socioespaciais históricas do Recife-PE na percepção de acolhimento urbano, o perfil sociodemográfico atua como um conjunto fundamental de variáveis independentes. Idade, sexo, nível de escolaridade, renda e localização residencial (região administrativa) não são meros descritores, mas sim determinantes sociais que modulam a experiência e a percepção da pessoa idosa sobre os domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI).

Portanto, antes de adentrarmos na avaliação da percepção urbana propriamente dita, esta seção procurou: contextualizar a população do estudo, garantindo a compreensão das características da população que forneceu as devidas respostas; e buscou estabelecer quais foram as variáveis de cruzamento, para preparar o campo para as análises inferenciais, onde o cruzamento dessas variáveis com os domínios da EBAPI permitiu identificar as disparidades na percepção do acolhimento.

A Tabela 1 sintetiza a distribuição da população do estudo segundo as variáveis sociodemográficas coletadas, oferecendo uma visão panorâmica do perfil dos idosos residentes no Recife-PE que participaram da investigação.

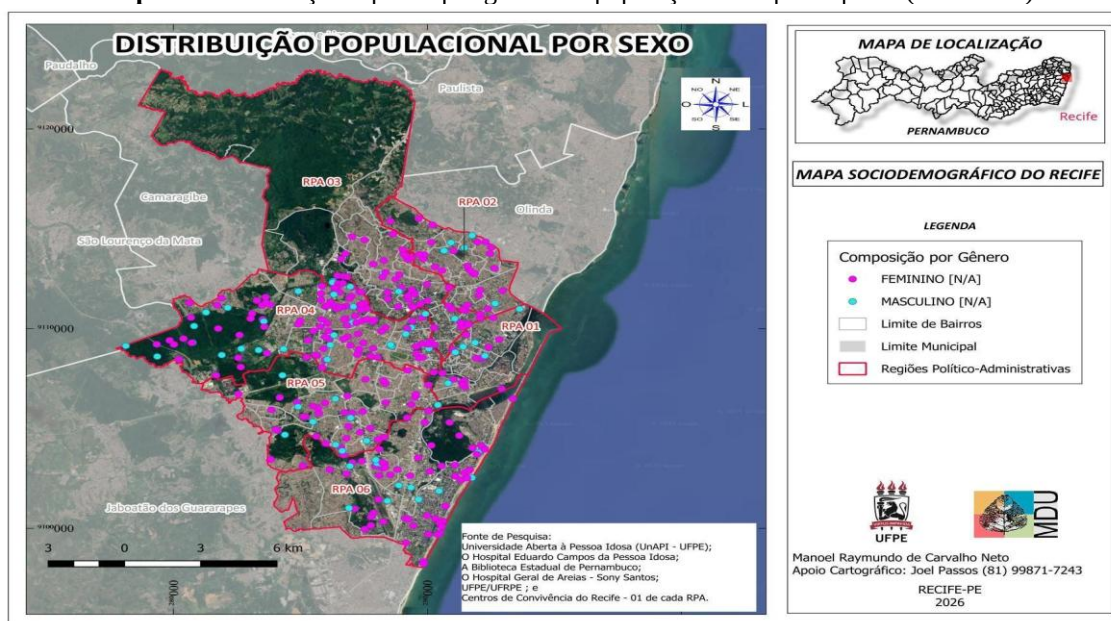
Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=336).

VARIÁVEL	n	%
Idade		
Mediana ± Intervalo Interquartil	68 ± 10	
Mínimo – máximo	60 – 88	
Faixa etária		
60 a 69 anos	204	60,7
70 a 79 anos	112	33,3
80 anos ou mais	20	6,0
Sexo		
Feminino	272	81,0
Masculino	64	19,0
Região Político-administrativa		
1	23	6,8
2	37	11,0
3	46	13,7
4	123	36,6
5	40	11,9
6	66	19,6
Não informou	1	0,3
Tempo de Residência		
Até 5 anos	18	5,4
Entre 5 e 10 anos	44	13,1
Mais de 10 anos	274	81,5
Com quem mora		
Sozinho	97	28,9
Cônjuge	129	38,4
Filhos	86	25,6
Cuidador	1	0,3
Outros	19	5,7
Não informou	4	1,2
Escolaridade		
Sem escolaridade	7	2,1
Fundamental Incompleto	31	9,2
Fundamental Completo	26	7,7
Médio Incompleto	20	6,0
Médio Completo	70	20,8
Superior Incompleto	28	8,3
Superior Completo	78	23,2
Pós-graduação	75	22,3
Não informou	1	0,3

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico dos idosos participantes da pesquisa, que se caracteriza predominantemente por indivíduos do sexo feminino (81,0%) e idosos, com idade média de 68 anos (60 a 88 anos). A maior parte dos participantes (60,7%) está na faixa etária de 60 a 69 anos.

Mapa 1 – Distribuição espacial por gênero da população idosa participante (Recife-PE).

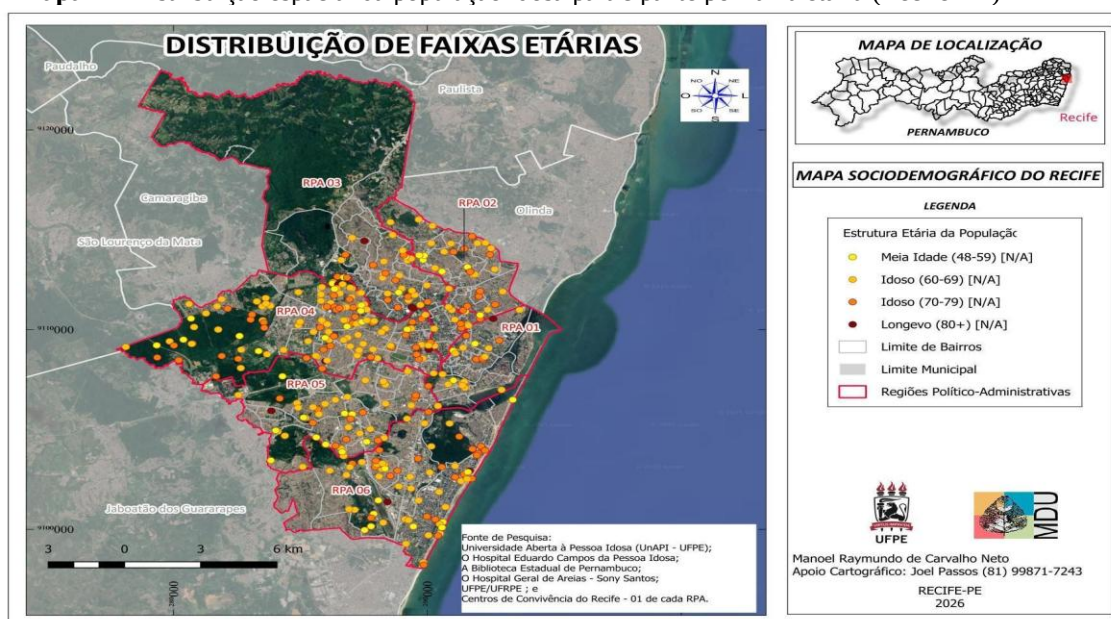


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A distribuição espacial dessas características demográficas pode ser observada nos Mapa 1 (Gênero) e Mapa 2 (Faixa Etária), que ilustram a capilaridade da amostra pelas seis RPAs do Recife.

Observa-se um forte vínculo com o local de estudo, 81,5% dos participantes residem no município há mais de 10 anos. Em relação ao arranjo de moradia, a maioria vive com o cônjuge (38,4%), seguida pelos que moram sozinhos (28,9%) e aqueles que residem com filhos (25,6%).

Mapa 2 – Distribuição espacial da população idosa participante por faixa etária (Recife-PE)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A consolidação do idoso no território é um fator de pertencimento. O Mapa 3 demonstra que a maioria da amostra possui um vínculo de longa duração com seus bairros, o que qualifica sua percepção sobre as mudanças urbanas.

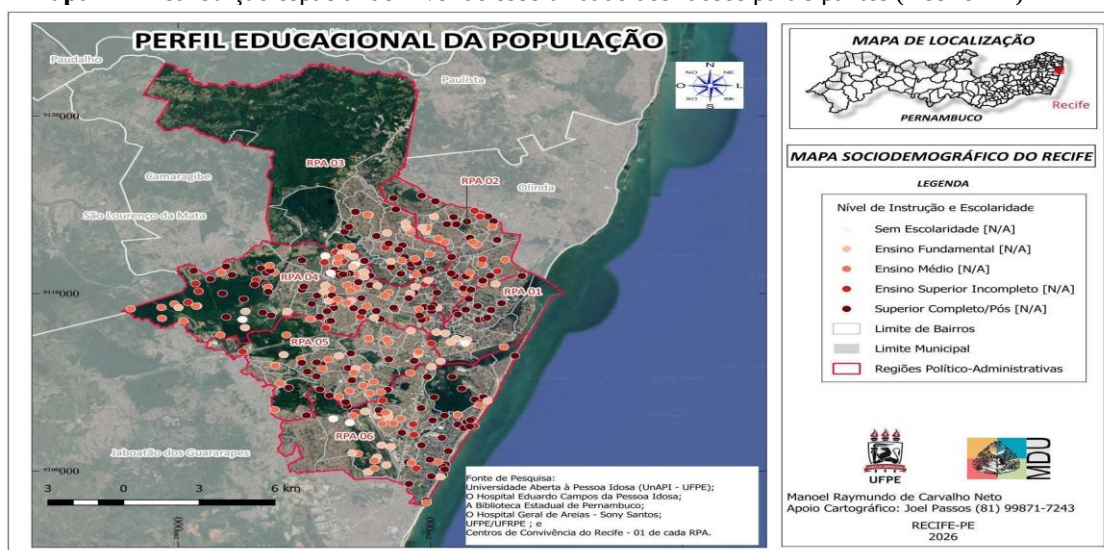
Mapa 3 – Tempo de residência dos idosos participantes no município do Recife-PE.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A amostra demonstra um alto nível educacional, contrastando com a renda. Quase metade dos idosos (45,5%) possui Ensino Superior (23,2%) ou Pós-graduação (22,3%). Os menores graus de escolaridade incluem sem escolaridade (2,1%), Ensino Médio incompleto (6%) e Ensino Fundamental completo (7,7%). Essa concentração de capital cultural não é uniforme no território. O Mapa 4 ilustra como os níveis mais elevados de instrução se distribuem geograficamente, evidenciando disparidades que, como será demonstrado na análise inferencial, impactam diretamente a percepção do idoso sobre o acolhimento da cidade.

Mapa 4 – Distribuição espacial do nível de escolaridade dos idosos participantes (Recife-PE)



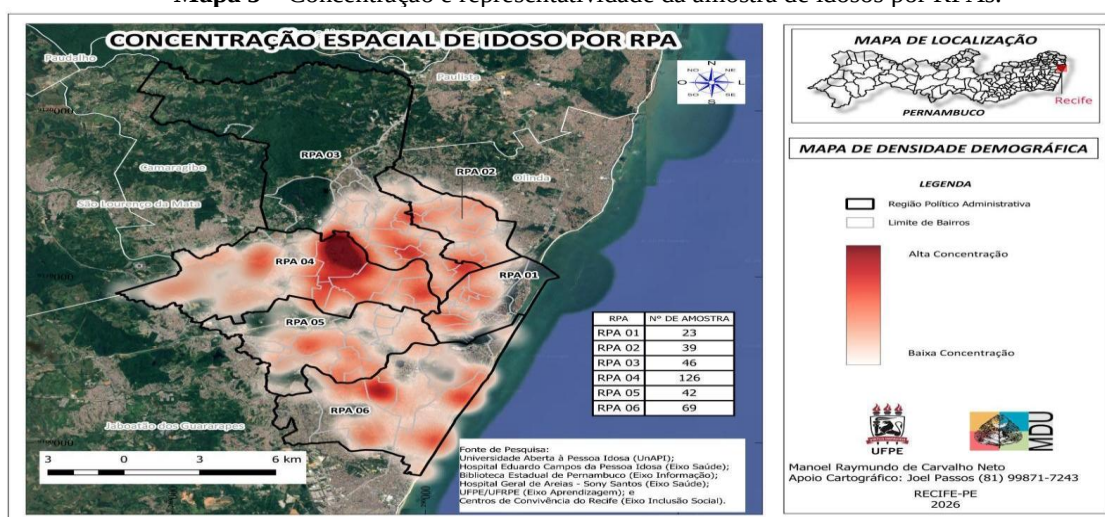
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A visualização espacial da escolaridade reforça a hipótese de que o acesso à informação e a capacidade de navegação urbana (suporte cognitivo) estão atrelados ao histórico socioeducacional do indivíduo em cada RPA.

Apesar do nível educacional, a maioria recebe até um salário mínimo (28,3%) e é aposentada (58,6%). Geograficamente, os idosos estão distribuídos em 06 Regiões Político-administrativas (RPAs), sendo a RPA 4 a mais representativa em concentração de idosos (36,6%), seguida sucessivamente pela RPA 6 (19,6%), RPA 3 (13,7%), RPA 5 (11,9%), RPA 2 (11,0%) e RPA 1 (6,8%). Dos 94 bairros que compõem as 06 RPAs do Recife, tivemos registrados em nossa pesquisa, 60 bairros deste total.

Dentro da RPA 01 os bairros que mais apareceram foram (Boa Vista, Joana Bezerra, Santo Amaro e São José); RPA 02 (Afogados, Água Fria, Alto Santa Teresinha, Campo Grande, Dois Unidos e Encruzilhada); RPA 3 (Alto José Bonifácio, Casa Amarela, Espinheiro e Parnamirim); RPA 4 (Cordeiro, Engenho do Meio, Iputinga, Torre e Várzea); RPA 5 (Areias, Barro, Curado e Jardim São Paulo); e RPA 6 (Boa Viagem, Ibura, Imbiribeira, Ipsep e Pina). Para melhor compreensão da abrangência territorial desta investigação, o Mapa 5 apresenta a distribuição quantitativa da amostra por RPA, evidenciando as áreas de maior densidade de respostas e a cobertura espacial alcançada nos 60 bairros registrados.

Mapa 5 – Concentração e representatividade da amostra de idosos por RPAs.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Como observado, a RPA 4 apresenta-se como a mais representativa em volume de dados, o que confere ao diagnóstico uma visão robusta sobre as áreas de transição e expansão urbana do Recife.

Para aprofundar as análises e identificar determinantes sociodemográficos

relevantes, o estudo buscou descrever as informações de saúde e laborais dos idosos participantes, detalhadas na Tabela 2.

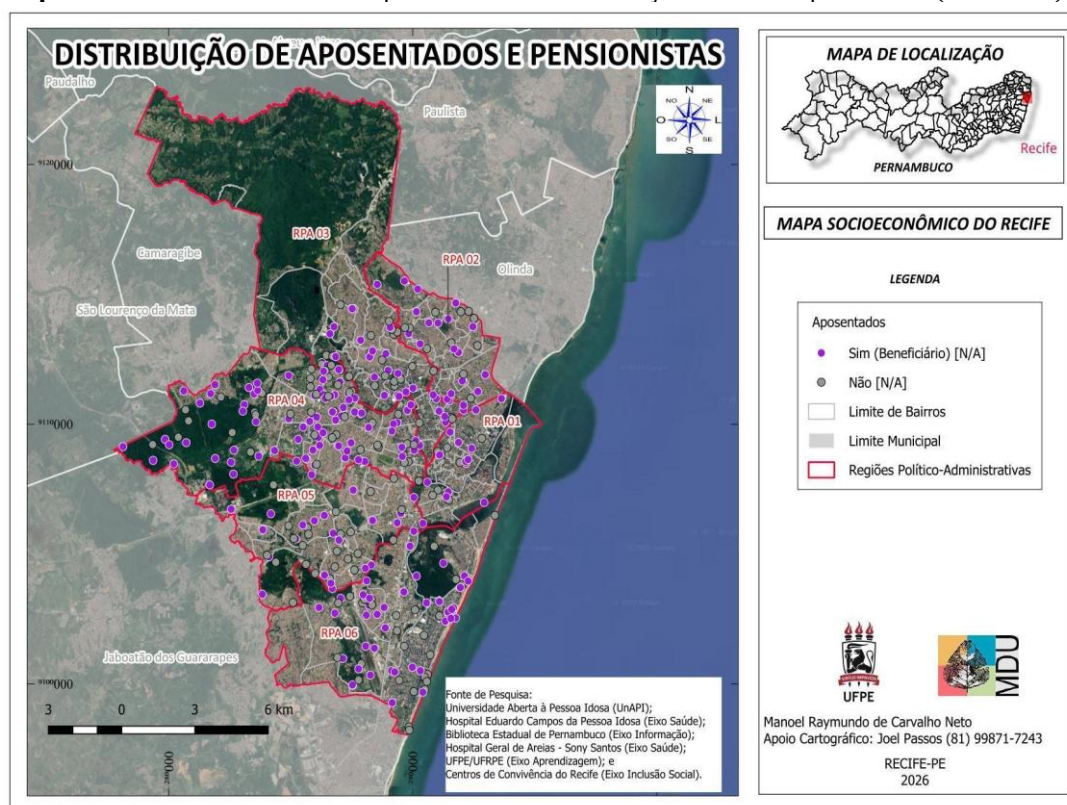
Tabela 2 - Dados laborais e de saúde dos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=336).

VARIÁVEL	N	%
Trabalha		
Sim	69	20,5
Não	267	79,5
Se sim, qual atividade?		
Atividades operacionais	6	8,7
Atividades gerenciais	1	1,4
Saúde	8	11,6
Educação	18	26,1
Autônomo	22	31,9
Servidor público	11	15,9
Não informado	3	4,4
Aposentado		
Sim	197	58,6
Não	137	40,8
Não informado	2	0,6
Renda		
Até 1 salário mínimo	95	28,3
De 1 a 2 salários mínimos	62	18,5
De 2 a 3 salários mínimos	43	12,8
De 3 a 5 salários mínimos	52	15,5
De 5 a 10 salários mínimos	48	14,3
Mais de 10 salários mínimos	26	7,7
Não informado	10	3,0
Acompanhamento médico		
Sim, mensalmente	33	9,8
Sim, a cada 3 meses	46	13,7
Sim, semestralmente	226	67,3
Não	26	7,7
Não informado	5	1,5
Faz uso de medicamentos?		
Sim	272	81,0
Não	60	17,9
Não informado	4	1,2
Apresenta alguma deficiência?		
Sim	37	11,0
Não	299	89,0
Se sim, qual?		
Auditiva	2	5,4
Visual	1	2,7
Cognitiva	2	5,4
Mobilidade reduzida	32	86,5
Qual problema de mobilidade especificamente?		
Problemas articulares/ ósseo	23	71,0
Limitação por câncer	5	16,0
Problemas musculares	2	6,5
Problemas cardíacos	1	3,2
Parkinson	1	3,2

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A maioria dos idosos não trabalha (79,5%), daqueles 20,5% que trabalham, a maioria afirmou que exerce atividades como autônomo (31,9%), no setor de educação (26,1%) e servidor público (15,9%), respectivamente. A dinâmica entre a atividade laboral e a condição de aposentadoria apresenta padrões de ocupação distintos no território. O Mapa 6 ilustra essa distribuição, revelando os pólos onde a presença do idoso ativo ou inativo é mais latente nas RPAs estudadas, o que influencia diretamente seus fluxos diários na cidade.

Mapa 6 – Panorama das atividades profissionais e concentração de idosos aposentados (Recife-PE)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A maioria dos idosos informou que é aposentado, apresenta uma renda de até um salário mínimo, sendo importante destacar que 15,5% dos idosos ganham até 5 salários mínimos, 14,3% até 10 salários mínimos e 7,7% mais de 10 salários mínimos.

Para além dos valores nominais apresentados, a espacialização da renda revela o desenho das desigualdades socioeconômicas no território. O Mapa 7 ilustra como os diferentes patamares de rendimento se distribuem pelas RPAs, permitindo correlacionar o poder aquisitivo com a localização residencial em áreas com distintos níveis de infraestrutura urbana.

A análise visual do Mapa 7 evidencia que a estratificação da renda no Recife guarda estreita relação com a divisão por RPAs, sugerindo que o poder aquisitivo pode atuar como um mediador no acesso a ambientes urbanos mais qualificados. Todavia, conforme discutido nas análises inferenciais, essa vantagem financeira não necessariamente se traduz em uma percepção uniforme de acolhimento, uma vez que as barreiras físicas da cidade impõem desafios que perpassam as diferentes classes econômicas.

Mapa 7 – Distribuição espacial dos níveis de renda mensal da população idosa participante (Recife-PE)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A distribuição observada reforça a necessidade de equipamentos de lazer e saúde de proximidade, uma vez que o uso do território por idosos aposentados tende a ser mais intensivo no próprio bairro de residência.

Em relação à saúde e autonomia, a maioria dos participantes (67,3%) realiza acompanhamento médico semestral. A maior parte (89%) não possui deficiência, mas 81% fazem uso contínuo de medicamentos. Entre os que apresentam deficiência, a mobilidade é a mais afetada (86,5%), decorrente principalmente de problemas articulares ou ósseos (72,0%), conforme detalhado na Tabela 2.

A compreensão das limitações físicas e das demandas por saúde ganha contornos territoriais no Mapa 8. A espacialização dos idosos com restrições de mobilidade evidencia as áreas da cidade onde as barreiras arquitetônicas e urbanísticas (Domínio 1 da EBAPI) tornam-se obstáculos intransponíveis para a autonomia.

Mapa 8 – Distribuição espacial das condições de saúde e restrições de mobilidade da população idosa

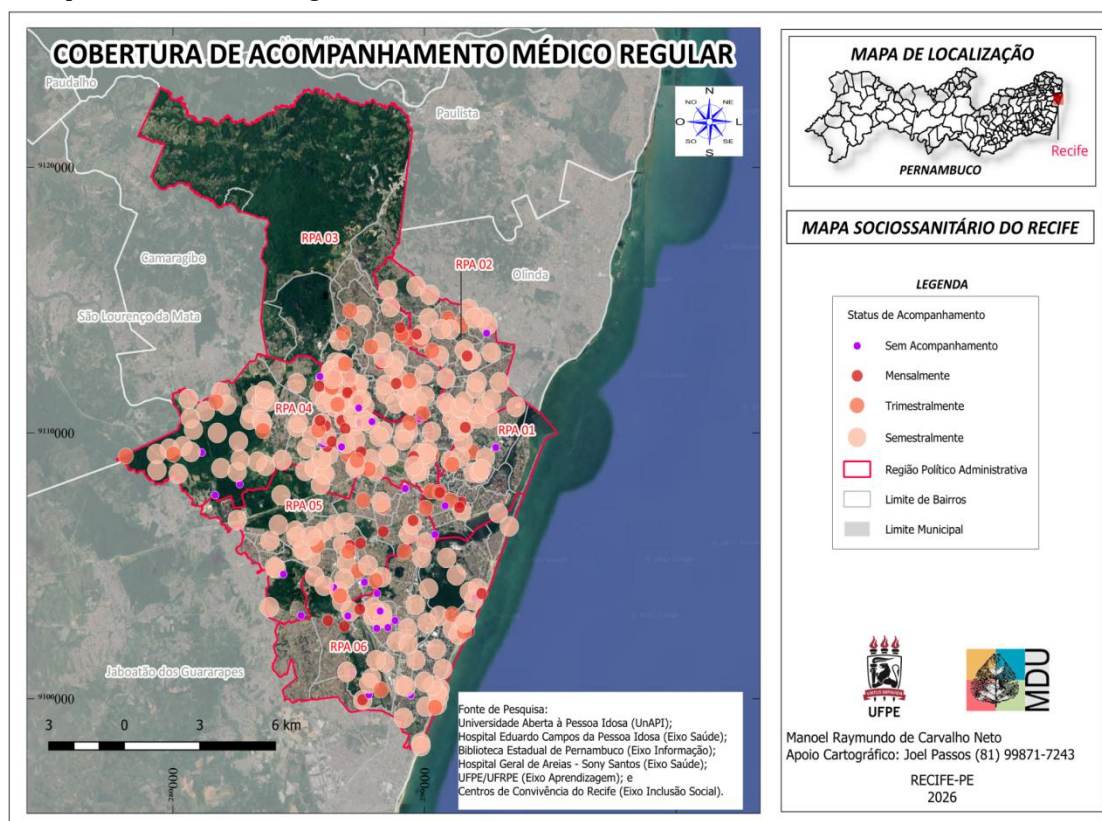


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A compreensão das condições de saúde e restrições de mobilidade exige, contudo, um olhar mais atento sobre a rotina de cuidados e a dependência medicamentosa dos participantes, variáveis que exercem pressão direta sobre a necessidade de deslocamento e a demanda por um ambiente urbano acessível. Nesse sentido, os mapas subsequentes detalham o comportamento da amostra em relação ao suporte clínico e farmacológico.

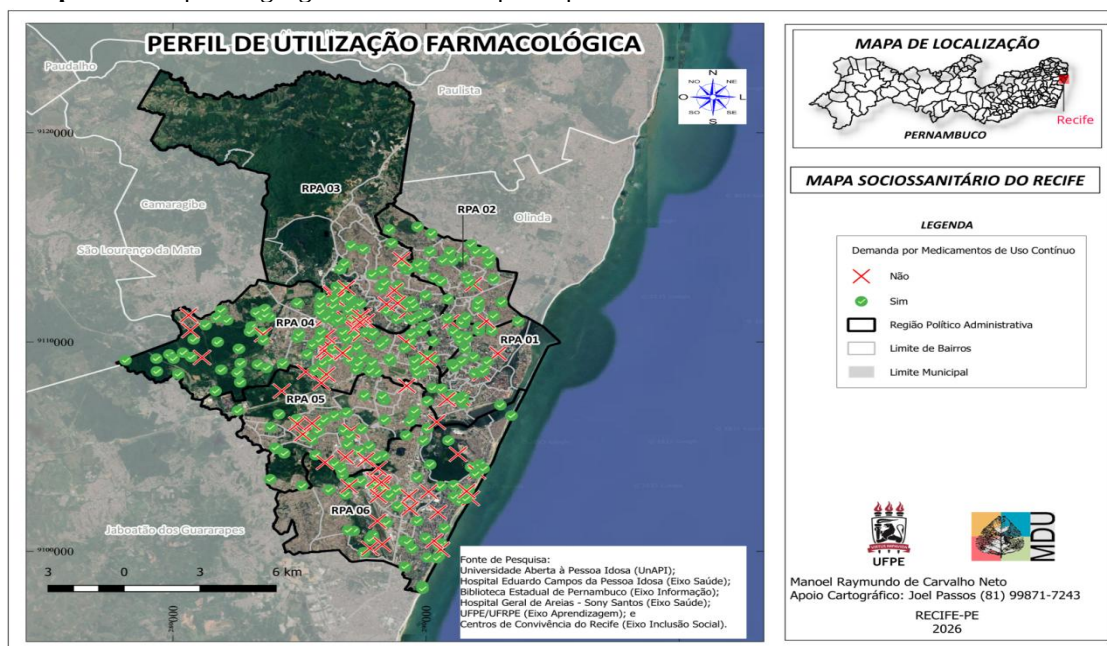
Conforme observado no Mapa 9, a necessidade de acompanhamento médico é uma constante distribuída por todas as RPAs. No entanto, essa demanda por saúde colide com a realidade do transporte público e do ambiente físico já diagnosticados. Essa vulnerabilidade é acentuada quando analisamos a dependência farmacológica (Mapa 10), que impõe ao idoso a necessidade de saídas frequentes para a aquisição de medicamentos de uso contínuo.

Mapa 9 – Distribuição espacial da população idosa participante segundo a realização de acompanhamento médico regular.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Mapa 10 – Dispersão geográfica dos idosos participantes conforme o uso contínuo de medicamentos.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O panorama consolidado por estes dez mapas de caracterização revela que o idoso recifense possui um vínculo territorial forte, mas é marcado por necessidades de saúde e mobilidade que a infraestrutura urbana atual, conforme será detalhado a seguir através das notas dos domínios EBAPI, falha em suprir de maneira equânime.

O cruzamento desses dados de saúde com a geografia do Recife encerra a caracterização da amostra e prepara o campo para a análise da percepção. Como demonstrado nesta sequência de oito mapas, a experiência do envelhecer no Recife é indissociável da localização geográfica e do perfil socioeducacional do idoso, variáveis que modelam as notas de satisfação apresentadas a seguir.

4.2 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SEGUNDO OS DOMÍNIOS DA ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA (EBAPI)

Após a caracterização sociodemográfica e a espacialização da amostra total (n=336) no item anterior, procede-se à análise da percepção dos idosos sobre os domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI). É importante ressaltar que, para esta análise específica, a amostra consolidada compreende 163 participantes que responderam integralmente ao instrumento de coleta, garantindo a integridade dos dados estatísticos apresentados.

Para conferir robustez aos achados, os dados foram confrontados com os indicadores do Censo 2022 (SIDRA/IBGE) para o município do Recife. Este confronto revela uma convergência significativa em variáveis críticas, como o predomínio feminino (feminização da velhice) e as disparidades de renda entre as RPAs, validando a amostra como um espelho fidedigno das heterogeneidades do envelhecimento na capital pernambucana.

O rigor metodológico foi estabelecido por meio de três etapas interligadas: a Estruturação da Informação e Coleta de Dados (trabalho de campo), o Processamento dos Dados e, por fim, a Análise e Interpretação dos Resultados. Esta seção, portanto, apresenta a Avaliação da Percepção dos Idosos por Domínio, utilizando os dados processados para quantificar as impressões da população estudada, distribuída pelas seis regiões administrativas do município.

4.2.1 A Cidade Percebida: Avaliação dos Domínios da EBAPI, Classificação Geral e Ranking de Satisfação

A percepção dos idosos de Recife-PE sobre o acolhimento urbano, avaliada pela Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), revela um padrão heterogêneo de satisfação, mas com focos críticos nos domínios relacionados à infraestrutura e à mobilidade.

Além dos objetivos já expostos e visando exibir nossa avaliação da percepção de usuários idosos em relação aos 08 domínios, apresentamos as Tabelas 3, 4 e 5. Estas tabelas contêm os dados referentes às impressões da população estudada, distribuída nas 06 regiões administrativas, sobre o ambiente urbano do Recife-PE.

Tabela 3 - Pontuação de cada domínio do EBAPI informada pelos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

VARIÁVEL	Mediana $\pm$ Intervalo Interquartil	Mínimo – máximo
Domínio		
Ambiente físico	1,91 $\pm$ 1,00	1,00 – 5,00
Transporte/ Mobilidade urbana	1,91 $\pm$ 1,00	0,50 – 4,50
Moradia	2,68 $\pm$ 1,56	0,31 – 5,00
Participação	1,71 $\pm$ 1,07	0,18 – 4,78
Respeito e inclusão social	2,80 $\pm$ 1,37	0,10 – 5,00
Comunicação e informação	2,50 $\pm$ 1,17	0,50 – 5,00
Oportunidades de aprendizagem	2,33 $\pm$ 1,44	0,33 – 5,00
Apoio, saúde e cuidado	2,05 $\pm$ 1,29	0,23 – 4,51

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os escores evidenciam que o sentimento de acolhimento é maior nos domínios subjetivos e de proximidade, Respeito e Inclusão Social (Mediana=2,80), seguido por Moradia (Mediana=2,68), como as áreas de maior acolhimento percebido. Logo em seguida temos Comunicação e informação (2,50), Oportunidade de aprendizagem (2,33) e Apoio, saúde e cuidado (2,05), em um nível intermediário. Em contrapartida, os domínios estruturantes da experiência urbana, Participação (Mediana=1,71), Ambiente Físico (Mediana=1,91) e Transporte/Mobilidade Urbana (Mediana=1,91), foram os que apresentaram as menores pontuações, indicando as áreas mais críticas (Tabela 3). Essa hierarquia de percepção é detalhada no Quadro 7.

Quadro 7 - Hierarquia de Acolhimento Percebido

Posição	Domínio EBAPI	STATUS
1º	Respeito e Inclusão Social (2,80)	ELEVADO
2º	Moradia (2,68)	ELEVADO
3º	Comunicação e Informação (2,50)	INTERMEDIÁRIO
4º	Oportunidades de Aprendizagem (2,33)	INTERMEDIÁRIO
5º	Apoio, Saúde e Cuidado (2,05)	CRÍTICO
6º	Ambiente Físico (1,91)	CRÍTICO
7º	Transporte/Mobilidade Urbana (1,91)	CRÍTICO
8º	Participação (1,71)	CRÍTICO

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A convergência das menores notas nos domínios de Ambiente Físico e Transporte (ambos com 1,91) evidencia que a deficiência na infraestrutura urbana — como calçadas irregulares e barreiras na mobilidade — atua como o principal limitador da longevidade ativa no Recife.

Esse cenário torna-se ainda mais crítico ao observar o domínio Participação (1,71), que obteve a menor pontuação geral. Tal resultado sugere que as barreiras físicas do território não apenas dificultam o deslocamento, mas promovem um isolamento social involuntário, retraindo o idoso do convívio comunitário.

Verifica-se que todos os domínios investigados possuíam subitens que permitiam ser avaliados separadamente, para que pudéssemos identificar qual a maior fragilidade percebida em cada um deste eixos, permitindo realizar uma classificação por ordem de relevância mediante pontuação, conforme pode ser notado na Tabela 4.

Tabela 4 - Pontuação de cada domínio do EBAPI informada pelos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

VARIÁVEL	Mediana ± Intervalo Interquartil	Mínimo – máximo
Ambiente físico (n=290)		
Calçadas em sua localidade	2,00 ± 1,80	1,00 – 5,00
Relação com o Trânsito	1,80 ± 1,40	0,40 – 4,80
Iluminação Pública	2,25 ± 1,50	1,00 – 5,00
Sinalização Urbana	2,00 ± 2,00	0,50 – 5,00
Banheiros Públicos	1,33 ± 1,00	0,30 – 4,30
Assentos Públicos (Bancos)	1,50 ± 1,50	0,50 – 5,00
Acesso a Prédios e Serviços na Cidade	2,00 ± 1,00	1,00 – 5,00
Praças e Pontos de Encontro Comunitários	2,33 ± 1,70	0,70 – 5,00
Transporte/ Mobilidade urbana (n=299)		
A Sinalização dos Destinos e das Rotas	2,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Assentos Prioritários	2,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Segurança	1,00 ± 1,00	1,00 – 5,00
Motoristas	2,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Pontos de Embarque	2,00 ± 2,00	0,50 – 5,00
O comportamento da população	2,00 ± 2,00	0,50 – 5,00
Moradia (n=156)		
A mobilidade dentro de sua casa	2,75 ± 1,3	1,00 – 5,00
As condições Financeiras	3,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Proteção da Casa	3,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Saneamento Básico	3,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Participação (n=237)		
Participação Cidadã	2,40 ± 1,30	0,20 – 5,00
Trabalho e Sustento	2,00 ± 1,30	0,70 – 4,30
Fundo Municipal do Idoso	1,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Respeito e inclusão social (n=271)		
Direito a vagas preferenciais em serviços, espaços, atividades culturais e turismo	3,00 ± 1,50	0,50 – 5,00
Prevenção e combate ao preconceito e violência contra a pessoa idosa	2,33 ± 2,00	0,30 – 5,00
Aposentadoria e Previdência Social	3,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Família e Amigos	4,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Participação de Atividades exclusivas para pessoas idosas	3,00 ± 1,50	0,50 – 5,00
Comunicação e informação (n=305)		
Fontes de informações sobre as atividades e serviços públicos	3,00 ± 1,70	0,70 – 5,00
Leitura	2,50 ± 1,50	0,50 – 5,00
Oportunidades de aprendizagem (n=274)		
Educação Básica	3,00 ± 2,00	1,00 – 5,00
Cursos, Palestras ou aulas em áreas de interesse	2,66 ± 1,30	0,30 – 5,00
Aprendizagem para trabalho	2,00 ± 2,00	0,50 – 5,00
Apoio, saúde e cuidado (n=262)		
Serviço de Saúde na Localidade que Mora	2,50 ± 1,20	0,50 – 5,00
Atendimento da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade	2,20 ± 1,40	0,20 – 5,00
Instituições de Longa Permanência	2,00 ± 2,00	0,50 – 5,00
Acesso a Benefícios e Serviços da Assistência Social	2,00 ± 1,70	0,30 – 5,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A tabela 4 apresenta a pontuação obtida em cada subitem dos domínios avaliados pelo instrumento EBAPI, permitindo uma análise detalhada das fragilidades e potencialidades. Observa-se que no domínio Ambiente, o subitem que apresentou maior pontuação foi ‘Praças e Pontos de Encontro Comunitários’ (Mediana=2,33) e o que apresentou menor pontuação foi ‘Banheiros Públicos’ (Mediana=1,33). Já no domínio Transporte/ Mobilidade urbana observa-se que todos os subitens apresentaram pontuação igual (Mediana=2,00) com exceção de do subitem ‘Segurança’ (Mediana=1,00) que apresentou uma pontuação inferior aos demais puxando a média para baixo.

Semelhante ao domínio Transporte/ Mobilidade urbana, o domínio Moradia apresentou todos subitens com mesma pontuação (Mediana=3,00), com exceção do subitem ‘A mobilidade dentro da sua casa’ (Mediana=2,75) que demonstrou pontuação inferior aos demais (Tabela 4).

No domínio Participação identifica-se que o subitem de maior pontuação foi ‘Participação cidadã’ (Mediana=2,40) e o com menor pontuação foi ‘Fundo municipal do idoso’ (Mediana=1,00). Quanto ao domínio Respeito e inclusão social, o subitem que obteve maior pontuação foi ‘Família e amigos’ (Mediana=4,00) e o que apresentou menor pontuação foi ‘Prevenção e combate ao preconceito e violência contra a pessoa idosa’ (Mediana=2,33) (Tabela 4).

Ainda na tabela 4, o domínio Comunicação e informação, teve no subitem ‘Fontes de Informações sobre as atividades e serviços públicos’ aquele que apresentou maior pontuação (Mediana= 3,00), enquanto que o subitem ‘Leitura’ foi o que apresentou menor pontuação (Mediana=2,50). Dentro do domínio Oportunidades de aprendizagem, o subitem de maior pontuação foi ‘Educação básica’ (Mediana=3,00) e o de menor pontuação foi ‘Aprendizagem para o trabalho’ (Mediana=2,00).

Quanto ao domínio Apoio, saúde e cuidado, o subitem que pontuou melhor foi ‘Serviço de Saúde na Localidade que Mora’ (Mediana=2,50) e dois subitens neste domínio pontuaram como os piores (Mediana=2,00), sendo eles ‘Instituições de Longa Permanência’ e ‘Acesso a Benefícios e Serviços da Assistência Social’, conforme pode ser visualizado na tabela 4.

Tabela 4.1 - Classificação dos subitens de cada domínio do EBAPI informada pelos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

POSICÃO	PONTUAÇÃO	Ambiente físico (n=290)
1º	2,33 ± 1,70	Praças e Pontos de Encontro Comunitários
2º	2,25 ± 1,50	Iluminação Pública
3º	2,00 ± 2,00	Sinalização Urbana
3º	2,00 ± 1,80	Calçadas em sua localidade
3º	2,00 ± 1,00	Acesso a Prédios e Serviços na Cidade
4º	1,80 ± 1,40	Relação com o Trânsito
5º	1,50 ± 1,50	Assentos Públicos (Bancos)
6º	1,33 ± 1,00	Banheiros Públicos
POSICÃO	PONTUAÇÃO	Transporte/Mobilidade urbana (n=299)
1º	2,00 ± 2,00	A Sinalização dos Destinos e das Rotas
1º	2,00 ± 2,00	Assentos Prioritários
1º	2,00 ± 2,00	Motoristas
1º	2,00 ± 2,00	Pontos de Embarque
1º	2,00 ± 2,00	O comportamento da população
2º	1,00 ± 1,00	Segurança

POSICÃO	PONTUAÇÃO	Moradia (n=156)
1º	3,00 ± 2,00	As condições Financeiras
1º	3,00 ± 2,00	Proteção da Casa
1º	3,00 ± 2,00	Saneamento Básico
2º	2,75 ± 1,3	A mobilidade dentro de sua casa
POSICÃO	PONTUAÇÃO	Participação (n=237)
1º	2,40 ± 1,30	Participação Cidadã
1º	2,00 ± 1,30	Trabalho e Sustento
2º	1,00 ± 2,00	Fundo Municipal do Idoso
POSICÃO	PONTUAÇÃO	Respeito e inclusão social (n=271)
1º	4,00 ± 2,00	Família e Amigos
2º	3,00 ± 2,00	Aposentadoria e Previdência Social
2º	3,00 ± 1,50	Direito à vagas preferenciais em serviços, espaços, atividades culturais e
2º	3,00 ± 1,50	Participação de Atividades exclusivas para pessoas idosas
3º	2,33 ± 2,00	Prevenção e combate ao preconceito e violência contra a pessoa idosa
POSICÃO	PONTUAÇÃO	Comunicação e informação (n=305)
1º	3,00 ± 1,70	Fontes de Informações sobre as atividades e serviços públicos
2º	2,50 ± 1,50	Leitura
POSICÃO	PONTUAÇÃO	Oportunidades de aprendizagem (n=274)
1º	3,00 ± 2,00	Educação Básica
2º	2,66 ± 130	Cursos, Palestras ou aulas em áreas de interesse
3º	2,00 ± 2,00	Aprendizagem para trabalho
POSICÃO	PONTUAÇÃO	Apoio, saúde e cuidado (n=262)
1º	2,50 ± 1,20	Serviço de Saúde na Localidade que Mora
2º	2,20 ± 1,40	Atendimento da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade
3º	2,00 ± 2,00	Instituições de Longa Permanência
4º	2,00 ± 1,70	Acesso a Benefícios e Serviços da Assistência Social

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Em continuidade, apresentamos a Tabela 5 que nos mostra a pontuação média obtida para cada domínio avaliado pelo instrumento EBAPI, com a separação dos dados por Região Político-Administrativa (RPA) do município de Recife-PE, conforme as percepções informadas pelos idosos participantes da pesquisa. Em seguida, apresentamos a classificação dos domínios por RPA, o que nos permite identificar disparidades territoriais na eficácia das políticas públicas.

Tabela 5 - Pontuação de cada domínio do EBAPI por região político-administrativa (RPA) do município de Recife-PE informada pelos idosos participantes da pesquisa.

	RPA 1 (n=14)	RPA 2 (n=19)	RPA 3 (n=18)	RPA 4 (n=59)	RPA 5 (n=22)	RPA 6 (n=31)
Domínio	<i>M ± DP</i> <i>(Min-Máx)</i>	<i>M ± DP</i> <i>(Min-Máx)</i>	<i>M ± DP</i> <i>(Min-Máx)</i>	<i>M ± DP</i> <i>(Min-Máx)</i>	<i>M ± DP</i> <i>(Min-Máx)</i>	<i>M ± DP</i> <i>(Min-Máx)</i>
<i>Ambiente físico</i>	1,96 ± 0,54 (1,00-3,00)	2,07 ± 0,72 (1,00-3,00)	2,22 ± 1,10 (1,00-5,00)	1,85 ± 0,68 (1,00-4,00)	2,04 ± 0,72 (1,00-4,00)	2,28 ± 0,96 (1,00-5,00)
<i>Transporte/ Mobilidade urbana</i>	2,32 ± 0,82 (1,33-4,00)	1,92 ± 0,71 (1,08-4,00)	2,25 ± 0,93 (0,67-3,92)	1,96 ± 0,73 (0,67-3,42)	2,15 ± 0,81 (0,50-4,50)	2,02 ± 0,89 (0,83-4,42)
<i>Moradia</i>	2,98 ± 1,03 (1,50-4,69)	2,60 ± 0,76 (1,00-3,63)	2,92 ± 1,03 (1,25-4,38)	2,53 ± 0,95 (0,31-5,00)	2,78 ± 0,95 (0,56-4,13)	2,91 ± 1,08 (1,00-4,69)
<i>Participação</i>	1,74 ± 0,83 (0,53-3,00)	1,84 ± 1,05 (0,22-3,89)	2,23 ± 0,92 (0,62-4,78)	1,74 ± 0,83 (0,18-3,84)	1,91 ± 0,80 (0,56-4,47)	1,89 ± 0,63 (0,64-3,00)
<i>Respeito e inclusão social</i>	2,54 ± 0,96 (1,40-4,23)	2,45 ± 1,04 (0,10-3,73)	2,94 ± 0,78 (1,77-4,80)	2,66 ± 0,87 (0,47-4,33)	2,87 ± 1,04 (0,30-5,00)	3,04 ± 1,06 (1,00-4,70)
<i>Comunicação e informação</i>	2,77 ± 0,89 (1,08-4,17)	2,52 ± 0,96 (1,00-4,50)	2,60 ± 1,04 (1,17-5,00)	2,53 ± 0,98 (0,50-4,83)	2,61 ± 0,96 (1,00-4,50)	2,65 ± 1,04 (1,00-5,00)
<i>Oportunidades de aprendizagem</i>	2,32 ± 0,78 (1,00-3,50)	2,16 ± 0,89 (0,50-4,28)	2,49 ± 1,05 (1,00-5,00)	2,40 ± 0,98 (0,33-4,56)	2,44 ± 1,03 (1,00-4,00)	2,83 ± 1,38 (0,44-5,00)
<i>Apoio, saúde e cuidado</i>	1,82 ± 0,83 (0,68-3,18)	1,77 ± 0,72 (0,50-3,52)	2,41 ± 1,11 (0,95-4,51)	2,18 ± 0,83 (0,48-3,97)	2,29 ± 1,05 (0,67-4,35)	2,20 ± 0,88 (0,23-3,73)

RPA- região político-administrativa; M-média; DP-desvio padrão; Mín-mínimo; Máx-máximo.

Em relação às pontuações de cada domínio do EBAPI por região político-administrativa (RPA) do município de Recife-PE informada pelos idosos participantes da pesquisa, observa-se que o domínio ‘Respeito e inclusão social’ foi o que obteve as maiores pontuações na maioria das regiões político-administrativas, ou seja, quatro das seis apresentadas. A exceção foi para as regiões 1 e 2 que tiveram destaque, respectivamente, para o domínio ‘Moradia’, conforme pode ser visto na Tabela 5.

Já o domínio ‘Participação’ foi o que apresentou as menores pontuações na maioria das regiões político-administrativas, exceto na região 2 que pontuou mais baixo o domínio ‘Apoio, saúde e cuidado’ e a região 3 que apresentou o domínio ‘Ambiente físico’ com as menores pontuações (Tabela 5).

Tabela 5.1 - Classificação dos domínios do EBAPI por RPA pelos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

POSIÇÃO	RPA 1	RPA 2
1º	Moradia	Moradia
2º	Comunicação e informação	Comunicação e informação
3º	Respeito e inclusão social	Respeito e inclusão social
4º	Oportunidades de aprendizagem	Oportunidades de aprendizagem
5º	Transporte/ Mobilidade urbana	Ambiente físico
6º	Ambiente físico	Transporte/ Mobilidade urbana
7º	Apoio, saúde e cuidado	Participação
8º	Participação	Apoio, saúde e cuidado
POSIÇÃO	RPA 3	RPA 4
1º	Respeito e inclusão social	Respeito e inclusão social
2º	Moradia	Moradia
3º	Comunicação e informação	Comunicação e informação
4º	Oportunidades de aprendizagem	Oportunidades de aprendizagem
5º	Apoio, saúde e cuidado	Apoio, saúde e cuidado
6º	Transporte/ Mobilidade urbana	Transporte/ Mobilidade urbana
7º	Participação	Ambiente físico
8º	Ambiente físico	Participação
POSIÇÃO	RPA 5	RPA 6
1º	Respeito e inclusão social	Respeito e inclusão social
2º	Moradia	Moradia
3º	Comunicação e informação	Oportunidades de aprendizagem
4º	Oportunidades de aprendizagem	Comunicação e informação
5º	Apoio, saúde e cuidado	Ambiente físico
6º	Transporte/ Mobilidade urbana	Apoio, saúde e cuidado
7º	Ambiente físico	Transporte/ Mobilidade urbana
8º	Participação	Participação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 ANÁLISE INFERENCIAL E TESTE DAS HIPÓTESES DA TESE

Para além da análise descritiva das pontuações médias por domínio e por região, e buscando aprofundar o entendimento sobre o impacto das características demográficas na percepção de acolhimento urbano, é fundamental testar a relação entre a variável idade e os resultados obtidos em cada domínio da EBAPI, para realmente saber o que impacta na opinião do idoso. Com o objetivo de verificar se a idade dos participantes influencia a sua percepção sobre a construção de uma cidade amiga do idoso no Recife-PE, a Tabela 6 apresenta os resultados da Análise de Correlação de Spearman.

Este teste não paramétrico é aplicado para avaliar a força e a direção da associação estatística entre a idade dos idosos e a pontuação alcançada nos oito domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa.

Tabela 6 - Análises de correlação de Spearman entre idade e os domínios do EBAPI dos idosos participantes da pesquisa residentes no município de Recife-PE (n=163).

	Ambiente físico	Transporte/Mobilidade urbana	Moradia	Participação	Respeito e inclusão social	Comunicação e informação	Oportu. de aprend.	Apoio, saúde e cuidado
Idade	0,049	0,120*	0,041	0,006	0,042	0,067	0,065	0,008
Ambiente físico	-	0,634**	0,341**	0,372**	0,429**	0,382**	0,404**	0,254**
Transporte/Mobilidade urbana	-	-	0,407**	0,326**	0,406**	0,366**	0,454**	0,347**
Moradia	-	-	-	0,328**	0,437**	0,309**	0,324**	0,293**
Participação	-	-	-	-	0,566**	0,486**	0,415**	0,525**
Respeito e inclusão social	-	-	-	-	-	0,659**	0,565**	0,507**
Comunicação e informação	-	-	-	-	-	-	0,566**	0,461**
Oportunidades de aprendizagem	-	-	-	-	-	-	-	0,546**

Nota: * = $p < 0,05$; ** = $p < 0,01$. EBAPI - Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Oportu. de aprend. - Oportunidades de aprendizagem.

Na tabela 6 estão os resultados das correlações obtidas entre as variáveis idade e cada um dos oito domínios do instrumento EBAPI (Ambiente físico, Transporte/Mobilidade urbana, Moradia, Participação, Respeito e inclusão social, Comunicação e informação e Oportunidades de aprendizagem). Observa-se que a variável idade apresentou uma correlação positiva estatisticamente significativa ($p < 0,05$) apenas com o domínio Transporte/Mobilidade Urbana. Considerando o tamanho de efeito desta correlação, a mesma apresenta uma influência de magnitude considerada fraca ($r = |0,10| - |0,39|$), porém positiva.

Ainda na Tabela 6 identifica-se que todos os componentes do instrumento EBAPI apresentam correlações positivas estatisticamente significantes ($p < 0,01$) entre si, que variam suas magnitudes de influência entre fraca ($r = |0,10| - |0,39|$) a moderada ($r = |0,40| - |0,69|$). Os domínios que apresentaram maior correlação entre si foram ‘Ambiente físico’ com ‘Transporte/Mobilidade urbana’ ($r = 0,634$) e os que apresentaram menor magnitude de correlação foram ‘Ambiente físico’ com ‘Apoio, saúde e cuidado’ ($r = 0,254$).

Foram realizados testes de análise de variância de uma via (ANOVA-One Way) com o objetivo de avaliar se havia diferenças nos escores obtidos em cada um dos oito domínios do EBAPI entre idosos de diferentes tempos de residência (até 5 anos, entre 5 e 10 anos e mais de 10 anos), pessoas com quem o idoso mora (sozinho, cônjuge, filhos e outros), escolaridade (até o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior ou pós-graduação) e renda (até dois salários mínimos, mais de dois até cinco salários mínimos e mais de cinco salários mínimos).

Dando continuidade à análise das variáveis sociodemográficas que podem influenciar a percepção de acolhimento urbano, o foco recai sobre a escolaridade. O nível de instrução é um fator crucial que pode mediar o acesso à informação, as oportunidades de engajamento social e o sentimento de pertencimento do idoso.

A Tabela 7 apresenta a associação entre a escolaridade dos idosos e os domínios Participação, Respeito e Inclusão Social e Comunicação e Informação do EBAPI, utilizando-se do teste de correlação apropriado para verificar o grau de influência desta variável sobre as dimensões avaliadas.

Tabela 7 - Associação entre a escolaridade dos idosos com os domínios Participação, Respeito e Inclusão Social e Comunicação e Informação do EBAPI (n=163).

Domínio	Comparações entre grupos		Diferença de Médias	p-valor	Estimativas de Bootstrapping (95% IC BCa)		
					Erro-padrão	Limite inferior	Limite Superior
Participação	Até ensino fundamental	Ensino médio	-0,22	0,393	0,15	-0,59	0,15
		Ensino superior	-0,47	0,007*	0,15	-0,85	-0,10
	Ensino médio	Ensino superior	-0,25	0,231	0,14	-0,61	0,10
Respeito e inclusão social	Até ensino fundamental	Ensino médio	-0,01	1,000	0,18	-0,42	0,44
		Ensino superior	-0,46	0,033*	0,18	-0,90	-0,02
	Ensino médio	Ensino superior	-0,45	0,030*	0,17	-0,87	-0,03
Comunicação e informação	Até ensino fundamental	Ensino médio	-0,63	0,001*	0,17	-1,06	-0,20
		Ensino superior	-0,80	<0,001*	0,17	-1,23	-0,37
	Ensino médio	Ensino superior	-0,16	0,696	0,17	-0,58	0,24
Estatísticas descritivas (Correção com Bootstrapping)							
	GRUPO	Até ensino fundamental		Ensino médio		Ensino superior	
Participação	Média ± DP	1,60 ± 0,67		1,82 ± 0,76		2,08 ± 0,90	
Respeito e inclusão social	Média ± DP	2,58 ± 0,88		2,59 ± 1,02		3,05 ± 0,86	
Comunicação e informação	Média ± DP	2,07 ± 0,79		2,71 ± 0,94		2,88 ± 0,95	

DP - Desvio-padrão; *p-valor estatisticamente significante.

Os resultados da ANOVA demonstraram que apenas para a variável escolaridade havia diferenças entre os grupos nos domínios Participação [$F(2, 159) = 4,839$; $p = 0,009$], Respeito e inclusão social [$F(2, 159) = 4,494$; $p = 0,013$] e Comunicação e informação [$F(2, 159) = 11,150$; $p < 0,001$]. Os resultados descritivos das diferenças entre os grupos encontram-se detalhados na Tabela 7. O Teste de Levene realizado para a ANOVA entre a variável escolaridade e os domínios Participação (Levene (2, 159) = 1,652; $p < 0,195$), Respeito e inclusão social (Levene (2, 159) = 0,728; $p < 0,484$) e Comunicação e informação (Levene (2, 159) = 0,857; $p < 0,426$) demonstrou que estes apresentam homogeneidade de variância.

Na tabela 7 estão os resultados do Teste post-hoc de GT2 de Hochberg, interpretado, demonstrando que no domínio Participação foram encontradas diferenças significativas entre as pontuações dos indivíduos com ensino fundamental comparado com aqueles que apresentam ensino superior [DM = -0,47; IC 95% Bca (-0,85; -0,10)], desta forma observa-se que os indivíduos com o maior grau de escolaridade deram pontuações maiores neste domínio comparado com aqueles de menor escolaridade.

A mesma diferença foi encontrada no domínio Respeito e inclusão social, em que diferenças estatisticamente significantes estavam entre as pontuações dos indivíduos com ensino fundamental comparado com aqueles que do ensino superior [DM = -0,46; IC 95% Bca (-0,90; -0,02)], portanto, os indivíduos com o maior grau de escolaridade deram pontuações maiores para o domínio Respeito e inclusão social comparado com aqueles de menor escolaridade (Tabela 7).

Para o domínio Comunicação e informação a diferença estatisticamente significantes estão entre as pontuações dos indivíduos com ensino fundamental comparado com os demais grupos: ensino fundamental x ensino médio [(DM = -0,63; IC 95% Bca (-1,06; -0,20)] e ensino fundamental x ensino superior [(DM = -0,80; IC 95% Bca (-1,23; -0,37)], assim, verifica-se que os indivíduos com maior escolaridade (ensino médio ou superior) pontuam mais neste domínio do que indivíduos com apenas o ensino fundamental (Tabela 7).

Por fim, os testes de análise de variância de uma via (ANOVA-One Way) realizados entre as demais variáveis (tempo de residência, pessoas com quem o idoso mora e renda) e os domínios do instrumento EBAPI não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre si ($p > 0,05$).

Dando prosseguimento à análise da influência das variáveis sociodemográficas e os domínios EBAPI, a percepção dos idosos sobre o acolhimento urbano é

aprofundada. Em complemento à análise descritiva apresentada nas seções anteriores, esta etapa avança para a análise inferencial, cujo objetivo é verificar a existência de associação estatisticamente significativa entre o conjunto das variáveis sociodemográficas, socioeconômicas e de condição de saúde (sexo, se trabalha, aposentado, uso de medicamentos, presença de deficiência e acompanhamento médico) e a percepção dos idosos nos oito domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI).

Tabela 8 - Associação entre Variáveis Sociodemográficas/Condição de Saúde e a Percepção dos 08 domínios EBAPI (n=163).

DOMÍNIO	VARIÁVEL					
	Sexo	Trabalha	Aposentado	Medicamento	Deficiência	Acompanha médico
	(IC95% BCa) p-valor	(IC95% BCa) p-valor	(IC95% BCa) p-valor	(IC95% BCa) p-valor	(IC95% BCa) p-valor	(IC95% BCa) p-valor
Ambiente físico	(-0,43; 0,18) p = 0,425	(-0,40; 0,25) p = 0,643	(-0,29; 0,31) p = 0,977	(-0,35; 0,29) p = 0,907	(-0,58; 0,12) p = 0,162	(-0,12; 0,56) p = 0,237
Transporte/ Mobilidade urbana	(-0,65; 0,01) p = 0,069	(-0,40; 0,39) p = 0,950	(-0,48; 0,06) p = 0,127	(-0,13; 0,53) p = 0,212	(-0,33; 0,45) p = 0,768	(-0,35; 0,41) p = 0,740
Moradia	(-0,37; 0,50) p = 0,891	(-0,35; 0,39) p = 0,959	(-0,14; 0,48) p = 0,305	(-0,42; 0,35) p = 0,906	(-0,68; 0,11) p = 0,147	(-0,41; 0,78) p = 0,476
Participação	(-0,31; 0,31) p = 0,976	(-0,35; 0,28) p = 0,893	(-0,18; 0,31) p = 0,564	(-0,41; 0,28) p = 0,721	(-0,50; 0,27) p = 0,574	(-0,22; 0,69) p = 0,283
Respeito e inclusão social	(-0,73; 0,04) p = 0,069	(-0,12; 0,70) p = 0,173	(-0,11; 0,46) p = 0,222	(-0,53; 0,27) p = 0,480	(-0,51; 0,23) p = 0,446	(-0,44; 0,91) p = 0,475
Comunicação e informação	(-0,81; 0,10) p = 0,078	(-0,13; 0,74) p = 0,177	(-0,25; 0,37) p = 0,703	(-0,56; 0,26) p = 0,445	(-0,79; 0,27) p = 0,277	(-0,56; 0,71) p = 0,822
Oportunidades de aprendizagem	(-0,21; 0,67) p = 0,325	(-0,43; 0,57) p = 0,746	(-0,43; 0,28) p = 0,665	(-0,39; 0,49) p = 0,832	(-0,74; 0,25) p = 0,300	(-0,66; 0,56) p = 0,901
Apoio, saúde e cuidado	(-0,48; 0,31) p = 0,676	(-0,48; 0,31) p = 0,645	(-0,34; 0,25) p = 0,777	(-0,36; 0,36) p = 0,948	(-0,40; 0,48) p = 0,882	(-0,11; 0,90) p = 0,125

IC 95% = intervalo de confiança de 95%; BCa = Bias corrected accelerated.

Conforme demonstrado na Tabela 8, os resultados obtidos por meio do teste estatístico empregado (ex: Teste t de Student ou Qui-quadrado) indicam que, para a totalidade dos domínios da EBAPI, as variáveis testadas não apresentaram diferenças estatisticamente significantes ($p > 0,05$).

Este achado sugere que, para a amostra em estudo, o perfil sociodemográfico e de saúde são fatores determinantes na variação da percepção de acolhimento urbano, indicando que a experiência de insatisfação (ou satisfação) nos domínios da EBAPI é distribuída de maneira mais homogênea em relação a esses fatores.

Essa ausência de significância reforça que as barreiras ao acolhimento urbano no Recife são sistêmicas, a hostilidade é sentida de forma coletiva, independentemente da condição individual de saúde ou atividade laboral do sujeito, incidindo sobre o desenho e a gestão do território como um todo.

A partir da convergência entre os achados estatísticos e a realidade institucional do município, torna-se necessário confrontar a percepção dos idosos com a capacidade de resposta da gestão pública atual.

O Quadro 8 sintetiza esse hiato, evidenciando as áreas onde a governança municipal encontra-se distanciada das demandas prioritárias identificadas nesta pesquisa, servindo como base para as diretrizes propositivas que serão apresentadas adiante.

Quadro 8 - Matriz de Confronto entre Percepção Social e Governança Municipal no Recife.

DOMÍNIO CRÍTICO (EBAPI)	DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO	HIATO DE GOVERNANÇA
Ambiente Físico (1,91)	Nota crítica para Banheiros Públicos (1,33) e manutenção de calçadas. O idoso sente-se inseguro no espaço aberto.	Inexistência de uma rede capilar de sanitários públicos e falhas na execução do Plano de Calçadas em áreas periféricas (RPAs 2, 3 e 5).
Transporte e Mobilidade (1,91)	Pior nota em Segurança (1,00). Medo de quedas e violência no sistema de transporte público.	Gestão do transporte metropolitano (Grande Recife) que dificulta intervenções municipais diretas em abrigos e na qualidade da frota.
Participação (1,71)	A menor nota geral. Desconhecimento ou ineficácia do Fundo Municipal do Idoso (1,00) e instâncias de decisão.	Centralização das decisões e baixa divulgação dos canais de participação direta, isolando o idoso das instâncias de planejamento urbano.
Saúde e Apoio (2,05)	Fragilidade no conhecimento sobre ILPIs (2,00) e serviços de assistência social.	Déficit de vagas em instituições públicas e falta de integração entre as políticas de assistência social e o ordenamento do território.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A análise integrada dos dados revela que o hiato identificado entre a norma e a percepção não é uniforme, sendo agravado pelas disparidades socioespaciais das RPAs e pelas barreiras de escolaridade. O diagnóstico confirma a hipótese de que a gestão municipal, embora possua arcabouço legal, carece de uma execução intersetorial que priorize os domínios de Ambiente Físico e Transporte. Diante desse cenário de fragilidades institucionais e infraestruturais, o capítulo seguinte apresenta diretrizes estratégicas voltadas à reorientação do planejamento urbano do Recife, buscando a efetivação de uma cidade acolhedora à longevidade.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As diretrizes aqui propostas transcendem a modificação física do espaço e exigem um reordenamento na governança municipal. Propõe-se a criação de um 'Comitê Intersetorial de Gerontologia Urbana' dentro do Plano Diretor do Recife, visando garantir que o Fundo Municipal do Idoso (FMI) não seja destinado apenas a eventos isolados, mas sim ao financiamento de microintervenções urbanas (como os banheiros públicos e iluminação de pedestre identificados como críticos nas RPAs 3 e 4).

A análise dos dados coletados no Recife revela um cenário complexo e contraditório sobre a longevidade urbana. O diagnóstico, fundamentado nos oito domínios da OMS (2008), aponta para uma cidade que apresenta potenciais de acolhimento na esfera privada e nas micro-relações sociais, mas que falha sistematicamente na garantia do direito à cidade no espaço público.

A discussão dos resultados busca, portanto, evitar um acúmulo abstrato de referências teóricas e, em vez disso, mobilizá-las como lentes específicas para interpretar os achados. Quando se analisa a distribuição desigual dos domínios por RPA, recorre-se à crítica da produção do espaço; ao examinar o peso da escolaridade nas percepções, aciona-se a noção de capital cultural; e, ao explorar as barreiras ambientais relatadas pelos idosos, empregam-se os conceitos de pressão ambiental e de deficiência como construção social. Essa chave de leitura integrada reforça a coerência entre a arquitetura teórica da tese e as evidências empíricas produzidas.

Os resultados não desenham uma cidade uniformemente "amiga" ou "hostil", mas sim um território fragmentado, onde a qualidade do envelhecimento é determinada pela classe social, pelo nível de instrução e, crucialmente, pela localização geográfica de moradia. A síntese dos achados empíricos sugere que o Recife acolhe a pessoa idosa da porta para dentro, mas a expulsa da porta para fora.

5.1 O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: A ELITE CRÍTICA, A FEMINIZAÇÃO E A CIDADANIA TENSIONADA

A análise pormenorizada do perfil sociodemográfico dos 163 participantes desta pesquisa revela, a priori, um distanciamento estatístico significativo em relação à média populacional do Recife, especialmente no que tange à escolaridade. Contudo, longe de configurar um viés amostral que invalidaria os achados, essa discrepância constitui-se como uma variável explicativa fundamental — talvez a mais importante — para a compreensão da severidade das críticas tecidas à gestão urbana. O fato de 45,5% da amostra possuir nível superior ou pós-graduação cria um fenômeno de "lente de aumento" sobre as carências da cidade, exigindo uma interpretação à luz da sociologia da educação e da gerontologia social.

Ao confrontarmos esse dado com o Censo Demográfico do IBGE (2022), observamos um hiato abissal. No Recife, e no Nordeste de forma geral, a coorte etária acima de 60 anos ainda carrega as marcas históricas do acesso restrito à educação formal no século XX, apresentando médias de escolaridade substancialmente inferiores. A amostra desta pesquisa, portanto, representa uma "elite educacional"¹, um recorte específico da sociedade recifense que conseguiu romper o ciclo de exclusão educacional de sua época.

Esse perfil diferenciado nos obriga a recorrer à teoria de Anita Neri (2007) sobre a "reserva cognitiva"². Neri argumenta que a escolaridade atua como um pilar central na velhice, permitindo ao indivíduo não apenas manter funções executivas por mais tempo, mas também articular, com maior complexidade, a leitura do mundo que o cerca. O idoso escolarizado deste estudo não é um sujeito passivo ou resignado; ele possui ferramentas intelectuais que lhe permitem comparar a realidade vivida (a calçada quebrada) com o ideal de direito prometido na legislação.

Nesse sentido, a teoria de Pierre Bourdieu (2007) sobre o capital cultural se faz imperativa para a discussão. O acúmulo de conhecimento formal desses idosos transforma-se em uma ferramenta de distinção e, crucialmente, de reivindicação

¹ Refere-se ao estrato da amostra que detém níveis de instrução formal (superior e pós-graduação) significativamente acima da média local. Este perfil implica maior capital cultural e capacidade de leitura crítica das barreiras urbanas.

² Hipótese da neurociência que explica a capacidade de resiliência cerebral perante o envelhecimento ou patologias. É construída via escolaridade e estímulos intelectuais, permitindo ao idoso encontrar estratégias alternativas para lidar com ambientes complexos ou hostis.

política. Ao avaliarem negativamente os domínios de "Comunicação e Informação" e "Participação Cívica" (Domínios 7 e 8), eles não estão expressando desconhecimento dos canais, mas sim a frustração de quem detém o código da linguagem culta e burocrática, mas não encontra interlocução eficiente no aparato estatal.

A significância estatística encontrada na ANOVA (Tabela 7) exclusivamente para a variável escolaridade confirma a hipótese de Daniel Groisman (2015) de que o "novo idoso" ³— mais instruído, conectado e consciente — tende a rejeitar o modelo de assistencialismo clássico e paternalista. Para este grupo, a política pública não deve ser uma concessão, favor ou caridade, mas um direito positivado e executável. A crítica severa captada pelo instrumento Q-EBAPI é, portanto, um exercício de "Cidadania Ativa", conceito defendido por Vicente Faleiros (2016), onde o sujeito reivindica seu lugar na pólis não pela compaixão, mas pela justiça social.

Entretanto, esse capital cultural elevado não blindava o corpo do idoso das barreiras físicas da cidade. O estudo revela um paradoxo cruel e democrático na sua perversidade: a "elite intelectual" da terceira idade recifense enfrenta os mesmos buracos na calçada, a mesma falta de iluminação e o mesmo medo de queda que a população não escolarizada. Isso valida a tese de Sueli Escorsim (2021) sobre a universalidade da violência urbanística no capitalismo periférico; a cidade hostil democratiza a exclusão física, nivelando por baixo a experiência de mobilidade, independentemente do diploma que o indivíduo ostente na parede.

Adentrando a dimensão de sexo, a predominância avassaladora de 81% de mulheres na amostra não é apenas um dado demográfico, mas um manifesto sociológico sobre quem, de fato, vive na cidade. Este percentual radicaliza a tendência de "feminização da velhice"⁴ apontada pelo IBGE, em que Recife já apresenta historicamente uma razão de sexo desequilibrada (cerca de 84 homens para cada 100 mulheres). Contudo, a super-representação feminina na pesquisa (muito acima da proporção censitária) indica um fenômeno comportamental: a "solidão participativa" da mulher.

³ O termo refere-se a uma nova coorte geracional de pessoas idosas que desafia os estereótipos tradicionais de passividade. Caracteriza-se por um perfil mais ativo, com maior nível de escolaridade, acesso à tecnologia, autonomia financeira e uma postura reivindicativa em relação aos seus direitos e ao uso do espaço urbano.

⁴ Conceito que descreve a maior proporção de mulheres na população idosa, resultante da maior expectativa de vida feminina. Este fenômeno implica uma perspectiva de gênero nas políticas urbanas, dado que as mulheres idosas apresentam trajetórias de vida, necessidades de cuidado e formas de ocupação do espaço público distintas das dos homens.

A expressiva predominância feminina na amostra (81,6%) não constitui apenas um dado demográfico isolado, mas evoca a necessidade de analisar o Recife sob a ótica do Urbanismo do Cuidado. Esta abordagem teórica reconhece que as mulheres, historicamente designadas como as principais gestoras das redes de suporte familiar, experienciam a cidade de forma mais intensa e fragmentada, realizando o que a literatura denomina de 'poligonal do cuidado'⁵.

Vale explicitar que além de refletir a “feminização da velhice” esse quantitativo pode representar também, um viés de participação/engajamento (mulheres mais presentes em espaços de convivência/serviços), o que impacta a leitura de determinados domínios (mobilidade, segurança, cuidados).

No contexto desta pesquisa, as barreiras físicas identificadas nas RPAs 3 e 4 e a insegurança nos terminais de transporte impactam desproporcionalmente este grupo, que depende da caminhabilidade e da acessibilidade para exercer sua autonomia. Portanto, os resultados apontam que a hostilidade do ambiente urbano recifense opera uma exclusão de sexo, onde a falta de infraestrutura básica (como iluminação e banheiros públicos) penaliza severamente o corpo feminino envelhecido, restringindo seu direito à cidade e sobrecarregando sua saúde física e mental.

Enquanto os homens idosos tendem ao isolamento doméstico ou ao falecimento precoce (sobre mortalidade masculina), as mulheres ocupam os espaços de convivência, os centros de saúde e as praças, a exemplo dos que participaram da pesquisa. Ana Amélia Camarano (2020) discute extensivamente como a mulher idosa brasileira se tornou a protagonista do cuidado e da gestão social. Essa centralidade na vida privada e comunitária, contudo, contrasta com a sua vulnerabilidade na vida pública urbana.

Ao saírem às ruas para exercerem esse papel de gestão familiar e social, elas colidem com uma infraestrutura desenhada historicamente para o corpo masculino, jovem e produtivo. A literatura de Guita Debert (1999) sobre a reinvenção da velhice aponta que essas mulheres buscam a socialização externa como forma de romper com o confinamento doméstico.

No entanto, os dados desta tese sobre a precariedade do "Ambiente Físico" mostram que o Recife impõe um obstáculo severo a essa emancipação.

⁵ Conceito oriundo do urbanismo feminista que descreve a rede de trajetos curtos e fragmentados realizados por quem exerce funções de cuidado (maioritariamente mulheres). Diferente do trajeto pendular tradicional (casa-trabalho), a poligonal do cuidado envolve múltiplos destinos diários — como postos de saúde, mercados, escolas e farmácias —, exigindo uma infraestrutura urbana mais conectada e segura.

Cruzando com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2019), verifica-se que as mulheres idosas relatam índices significativamente maiores de limitações funcionais e, crucialmente, de "medo de cair" em via pública. Esse medo atua como um mecanismo de controle social e espacial. A avaliação negativa do ambiente físico na tese é, predominantemente, um grito da mulher idosa que se sente cerceada em seu direito de ir e vir.

A "dupla penalização" ⁶ citada pela filósofa Simone de Beauvoir (1990) em sua obra seminal "A Velhice" — a condição de ser velha somada à condição de ser mulher — ganha, no Recife contemporâneo, uma terceira camada de opressão: habitar uma cidade não planejada. A insegurança urbana, tanto a criminal quanto à viária (atropelamentos, quedas), afeta desproporcionalmente a psique feminina, gerando estratégias de evitação que reduzem o território vivido.

É imperativo também discutir a intersecção entre renda e escolaridade presente na amostra. Observa-se um fenômeno particular do Nordeste brasileiro: a alta instrução nem sempre se traduz em alta renda na aposentadoria. O fato de 28,3% da amostra viver com até um salário mínimo, apesar da escolaridade, dialoga com Heleieth Saffioti (2015) ao demonstrar a precarização da vida na velhice. A aposentadoria da classe média é corroída pela inflação médica (planos de saúde e remédios), restando poucos recursos para suprir as falhas do Estado (como pagar táxi para evitar o ônibus ruim).

Outro ponto de destaque nevrálgico é o arranjo domiciliar. Com quase 30% dos participantes relatando morar sozinhos, a amostra supera largamente a média nacional apontada pelo Censo 2022 (onde os domicílios unipessoais giram em torno de 18,9%). Esse dado confirma a atomização das famílias e o crescimento da "velhice solitária" nas metrópoles.

O sociólogo Zygmunt Bauman (2001), ao tratar da modernidade líquida, alerta para o enfraquecimento dos laços comunitários tradicionais. No caso do Recife, o idoso que mora só é duplamente dependente da cidade: ele precisa que a farmácia seja perto, que o posto de saúde seja acessível e que o transporte funcione, pois não há, muitas vezes, um coabitante para realizar essas tarefas por ele.

A alta taxa de moradia unipessoal na amostra valida a urgência expressa nas

⁶ Conceito que descreve a sobreposição de vulnerabilidades ou discriminações (interseccionalidade). No contexto urbano, refere-se ao acúmulo de desvantagens sofridas pelo indivíduo, como a soma do preconceito etário (ageísmo) com barreiras de gênero, raça ou condições socioeconômicas precárias do território onde reside.

avaliações negativas do domínio "Suporte Comunitário e Serviços de Saúde". Para quase um terço desses idosos, a rede pública e urbana é a única família disponível. Quando a calçada falha ou o ônibus não para, o Estado não está apenas falhando na mobilidade; está cometendo um abandono de incapaz institucionalizado.

A invisibilidade masculina na pesquisa (apenas 19% de participantes) também merece uma reflexão crítica baseada em Cecília Minayo (2012). Esse absentismo reflete a cultura de masculinidade hegemônica que afasta o homem dos espaços de cuidado e convivência, tornando-o mais vulnerável à depressão, ao suicídio e ao isolamento social. O homem idoso recifense, diferentemente da mulher, parece "desaparecer" da esfera pública após a aposentadoria, o que é um problema de saúde coletiva latente.

O perfil encontrado nesta tese é, em suma, o de uma "sobrevivente ativa e crítica"⁷. A mulher idosa, escolarizada, que respondeu ao questionário, está lutando para manter sua autonomia e dignidade em um cenário adverso. A sua insatisfação registrada nos dados não deve ser lida como rabugice, mas como uma forma de resistência política. Ela se recusa a ser invisível, ocupando os dados, os grupos e as ruas, mesmo que estes lhe sejam hostis.

Conclui-se, portanto, que o perfil sociodemográfico da amostra confere uma robustez singular ao diagnóstico. Não estamos lidando com a opinião de transeuntes aleatórios, mas com a avaliação qualificada de cidadãos que vivem a cidade intensamente e possuem capital cognitivo para dissecá-la. A discrepância com o Censo do IBGE revelou-se, assim, o maior trunfo analítico deste trabalho: provou que no Recife, nem mesmo a elite educacional consegue transpor as barreiras da ineficiência urbana, evidenciando o caráter estrutural e democrático da exclusão espacial na capital pernambucana.

A política pública para o envelhecimento no Recife precisa, urgentemente, recalibrar seu alvo para este perfil. Não basta oferecer atividades de lazer passivo; é necessário oferecer canais de governança, conselhos deliberativos ativos e, acima de tudo, uma infraestrutura física que respeite a autonomia dessa mulher idosa que insiste em ser cidadã, apesar da cidade que habita.

⁷ Expressão que caracteriza o perfil da amostra estudada: indivíduos que, embora enfrentem as adversidades de um ambiente urbano hostil e excludente ('sobreviventes'), mantêm o protagonismo social ('ativa') e a capacidade analítica de reivindicar melhorias nas políticas públicas ('crítica').

5.2 ENTRE O ACOLHIMENTO DOMÉSTICO E A HOSTILIDADE PÚBLICA: O DIAGNÓSTICO DA CIDADE

A análise comparativa da hierarquia dos oito domínios da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), revelada pelos dados desta pesquisa, permite validar empiricamente uma das hipóteses centrais da tese: a existência de um hiato estrutural intransponível entre o acolhimento experienciado no espaço privado e a hostilidade percebida no espaço público. Os resultados evidenciam uma dicotomia que remete à clássica análise de Roberto DaMatta (1997) sobre a sociedade brasileira: a "casa" como o espaço da pessoa, da proteção e do afeto, em oposição à "rua" como o espaço da lei impessoal, do perigo e da desordem. Para o idoso recifense, essa separação não é apenas simbólica, mas física e barreira arquitetônica.

Os dados demonstram que, enquanto as redes sociais primárias e o ambiente doméstico ainda funcionam como instâncias de proteção e pertencimento, a cidade material — composta por infraestrutura, serviços e dispositivos de mobilidade — falha em garantir condições mínimas de inclusão. O domínio "Respeito e Inclusão Social", que obteve a maior pontuação geral (Mediana = 2,80), expressa esse acolhimento ancorado predominantemente na esfera interpessoal. O subitem "Família e amigos", ao alcançar a pontuação máxima mediana (4,00), revela a centralidade absoluta das redes familiares no suporte cotidiano.

Tal achado dialoga diretamente com a Teoria da Pressão Ambiental de Lawton e Nahemow (1973). Segundo os autores, à medida que a competência individual declina (perdas funcionais do envelhecimento), a docilidade ambiental torna-se crucial. O lar, adaptado e gerido pela família, oferece essa docilidade. Configura-se, assim, o fenômeno do *Aging in Place* (envelhecer no lugar), onde o domicílio não é apenas um ativo imobiliário, mas um território existencial de continuidade biográfica, conforme defende Lawton (1980).

Contudo, é imperativo notar que esse acolhimento não se estende de forma equivalente à esfera pública e institucional. O subitem "Prevenção e combate ao preconceito e violência contra a pessoa idosa", dentro do mesmo domínio, apresentou pontuação consideravelmente inferior (Mediana = 2,33). Isso evidencia que o respeito percebido pelos idosos é majoritariamente relacional (privado), e não resultado de políticas públicas efetivas. A sociedade recifense respeita o "seu" idoso (avô/pai), mas negligência o idoso "do outro" na fila do ônibus ou na calçada.

Esse resultado reforça as análises de Cecília Minayo (2019), que aponta que a violência contra a pessoa idosa em contextos urbanos desiguais tende a ser naturalizada. A baixa pontuação neste quesito sugere que o idoso se sente vulnerável à violência estrutural, aquela que não deixa hematomas visíveis, mas que se manifesta na falta de prioridade no atendimento, na impaciência no trânsito e na invisibilidade política. O "etarismo" ou "ageísmo", conceituado por Robert Butler (1969), opera aqui como uma força silenciosa que expulsa o idoso da convivência pública.

Na extremidade oposta da hierarquia encontram-se justamente os domínios que dependem de ação estatal direta e planejamento urbano integrado: "Ambiente Físico" (Mediana = 1,91), "Transporte/Mobilidade Urbana" (Mediana = 1,91) e "Participação" (Mediana = 1,71). A coincidência dessas notas baixas revela que a cidade do Recife, enquanto materialidade, opera como um dispositivo de exclusão. A gestão urbana falha em prover o "Direito à Cidade", nos termos de Henri Lefebvre (2001), transformando o espaço urbano em um privilégio dos corpos jovens e aptos.

Essa constatação converge com os diagnósticos globais da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007), que destaca que cidades não adaptadas ao envelhecimento populacional tendem a produzir dependência induzida. Quando o idoso avalia mal o transporte e o ambiente físico, ele está sinalizando que a cidade antecipa sua incapacidade. O meio urbano torna-se "incapacitante", acelerando o declínio funcional que, em um ambiente amigável, poderia ser retardado por anos.

A análise dos subitens desses domínios permite identificar fragilidades críticas. No domínio "Transporte/Mobilidade Urbana", o subitem "Segurança" obteve a pior avaliação de todo o instrumento (Mediana = 1,00). Este dado é alarmante e deve ser lido em conjunto com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2019), que indica as quedas como uma das principais causas de internação em idosos. O deslocamento no Recife é percebido não como um direito, mas como uma atividade de alto risco biológico.

Conforme argumenta Jan Gehl (2013) em "Cidades para Pessoas", a segurança é o pré-requisito elementar para a vitalidade urbana. Sem a certeza de que não será atropelado ou assaltado, o pedestre se retira. Para o idoso, cuja recuperação física é lenta, o medo da queda atua como um "muro invisível"⁸. A insegurança viária compromete diretamente a autonomia, pilar central do Envelhecimento Ativo defendido

⁸ Refere-se às barreiras simbólicas e psicológicas que, embora desprovidas de materialidade física, segregam o espaço urbano. Manifestam-se através do medo, do preconceito e do sentimento de não pertença, impedindo a livre circulação de grupos vulneráveis em determinadas áreas da cidade.

por Alexandre Kalache (2013).

Outro elemento emblemático da exclusão urbana identificada é a escassez de banheiros públicos, que recebeu pontuação extremamente baixa (Mediana = 1,33). Embora pareça um detalhe trivial para o planejamento urbano tecnocrata, a ausência de infraestrutura sanitária é um limitador fisiológico da cidadania. Tine Buffel e Chris Phillipson (2012) argumentam que a falta de equipamentos de apoio (banheiros e bancos) promove um "confinamento doméstico involuntário".

A forte correlação estatística observada entre os domínios "Ambiente Físico" e "Transporte/Mobilidade Urbana" ($r = 0,634$) reforça a compreensão de que, para o idoso, esses sistemas são indissociáveis. A calçada irregular, a ausência de rampas, a sinalização precária e o ônibus inadequado compõem um único conjunto de barreiras. Tal achado dialoga com o conceito de "Cadeia da Mobilidade"⁹ de Eduardo Vasconcellos (2014), que coloca um prisma de acessibilidade efetiva, quando todos os elos são funcionais. Se a calçada até o ponto de ônibus é intransitável, o ônibus com ar-condicionado é inútil.

O domínio "Participação", com a pior mediana geral (1,71), reflete o isolamento cívico. A cidade não oferece espaços de escuta. A teoria de Maria da Glória Gohn (2010) sobre a participação social nos alerta que, sem canais institucionalizados, a cidadania se esvazia. O idoso quer participar (como visto no seu perfil escolarizado), mas a cidade não oferece o agora e sim o isolamento.

Esses resultados devem ser interpretados à luz da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF/OMS, 2001), que desloca o entendimento da deficiência do corpo para a interação entre indivíduo e ambiente. Assim, a baixa avaliação da infraestrutura urbana não expressa apenas insatisfação subjetiva, mas a vivência concreta de um ambiente que produz incapacidade. O Recife hostiliza o idoso ao não acomodar suas restrições biomecânicas naturais.

O contraste entre os domínios bem avaliados (privados) e os mal avaliados (públicos) evidencia um padrão de "responsabilização informal do cuidado". A família compensa a ausência do Estado. Dados do IBGE sobre cuidados mostram que essa carga recai desproporcionalmente sobre as mulheres da família. A cidade conta com essa "mão de obra gratuita" para suprir sua falta de acessibilidade.

⁹ Conceito que compreende a mobilidade como um sistema de etapas interligadas (deslocamento, transferência e acesso). Defende que a acessibilidade só é plena quando todos os elos — desde a saída da residência até ao destino final — são contínuos e seguros, sem interrupções físicas ou informacionais.

Se a cidade fosse amigável, o idoso poderia ir ao médico sozinho. Como não é, ele precisa que um familiar falte ao trabalho para acompanhá-lo, gerando impacto econômico nas famílias. Ana Amélia Camarano (2020) define isso como o custo oculto da dependência. A ineficiência urbana do Recife é, portanto, um imposto indireto cobrado das famílias que cuidam dos seus.

A análise do transporte também revela a exclusão digital. Muitos serviços de mobilidade migraram para aplicativos, criando barreiras para uma geração que não é nativa digital. A baixa nota em "Informação" conecta-se a isso. A cidade "inteligente" (*Smart City*) muitas vezes é uma cidade excludente para o analógico.

Dessa forma, o diagnóstico construído revela que o Recife apresenta características de uma cidade esquizofrênica: acolhe o idoso no sofá da sala, mas o agride na calçada da frente. Tal contradição explicita o hiato entre os princípios normativos da "Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa" e a realidade de concreto e asfalto.

A cidade falha não por ausência de vínculos sociais — que se mostram fortes na variável "Família" —, mas pela incapacidade política de traduzir o respeito difuso em infraestrutura dura, porque o afeto da família não tapa o buraco da rua.

Conclui-se, portanto, que a hostilidade pública funciona como um agente de confinamento. Ao negar a segurança, o banheiro e a calçada, o Recife envia uma mensagem silenciosa ao seu cidadão longo: "fique em casa". Romper com essa lógica exige mais do que campanhas educativas; exige obras, concreto e um redesenho urbano que coloque o corpo frágil, e não o automóvel, como medida de todas as coisas.

5.3 TERRITÓRIO E DESIGUALDADE: AS NUANCES REGIONAIS E A GEOGRAFIA DO ENVELHECIMENTO

A confirmação da hipótese de que a localização residencial atua como um determinante fundamental na percepção da qualidade de vida valida a premissa de que o Recife não é uma unidade homogênea, mas um mosaico de territórios desiguais. A análise comparativa entre as Regiões Político-Administrativas (RPAs) revela que o "CEP" (Código de Endereçamento Postal) é uma variável tão impactante para o envelhecimento quanto a genética ou a renda. Os resultados evidenciam que as disparidades territoriais moldam a experiência da longevidade, criando zonas de

conforto e zonas de sacrifício dentro da mesma malha urbana.

Essa constatação empírica dialoga profundamente com a obra de Flávio Villaça (2001) sobre a estrutura intraurbana brasileira. Villaça argumenta que a segregação socioespacial não é um acidente, mas um produto do planejamento estatal e do mercado imobiliário, que concentram investimentos nas regiões centrais e litorâneas, relegando as periferias à precariedade. O idoso recifense, portanto, não envelhece apenas no tempo (biológico), mas no espaço (geográfico), e a qualidade desse espaço determina se esse envelhecimento será ativo ou restrito.

A teoria do "Território Usado" de Milton Santos (2006) é essencial para interpretar esses dados. Santos diferencia o território normativo (as leis) do território usado (a vida real). No Recife, enquanto a legislação urbanística (Plano Diretor, Estatuto da Cidade) promete equidade, o uso do território pelas RPAs revela uma hierarquia brutal. As áreas centrais oferecem "fluidez" para os corpos envelhecidos, enquanto as áreas periféricas impõem "viscosidade" e atrito, dificultando cada movimento cotidiano.

Estudos de Ermínia Maricato (2014) sobre o impasse da política urbana no Brasil reforçam que a desigualdade no acesso à infraestrutura é a face mais visível da dívida social. Quando os dados desta pesquisa mostram variações drásticas na avaliação do "Ambiente Físico" entre as RPAs, eles estão mensurando essa dívida. O idoso que reside em áreas de urbanização consolidada usufrui de uma cidade; aquele que reside em áreas de expansão precária ou morros, sobrevive em outra.

Diferenças regionais nos domínios EBAPI: Do Centro à Periferia

A dissecção dos oito domínios da EBAPI pelas lentes regionais expõe a anatomia dessa desigualdade. O fato de o domínio "Respeito e Inclusão Social" ter sido bem avaliado transversalmente em quatro das seis RPAs sugere que o capital social e as redes de solidariedade são o tecido que mantém a cidade coesa, mesmo onde o Estado falha. Contudo, essa coesão social não substitui a necessidade de infraestrutura dura.

Nas RPAs 1 (Centro) e 2 (Zona Norte Plana/Arruda/Encruzilhada), o destaque para o domínio "Moradia" reflete a herança histórica de investimentos. Estas regiões concentram o estoque habitacional mais formal, saneado e servido por equipamentos públicos. Esse padrão corrobora as análises de David Harvey (2008) sobre a

acumulação de capital no espaço urbano. O centro atrai melhorias contínuas, criando um ciclo virtuoso de valorização que beneficia o idoso residente, oferecendo-lhe calçadas mais largas, iluminação e proximidade com serviços de saúde de alta complexidade.

Raquel Rolnik (2015), ao discutir a "Guerra dos Lugares"¹⁰, aponta que a qualidade da moradia e do entorno nas áreas centrais é fruto de um "urbanismo de exceção"¹¹, onde as regras de acessibilidade e conforto são mais propensas a serem cumpridas. Para o idoso da RPA 1, a cidade oferece um nível de "caminhabilidade" e acesso a bens culturais que materializa, ainda que parcialmente, o "Direito à Cidade" preconizado por Henri Lefebvre (2001) — o direito não apenas de viver, mas de usufruir da obra urbana.

Por outro lado, a desigualdade territorial manifesta-se com violência geográfica na RPA 3 (Zona Norte/Morros/Casa Amarela). O fato de o "Ambiente Físico" ser o domínio mais crítico nesta região não é surpresa, mas uma denúncia. A topografia acidentada, somada à densidade populacional e à manutenção precária de escadarias e vielas, ergue barreiras intransponíveis. Aqui, o conceito de "Injustiça Ambiental" de Henri Acselrad (2009) se aplica com precisão: as populações mais vulneráveis são empurradas para os terrenos geofisicamente mais difíceis.

Para o idoso com sarcopenia (perda de massa muscular) ou osteoartrose, comuns nessa faixa etária, viver na RPA 3 significa enfrentar uma maratona diária. A falta de corrimãos, os degraus irregulares e a drenagem insuficiente transformam a topografia em um agente de confinamento. A morfologia urbana, neste caso, atua contra a biologia do envelhecimento, pois o "lugar" deixa de ser abrigo e torna-se ameaça.

A literatura sobre os Determinantes Sociais de Saúde (DSS), discutida por Paulo Buss e Alberto Pellegrini Filho (2007), estabelece que o ambiente físico é um preditor de saúde. Na RPA 3, o ambiente "patogênico" (que gera doença/risco de queda) anula os esforços individuais de autocuidado. Não adianta recomendar caminhadas para o controle da hipertensão se a rua é uma ladeira escorregadia e sem calçada.

Um achado peculiar e instigante da pesquisa foi a fragilidade apontada pela RPA

¹⁰ Conceito de Raquel Rolnik que descreve a disputa pelo espaço urbano entre o valor de troca (lógica financeira e imobiliária) e o valor de uso (direito à cidade e à moradia). Reflete o processo de exclusão de grupos vulneráveis em prol da valorização do capital no território.

¹¹ Conceito que descreve a prática de flexibilizar ou suspender normas urbanísticas vigentes para viabilizar grandes empreendimentos privados. Essa lógica prioriza interesses econômicos pontuais em detrimento do planejamento coletivo, aprofundando a segregação e as barreiras no espaço urbano

2 (Zona Norte Plana) no domínio "Apoio, Saúde e Cuidado". Sendo uma região de classe média consolidada, esperava-se melhor avaliação. Essa anomalia sugere o fenômeno dos "desertos de cuidado" ou a saturação dos serviços. Eugênio Vilaça Mendes (2019) alerta que, muitas vezes, áreas densamente povoadas sofrem com a fragmentação das redes de atenção à saúde. A simples presença de hospitais e clínicas na região não garante o acesso ou a qualidade do cuidado continuado (longitudinalidade) necessário ao idoso.

Além disso, a variação espacial no acesso a serviços públicos reflete a descentralização desigual das políticas urbanas. Conforme aponta o IPEA (2021), a distribuição de equipamentos de saúde (como USF e Policlínicas) muitas vezes não obedece à lógica da necessidade epidemiológica, mas a lógicas políticas ou de facilidade fundiária. O idoso da RPA 2 pode estar vivendo o paradoxo da "proximidade inacessível"¹²: ter o serviço perto, mas não conseguir vaga ou atendimento humanizado devido à superlotação.

Essa análise regional revela que o Recife opera como um "Arquipélago Urbano"¹³. Não há uma continuidade de qualidade de vida. Atravessar uma ponte ou subir uma ladeira altera drasticamente os indicadores de "Cidade Amiga". A RPA 1 vive em um século urbanístico, enquanto a RPA 3 luta por infraestrutura do século passado (pavimentação básica). A segregação socioespacial, portanto, não é apenas um tema para geógrafos, mas uma questão de saúde pública gerontológica. Ana Fani Alessandri Carlos (2008) argumenta que o espaço reproduz as relações sociais. No Recife, o espaço reproduz o esquecimento, ao negligenciar a adaptação das áreas de morro e periferia, o poder público condena o idoso dessas regiões a um envelhecimento de segunda classe.

A discussão sobre a RPA 4 (Oeste), frequentemente associada a problemas de mobilidade em estudos correlatos, reforça a visão de que as zonas distantes do litoral sofrem com o tempo de deslocamento em transporte público precário, que finda subtraindo horas de vida e lazer do idoso, funcionando como um imposto temporal regressivo.

¹² Paradoxo urbanístico que ocorre quando a proximidade física de um serviço ou equipamento não se traduz em acesso real, devido a barreiras arquitetônicas, falta de segurança ou infraestrutura precária que impedem o deslocamento da pessoa idosa.

¹³ Conceito que descreve a cidade fragmentada em núcleos de desenvolvimento e infraestrutura de alta qualidade ('ilhas') isolados por áreas de exclusão social e precariedade urbana. Reflete a descontinuidade do espaço e a dificuldade de conexão fluida entre os diferentes territórios da cidade.

A convergência dos indicadores socioeconômicos e das percepções colhidas nos oito domínios da EBAPI permite a construção de uma síntese geoanalítica da capital pernambucana. Esta sistematização, apresentada no Quadro 9, agrupa a performance das RPAs e revela como as disparidades socioespaciais do Recife moldam ambientes urbanos com níveis de acolhimento distintos.

Quadro 9 - Perfil sintético do envelhecimento por RPA – Recife.

RPA	RENDIA	SAÚDE	TRANSPORTE MOBILIDADE	ACESSIBILIDADE	SÍNTESE EBAPI
RPA 1	Baixa-média	Boa	Boa	Baixa	Ambiente contraditório ao envelhecimento
RPA 2	Baixa	Baixa-média	Baixa	Baixa	Ambiente desfavorável
RPA 3	Alta	Muito boa	Boa	Média-alta	Ambiente favorável, com barreiras pontuais
RPA 4	Média	Média	Média	Baixa-média	Condição intermediária
RPA 5	Muito baixa	Baixa	Baixa	Muito baixa	Ambiente altamente hostil ao envelhecimento
RPA 6	Muito alta	Excelente	Muito boa	Alta	Ambiente muito favorável ao envelhecimento

Fonte: Elaboração própria a partir da análise territorial da EBAPI (2026).

Os dados sintetizados evidenciam que a 'Cidade Amiga' no Recife não é uma realidade uniforme, mas um privilégio geograficamente restrito. A polarização extrema entre a RPA 5 (Ambiente altamente hostil) e a RPA 6 (Ambiente muito favorável) demonstra que a loteria do CEP define, em última instância, a segurança e a autonomia do idoso. Enquanto as áreas de morro e periferias planas sofrem com uma precariedade estrutural que 'asfixia' a longevidade, as zonas de maior capital econômico conseguem converter infraestrutura em qualidade de vida, confirmando a urgência de uma justiça territorial nas políticas de planejamento urbano.

Conclui-se, nesta análise territorial, que a política de "Cidade Amiga da Pessoa Idosa" no Recife não pode ser aplicada de forma padronizada. Um banco de praça na RPA 1 é um conforto; na íngreme RPA 3, um corrimão é uma necessidade vital. A equidade, princípio do SUS e do planejamento urbano justo, exige tratar desigualmente os territórios desiguais.

Sem uma intervenção maciça na microacessibilidade das RPAs críticas (3 e 4)

e uma revisão da rede de cuidados nas áreas saturadas (RPA 2), o Recife continuará sendo uma cidade amigável apenas para o idoso que vive no "lugar certo"¹⁴. A tese demonstra, com robustez estatística e teórica, que a geografia é destino no envelhecimento recifense, e que mudar esse destino exige enfrentar a estrutura histórica da desigualdade regional.

Implicações da Segregação Socioespacial: A Fragmentação do Envelhecer

Os resultados desta investigação confirmam, com robustez estatística e teórica, que o Recife opera como uma cidade profundamente fragmentada territorialmente, onde o processo de envelhecimento é uma experiência mediada pela geografia da exclusão. A cidade apresenta-se cindida: de um lado, as RPAs centrais e planas, com vantagens de acessibilidade; do outro, as periferias e morros, com as piores avaliações de "Ambiente Físico", "Transporte" e "Participação".

Tal padrão ecoa as análises de Flávio Villaça (2001) sobre a segregação como mecanismo de dominação, onde as classes de maior renda se apropriam das localizações com menor "atrito espacial". O idoso dessas áreas usufrui de um "bônus de localização", enquanto o da periferia paga um "imposto de localização" traduzido em esforço físico e isolamento.

Raquel Rolnik (2015), em "Guerra dos Lugares", ilumina a concentração de investimentos em áreas de mercado, deixando a periferia entregue à precariedade; para o idoso da RPA 3 ou 4, calçada e drenagem tornam-se luxos inalcançáveis. A confirmação estatística das diferenças (ANOVA/Teste F) valida a tese de David Harvey (2008) sobre o desenvolvimento geográfico desigual: o capitalismo urbano produz zonas de subdesenvolvimento onde o corpo do idoso, em um bairro, caminha, e no outro, tropeça.

Essa configuração demonstra que o "Direito à Cidade" de Henri Lefebvre (2001) é distribuído a conta-gotas; sem acesso material, a cidadania do idoso periférico é mutilada. A relação entre morfologia e exclusão social é evidente na RPA 3, onde a ausência de microacessibilidade transforma o relevo em barreira. Ermínia Maricato

¹⁴ Refere-se à parcela do território dotada de infraestrutura plena, serviços e segurança, onde o direito à cidade é garantido. Contrapõe-se às áreas de precariedade, evidenciando que a qualidade do envelhecimento está condicionada à localização geográfica e ao privilégio urbanístico.

(2014) aponta que o "urbanismo de risco"¹⁵ afeta os mais pobres, tornando a queda na ladeira um evento previsível diante da negligência estatal.

Além disso, a segregação impacta a dimensão psicossocial: a Teoria da Quebra de Janelas, revisitada por Buffel, Phillipson e Scharf (2012), sugere que a desordem física gera sensação de abandono e acelera quadros depressivos. A dependência do transporte público agrava o cenário; na periferia, a "tirania da distância"¹⁶ impõe a humilhação de veículos inadequados, o que Eduardo Vasconcellos (2001) define como a "imobilidade dos cativos"¹⁷.

O idoso torna-se cativo do bairro, sem "passaporte" para a cidade formal. Esta realidade é corroborada pelos dados do IBGE (2022) sobre aglomerados subnormais no Recife, evidenciando que as piores avaliações na EBAPI coincidem com territórios de menor investimento per capita.

Conclui-se, via Milton Santos (2006), que não há justiça social sem "Justiça Territorial"¹⁸: tratar todos os idosos como iguais é perpetuar a desigualdade, pois as demandas da RPA 1 e da RPA 4 são de séculos diferentes. A segregação também cria "desertos de cuidado" na saúde, onde a barreira física impede o acesso mesmo onde o serviço existe.

O modelo de "Cidade Amiga" da OMS deve ser politizado; como argumenta Tine Buffel (2012), contextos desiguais exigem "discriminação positiva"¹⁹. A lentidão do planejamento, denunciada por Ana Fani Alessandri Carlos (2008) como a produção do espaço como mercadoria, ignora o idoso pobre sem valor de troca. O CEP define a dignidade do cotidiano em um apartheid etário velado.

¹⁵ Conceito que descreve a produção de perigos no espaço urbano através de infraestruturas precárias, falta de manutenção e planejamento excludente. Reflete a condição em que o ambiente urbano deixa de ser um espaço de proteção para se tornar um cenário de ameaça à integridade física dos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis.

¹⁶ Conceito que descreve como a distância geográfica atua como uma barreira de exclusão. No contexto do envelhecimento, refere-se ao impacto negativo que longos trajetos e a dispersão de serviços exercem sobre a autonomia e a qualidade de vida de pessoas com mobilidade reduzida.

¹⁷ Expressão que descreve a condição de indivíduos impedidos de circular livremente devido às barreiras e perigos do ambiente externo. Reflete o estado de 'confinamento forçado' em que o idoso se torna prisioneiro da sua própria casa ou entorno imediato por falta de autonomia e segurança urbana.

¹⁸ Princípio que defende a distribuição equitativa de infraestruturas, serviços públicos e oportunidades no espaço urbano. Refere-se ao direito de todos os cidadãos, independentemente da sua localização geográfica, de acederem às mesmas condições de qualidade de vida e suporte à autonomia.

¹⁹ Conjunto de políticas públicas que visam favorecer grupos vítimas de exclusão ou preconceito, conferindo-lhes um tratamento preferencial. O objetivo é compensar desvantagens históricas e sociais, garantindo a igualdade de oportunidades e a justiça social no território.

Assim, o envelhecimento ativo exige "acupuntura urbana"²⁰ massiva nas áreas vulneráveis como imperativo ético, ou seja, prezar por ações especificamente direcionadas à fragilidade percebida nestas regiões. Sem enfrentar a segregação, qualquer selo de amizade será apenas honraria de gabinete, exigindo-se a integração da cidade através da infraestrutura inclusiva.

Conclusões Sobre Desigualdade Territorial: A Síntese da Injustiça Espacial

A síntese da análise territorial empreendida nesta tese permite ultrapassar a constatação descritiva das disparidades para formular um diagnóstico estrutural sobre a dinâmica do envelhecimento em metrópoles desiguais do Sul Global. O Recife revela-se não apenas fragmentado, mas polarizado por uma "injustiça espacial"²¹ sistêmica, conceito de Edward Soja (2010), onde a geografia atua como mecanismo de distribuição desigual de recursos e riscos.

O primeiro pilar dessa conclusão reside na constatação de que o acolhimento interpessoal é a única constante positiva; a estabilidade do "Respeito e Inclusão" reflete a resiliência das redes primárias, o "Capital Social de Vínculo"²² (Robert Putnam, 2000). Contudo, esse "familismo"²³ forçado denuncia a falência do Estado de Bem-Estar Social urbano. Conforme Gosta Esping-Andersen (1990), onde o Estado recua, a família é sobrecarregada, suprimindo transporte, segurança e saúde. A cidade torna-se parasitária da solidariedade familiar, transferindo os custos de sua ineficiência para a esfera privada.

O segundo pilar é a confirmação da infraestrutura como vetor de exclusão. Milton Santos (2006) alerta para a distinção entre a "tecnosfera" (hostil) e a "psicosfera" (acolhedora) no Recife periférico, gerando uma experiência esquizofrênica de

²⁰ Conceito de Jaime Lerner que propõe intervenções urbanas pontuais, rápidas e estratégicas em locais degradados ou subutilizados. O objetivo é criar uma reação em cadeia positiva, revitalizando o entorno e gerando melhorias sistêmicas na dinâmica da cidade.

²¹ Conceito de Edward Soja que se refere à expressão geográfica das injustiças sociais. Ocorre quando a organização do espaço e a distribuição desigual de recursos urbanos prejudicam determinados grupos, privando-os de serviços essenciais e infraestruturas com base na sua localização.

²² Conceito de Robert Putnam que se refere às redes de apoio e laços de solidariedade interna em grupos homogêneos (família, vizinhos e amigos próximos). Funciona como um recurso de proteção social e resiliência, suprimindo carências de infraestrutura através do suporte mútuo.

²³ Conceito que descreve o modelo social onde a responsabilidade pelo cuidado e bem-estar dos indivíduos recai prioritariamente sobre a rede familiar, em detrimento de uma rede pública de suporte. No urbanismo, manifesta-se pela escassez de serviços públicos de cuidado, assumindo a família como a única unidade de suporte ao idoso.

envelhecimento: o idoso é amado pelos vizinhos, mas agredido pelas calçadas. Como argumentam Tine Buffel e Chris Phillipson (2016), ao não prover suporte material, a cidade decreta o isolamento social por interdição física do espaço.

A terceira conclusão aponta para a urgência de uma mudança de paradigma: a implementação da EBAPI deve abandonar a universalidade homogênea em favor de uma "sensibilidade territorial"²⁴. Raquel Rolnik (2015) critica o planejamento tecnocrata que ignora as diferenças entre a planície e o morro.

Essa sensibilidade exige a "Acupuntura Urbana" em escala massiva, priorizando áreas vulneráveis não como discriminação, mas como equidade, aplicando o "Princípio da Diferença" de John Rawls (2003): investir onde a carência é maior para inverter a lógica de embelezar apenas o centro.

A quarta conclusão revela que a desigualdade espacial funciona como um multiplicador de desvantagens socioeconômicas. Henri Acselrad (2009) define isso como sobreposição de vulnerabilidades, onde o território agrava a pobreza e acelera o adoecimento. A mobilidade emerge como mecanismo central dessa reprodução; a tese demonstra que o Recife expropriou a "Motilidade"²⁵ (Vincent Kaufmann, 2002) dos idosos periféricos, tornando o acesso a direitos apenas virtuais.

Diante disso, reforça-se a necessidade de integração intersetorial. Como preconiza Eugênio Vilaça Mendes (2011), a "Saúde do Idoso" não se faz apenas no consultório, mas na Secretaria de Obras: um buraco tapado na RPA 3 é saúde preventiva.

A ausência dessa visão resulta no ciclo de ineficiência denunciado por Ermínia Maricato (2014), onde o setor de saúde trata a fratura que o urbanismo causou. As conclusões alinham-se à Nova Agenda Urbana (ONU-Habitat III), alertando que modelos do Norte Global devem ser tropicalizados: ser "amigo do idoso" no Recife é combater a pobreza e a segregação.

A geografia é destino; a "loteria do CEP" determina se haverá autonomia ou isolamento. A batalha pelo envelhecimento digno será vencida ou perdida no planejamento urbano. A tese finaliza defendendo o "Direito à Cidade" (David Harvey,

²⁴ Capacidade de compreender e incorporar as particularidades sociais, culturais e geográficas de um território no planejamento. Propõe que as políticas públicas deixem de ser genéricas para se tornarem ajustadas às necessidades reais e específicas de quem habita cada espaço.

²⁵ Conceito de Vincent Kaufmann que define o capital de mobilidade de um indivíduo. Refere-se à capacidade teórica e real de se deslocar, envolvendo a oferta de transporte, as competências individuais (físicas e cognitivas) e a apropriação dos sistemas de mobilidade.

2008) como o direito de não ser segregado ou imobilizado. A infraestrutura é a política, e o Recife precisa, urgentemente, fazer as pazes com sua população grisalha e periférica.

5.4 DETERMINANTES DO ACOLHIMENTO: O CAPITAL CULTURAL COMO FATOR DE INCLUSÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DA PRECARIIDADE

A análise inferencial realizada neste estudo, consubstanciada pelos testes de Análise de Variância (ANOVA), revelou um fenômeno sociológico de profunda relevância para o planejamento urbano no Recife: a preponderância do capital cultural sobre o capital econômico na determinação da experiência urbana.

O fato de variáveis clássicas de estratificação, como renda, situação laboral e arranjo de moradia, não apresentarem diferenças estatisticamente significativas ($p > 0,05$) em nenhum dos oito domínios da EBAPI desafia o senso comum e exige uma interpretação teórica refinada. Esse resultado sugere a existência do que podemos denominar de "democratização da precariedade".

A infraestrutura urbana do Recife — caracterizada por calçadas intransitáveis, ausência de mobiliário e insegurança viária — atingiu um nível de degradação tal que se tornou um equalizador negativo. A hostilidade do concreto não distingue a conta bancária; o idoso de classe média, ao colocar o pé na calçada, enfrenta o mesmo risco biomecânico de queda que o idoso de baixa renda. A cidade, em sua materialidade, impõe uma barreira física que o dinheiro, isoladamente, não transpõe.

Esta constatação alinha-se à teoria da "Espoliação Urbana" de Lúcio Kowarick (1979), que argumenta que o caos urbano é uma forma de exploração que subtrai qualidade de vida através do consumo coletivo precário. No Recife, essa espoliação tornou-se universal na velhice, provando que a crise urbana denunciada por Ermínia Maricato (2010) rompeu os muros da segregação e atingiu a mobilidade de todos. O carro particular pode mitigar o trajeto, mas não resolve a vivência da cidade como lugar de encontro.

Em contrapartida, a escolaridade emergiu como o grande divisor de águas, gerando clivagens significativas nos domínios de "Comunicação", "Participação" e "Respeito". Este achado valida a aplicabilidade da teoria do Capital Cultural de Pierre Bourdieu (1986) ao envelhecimento urbano.

O capital cultural, institucionalizado nos diplomas e incorporado no *habitus*, confere um poder simbólico de navegação: a educação formal funciona como uma bússola. O idoso mais escolarizado detém os códigos para decifrar a metrópole, entende a linguagem burocrática e possui a fluência digital necessária para acessar direitos que migram para plataformas virtuais.

A cidade é um texto, e a escolaridade determina a capacidade de lê-lo. A diferença no domínio "Participação Cívica" ilustra essa dinâmica, pois participar exige competência cívica. O idoso escolarizado sente-se autorizado a participar, enquanto o de baixa escolaridade, vitimado pela "Cultura do Silêncio" (Paulo Freire, 1987), tende a se autoexcluir, percebendo a cidade como uma entidade imutável e não como uma construção social passível de intervenção.

A escolaridade também atua como um escudo contra o etarismo no domínio "Respeito e Inclusão Social". Na sociedade brasileira, marcada pelo bacharelismo, o título acadêmico ou a posse da norma culta confere *status*; o idoso "doutor" recebe uma deferência que o analfabeto raramente acessa.

O capital cultural compra uma moeda que o econômico nem sempre garante: a dignidade no tratamento. Esse fenômeno se estende ao que Don Nutbeam (2000) define como *Health Literacy* (Letramento em Saúde), traduzido aqui como um "Letramento Urbano" que permite ao idoso gerenciar estrategicamente a cidade para preservar sua autonomia.

O fato de a renda não ter sido determinante reflete ainda o "achatamento da classe média" na velhice, onde o custo do envelhecimento (medicamentos e planos) consome a renda disponível, restando ao idoso, rico ou pobre, a mesma praça mal iluminada. A análise revela ainda que a "Informação" é o novo vetor de exclusão. Em uma era de *Smart Cities*, o idoso com baixa escolaridade vive um apartheid informacional, conforme o alerta de Manuel Castells (1999) sobre a exclusão na sociedade em rede.

No Recife, isso se materializa na dificuldade de agendar consultas ou checar horários de ônibus via aplicativos. Paralelamente, a "Reserva Cognitiva"²⁶ (Anita Neri, 2007) explica por que os escolarizados são mais críticos: a educação formal treina para o pensamento crítico. Enquanto o idoso com menos instrução naturaliza a ausência de calçadas, o instruído a percebe como violação de direito.

²⁶ Conceito da neurociência que descreve a capacidade do cérebro de improvisar e encontrar formas alternativas de realizar tarefas, compensando perdas funcionais. É construída ao longo da vida através da educação, ocupação e estímulos intelectuais, conferindo maior resiliência ao idoso.

A insatisfação é, portanto, sinal de cidadania ativa. Essa dinâmica confirma que o "Direito à Cidade" (David Harvey, 2012) é também um direito de apropriação intelectual do espaço. Aqueles a quem foi negado o direito à escola no passado, hoje têm negado o direito à cidade plena.

Por fim, a irrelevância do "Arranjo de Moradia" ²⁷ reforça que a hostilidade externa anula o suporte interno; ter com quem morar não conserta o buraco da rua. A discussão aponta para a insuficiência de políticas de transferência de renda isoladas: aumentar a aposentadoria não resolve a falta de rampa, visto que o problema é estrutural e físico.

Comunicação e Informação: A Cidade Ilegível e o Silenciamento Simbólico

O domínio "Comunicação e Informação" revelou-se o epicentro da desigualdade simbólica no Recife, apresentando a disparidade estatística mais acentuada de toda a pesquisa ($p < 0,001$) entre idosos com ensino fundamental e ensino superior. Este achado denuncia a existência de um *apartheid* informacional: enquanto a cidade física impõe barreiras de concreto, a simbólica ergue muros semióticos que barram seletivamente aqueles desprovidos de capital escolar, confirmando o Recife como uma "Cidade Ilegível"²⁸.

O conceito de legibilidade (*legibility*), cunhado por Kevin Lynch (1960), falha para o idoso de baixa escolaridade não apenas na morfologia, mas na sinalização e na comunicação institucional, transformando o espaço em um labirinto indecifrável. A nota mediana de 2,50 atribuída aos subitens de leitura indica barreiras severas de letramento funcional, tensionando a teoria de Paulo Freire (1989): o idoso possui a "leitura do mundo"²⁹, mas a cidade exige a leitura da palavra técnica e burocrática. Quando o Estado utiliza linguagem hermética, pratica uma exclusão ativa.

Esse cenário é agravado pela falha no Letramento em Saúde (*Health Literacy*), definido por Don Nutbeam (2000) como a competência para acessar e usar informações para promover a saúde. A incapacidade de decodificar fluxos de atendimento compromete

²⁷ Conceito demográfico e sociológico que descreve a composição do núcleo familiar e a organização dos indivíduos dentro de um domicílio. Define a estrutura de suporte imediato do idoso, sendo determinante para a análise da sua autonomia e das necessidades de cuidado no território.

²⁸ Conceito que descreve a dificuldade do indivíduo em compreender a organização, os trajetos e os significados do espaço urbano. A ilegibilidade decorre da falta de clareza na sinalização, infraestrutura descontínua e poluição visual, comprometendo a orientação e a autonomia, especialmente de pessoas idosas.

²⁹ Conceito de Paulo Freire que estabelece que a percepção crítica da realidade e do contexto social precede a alfabetização formal. No urbanismo, refere-se à capacidade do indivíduo de interpretar o espaço, identificar barreiras e significados a partir da sua experiência de vida.

a autonomia e a adesão terapêutica, criando, como reforça Rima Rudd (2015), uma barreira sistêmica que se torna uma questão de vida ou morte.

O fenômeno da "Info-exclusão" digital, alertada por Manuel Castells (1999), cassa o direito à cidade do cidadão analógico através da tela de *smartphones* que ele não opera. Soma-se a isso a falha na ergonomia da informação, que ignora as alterações sensoriais (presbiopia e acuidade auditiva) do envelhecimento, tornando a cidade biologicamente excludente.

Sob a ótica de Pierre Bourdieu (1989), a linguagem da administração pública exerce uma "Violência Simbólica"³⁰ que humilha e silencia, afastando o idoso da participação cívica por vergonha. Estudos de Nagler et al. (2014) demonstram que a desigualdade na comunicação gera desigualdade no engajamento; o isolamento social correlaciona-se à baixa nota em informação. A ilegibilidade da cidade atua como um fator patogênico, elevando níveis de estresse e minando a confiança nas instituições, o que abre espaço para a desinformação (*fake news*).

Enquanto a "Reserva Cognitiva" (Anita Neri, 2007) atua como proteção para os escolarizados, os demais enfrentam uma dupla barreira cognitiva e educacional. É imperativo que o "Direito à Compreensão"³¹ seja incorporado ao Direito à Cidade (Lefebvre, 2001), combatendo o "efeito Mateus"³² informacional onde a brecha de saber amplia a brecha social.

O "Letramento Urbano"³³ emerge como determinante de saúde tão vital quanto o saneamento. A tese demonstra que superar esse abismo exige a implementação de leis de "Linguagem Simples" (*Plain Language*) e um desenho urbano autoexplicativo, sem os quais a "Cidade Amiga" será apenas um *slogan* que o idoso não consegue ler, restando-lhe a dependência infantilizada relatada por Burnett et al. (2016).

Participação Social e Cívica: O Descrédito Institucional e a Democracia Censitária

³⁰ Conceito de Pierre Bourdieu que descreve formas de dominação que não utilizam a força física, mas o convencimento e a imposição de significados. Manifesta-se quando grupos vulneráveis naturalizam as barreiras e exclusões sociais, aceitando-as como parte da ordem natural das coisas.

³¹ Princípio que estabelece o direito de qualquer cidadão de entender informações públicas de forma clara e inequívoca. No contexto da gerontologia, refere-se à eliminação de barreiras linguísticas e cognitivas, garantindo que o idoso compreenda o funcionamento e as normas do espaço urbano.

³² Conceito sociológico de Robert K. Merton que descreve o fenômeno da acumulação de vantagens ou desvantagens. No urbanismo, refere-se à tendência de investimentos e infraestruturas se concentrarem em áreas já privilegiadas, enquanto territórios vulneráveis permanecem marginalizados, ampliando o fosso da desigualdade territorial.

³³ Refere-se ao conjunto de competências e conhecimentos que permitem ao indivíduo ler, interpretar e agir sobre o espaço urbano. Envolve desde a orientação espacial e o uso de sistemas de transporte até a compreensão dos direitos cidadãos e dos canais de participação política na gestão da cidade.

A análise estatística revelou uma fratura exposta na democracia local: a escolaridade modulou significativamente ($p=0,009$) a percepção de pertencimento cívico, indicando uma cidadania política regulada pelo diploma. Idosos com ensino superior reportaram aptidão substancialmente maior para o engajamento, enquanto os demais manifestaram exclusão das esferas decisórias, confirmando que a "Cidade Amiga" reproduz a lógica de que apenas os letrados desenham a *polis*.

O subitem "Fundo Municipal do Idoso" (nota 1,00) ergue-se como um monumento ao descrédito institucional, refletindo uma desconfiança sistêmica na eficácia dos instrumentos públicos. Esta alienação dialoga com a crítica de Leonardo Avritzer (1996) sobre a "gramática política"³⁴ excludente, onde instrumentos desenhados em linguagem hermética funcionam como barreiras. A tecnocracia sequestrou a participação, transformando audiências públicas em rituais de validação entre especialistas.

A discrepância na "participação cidadã informal" (mediana 2,40) reforça a tese da "Aristocracia Associativa"³⁵, onde a liderança é capturada por quem detém capital cultural, relegando o idoso trabalhador braçal à posição de ouvinte passivo. Conforme a teoria do "Empoderamento" (Empowerment) de John Friedmann (1992), a pobreza é também falta de poder social; a baixa escolaridade opera como um desempoderamento sistemático que silencia o idoso diante da autoridade.

Esse silêncio corrobora os estudos de Buffel, Phillipson e Scharf (2012), demonstrando que a inclusão cívica é privilégio das classes médias urbanas. A educação formal atua como mediadora do capital simbólico necessário para navegar na prefeitura, conferindo o que Pierre Bourdieu (1989) chama de "competência estatutária", sem a qual o idoso vive como súdito do clientelismo local.

A falência dos Conselhos Municipais e a "Cultura do Silêncio"³⁶ (Paulo Freire, 1987) culminam em uma velhice politicamente muda, onde o sistema educacional que falhou com o idoso no passado cobra o preço na baixa cidadania ativa de hoje. Além

³⁴ Conceito que se refere ao conjunto de regras, códigos e lógicas que estruturam o debate público e a tomada de decisão. No contexto urbano, define como os direitos são interpretados e quais grupos sociais possuem maior influência na configuração do território e na distribuição de recursos.

³⁵ Conceito que descreve a tendência de os espaços de participação civil e política serem ocupados majoritariamente por indivíduos com alto capital cultural e socioeconômico. Reflete uma desigualdade no exercício da cidadania, onde grupos mais escolarizados detêm o monopólio da representação e da articulação de demandas junto ao Estado.

³⁶ Conceito de Paulo Freire que descreve o estado de passividade e emudecimento de grupos marginalizados diante da opressão. No contexto urbano, refere-se à naturalização das precariedades por parte da pessoa idosa, que passa a aceitar a exclusão e a invisibilidade como condições inevitáveis, abdicando do seu papel de sujeito de direitos.

disso, a hostilidade física das instâncias de participação e a imobilidade urbana esvaziam o direito de reunião (David Harvey, 2014), restando a assembleia para a elite escolarizada.

A digitalização dos processos participativos aprofundou o fosso através de uma "seleção natural tecnológica", onde o cidadão analógico é deletado do processo decisório. O sentimento de "Inutilidade Social"³⁷ retrai o idoso para a esfera doméstica ou religiosa, o que demanda uma urgente "Pedagogia da Participação"³⁸ e a adoção de Linguagem Simples. A descrença no Fundo Municipal é um alerta para a gestão fiscal, exigindo transparência ativa para superar o que Maria da Glória Gohn (2010) identifica como participação tutelada. A clivagem educacional cria duas cidades políticas: a dos que reclamam e são atendidos e a dos que sofrem em silêncio.

A "Ação Comunicativa"³⁹ de Jürgen Habermas (1987) permanece uma utopia no Recife, onde a comunicação é ruidosa e assimétrica. A tese demonstra que a democracia urbana é incompleta e "para na porta da escola", exigindo que o Fundo Municipal e o Plano Diretor sejam acessíveis tanto à moradora do morro quanto ao doutor da beira-mar, rompendo o teatro de sombras da elite grisalha.

Percepção de Respeito: O Capital Simbólico Como Proteção e a Hierarquia Da Dignidade

A análise deste domínio revelou uma das facetas mais sutis e perversas da desigualdade urbana no Recife: a existência de uma "hierarquia da dignidade"⁴⁰. Os testes estatísticos demonstraram que a escolaridade atua como um filtro determinante ($p=0,013$) que regula a qualidade do respeito recebido no espaço público. Enquanto a idade deveria garantir a deferência preconizada no Estatuto da Pessoa Idosa, os dados indicam que ela é seletiva, concedida preferencialmente aos que ostentam sinais de educação formal.

³⁷ Conceito que descreve a desvalorização sistemática do indivíduo no envelhecimento, baseada na lógica produtivista que atrela o valor humano à capacidade de gerar lucro ou trabalho ativo. Essa percepção sustenta a negligência de políticas públicas e a invisibilidade do idoso no planejamento das cidades.

³⁸ Conceito que compreende a participação social como um processo educativo e emancipatório. Defende que o envolvimento ativo dos sujeitos na tomada de decisão e no diagnóstico da realidade não é apenas um instrumento de gestão, mas uma forma de aprendizado da cidadania e de fortalecimento da autonomia política.

³⁹ Conceito de Jürgen Habermas que define a interação social voltada para o entendimento mútuo e o consenso, em oposição à ação estratégica ou instrumental. No urbanismo participativo, fundamenta o diálogo democrático onde a validade das propostas é determinada pela livre troca de argumentos entre sujeitos em busca de soluções para o bem comum.

⁴⁰ Conceito crítico que descreve a diferenciação no valor atribuído à vida e aos direitos dos cidadãos no espaço urbano. Manifesta-se quando o planejamento privilegia as necessidades de determinados grupos ou modais em detrimento da segurança e autonomia de populações vulneráveis, estabelecendo uma gradação na aplicação do princípio da dignidade humana no território.

Esta discrepância sugere que a cidade opera sob a lógica do "Bacharelismo"⁴¹, fenômeno discutido por Sérgio Buarque de Holanda (1936), onde o título acadêmico funciona como escudo contra a desumanização. O idoso "doutor" é atendido com presteza, enquanto o sem título é tolerado com impaciência. Este achado dialoga com a "Violência Simbólica" de Pierre Bourdieu (1989): o desrespeito aos menos escolarizados manifesta-se em gestos sutis e tons condescendentes, exercendo uma dominação que rebaixa o outro à condição de subcidadão.

A interação social torna-se um palco de disputas por reconhecimento, onde a sociologia de Erving Goffman (1967) sobre os "rituais de interação"⁴² explica como o idoso instruído domina as regras para exigir direitos, enquanto o de baixa instrução "perde a face" e se retrai ao silêncio obsequioso.

O fenômeno da infantilização emerge como queixa recorrente, atingindo desproporcionalmente os menos escolarizados. O uso de diminutivos é uma forma de etarismo linguístico que, como alertava Robert Butler (1969), nega a autoridade do velho. Soma-se a isso a crise da "Civildade Urbana"⁴³ (Norbert Elias, 1994), onde a impaciência com o tempo da velhice marca um processo descivilizador no trânsito e serviços.

A teoria do "Reconhecimento"⁴⁴ de Axel Honneth (2003) é fundamental aqui: o idoso recifense possui o amor (família), mas falha no reconhecimento jurídico e social pleno. A escolaridade atua como muleta social; sem ela, vive-se uma cidadania de segunda classe marcada pela "Invisibilidade Pública"⁴⁵ e pela injustiça de *status* (Nancy Fraser, 2000).

⁴¹ Tradição sociocultural brasileira que privilegia o saber retórico, o formalismo jurídico e o prestígio dos títulos acadêmicos em detrimento da eficácia prática e da realidade social. No contexto urbano, reflete-se na elaboração de normas e planos técnicos que, embora formalmente perfeitos, apresentam baixa aderência às necessidades reais da população no território.

⁴² Conceito de Erving Goffman e Randall Collins que descreve as unidades básicas da vida social baseadas em encontros face a face. Refere-se às regras de conduta e aos mecanismos de foco compartilhado e carga emocional que sustentam os laços sociais e a identidade dos indivíduos durante as interações cotidianas no espaço público.

⁴³ Conceito que define a capacidade de convivência respeitosa e o reconhecimento mútuo entre diferentes sujeitos no espaço público. Refere-se à etiqueta social e ao compromisso ético com o bem comum, sendo essencial para garantir que grupos mais vulneráveis, como os idosos, possam circular com segurança, dignidade e sentimento de pertença à cidade.

⁴⁴ Teoria desenvolvida por Axel Honneth (Escola de Frankfurt) que estabelece que a formação da identidade e a justiça social dependem de três esferas de reconhecimento: afetiva, jurídica e social. No contexto da tese, fundamenta a ideia de que o planejamento urbano inclusivo é uma forma de reconhecimento da dignidade e dos direitos do idoso, enquanto a negligência territorial representa uma forma de desrespeito social e negação da cidadania.

⁴⁵ Conceito que descreve o fenômeno de apagamento social de determinados sujeitos ou grupos, que passam a ser tratados como inexistentes ou irrelevantes na esfera pública, apesar da sua presença física. No contexto urbano, manifesta-se pela negligência no planejamento de espaços para o idoso e pela desumanização das suas necessidades, resultando na perda de voz política e social.

O atendimento prioritário torna-se um campo de batalha simbólico onde a "cordialidade"⁴⁶ brasileira (Roberto DaMatta, 1979) revela seu lado sombrio: a lei só é eficaz para quem pode cobrar "você sabe com quem está falando?". Esse estresse gera uma "Carga Alostática"⁴⁷ elevada, levando ao isolamento social como estratégia de defesa psíquica.

A segregação espacial potencializa esse desrespeito, criando um ambiente propício ao conflito nas periferias negligenciadas. A questão racial, imbricada na escolaridade, sugere que o desrespeito tem cor, onde o racismo estrutural coloca o idoso negro e pouco escolarizado na base da pirâmide urbana.

A tecnologia agrava o quadro, pois o atendimento automatizado é o agente final da desumanização para quem não possui letramento digital. Os dados sugerem que a inclusão dos escolarizados é uma "inclusão por distinção"⁴⁸, um privilégio de casta.

A tese aponta que a humanização depende de protocolos rígidos, pois a solidariedade intergeracional aparece fraturada em uma cidade que celebra apenas a juventude produtiva.

Embora os instruídos atuem como resistência, a conquista deve ser socializada pelo empoderamento em direitos. Conclui-se que o Recife vive uma crise de "Etiqueta Cidadã"⁴⁹, onde o olhar exclui tanto quanto a falta de rampa. Superar essa herança colonial exige uma revolução pedagógica para que o idoso analfabeto receba a mesma deferência do catedrático.

A Democratização da Hostilidade: Limites do Capital Econômico e a Supremacia do Saber

⁴⁶ Conceito de Sérgio Buarque de Holanda que descreve um traço da formação social brasileira, onde as relações são pautadas pela predominância do afeto e dos laços familiares sobre a impessoalidade do Direito e das normas públicas. No urbanismo, manifesta-se na substituição do acesso universal a direitos por redes de favores e relações pessoais, dificultando a consolidação da cidadania plena.

⁴⁷ Conceito que descreve o desgaste cumulativo do corpo resultante da exposição prolongada e repetida a estressores crônicos. No contexto urbano, refere-se ao impacto fisiológico negativo causado por ambientes hostis e inacessíveis, que exigem um esforço adaptativo constante do idoso, resultando na sobrecarga dos sistemas biológicos e no agravamento de comorbidades.

⁴⁸ Conceito que descreve o fenômeno onde o acesso a direitos e espaços públicos é facultado apenas a indivíduos que possuem capitais (cultural, social ou econômico) que os distinguem da maioria. No urbanismo, revela que a inclusão de certos idosos ocorre não pelo reconhecimento da sua cidadania plena, mas pela sua posição social diferenciada, mantendo a exclusão daqueles que não possuem as mesmas marcas de distinção.

⁴⁹ Refere-se ao conjunto de práticas e comportamentos éticos adotados pelos indivíduos no espaço público, visando a convivência harmônica e o respeito mútuo. Diferencia-se da etiqueta formal por focar na responsabilidade cívica e no reconhecimento das necessidades do outro, sendo vital para a autonomia e segurança de populações com mobilidade reduzida.

O achado empírico de que a renda não apresentou impacto estatisticamente significativo na avaliação da "Cidade Amiga" constitui o resultado mais contraintuitivo desta tese, desafiando a ortodoxia que lê a realidade brasileira apenas pela estratificação de classe. No Recife, a hostilidade urbana atingiu tal saturação que rompeu os diques da segregação, espalhando-se como uma "mancha de óleo" que contamina tanto o idoso de salário mínimo quanto o de camadas altas.

Diferente de contextos europeus ou norte-americanos, a cidade evidencia uma "socialização da precariedade"⁵⁰: o buraco na calçada e a ausência de drenagem são bens públicos negativos indivisíveis, que o poder de compra individual não contorna.

Esta constatação valida a tese da "Espoliação Urbana"⁵¹ de Lúcio Kowarick (1979) em chave ampliada, onde a degradação do ambiente nivela por baixo a qualidade de vida; quando a cidade alaga, o direito de ir e vir é suspenso tanto para o SUV de luxo quanto para o ônibus.

A irrelevância da renda reforça que o "Direito à Cidade" (David Harvey, 2012) é um direito coletivo, onde a riqueza privada perde sua potência de conversão em bem-estar se o espaço público está degradado, confinando o idoso de alta renda em uma "prisão dourada" tão imobilizante quanto o barraco periférico.

O conceito de "Rugosidade"⁵² de Milton Santos (2006) explica essa inércia: as heranças físicas do passado impõem resistências que o capital financeiro não dissolve instantaneamente. Para a biologia do envelhecimento, a vibração do asfalto remendado é dolorosa independentemente da marca do veículo.

Este cenário revela o fracasso das soluções neoliberais; o mercado oferece o "enclave fortificado"⁵³ (Teresa Caldeira, 2000), mas não consegue oferecer a cidade

⁵⁰ Conceito que descreve o processo de naturalização e aceitação coletiva das carências de infraestrutura e serviços públicos. Reflete a transferência do ônus da negligência estatal para o indivíduo, que passa a incorporar a precariedade como um dado inevitável da vida cotidiana, inibindo a percepção da carência urbana como uma violação de direitos.

⁵¹ Conceito formulado por Lúcio Kowarick que descreve a soma das extorsões sofridas pelas camadas populares na cidade, para além da exploração no trabalho. Refere-se à carência ou precariedade de infraestruturas e serviços de consumo coletivo (transporte, saúde, habitação), que obriga o indivíduo a arcar com custos privados para garantir a sua reprodução social e sobrevivência no território.

⁵² Conceito formulado por Milton Santos que define as heranças do passado que permanecem no espaço geográfico, manifestando-se em formas construídas, infraestruturas e objetos que resistem à substituição. No contexto urbano, refere-se aos elementos físicos e espaciais de tempos passados que condicionam, limitam ou oferecem resistência às novas dinâmicas e necessidades de mobilidade e uso da cidade atual.

⁵³ Conceito de Teresa Caldeira que descreve espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo ou lazer, que rompem com a continuidade do tecido urbano e a vida pública da rua. No Recife, manifestam-se como condomínios e centros empresariais murados que, ao priorizarem a segurança privada e a segregação social, fragilizam a mobilidade do pedestre e o convívio democrático no espaço comum.

necessária ao envelhecimento ativo. A "Cultura do Medo"⁵⁴ e a violência urbana operam como equalizadores perversos, invalidando o capital econômico como garantia de tranquilidade.

Neste contexto, a escolaridade desponta como o verdadeiro fiel da balança, pois o "saber" supera o "ter" ao fornecer ferramentas para navegar no caos e acionar redes de influência. Conforme as "Capabilidades"⁵⁵ de Amartya Sen (2000), a renda é apenas um meio; se a cidade impede sua conversão em funcionamento, a liberdade real é nula. A escolaridade amplia as capacidades internas, enquanto a renda bate no teto da incapacidade urbana (Eduardo Vasconcellos, 2014).

A análise considera ainda o fenômeno da "proletarização da velhice"⁵⁶, onde o custo do envelhecimento corrói a renda nominal, diminuindo a distância prática entre a classe média e o pobre em uma cidade hostil. A especificidade geográfica do Recife, com a contiguidade entre "torres e palafitas", impede a "secessão dos ricos", pois os problemas de drenagem da favela transbordam para a área nobre.

O resultado aponta para a falácia da meritocracia urbana: o idoso que "venceu na vida" descobre que o fracasso do planejamento anula seu sucesso individual. A irrelevância da renda é uma denúncia da falência do Estado em prover bens comuns; o buraco e o medo tornaram-se democráticos.

A predominância do capital cultural sugere que a nova elite é a da informação, capaz de processar a complexidade urbana. Esta "democracia da hostilidade" impõe uma "igualdade negativa": somos todos iguais perante o buraco.

Assim, a luta pela "Cidade Amiga" torna-se uma luta interclassista, unindo objetivamente o morro e o asfalto em torno da reivindicação política por infraestrutura inclusiva.

5.5 A UNIVERSALIDADE DA PRECARIÉDADE E O FATOR IDADE: A CIDADE

⁵⁴ Conceito que descreve o estado social de insegurança e ansiedade coletiva, muitas vezes alimentado pelo discurso midiático e pela percepção de risco constante. No planejamento urbano, manifesta-se no retraimento das pessoas para espaços privados e na fragmentação da vida pública, afetando severamente a autonomia de grupos vulneráveis, como os idosos, que passam a restringir os seus deslocamentos por medo da violência.

⁵⁵ Conceito formulado por Amartya Sen que define as liberdades reais de que uma pessoa dispõe para realizar aquilo que ela tem razão para valorizar. Diferencia-se da posse de bens ou da existência de infraestruturas, focando na capacidade efetiva do indivíduo (neste caso, o idoso) de converter recursos urbanos em funcionamentos que garantam a sua autonomia e bem-estar no território.

⁵⁶ Conceito que descreve a perda de estatuto socioeconômico e a precarização das condições de vida na velhice. Refere-se ao processo em que a pessoa idosa, devido à insuficiência de rendimentos e ao aumento dos custos de sobrevivência e saúde, é empurrada para uma condição de vulnerabilidade material semelhante à do proletariado, perdendo autonomia e capacidade de escolha sobre o seu modo de vida no território.

COMO AGENTE INCAPACITANTE

A análise inferencial conduzida neste estudo revelou um cenário de "homogeneidade na adversidade"⁵⁷ que desafia as expectativas da gerontologia clássica. Os resultados indicam que a idade cronológica apresentou correlação estatisticamente significativa apenas com o domínio "Transporte e Mobilidade Urbana" ($p < 0,05$) — e ainda de forma fraca —, enquanto nos demais eixos (Saúde, Moradia, Respeito e Ambiente Físico) a percepção manteve-se inalterada, independentemente de o sujeito ter 60 ou 90 anos.

Este dado denuncia a brutalidade do ambiente construído no Recife. A "hipótese da docilidade ambiental" de Lawton e Nahemow (1973) postula que, quanto menor a competência individual, maior a pressão do ambiente; contudo, a estabilidade das avaliações negativas sugere que o nível de pressão da cidade é tão elevado que ultrapassa o limiar de competência de todos os idosos, nivelando a experiência por baixo.

A cidade não distingue o "idoso jovem" (*young-old*) do "idoso muito velho" (*oldest-old*); ela impõe barreiras intransponíveis a ambos. A correlação encontrada no transporte confirma que esta é a dimensão onde a "violência cinética"⁵⁸ (Paul Virilio, 1996) se manifesta com maior crueza, exigindo uma performance física que o envelhecimento corrói progressivamente. O transporte é o elo onde a biologia colide frontalmente com a máquina.

A ausência de impacto significativo da idade nos outros domínios sugere uma "universalização da barreira"⁵⁹. O ambiente físico do Recife atua como um "agente totalitário"⁶⁰, impondo hostilidade de forma democrática e anulando as nuances da heterogeneidade do envelhecimento. Os testes t de Student, que confirmaram a ausência

⁵⁷ Conceito que descreve a condição de grupos sociais que, apesar de possuírem trajetórias distintas, são nivelados por uma base comum de privações e precariedades impostas pelo ambiente ou pelo Estado. No contexto urbano, refere-se ao modo como as carências de infraestrutura e serviços tornam as dificuldades de sobrevivência e circulação uma experiência uniforme e compartilhada entre as populações vulneráveis.

⁵⁸ Conceito derivado da Dromologia de Paul Virilio, que define a velocidade como um instrumento de poder e dominação. No urbanismo, refere-se à agressividade imposta pelos fluxos acelerados de veículos sobre os ritmos biológicos e humanos, onde a priorização da fluidez motorizada atua como uma forma de violência física e simbólica contra os sujeitos de mobilidade reduzida.

⁵⁹ Conceito crítico que descreve a onipresença de obstáculos físicos, informacionais e sociais no território urbano. Ao contrário da acessibilidade universal, a universalização da barreira refere-se à condição em que a precariedade e o impedimento à livre circulação deixam de ser exceções e passam a constituir a regra da experiência cotidiana dos sujeitos de mobilidade reduzida na cidade.

⁶⁰ Conceito que designa atores hegemônicos — sejam eles econômicos ou estatais — que exercem um poder decisivo e unidirecional sobre a produção e organização do espaço urbano. Estes agentes impõem lógicas de mercado ou de circulação que tendem a anular as especificidades dos lugares e as necessidades de grupos vulneráveis, subordinando a vida cotidiana aos interesses de acumulação ou eficiência técnica.

de impacto de variáveis como trabalho, deficiência ou gênero, reforçam a tese da "supremacia do ambiente"⁶¹.

O fato de pessoas com e sem deficiência reportarem percepções estatisticamente semelhantes valida o Modelo Social da Deficiência de Michael Oliver (1990): não é o corpo que é deficiente, mas a sociedade que o incapacita. No Recife, a infraestrutura "deficiência" a todos, criando uma "Deficiência Situacional" onde o ambiente urbano anula a funcionalidade do corpo e transforma a caminhada em uma prova de obstáculos olímpica para qualquer um sem a vitalidade da juventude.

Da mesma forma, a inexistência de diferença por gênero sugere que o medo de cair (risco físico) superou as questões de gênero e violência social (Pain, 2001), criando uma comunhão no temor. Nem mesmo a variável "Trabalho" blindou o idoso, derrubando o mito de que o "envelhecimento ativo" produtivo seria uma panaceia; o trabalho confere renda, mas não imunidade contra o ônibus lotado.

Essa invariância nos resultados aponta para um colapso sistêmico da acessibilidade. Como discute Richard Sennett (1994) em "Corpo e Pedra", a cidade moderna foi desenhada para o fluxo, ignorando a fadiga da carne.

No Recife, a ausência de bancos de descanso impede a apropriação do espaço e força o confinamento. A fraca correlação no transporte pode indicar ainda o "Paradoxo da Satisfação"⁶² (Baltes e Baltes, 1990), onde os muito idosos restringem seus trajetos para evitar a frustração, avaliando o pouco que usam de forma menos crítica.

A cidade opera como uma máquina de produzir dependência, onde a "deficiência" não é atributo de uma minoria, mas uma condição latente de toda a população longeva. Isso questiona a eficácia de políticas focadas apenas em grupos específicos; se o oceano é de exclusão, a vaga exclusiva é apenas uma ilha.

É urgente transitar para o "Desenho Universal" (Mace, 1985), criando "gradientes de desafio" que hoje inexistem. A tese identifica um "Teto de Vidro Biomecânico"⁶³:

⁶¹ Conceito da Gerontologia Ambiental (M. Powell Lawton) que ocorre quando as exigências e pressões do meio físico superam as competências funcionais do indivíduo. Reflete a perda de autonomia do idoso diante de um território hostil, onde as barreiras arquitetônicas e urbanas exercem um domínio sobre o comportamento, forçando o retraimento social e o confinamento doméstico.

⁶² Fenômeno observado na gerontologia social em que indivíduos idosos relatam níveis elevados de satisfação subjetiva com a vida ou com o ambiente, apesar de apresentarem condições objetivas de precariedade, carência ou limitações funcionais. Resulta de processos adaptativos, como o ajuste de expectativas, a comparação social descendente e a valorização de dimensões afetivas em detrimento das deficiências infraestruturais do território.

⁶³ Metáfora que descreve a barreira invisível, mas intransponível, imposta pela desproporção entre as exigências físicas do ambiente urbano (como aclives acentuados, falta de bancos e tempos semaforicos curtos) e as capacidades biomecânicas do idoso. Refere-se ao limite de esforço e segurança que condiciona a liberdade de circulação, impedindo o sujeito de atingir destinos visíveis, mas funcionalmente inacessíveis.

acima dele, a cidade é fricção constante. O "Fator Idade" no Recife importa menos do que o "Fator Cidade". A cronologia do indivíduo é achatada pela topografia da exclusão, democratizando a paralisia e rejeitando o futuro de todos os seus habitantes.

Transporte e Mobilidade: A Adaptação das Expectativas e o Paradoxo da Satisfação na Quarta Idade

A análise inferencial da variável idade revelou um fenômeno aparentemente paradoxal: a existência de uma correlação fraca, porém positiva, entre o avanço da idade e a avaliação do transporte público. Em termos práticos, os idosos longevos (80+) tendem a ser ligeiramente menos críticos em relação à mobilidade urbana do que os "jovens idosos" (60–69 anos).

Longe de indicar que o sistema de transporte se torna mais eficiente para os mais velhos, este dado sugere uma complexa reconfiguração das expectativas subjetivas frente a uma realidade objetiva imutável. Para compreender esse achado, é imperativo recorrer à Teoria da Seletividade Socioemocional de Laura Carstensen (1999).

A autora postula que, com o encurtamento da perspectiva de tempo futuro, o indivíduo prioriza metas emocionais e evita confrontos negativos; aplicado à percepção urbana, o idoso octogenário pode estar acionando um mecanismo de defesa psíquica, "suavizando" o julgamento sobre barreiras imutáveis para evitar o estresse. Em contraste, o grupo dos "jovens idosos" encontra-se no epicentro da fricção urbana, demandando uma eficiência que o Recife não entrega, pois avaliam o sistema com a régua da necessidade laboral e da agilidade.

Esta dinâmica pode ser analisada sob a ótica das "Preferências Adaptativas"⁶⁴ de Amartya Sen (1999): pessoas em situações de privação crônica ajustam seus desejos às possibilidades limitadas para evitar a dissonância cognitiva. O idoso recifense pode ter desenvolvido um "ceticismo aprendido"⁶⁵, onde a resignação leva a uma avaliação

⁶⁴ Conceito que descreve o ajuste inconsciente dos desejos e expectativas de um indivíduo às suas condições limitadas de vida. Ocorre quando sujeitos em situação de privação ou exclusão urbana passam a considerar as suas restrições como normais ou aceitáveis, reduzindo o seu horizonte de aspirações como mecanismo de defesa psicológica diante da impossibilidade de mudança do ambiente hostil.

⁶⁵ Conceito que descreve a descrença sistemática e a desconfiança racional de indivíduos ou grupos em relação a instituições e políticas públicas, resultantes de um histórico de promessas não cumpridas e experiências negativas de negligência estatal. Diferente do desinteresse, o ceticismo aprendido atua como um mecanismo de defesa contra futuras frustrações, desestimulando a mobilização política e a crença na transformação do ambiente urbano.

benevolente não pela qualidade do serviço, mas pela destruição da expectativa por décadas de negligência.

Soma-se a isso a "Comparação Social Descendente", onde o sobrevivente de sua coorte compara sua situação atual ("ainda consigo sair") com a de pares acamados, e o "Efeito Coorte", que distingue a geração estóica de meados do século XX da geração *Baby Boomer*, mais reivindicatória.

Além disso, a presença frequente de um "Passageiro Acompanhado" (cuidador ou familiar) amortece a hostilidade do sistema, criando uma "borbulha de cuidado" que eleva artificialmente a satisfação, enquanto o "Desengajamento Seletivo" (Cumming & Henry, 1961) sugere que a satisfação pode refletir a renúncia ao direito à cidade plena em favor da reclusão.

Estudos de Krebs e Allard (2020) corroboram que a percepção de barreiras diminui com a idade porque o idoso desenvolve "mapas mentais defensivos", excluindo rotas inviáveis de sua cognição. Ocorrem aqui a "Adaptação Hedônica" e o viés de sobrevivência: os que respondem ao questionário usando ônibus aos 80 anos são uma elite biológica que mantém funcionalidade apesar do sistema.

No entanto, o silêncio dos mais vulneráveis é um sintoma de exaustão, uma "polidéz do desespero" que a gestão urbana não deve confundir com aprovação. O nível de exigência das políticas públicas deve ser balizado pela "insatisfação crítica" dos idosos de 60 anos, garantindo que a "Cidade Amiga" não conte com a paciência infinita dos longevos.

A correlação idade-satisfação é, na verdade, a medida do quanto o cidadão teve de ceder de sua cidadania para continuar pertencendo ao Recife; um sucesso psicológico construído sobre um fracasso urbanístico.

Precariedade Estrutural Universal: A Cidade Como Barreira Totalitária

A análise transversal dos dados desta pesquisa permite formular um diagnóstico contundente: o Recife impõe aos seus idosos uma "Precariedade Estrutural Universal". A ausência de impacto estatístico significativo de variáveis classicamente estratificadoras — como renda, situação laboral, deficiência preexistente ou gênero — sobre a percepção da cidade confirma a hipótese de que o ambiente urbano atingiu um grau de degradação tal que se tornou um equalizador negativo.

Problemas como calçadas irregulares, ausência de abrigos de ônibus e insegurança viária configuram-se como barreiras macroestruturais que não são mitigadas pelo status social do indivíduo. Estamos diante do que Ermínia Maricato (2010) descreve como a crise do modelo de urbanização brasileiro, onde a precariedade não é uma exceção localizada, mas a regra geral de produção do espaço. O "direito de ir e vir" é cassado pela materialidade do concreto quebrado, afetando tanto o aposentado de um salário mínimo quanto o funcionário de alta renda.

A teoria da "Marginalidade Avançada" de Loïc Wacquant (2008) pode ser transposta aqui: a cidade torna-se um mecanismo de segregação onde o próprio corpo envelhecido é o alvo, e a "blindagem" do capital privado falha diante da indivisibilidade do espaço público.

A invariância dos resultados por gênero e deficiência é um achado perturbador que desafia a literatura tradicional (Pain, 2001). No Recife, o risco de queda é uma ameaça biológica que nivela homens e mulheres; a cidade não é perigosa apenas porque é violenta, mas porque é fisicamente agressiva.

A variável "Deficiência" não gerou distinção estatística porque o ambiente urbano "deficiência" a todos, exigindo uma performance atlética para ser transposto. Ocorre uma "Deficiência Situacional"⁶⁶ generalizada, validando o Modelo Social da Deficiência que retira a culpa do corpo e a coloca na arquitetura excludente. Sob a ótica de Eduardo Vasconcellos (2014), o sistema viário colapsou em um cenário de "soma zero" onde a priorização do fluxo de veículos em detrimento das pessoas destrói a malha fina da vida social.

Esse microconfinamento gera uma cidade sem "olhos na rua", retroalimentando a insegurança e isolando o cidadão longo atrás de um muro invisível formado por barreiras físicas e semióticas. Essa constatação reforça a importância vital de políticas baseadas no Desenho Universal (Mace, 1985), transitando do foco na "necessidade especial" para a criação de um ambiente utilizável por todos.

Enquanto a gestão urbana operar no paradigma do "Homem Médio" e se mantiver reativa e negligente (Buffel e Phillipson, 2012), ela continuará sendo uma máquina de exclusão. A ausência de impacto da situação laboral derruba o mito de que a inserção

⁶⁶ Conceito que descreve a limitação funcional temporária ou contextual imposta por fatores ambientais a um indivíduo, independentemente de ele possuir uma deficiência permanente. No urbanismo, refere-se ao momento em que as características do meio (ex.: excesso de ruído, má iluminação, calor extremo ou obstáculos físicos) impedem ou dificultam o desempenho de atividades cotidianas, tornando o ambiente o principal gerador da incapacidade.

produtiva resgata a cidadania urbana; a dignidade é um bem público que o sucesso individual não substitui.

A "Justiça Espacial" de Edward Soja (2010) é violada não apenas na distribuição desigual, mas na qualidade absoluta do espaço, que rompeu o " piso de cidadania". O Recife democratizou o sofrimento urbano através de uma "Vulnerabilidade Estrutural" construída politicamente por décadas. Superar esse quadro exige um "New Deal" urbano que coloque o pedestre vulnerável no centro, pois a política social sem política urbana é, em última instância, enxugar gelo.

Idade Como Determinante Universal da Vulnerabilidade: O Corpo Como Fronteira Final

A síntese dos achados desta investigação permite postular que, embora a renda não blinde a percepção da cidade, o processo natural e inexorável do envelhecimento corporal constitui o fator basal que potencializa a vulnerabilidade urbana. A vulnerabilidade é aqui entendida como uma condição ontológica: a limitação biomecânica, a redução da acuidade sensorial e a alteração do equilíbrio tornam o idoso uma "antena sensível" às falhas da infraestrutura.

O Modelo de Pressão Ambiental de Lawton e Nahemow (1973) oferece a chave interpretativa: no Recife, onde o ambiente é agressivo (alta pressão), a menor perda de competência biológica resulta em uma queda drástica no bem-estar. A idade funciona como um amplificador das inadequações urbanas; a sarcopenia e a instabilidade postural atingem todos os corpos e, quando a cidade ignora essas necessidades corporais universais, ela transforma o envelhecer em um processo artificial de incapacitação.

Esse achado corrobora a tese de que a exclusão urbana é produto de fatores estruturais que negam o 'Direito à Cidade' (Lefebvre, 2001) pela via somática. O idoso é, por definição arquitetônica, um corpo desviante em um sistema calibrado para um 'Homem Médio' jovem e atlético — uma materialização da injustiça espacial (Harvey, 2012) que prioriza a fluidez do capital em detrimento da diversidade dos corpos.

Fatores sociais como a escolaridade (vistos em 5.4) servem para navegar no "software" da cidade (informação), mas a idade determina a relação com o "hardware" (concreto e asfalto). O idoso doutor sabe ler a placa, mas seu título não o impede de cair

se a calçada falha; a vulnerabilidade física é, portanto, mais democrática e implacável que a informacional.

A Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty (1999) lembra que a experiência da cidade é mediada pela carne; se o corpo sofre fricção constante, a percepção urbana torna-se uma percepção de ameaça, confirmando a insensibilidade da "pedra" denunciada por Richard Sennett (1994).

Esta vulnerabilidade endêmica exige um novo paradigma: a "gerontologia do concreto", onde cada obra pública seja auditada sob a ótica da fragilidade. A segurança, nesse contexto, exige políticas de Traffic Calming para conter a "violência cinética" do trânsito, tratando a acessibilidade não como cota, mas como sustentabilidade demográfica. Sem suporte ambiental, o "Envelhecimento Ativo" da OMS (2005) torna-se inviável, pois a atividade é uma via de mão dupla que o Recife rompeu.

A hostilidade urbana também possui uma dimensão de gênero indireta ao sobrecarregar as mulheres no papel de cuidadoras, privatizando o custo da acessibilidade. Sob a ótica da "Biopolítica" de Michel Foucault (2008), o desenho urbano do Recife decide quem deve circular e quem deve ser confinado ao espaço doméstico por ser "improdutivo".

A intersectorialidade torna-se urgente: a queda na calçada é um problema de saúde que se resolve com cimento. A idade revela-se como o "grande equalizador" — diante de um ônibus sem degrau baixo, o desembargador e a lavadeira enfrentam a mesma humilhação biomecânica, o que justifica uma coalizão política ampla pela reforma urbana.

A tese encerra afirmando que a precariedade urbana é a doença e a idade é apenas o fator de risco que expõe a infecção. A cura exige refundar a capital pernambucana sobre um "Urbanismo do Cuidado", pois uma cidade incapaz de acolher o corpo que envelhece falha em sua missão civilizatória primordial.

5.6 SÍNTESE E CONTRIBUIÇÕES PARA A "CIDADE AMIGA DA PESSOA IDOSA": DA RETÓRICA À JUSTIÇA ESPACIAL

O percurso analítico trilhado por esta tese, ao perscrutar as entranhas da experiência urbana do envelhecimento no Recife, desemboca em uma síntese inquietante: a cidade vivencia uma esquizofrenia estrutural. A "Cidade Amiga" preconizada nos

manuais internacionais e na retórica oficial colide frontalmente com a "Cidade Real" de concreto, asfalto e medo.

A síntese dos achados empíricos permite afirmar que o Recife opera sob uma lógica binária de acolhimento privado e hostilidade pública, onde a porta de casa funciona como a fronteira entre a dignidade (garantida pela família) e a barbárie (imposta pelo urbanismo).

Esta constatação oferece uma contribuição original ao debate sobre o envelhecimento no Sul Global: enquanto a literatura eurocêntrica foca na "solidão" como o grande mal da velhice, os dados desta pesquisa mostram que, no Recife, o problema central não é a falta de laços humanos, mas a carência de suporte material.

A família e a comunidade "carregam a cidade nas costas", suprimindo com afeto e solidariedade o que o Estado nega em infraestrutura. O conceito de *Aging in Place*, portanto, é garantido pela resiliência das redes primárias, e não pela eficiência das políticas urbanas.

A Dicotomia Entre Esfera Privada e Pública: O Lar Como Refúgio e a Rua Como Ameaça

A análise transversal dos dados revela uma fratura exposta na experiência do envelhecimento: a existência de um abismo intransponível entre a esfera privada e a pública. Os resultados indicam uma cidade partida afetivamente, onde os domínios relacionais sustentam pontuações positivas, enquanto os domínios que dependem da materialidade urbana — "Ambiente Físico" e "Transporte" — despencam para níveis críticos de reprovação (médias entre 1,71 e 1,91).

Esta dicotomia valida empiricamente a clássica distinção sociológica de Roberto DaMatta (1997) em "A Casa & A Rua": a casa permanece como o reduto da proteção e da pessoa, enquanto a rua confirma-se como o espaço do perigo e da "lei do mais forte", onde a fragilidade física não encontra amparo. O bem-estar na velhice no Recife depende de uma "prótese social" familiar (Lawton e Nahemow, 1973), o que esconde a perversidade da privatização do cuidado.

O Estado, ao falhar na provisão de infraestrutura pública, sobrecarrega as famílias e penaliza duplamente as mulheres. Como alertado por Richard Sennett (1988), o idoso retira-se da vida pública por autodefesa, gerando um retraimento que elimina os "olhos

na rua" de Jane Jacobs (2011) e transforma a cidade em um corredor de passagem perigoso.

Territorialidade e Desigualdade Urbana: A Geografia Como Destino e a Justiça Espacial

A análise regional segmentada pelas RPAs confirmou que a percepção da "Cidade Amiga" é uma variável dependente da geografia, onde o mapa da satisfação sobrepõe-se quase perfeitamente ao mapa histórico da segregação socioespacial. As áreas consolidadas funcionam como ilhas de urbanidade, enquanto as periferias e morros configuram-se como territórios de fricção e desgaste, validando a teoria de Flávio Villaça (2001) sobre o privilégio das elites no desenho intraurbano.

O contraste entre a RPA 1 (Centro) e a RPA 3 (Morro) ilustra a "produção desigual do espaço" (David Harvey, 2006). Para o idoso da RPA 3, a cidade é um estado de "confinamento topográfico", onde a geografia atua como um determinante social de saúde tão letal quanto um vírus. Nas periferias planas, a "injustiça espacial" (Edward Soja, 2010) opera pela "tirania da distância".

É imperativo notar, contudo, a fragmentação interna da própria RPA 3, no mesmo recorte administrativo, coexistem encostas precárias e enclaves de alta renda e intelectualidade. Essa vizinhança de contrastes revela a seletividade da especulação imobiliária e a concentração socioeconômica, reforçando que, no Recife, a qualidade do envelhecer é ditada pela lógica do capital sobre o território.

O "Urbanismo de Exceção" (Raquel Rolnik, 2015) tolera a improvisação nas áreas pobres, tratando o idoso como cidadão de segunda classe. A tese demonstra que a topografia do Recife, sem a devida correção via engenharia social e investimentos de equalização ("discriminação positiva"), é uma máquina de exclusão etária.

Escolaridade Como Determinante de Inclusão: A Supremacia do Capital Cultural

Um dos achados mais potentes desta investigação é a inversão hierárquica onde o capital cultural emergiu como um preditor de inclusão muito mais robusto do que o capital econômico. Validando empiricamente a teoria de Pierre Bourdieu (1986), a escolaridade

confere ao idoso recifense uma "competência estatutária" que lhe permite "hackear" um sistema urbano hostil e burocratizado.

A irrelevância estatística da renda reforça a tese de que a precariedade atingiu um nível de saturação democrática: a calçada esburacada é um "bem público negativo" que o dinheiro isoladamente não contorna.

A "Cidade Ilegível" (Kevin Lynch, 1960) torna-se um labirinto semiótico para o idoso de baixa escolaridade, onde a burocracia opaca e a exclusão digital (Manuel Castells, 1999) cassam o direito à cidade.

A educação formal funciona como um escudo de dignidade contra a "Violência Simbólica" (Bourdieu, 1989) e a infantilização, enquanto a "Reserva Cognitiva" (Anita Neri, 2015) permite aos instruídos gerenciar o estresse ambiental de forma mais eficaz. Sem o "Letramento Urbano", a democracia local permanece censitária pelo saber.

Idade e Vulnerabilidade Estrutural: A Biologia Como Fronteira e a Resignação Como Estratégia

A investigação do fator etário revela uma homogeneização da experiência urbana pela base, onde o Recife impõe uma "ditadura da precariedade" que nivela idosos de todas as idades.

A leve atenuação da crítica no grupo 80+ é explicada pela Teoria da Seletividade Socioemocional (Laura Carstensen, 1999): trata-se de uma recalibragem subjetiva das expectativas e não de uma melhoria objetiva. O idoso recifense apresenta o que Amartya Sen (1999) define como "Preferências Adaptativas", ajustando seus desejos a uma realidade medíocre para evitar a dissonância cognitiva.

Entretanto, a biologia permanece a fronteira final: a sarcopenia e a perda de reflexos tornam o corpo uma antena sensível à agressividade do ambiente. O Recife exerce uma "Biopolítica" de exclusão (Foucault, 2008), confinando corpos improdutivos e roubando a vitalidade do idoso através da fricção constante com o hardware urbano. A idade é o "fio desencapado" que expõe a falência do modelo carrocêntrico: se o corpo velho não circula com autonomia, a cidade está doente e falhou em sua missão civilizatória.

Contribuições e Diretrizes Estratégicas: Da Práxis Transformadora ao Urbanismo do Cuidado

A pesquisa confirma e radicaliza a visão da OMS, oferecendo uma leitura "tropicalizada" ⁶⁷que exige que o Recife seja funcional antes de ser amigo. A tese propõe a transição do paradigma *Age-Friendly* para o de "Cidade Justa para Todas as Idades" (*Age-Just City*), onde a justiça é baseada em direitos perenes.

A implementação desta práxis exige diretrizes materiais imediatas, começando pela criação de uma Rede de Microacessibilidade que priorize a escala do pedestre e a continuidade dos percursos na escala do bairro.

O desenho público deve incorporar a "escala humana" rigorosa, com pontos de descanso e bancos estratégicos para acolher a fadiga da carne, além de uma iluminação focada no pedestre para eliminar o "toque de recolher" simbólico noturno.

A equidade territorial deve ser o princípio norteador do Plano Diretor, exigindo um aporte desproporcional de recursos nas RPAs de "vazio de acolhimento" para compensar décadas de negligência.

É imperativo institucionalizar um Sistema Integrado de Gestão da Longevidade, unindo Saúde e Urbanismo sob o lema de que a calçada nivelada é o equipamento de saúde mais eficiente da metrópole.

Validando a subjetividade captada pelo Q-EBAPI como dado técnico soberano, a tese conclui que o Desenho Universal (Mace, 1985) não é um favor às minorias, mas a única estratégia sustentável para uma sociedade que envelhece. Ao projetar para quem caminha devagar, a gestão municipal projetará uma cidade mais resiliente, democrática e justa para todos os seus cidadãos.

6 CONSIDERAÇÕES

A conclusão desta tese não encerra apenas um percurso investigativo acadêmico; ela denuncia um estado de coisas e formaliza um diagnóstico sobre a condição urbana contemporânea no Sul Global. Ao analisar as entranhas da experiência do envelhecimento

⁶⁷ Conceito que designa o processo de adaptação de modelos, teorias e tecnologias estrangeiras às condições climáticas, sociais, económicas e culturais de países tropicais e em desenvolvimento. No urbanismo, enfatiza a necessidade de ajustar premissas de planeamento (frequentemente oriundas do Norte Global) às realidades de calor extremo, desigualdade socioespacial e precariedade infraestrutural típicas do contexto brasileiro.

no Recife, sob a lente multidimensional da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), este estudo desvelou uma realidade marcada por uma esquizofrenia urbana estrutural.

A "Cidade Amiga", longe de ser uma realidade consolidada, revela-se um campo de disputa travado na tensão dialética entre o acolhimento privado e a hostilidade pública. A tese central que se cristaliza nestas considerações finais é a de que o Recife opera sob uma lógica de exclusão cinética e simbólica: a cidade “acolhe” o idoso na intimidade afetiva do lar, amparado pela resiliência das redes familiares, mas o expulsa violentamente do espaço público através de um urbanismo que ignora a fragilidade humana e censura o corpo envelhecido.

Esta pesquisa cumpriu o objetivo de diagnosticar a relação entre a longevidade e o espaço urbano no Recife, revelando um hiato profundo entre a retórica normativa e a experiência cotidiana. O diagnóstico aqui construído ultrapassa a constatação óbvia da precariedade para identificar a natureza perversamente "democrática" da hostilidade física.

Diferentemente de outras dinâmicas sociais onde a renda blindava o indivíduo, a degradação da cidade material no Recife atingiu um ponto de saturação tal que se tornou um equalizador negativo. O corpo do idoso, seja ele habitante da orla nobre ou do morro periférico, enfrenta a mesma fricção biomecânica e o mesmo risco de queda, provando que a qualidade da velhice é, inexoravelmente, uma questão de bem comum que exige resposta estatal.

Mais do que apontar falhas, este estudo identificou a universalidade da vulnerabilidade biológica como o fator que deveria orientar o planejamento urbano. A infraestrutura do Recife, desenhada para o fluxo veloz do automóvel e para a produtividade do corpo jovem.

O urbanismo atual é, em última análise, um “urbanismo necrófilo”, que acelera a morte social daquele que não consegue acompanhar a velocidade da máquina. Por fim, estas considerações apontam para a necessidade de uma ruptura epistemológica e política na gestão: o Recife precisa transitar de um Urbanismo da Produção para um Urbanismo do Cuidado, focado na permanência e na segurança.

Quadro 10 - Matriz de Ruptura: Urbanismo da Produção ao Urbanismo do Cuidado

URBANISMO DA PRODUÇÃO	URBANISMO DO CUIDADO
Velocidade e Fluxo de Veículos	Permanência e Segurança do Pedestre
O "Corpo Produtivo"	O "Corpo Senescente"
Centralização e Eficiência de Mercado	Equidade Territorial e Proximidade
Digitalizada, Opaca e Complexa	Analógica, Intuitiva e Inclusiva
"Democratização da Precariedade"	Acolhimento Físico e Cognitivo
Capital Econômico	Capital Cultural

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Aprofundando as conclusões do estudo, o diagnóstico demonstra que o Recife enfrenta um paradoxo estrutural no qual o reconhecimento simbólico do envelhecimento não se converte em garantias materiais.

Os resultados evidenciam que a exclusão urbana na velhice não se organiza primordialmente em torno da renda, mas se estrutura a partir de barreiras territoriais e, sobretudo, educacionais.

Se a barreira física nivela por baixo, a barreira simbólica reitera as hierarquias de classe: a emergência do Capital Cultural (escolaridade) como o principal preditor de inclusão constitui um dos achados mais potentes desta pesquisa. Em uma cidade que se tornou ilegível, a escolaridade funciona como a única bússola capaz de guiar o cidadão longo no labirinto urbano.

À luz do referencial de Pierre Bourdieu, observa-se que o capital cultural incorporado pelos senescentes funciona como um mecanismo de resiliência urbana. O idoso desprovido de letramento vive um confinamento cognitivo, configurando uma democracia censitária onde apenas os letrados desenham os destinos da *polis*. Esta dimensão territorial, mapeada através das Regiões Político-Administrativas (RPAs), confirmou que a geografia é destino.

As disparidades abissais entre as áreas consolidadas e as zonas de morros revelam "zonas de sacrifício"⁶⁸ e imobilidade compulsória. A tese sustenta que a justiça social no envelhecimento é indissociável da justiça espacial. É imperativo reconhecer, contudo, as

⁶⁸ Conceito da Justiça Ambiental que designa territórios habitados por populações de baixa renda ou grupos vulnerabilizados, que são sistematicamente negligenciados pelo Poder Público e expostos a riscos ambientais e precariedade infraestrutural. Reflete uma lógica de planejamento urbano que concentra investimentos em áreas de elite enquanto 'sacrifica' a dignidade e a saúde dos residentes em zonas periféricas ou desvalorizadas pelo mercado.

limitações que balizam esta investigação e apontam para a continuidade da agenda de pesquisa.

O delineamento diagnóstico e exploratório, embora robusto, apresenta fronteiras necessárias: o perfil da amostra (majoritariamente feminino e de longa residência) e a seleção por conveniência em pontos de assistência podem não ter capturado integralmente a percepção do "idoso invisível" — aquele em isolamento social absoluto. Ademais, o foco na percepção subjetiva não se aprofundou nas causas orçamentárias da gestão, sugerindo que pesquisas futuras incorporem análises de políticas públicas e ensaios de intervenção direta em RPAs críticas, como a RPA 3.

Diante do cenário exposto, as contribuições deste estudo traduzem-se em recomendações estratégicas para a gestão urbana. Urge a priorização emergencial da infraestrutura com a adoção compulsória do Desenho Universal (NBR 9050) e o ajuste do tempo semafórico.

No campo da equidade territorial, o município deve institucionalizar indicadores locais de monitoramento baseados na percepção, alocando recursos de forma desproporcional para as áreas de maior vazio de acolhimento. A "Cidade Amiga" não pode continuar parasitando o afeto das famílias através do modelo de "familismo"; ela precisa oferecer a infraestrutura que permita ao cuidado ser uma escolha, e não um fardo imposto pela ausência de alternativas públicas.

Conclui-se que o envelhecimento digno no Recife não é uma impossibilidade técnica, mas uma escolha política. A contribuição original desta tese reside na prova estatística de que o acolhimento de uma cidade se mede pela presença de suportes cognitivos e materiais.

Embora o presente estudo tenha se concentrado em uma abordagem quantitativa, o que permite o mapeamento estatístico dos nós críticos da cidade, reconhece-se a necessidade de futuras investigações de cunho qualitativo. Tais estudos poderão aprofundar as nuances subjetivas e as estratégias de resiliência que os idosos desenvolvem para ocupar um espaço urbano que, conforme demonstrado neste diagnóstico, ainda não os reconhece plenamente como sujeitos de direito à cidade.

Ao demonstrar que a escolaridade supera a renda na definição da autonomia, este estudo oferece um novo paradigma para o monitoramento urbano. Que os diagnósticos e caminhos aqui apontados sirvam como instrumento de luta para que o Recife, enfim, se reencontre com sua gente e reestabeleça seu pacto urbano sob a premissa de que a cidade só é legítima se for capaz de abrigar a vida em sua plena diversidade de condições.

REFERÊNCIAS

- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050:** acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- ACSELRAD, H. **O que é justiça ambiental**. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.
- AGUIAR, G. O. de. **A urbanização desenfreada e a desorganização espacial de cidades brasileiras**. Campo Grande: Editora UFMS, 2005.
- AGUIAR, D. B. **Urbanismo e a matéria urbana: entre a ideia e o projeto**. Porto Alegre: Ed. do Autor, 2020.
- ALBUQUERQUE, M. C. **Envelhecimento populacional e desafios à gestão urbana:** uma análise contemporânea. São Paulo: Blucher, 2023.
- ALLARD, P. **L'Espace de la vieillesse**. Paris: L'Harmattan, 2020.
- ANDERSEN, R. M. Revisiting the behavioral model of health care utilization. **Journal of Health and Social Behavior**, v. 36, n. 1, p. 1-10, 1995.
- ARENDT, H. **A condição humana**. Tradução de Roberto Raposo. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
- AREOSA, J. **Envelhecimento e sociedade:** perspectivas contemporâneas. Lisboa: Mundos Sociais, 2019.
- AVRITZER, L. **A moralidade da democracia:** ensaios em teoria habermasiana e teoria democrática. São Paulo: Perspectiva, 1996.
- BALTES, P. B.; BALTES, M. M. (Eds.). **Successful aging:** perspectives from the behavioral sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- BAPTISTA, G. A.; BESTETTI, M. L. T. Espaços compartilhados ou partilhados e o envelhecimento saudável. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 4, p. 755-764, 2012.
- BARBOSA, M. S. **Políticas públicas e o idoso no Brasil**. São Paulo: Papirus, 2015.
- BAUMAN, Z. **Modernidade líquida**. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
- BEAUVOIR, S. de. **A velhice**. Tradução de Maria Helena Franco Martins. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
- BELLINI, C. **Mobiliário urbano no Brasil como "Abrigo de Ônibus":** análise de design e ergonomia. Curitiba: Appris, 2008.

BENEVIDES, M. V. **A cidadania ativa**: referendo, plebiscito e iniciativa popular. São Paulo: Ática, 1991.

BITOUN, J. **IDH dos bairros de Recife**: desigualdades socioespaciais. Recife: Editora UFPE, 2005.

BORTOLOTI, F. P.; PAVOSKI, F.; VESOLOSKI, C. **Qualidade de vida**: avaliação multifacetada do bem-estar. Porto Alegre: Artmed, 2024.

BOURDIEU, P. **A distinção**: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007.

BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. Lisboa: Difel, 1989.

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa**: Guia para gestores. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.

BUFFEL, T.; PHILLIPSON, C. Can global cities be ‘age-friendly cities’? Urban development and ageing populations. **Cities**, v. 55, p. 94-100, 2016.

BURNETT, D. et al. Health literacy and the city: a social-ecological approach. **Health Promotion International**, v. 31, n. 2, 2016.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007.

BUTLER, R. N. Age-ism: Another form of bigotry. **The Gerontologist**, v. 9, n. 4, p. 243-246, 1969.

CALDEIRA, T. P. do R. **Cidade de muros**: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Edusp/Editora 34, 2000.

CARLOS, A. F. A. **A cidade**. São Paulo: Contexto, 2008.

CARSTENSEN, L. L. et al. Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. **American Psychologist**, v. 54, n. 3, p. 165, 1999.

CASTELLO, I. R. **Espaços criados como lugares feitos pelas pessoas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CORRÊA, R. L. **Exclusão social e desigualdades no espaço urbano**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

CUMMING, E.; HENRY, W. E. **Growing old**: the process of disengagement. New York: Basic Books, 1961.

DAMATTA, R. **A casa & a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil**. 5. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

DARDEL, E. **O Homem e a Terra: natureza da realidade geográfica**. São Paulo: Perspectiva, 2011.

DARDOT, P.; LAVAL, C. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo: Boitempo, 2016.

DEBERT, G. G. **A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do envelhecimento**. São Paulo: Edusp, 1999.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. **Mais de 1 milhão de pernambucanos viviam em extrema pobreza em 2022**. Recife, 2023. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br>. Acesso em: 23 jan. 2026.

ELIAS, N. **O processo civilizador: uma história dos costumes**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

ESCORSIM, S. M. **O Envelhecimento Populacional e a Cidade: reflexões sobre o acolhimento urbano**. São Paulo: Cortez, 2021.

ESPING-ANDERSEN, G. **The three worlds of welfare capitalism**. Princeton: Princeton University Press, 1990.

FALEIROS, V. de P. Cidadania e direitos da pessoa idosa. **Ser Social**, Brasília, v. 18, n. 38, p. 33-55, 2016.

FERNANDES, S. A. **Exploração ineficiente dos recursos naturais e o consequente desperdício ambiental**. São Paulo: Annablume, 2008.

FIELD, A. **Descobrimdo a Estatística usando o IBM SPSS Statistics**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2018.

FOUCAULT, M. **Nascimento da biopolítica**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FRASER, N. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era pós-socialista. **Cadernos de Campo**, n. 15, p. 231-239, 2006 (Ref. 2000).

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FRIEDMANN, J. **Empowerment: the politics of alternative development**. Cambridge: Blackwell, 1992.

GEHL, J. **Cidades para pessoas**. Tradução de Anita Di Marco. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

GOFFMAN, E. **Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior**. New York: Pantheon Books, 1967.

GOHN, M. G. **Conselhos Gestores e Participação Sociopolítica**. São Paulo: Cortez, 2011 (Ref. 2010).

GROISMAN, D. **A velhice como objeto de cuidado**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2015.

HABERMAS, J. **Teoria da ação comunicativa**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

HARVEY, D. **A Justiça Social e a Cidade**. São Paulo: Hucitec, 1980.

HARVEY, D. **O direito à cidade**. LusoSofia, 2008.

HARVEY, D. **Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana**. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

HAUKOOS, J. S.; LEWIS, R. J. Advanced Statistics: Bootstrapping Methods in Clinical Research. **Academic Emergency Medicine**, v. 12, n. 4, 2005.

HOLANDA, S. B. de. **Raízes do Brasil**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1936.

HONNETH, A. **Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais**. São Paulo: Editora 34, 2003.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022: aglomerados subnormais e infraestrutura urbana**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2026.

JACOBS, J. **Morte e vida de grandes cidades**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

JOHN, K. **The Age-Friendly City: Architecture and Design for Life**. Londres: Routledge, 2012.

KAISIK, M. A. **Metodologia da Pesquisa Diagnóstica: da amostra à intervenção**. Curitiba: Appris, 2018.

KAUFMANN, V. **Re-thinking mobility: contemporary sociology**. Aldershot: Ashgate, 2002.

KOWARICK, L. **A espoliação urbana**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

LAWTON, M. P. **Environment and aging**. Monterey: Brooks/Cole Publishing, 1980.

LAWTON, M. P.; NAHEMOW, L. Ecology and the aging process. In: EISDORFER, C.; LAWTON, M. P. (Eds.). **The Psychology of Adult Development and Aging**. Washington, DC: American Psychological Association, 1973.

LEFEBVRE, H. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A. M. C. **O novo papel do Estado perante a sociedade: concepção de políticas públicas saudáveis**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

LIKERT, R. A Technique for the Measurement of Attitudes. **Archives of Psychology**, v. 22, n. 140, p. 1-55, 1932.

LYNCH, K. **The image of the city**. Cambridge: MIT Press, 1960.

MACE, R. **Universal Design: barrier-free environments**. North Carolina: NCSU, 1985.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARICATO, E. **O impasse da política urbana no Brasil**. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

MASCARÓ, J. L. **Atividade urbana e o impacto no clima e solo**. Porto Alegre: Masquatro, 2009.

MELLO, M. A. **A importância da dimensão espacial e sua abordagem nos meios acadêmicos e institucionais**. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

MELO, C.; NICKEL, E.; PUREZA, A. **Desigualdades regionais e a capacidade de resposta do sistema de saúde**. Brasília: OPAS, 2025.

MERLEAU-PONTY, M. **Fenomenologia da percepção**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MINAYO, M. C. S. **O imperativo de cuidar da pessoa idosa**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012.

MIRANDA, M. M. M.; MENDES, M. M.; SILVA, A. A. da. **Urbanização e envelhecimento populacional: estudos interdisciplinares**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016.

MONTENEGRO, G. **Design centrado no homem, na ecologia e na ética do mobiliário urbano**. São Paulo: Edgar Blücher, 2017.

MOURTHÉ, S. A. G. O. **A terminologia "mobiliário urbano" no contexto brasileiro**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998.

NAGLER, E. M. et al. The Influence of Social Mobilization on Health Outcomes. **Journal of Health Communication**, v. 19, 2014.

NERI, A. L. **Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade**. São Paulo: Editora SESC, 2007.

NERI, A. L. (Org.). **Conceitos fundamentais em gerontologia**. Campinas: Átomo e Alínea, 2015.

NEWMAN, P.; KENWORTHY, J. **Sustainability and cities**: overcoming automobile dependence. Washington: Island Press, 1999.

NUTBEAM, D. Health literacy as a public health goal. **Health Promotion International**, v. 15, n. 3, p. 259-267, 2000.

OLIVER, M. **The politics of disablement**. London: Macmillan, 1990.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Guia Global das Cidades Amigas do Idoso**. Genebra: OMS, 2007.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde**. Genebra: OMS, 2023.

PASQUALOTTO, R.; SENA, R. **O ambiente urbano e seus impactos ambientais**. Curitiba: Appris, 2018.

POPPER, K. R. **A Lógica da Pesquisa Científica**. Londres: Hutchinson, 1959.

PUTNAM, R. D. **Bowling alone**: the collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster, 2000.

RAWLS, J. **Justiça como equidade**: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

RECIFE. Prefeitura Municipal. **Lei nº 17.511, de 29 de dezembro de 2008**. Institui o Plano Diretor do Município do Recife. Recife: Diário Oficial do Município, 2008.

RECIFE. **Lei Complementar nº 002/2020**. Institui o novo Plano Diretor do Município do Recife. Recife, 2020.

ROLNIK, R. **Guerra dos lugares**: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

RUDD, R. E. The Health Literacy Environment Analysis. **Health Literacy Media**, 2015.

SANTOS, L. L. **O Direito à Cidade e o Envelhecimento Ativo**. Recife: Editora UFPE, 2013.

SANTOS, M. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2006.

SANTOS, W. G. dos. **Cidadania e justiça**: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979.

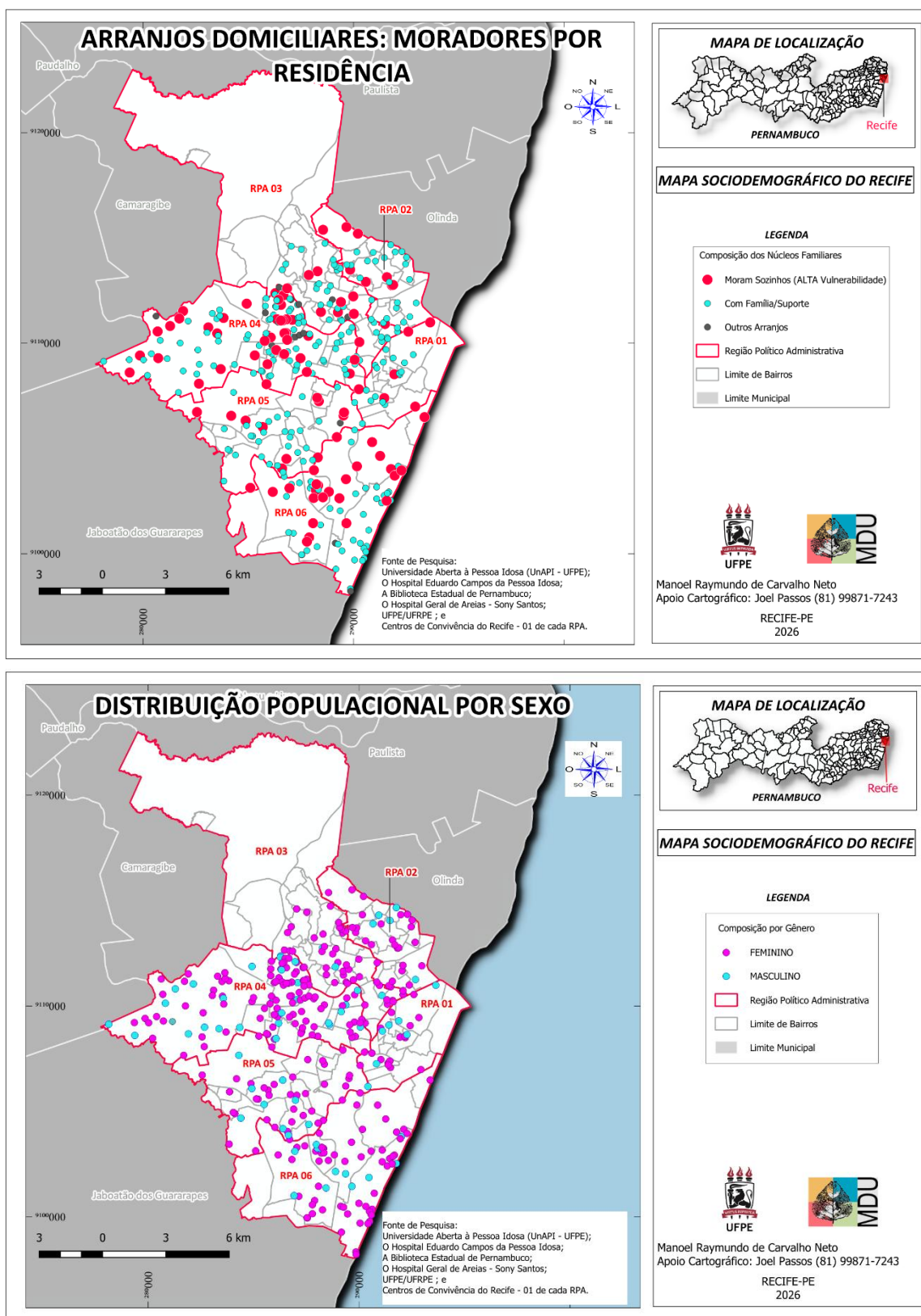
SCHMID, A. B. **O ambiente construído como anteparo existencial**. Zurique: ETH, 2005.

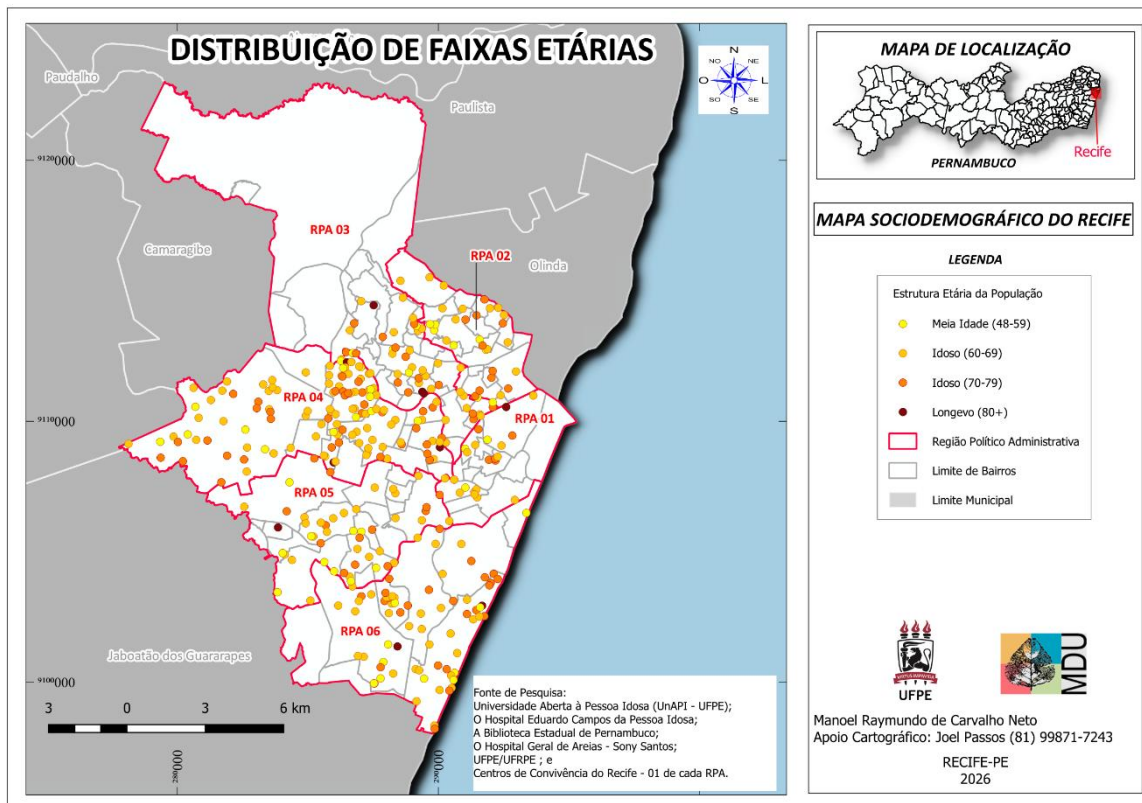
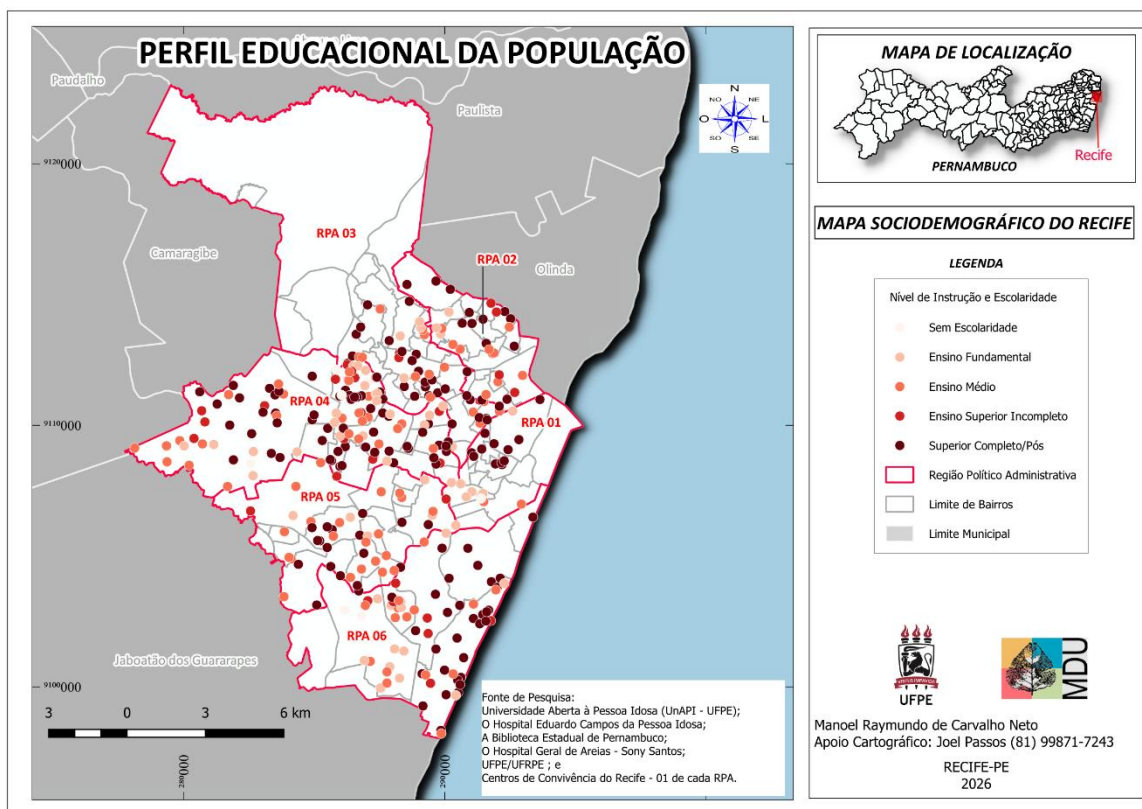
SCHOBER, P.; BOER, C.; SCHWARTE, L. A. Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. **Anesthesia & Analgesia**, v. 126, n. 5, p. 1763-1768, 2018.

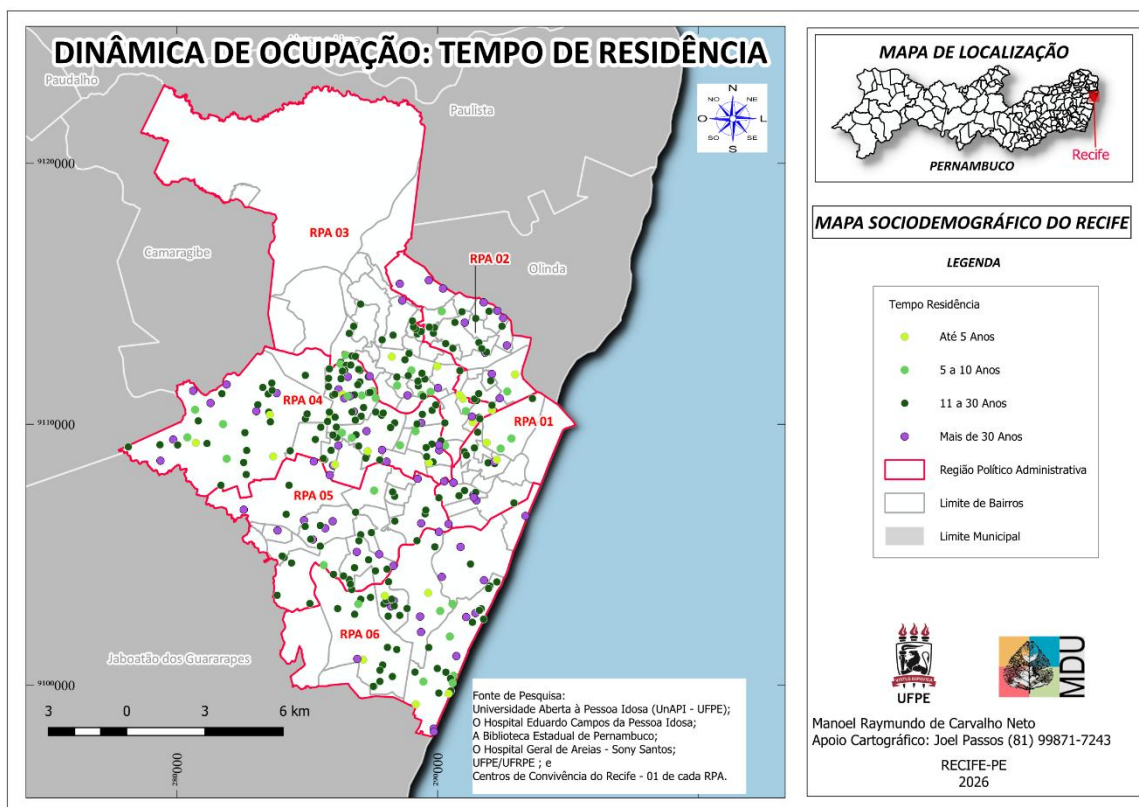
- SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- SENNETT, R. **A consciência do olho: projeto e vida social nas cidades**. Rio de Janeiro: Record, 1988.
- SENNETT, R. **Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental**. Rio de Janeiro: Record, 1994.
- SHAKESPEARE, T. **Disability Rights and Wrongs Revisited**. 2. ed. Londres: Routledge, 2013.
- SILVA, R.; SANTOS, L. **O impacto dos ambientes artificiais na saúde**. Belo Horizonte: UFMG, 2021.
- SOJA, E. W. **Seeking spatial justice**. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.
- SOUZA, M. L. **O desenvolvimento urbano contemporâneo e a falta de integração entre políticas setoriais**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
- TAVARES, M. F. **Planejamento Urbano e Envelhecimento**. Recife: Editora UFPE, 2020.
- TEIXEIRA, S. M. **Políticas Públicas para Idosos no Brasil**. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
- TUAN, Y.-F. **Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência**. São Paulo: Difel, 1983.
- VASCONCELLOS, E. A. de. **Mobilidade urbana e cidadania**. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2014.
- VERAS, R. P.; OLIVEIRA, C. M. **A escassez e/ou restrição de recursos para a demanda crescente do idoso na saúde**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2018.
- VILLAÇA, F. **Espaço intra-urbano no Brasil**. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2001.
- VIRILIO, P. **A velocidade de libertação**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.
- VITTA, F. C. R. de F. **A Ergonomia e o Design no mobiliário urbano**. Bauru: Edusc, 2006.
- VYGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- WACQUANT, L. **As duas faces do gueto**. São Paulo: Boitempo, 2008.
- WILLIAMS, S. J. et al. Bourdieusian sociology and public health: changing health-related behaviours. **Sociology of Health & Illness**, v. 39, n. 4, p. 620-637, 2017.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global Age-friendly Cities: a guide**. Geneva: WHO, 2007.

APÊNDICE

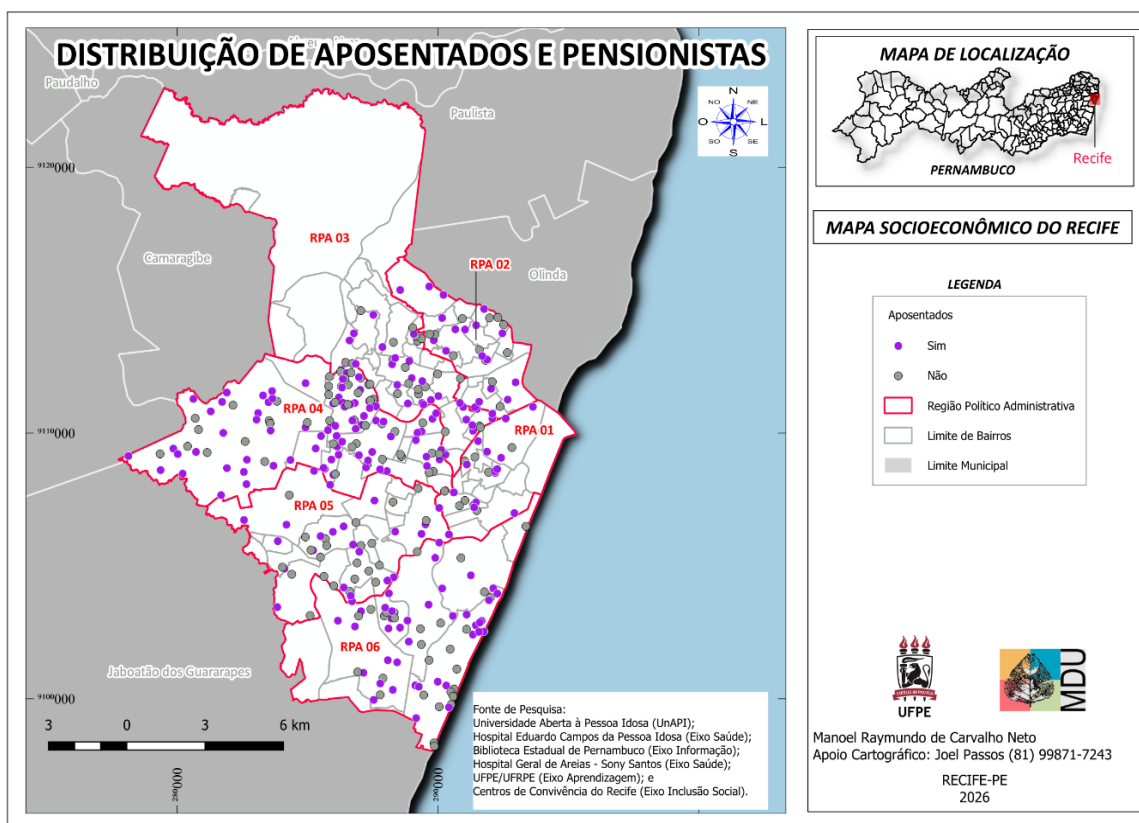
MAPAS SOCIODEMOGRÁFICOS

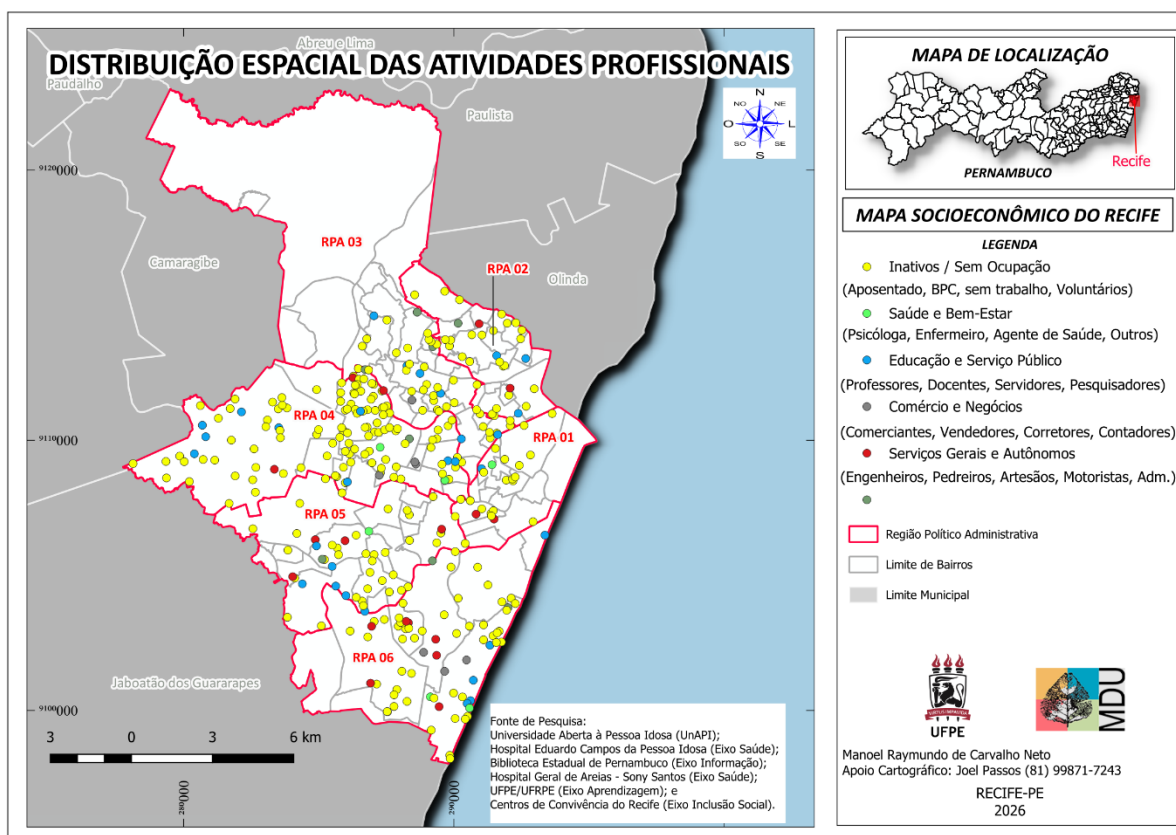
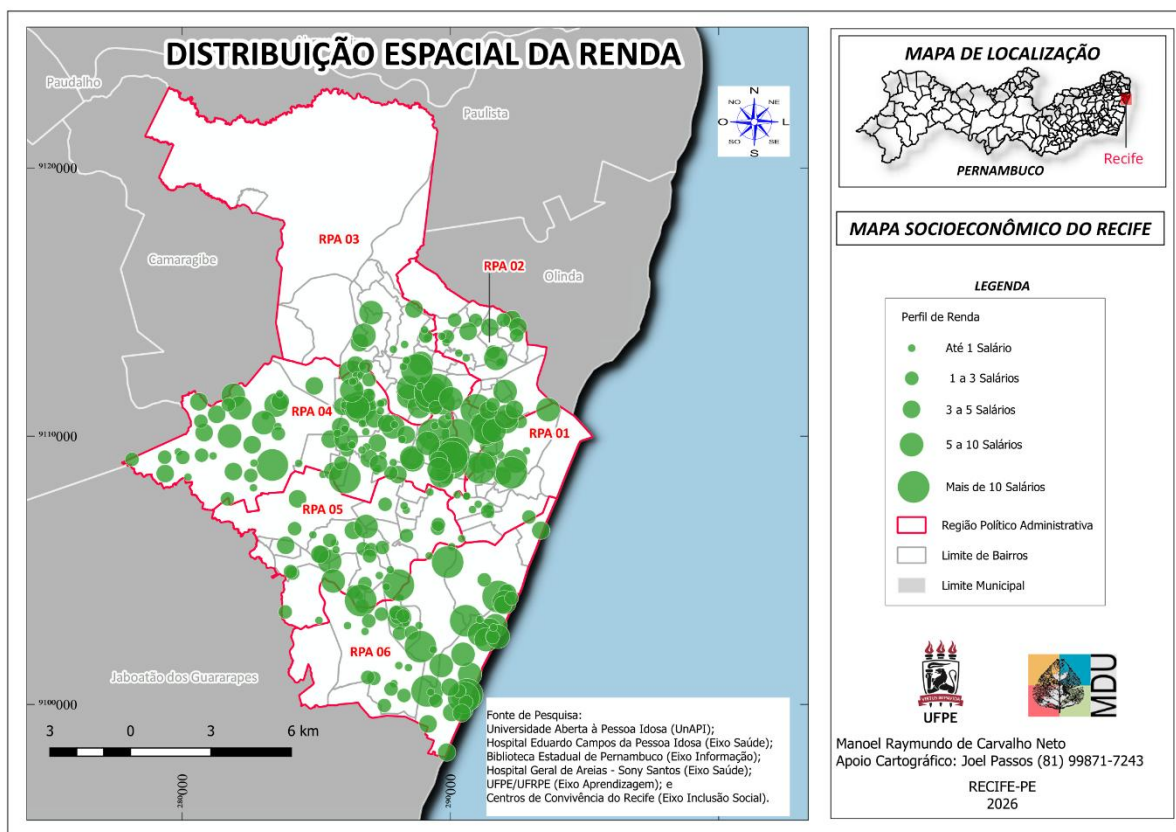


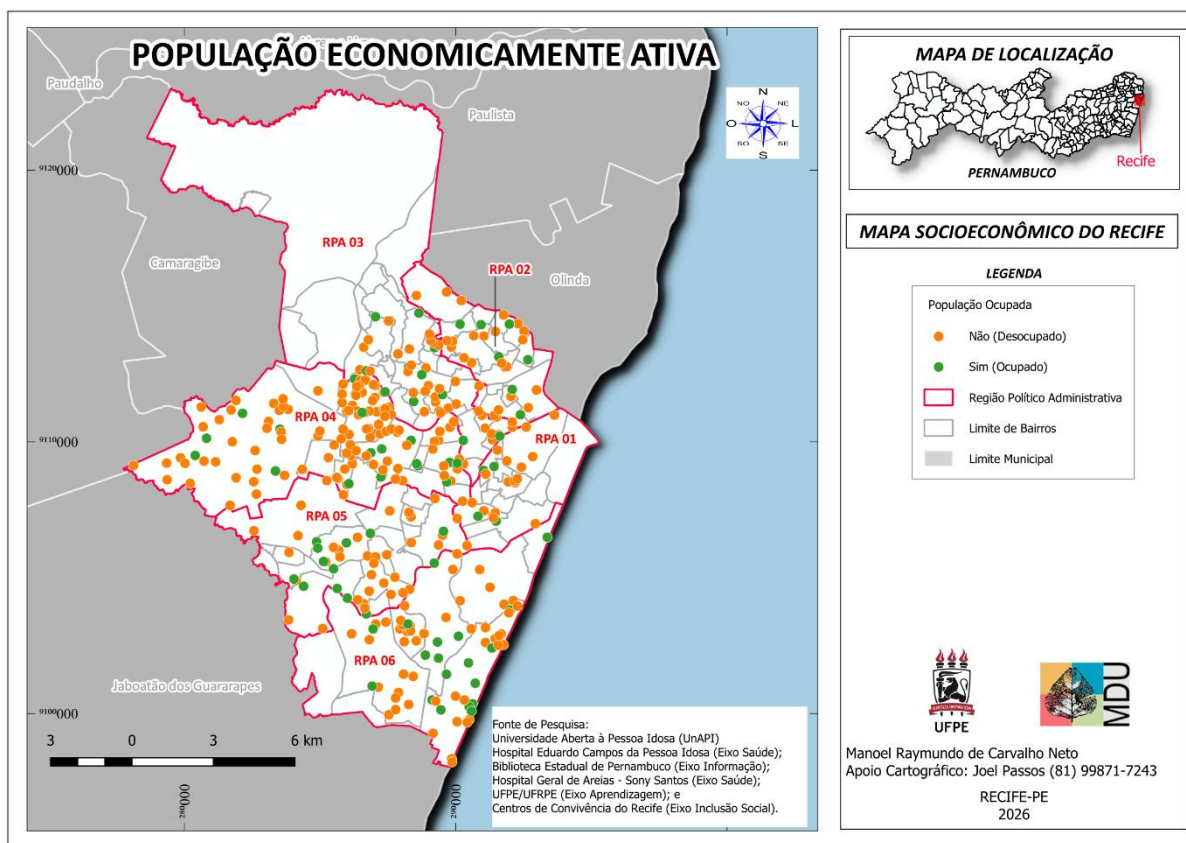




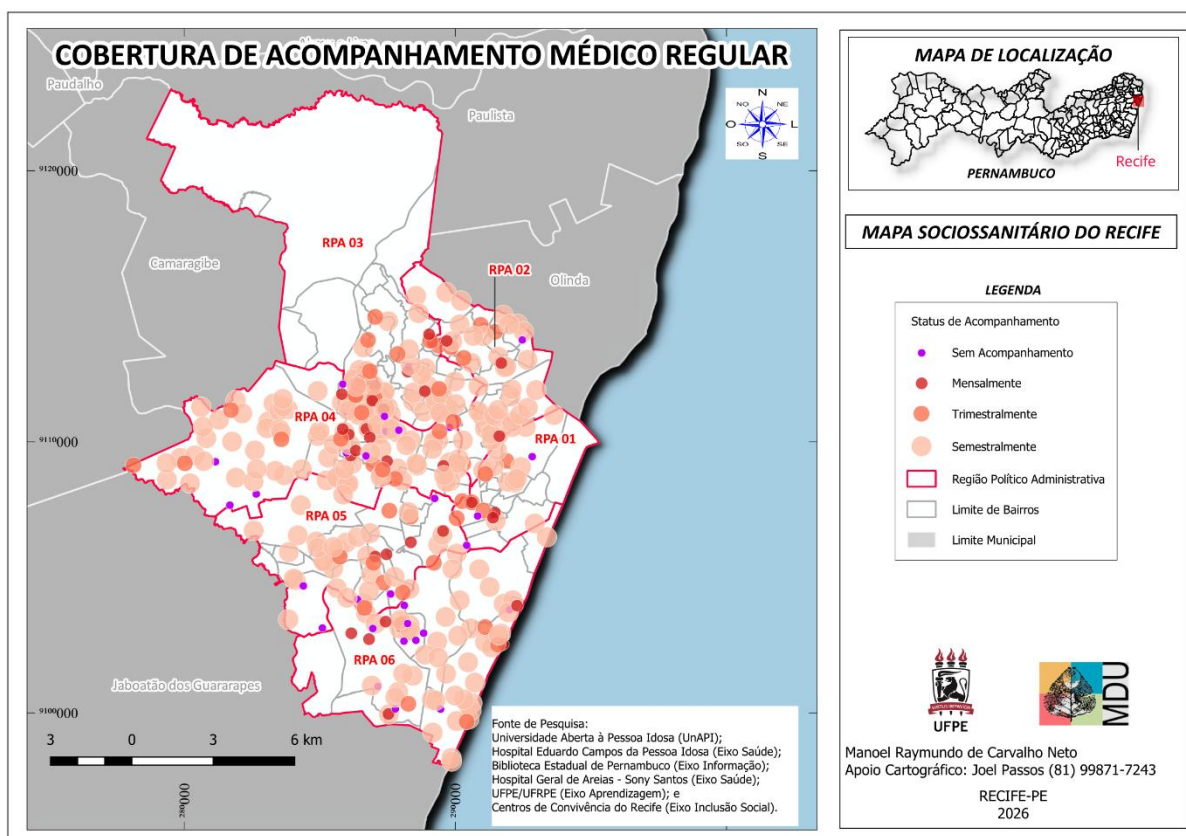
MAPAS SOCIOECONÔMICO

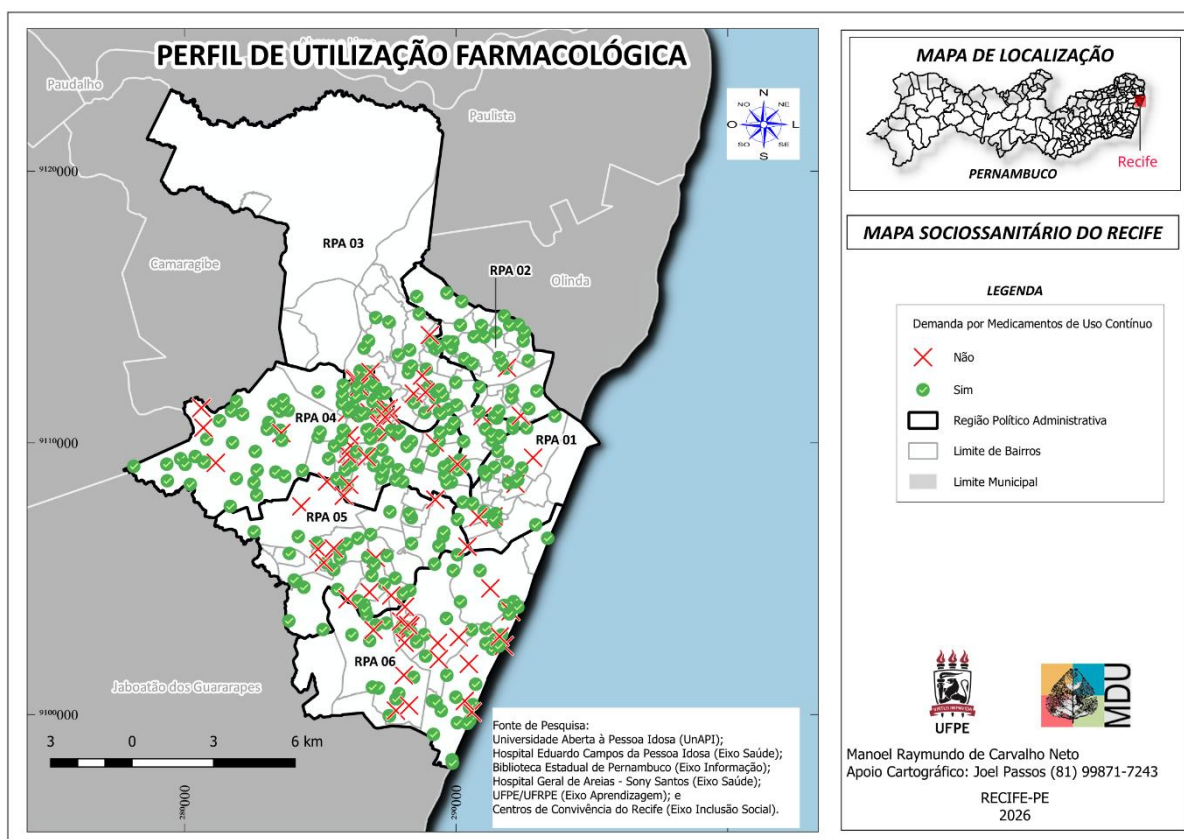
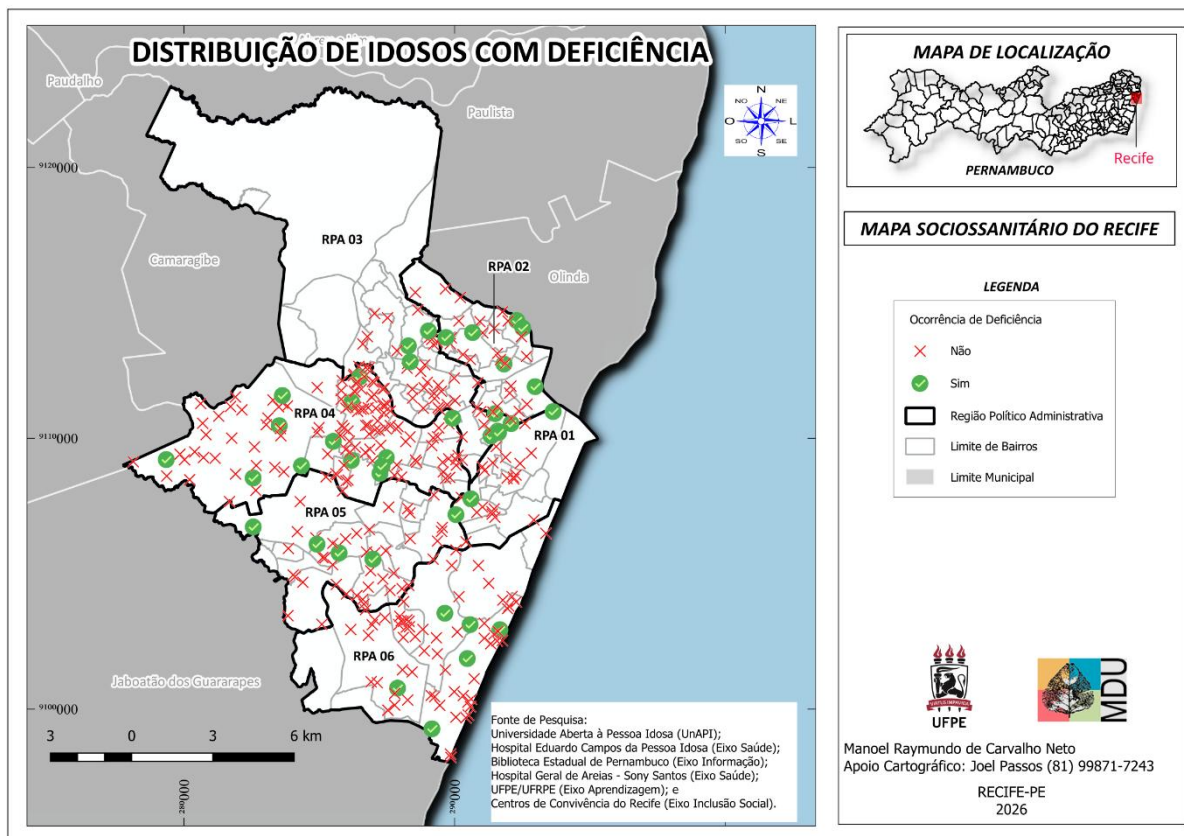






MAPAS SOCIOSANITÁRIOS





ANEXOS – ANEXO I – TCLE / FORMULÁRIO DE ESCUTA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO***(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP)**

*A ser aplicado aos participantes do diagnóstico

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa científica: **“LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE: diagnóstico para uma cidade acolhedora ao envelhecimento”**, que está sob a responsabilidade do pesquisador Manoel Raymundo de Carvalho Neto – Servidor Público e discente do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo (MDU) da Universidade Federal de Pernambuco.

Após ser esclarecido(a) sobre o projeto de pesquisa, no caso de aceitar ser voluntário do estudo, favor assinar este documento, que estará impresso em duas vias, uma do participante e a outra do pesquisador responsável. Em caso de recusa ou desconforto o(a) Sr.(a), em qualquer tempo, têm total liberdade de negar ou retirar o consentimento em participar da pesquisa, sem qualquer penalização.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Trata-se de um projeto que visa: analisar como as ações do município do Recife-PE, que refletem na vida de seus cidadãos idosos, têm sido percebidas por eles próprios, considerando os domínios propostos pela Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), que são: ambiente físico; transporte; moradia; participação; respeito e inclusão social; comunicação e informação; oportunidades para aprendizagem; apoio, saúde e cuidado; e domínio de protagonismo local, a ser definido pelos participantes da pesquisa.

A pesquisa será desenvolvida no Serviço de Assistência Ambulatorial gerontogeriatrico – Núcleo de Atenção ao Idoso – NAI/UFPE e Universidade Aberta à Terceira Idade – UnATI/UFPE, Programa de Educação Permanente para Idosos, o qual está sob Coordenação da Profa. a Dra. Anna Karla de Oliveira Tito Borba.

As informações coletadas serão confidenciais e divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre o responsável pela coleta, sendo assegurado o sigilo quanto à participação. Os dados coletados ficarão devidamente armazenados, sob a responsabilidade do orientador da pesquisa pelo período mínimo de 05 (cinco) anos.

Os participantes não serão remunerados pela participação na pesquisa, pois sua participação é voluntária. O responsável pela pesquisa é o Sr. Manoel Raymundo de Carvalho Neto (fone de contato 81- 99756-2497).

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar deste projeto. Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, dúvidas que não estejam sendo resolvidas pelo pesquisador ou caso seus direitos sejam negados, favor recorrer ao Comitê de Ética da UFPE, que está aberto ao público segundas, terças, quintas e sextas-feiras, no horário de 08h às 12h, no endereço Av. das Engenharias, s/n. prédio do CCS - 1º andar, sala 4. Fone: 81 2126.8588, E-mail: cephumanos.ufpe@ufpe.br.

(Assinatura do participante)

FORMULÁRIO DE ESCUTA DA POPULAÇÃO IDOSA
(Questionário Individual Adaptado da Proposta EBAPI - Pesquisa Quantitativa)

INFORMAÇÕES PESSOAIS

CAMPO	RESPOSTA
Nome do Participante	
Idade	_____ 60-69 () / 70-79 () / 80-89 () / 90+ ()
Gênero	Masculino () / Feminino () / Outro () _____
Bairro/Localidade que reside no Recife-PE	() Norte / () Sul / () Leste (litoral) / () Oeste Bairro _____
Tempo de residência no bairro/localidade	Menos de 5 anos () / Entre 5 e 10 anos () / Mais de 10 anos ()
Com quem mora	Sozinho () / Cônjuge () / Filhos () / Amigos () / Cuidador () / Outro: _____
Escolaridade	Sem escolaridade () / Fund. Incompleto () / Fund. Completo () / Médio Incompleto () / Médio Completo () / Superior Incompleto () / Superior Completo () / Pós-graduação ()
Renda mensal	Até 01 salário () / de 01 a 02 salários () / de 02 a 03 salários () / 03 a 05 salários () / de 05 a 10 salários () / Mais de 10 salários ()
Exercício de atividade remunerada?	Sim, qual: _____ / Não () / Aposentado(a) ()
Faz acompanhamento médico	Sim, mensalmente () / Sim, a cada 3 meses () / Sim, semestralmente () / Não ()
Faz uso de medicamentos diários?	Sim () / Não ()
Possui alguma deficiência ou limitação funcional que impacte suas atividades cotidianas? Sim, qual?	Sim () / Não () Qual? _____

FORMULÁRIO DE ESCUTA DA POPULAÇÃO IDOSA
(Questionário Individual Adaptado da Proposta EBAPI - Pesquisa Quantitativa)

Dimensão: AMBIENTE FÍSICO

Avaliação: péssimo = 1; ruim = 2; regular = 3; bom = 4; ótimo = 5; não se aplica = N/A

QUESTÃO CENTRAL	QUESTÃO ESPECÍFICA	NOTA
1. Calçadas em sua localidade	1.1 Espaço livre suficiente para caminhar.	
	1.2 O piso das calçadas é regular, firme e sólido.	
	1.3 A altura do meio-fio em relação à pista é complementar.	
	1.4 As rampas possuem inclinações adequadas.	
2. Relação com o Trânsito	2.1 Presença de faixas de pedestres sem semáforos.	
	2.2 Motoristas respeitam as travessias.	
	2.3 Quantidade de semáforos exclusivos para pedestres.	
	2.4 Respeito ao tempo de travessia dos pedestres, mesmo quando o semáforo abre para veículos.	
	2.5 Frequência de campanhas de educação no trânsito ativo.	
3. Iluminação Pública	3.1 Qualidade da iluminação nos trajetos percorridos à noite.	
	3.2 Iluminação nas praças, parques e outros locais públicos que são utilizados à noite.	
4. Sinalização Urbana	4.1 Clareza da sinalização (placas, mapas), com letras e desenhos em tamanho adequado e bom contraste.	
	4.2 Efetividade da sinalização no deslocamento.	
5. Banheiros Públicos	5.1 Presença de banheiros públicos nos trajetos percorridos.	
	5.2 Conservação e acessibilidade.	
	5.3 Condições de limpeza e higiene dos banheiros públicos.	
6. Assentos Públicos (Bancos)	6.1 Presença de bancos públicos para descanso nos trajetos percorridos.	
	6.2 Estado de conservação (encosto, braços, etc).	
7. Acesso a Prédios e Serviços na Cidade	7.1 Facilidade de entrada, circulação e saída.	
8. Praças e Pontos de Encontro Comunitários	8.1 Existência de praças em espaços públicos (suficiente na cidade/onde mora).	
	8.2 Estado físico de conservação de praças e parques.	
	8.3 Pontos de Encontro Comunitários em espaços públicos.	

Dimensão: TRANSPORTE / MOBILIDADE URBANA

Avaliação: péssimo = 1; ruim = 2; regular = 3; bom = 4; ótimo = 5; não se aplica = N/A

QUESTÃO CENTRAL	QUESTÃO ESPECÍFICA	NOTA
1. A Sinalização dos Destinos e das Rotas	1.1 Clareza da sinalização de rotas e destino na cidade.	
2. Assentos Prioritários	2.1 Disponibilidade de assentos prioritários.	
3. Segurança	3.1 Segurança no transporte público (acidentes, roubos, policiamento).	
4. Motoristas	4.1 Comportamento dos motoristas (respeito às leis e às pessoas idosas).	
5. Pontos de Embarque	5.1 Tempo de espera nos pontos e estações.	
	5.2 Acessibilidade nos pontos e estações.	
6. O comportamento da população	6.1 Às pessoas, em geral, respeitam a pessoa idosa e cedem assentos.	
	6.2 Em geral, as pessoas auxiliam, quando você precisa utilizar o transporte público.	

Dimensão: MORADIA

QUESTÃO CENTRAL	QUESTÃO ESPECÍFICA	NOTA
1. A mobilidade dentro de sua casa	1.1 Nivelamento e segurança dos pisos.	
	1.2 Iluminação dos cômodos.	
	1.3 Presença de corrimãos e barras de apoio.	
	1.4 Acessibilidade para cadeirante.	
2. As condições Financeiras	2.1 Custeio para manutenção, aluguel e serviços diversos.	
3. Proteção da Casa	3.1 Sensação de segurança contra roubos, assaltos e invasão.	
4. Saneamento Básico	4.1 Rede de água e esgoto (saneamento básico).	

Dimensão: PARTICIPAÇÃO

QUESTÃO CENTRAL	QUESTÃO ESPECÍFICA	NOTA
1. Participação Cidadã	1.1 Em conselhos municipais (idosos, saúde, assistência social).	
	1.2 Em associações ou grupos sociais.	
	1.3 Envolvimento em discussões ou decisões políticas.	
	1.4 Exercício do direito ao voto nas eleições.	
	1.5 Participação em atividades culturais e sociais.	
2. Trabalho e Sustento	2.1 Oferta de emprego para a pessoa idosa, qualificação e aceitação no mercado de trabalho.	
	2.2 A renda mensal (própria ou terceiros) para o pagamento de suas despesas é adequada para sua realidade.	
	2.3 Percebe-se igualdade, independente de gênero, cor ou raça?	
3. Fundo Municipal do Idoso	3.1 O seu conhecimento sobre a existência de um Fundo Municipal do Idoso e sua função.	

DIMENSÃO: RESPEITO E INCLUSÃO SOCIAL

Avaliação: péssimo = 1; ruim = 2; regular = 3; bom = 4; ótimo = 5; não se aplica = N/A

QUESTÃO CENTRAL	QUESTÃO ESPECÍFICA	NOTA
1. Direito à vagas preferenciais em serviços, espaços, atividades culturais e turismo	1.1 Respeito à preferência em atendimentos públicos e privados, considerando igualdade de tratamento independente de gênero, cor ou raça.	
	1.2 Direito a descontos em atividades culturais e turísticas.	
2. Prevenção e combate ao preconceito e violência contra a pessoa idosa	2.1 Campanhas de combate ao preconceito contra pessoas idosas, incluindo recortes específicos relacionados a gênero, cor e raça.	
	2.2 Conhecimento sobre canais de denúncia e apoio em casos de abuso.	
	2.3 Ações de Prevenção contra o abuso financeiro, psicológico e físico.	
3. Aposentadoria e Previdência Social	3.1 Seu conhecimento sobre as regras de aposentadoria e onde obter informações, com avaliação se há barreiras no acesso para pessoas idosas de diferentes gêneros, núcleos ou raça.	
4. Família e Amigos	4.1 Frequência com que se encontra presencialmente com a família/amigos, e se há algum impacto do gênero, cor ou raça.	
5. Participação de Atividades exclusivas para pessoas idosas	5.1 Conhecimento e participação em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SUAS), avaliando se há equidade no acesso para pessoas idosas de diferentes gêneros, núcleos ou raças.	
	5.2 Conhecimento e participação em atividades para integrar gerações, atividades físicas e/ou esportivas e culturais e/ou sociais.	

DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

QUESTÃO CENTRAL	QUESTÃO ESPECÍFICA	NOTA
1. Fontes de Informações sobre as atividades e serviços públicos	1.1 Conhecimento sobre canais de informações sobre serviços e atividades para idosos.	
	1.2 Facilidade de acesso a informações importantes (ex.: benefícios, campanhas).	
	1.3 Utilização de diferentes meios de comunicação (TV, rádio, jornais, internet, etc.)	
2. Leitura	2.1 Existência de espaços públicos adequados para leitura.	
	2.2 Hábito de leitura e acesso a materiais como jornais, livros e revistas.	

DIMENSÃO: OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

QUESTÃO CENTRAL	QUESTÃO ESPECÍFICA	NOTA
1. Educação Básica	1.1 Oferta de educação básica para pessoas idosas.	
2. Cursos, Palestras ou aulas em áreas de interesse	2.1 Disponibilidade de cursos e palestras sobre temas de interesse.	
	2.2 Facilidade de acesso a cursos profissionalizantes.	
	2.3 Incentivo ao uso de tecnologia (celulares, computadores, internet).	
3. Aprendizagem para trabalho	3.1 Gestão financeira e aprendizado sobre planejamento de despesas.	
	3.2 Oferta de cursos profissionalizantes, adequados para a pessoa idosa em sua comunidade.	

DIMENSÃO: APOIO, SAÚDE E CUIDADO

Avaliação: péssimo = 1; ruim = 2; regular = 3; bom = 4; ótimo = 5; não se aplica = N/A

QUESTÃO CENTRAL	QUESTÃO ESPECÍFICA	NOTA
1. Serviço de Saúde na Localidade que Mora	1.1 Conhecimento sobre a existência de Unidade Básica perto de sua residência.	
	1.2 Qualidade da estrutura física das Unidades que precisou utilizar ou que frequenta (iluminação, acessibilidade, conservação, limpeza).	
	1.3 Qualidade e acesso aos serviços de saúde.	
	1.4 Facilidade para agendamento de consultas e exames.	
	1.5 Atendimento domiciliar para pessoas idosas.	
	1.6 Disponibilidade de medicamentos gratuitos.	
	1.7 Divulgação e realização de campanhas de vacinação.	
	1.8 Há campanhas e materiais informativos acessíveis que abordam questões de saúde e prevenção que abrangem as necessidades específicas de pessoas idosas de diferentes gêneros e raças?	
	1.9 Você percebe diferenças no acesso a serviços de saúde, como consultas, exames e tratamentos, para pessoas idosas, considerando fatores como gênero, raça ou o tipo de núcleo familiar em que vive (sozinhas, em lares multigeracionais, instituições, entre outros)?	
	1.10 Existem dificuldades específicas enfrentadas por mulheres idosas, homens idosos ou pessoas idosas de minorias raciais ao procurar atendimento médico?	
2. Atendimento da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade	2.1 Acesso e serviços de assistência social e apoio em casos de vulnerabilidade.	
	2.2 Seu conhecimento sobre o acesso aos centros de atendimento da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, por violação de direitos ou contingência, como Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS.	
	2.3 Qualidade do atendimento prestado nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS.	
	2.4 Os profissionais de saúde demonstram respeito e sensibilidade às diferenças de gênero e raça durante os atendimentos realizados?	
	2.5 Você já presenciou ou vivenciou discriminação em ambientes de saúde relacionados ao gênero ou raça?	
3. Instituições de Longa Permanência	3.1 Conhecimento dos serviços das instituições de acolhimento (Casas Lares, Repúblicas, Residências Inclusivas).	
	3.2 Qual sua avaliação sobre os serviços das instituições de acolhimento? (Casas Lares, Repúblicas, Residências Inclusivas).	
4. Acesso a Benefícios e Serviços da Assistência Social	4.1 Como você considera o seu conhecimento sobre Programas Sociais?	
	4.2 Avalie seu acesso aos Programas Sociais Federais, Estaduais e Municipais disponíveis para participação, incluindo inscrição, obtenção de informações e facilidade de contato.	
	4.3 Frequência de utilização de serviços oferecidos por Instituições de Acolhimento e Centros Regionais Especializados de Assistência Social - CREAS.	

ANEXO II

CARTAS DE ANUÊNCIA



CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos para os devidos fins, que aceitaremos o pesquisador **Manoel Raymundo de Carvalho Neto**, a desenvolver o seu projeto de pesquisa intitulado **Longevidade no espaço urbano do Recife-PE: diagnóstico para uma urbe acolhedora ao envelhecimento**, cujo objetivo é analisar pesquisa diagnóstica a ser efetuada com usuários idosos do Recife-PE, quanto à sua percepção de urbanidade, no que tange aos domínios propostos pela Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), na Universidade Aberta à Terceira Idade ((UnATI/PROEXC/UFPE).

Esta autorização está condicionada ao cumprimento do (a) pesquisador (a) aos requisitos das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, comprometendo-se utilizar os dados pessoais dos participantes da pesquisa, exclusivamente para os fins científicos, mantendo o sigilo e garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades.

Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá apresentar a esta Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP.

Recife, 14 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
ANNA KARLA DE OLIVEIRA TITO BORBA
Data: 14/11/2023 11:08:45-0300
Verifique em <https://ndiclar.ti.gov.br>

Profa. Dra. Anna Karla de Oliveira Tito Borba
Coordenadora do Programa do Idoso (PROIDOSO/UFPE)



CARTA DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL

Esclarecimentos

Esta é uma solicitação para realização da pesquisa intitulada **"LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE: diagnóstico para uma urbe acolhedora a pessoa idosa"**, pelo pesquisador MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO, que utilizará da metodologia da pesquisa diagnóstica, conduzida por uma abordagem exploratória de campo e descritiva, com coleta de dados primários, mediante aplicação de instrumento quantitativo previamente validado, a ser utilizado em entrevistas face a face com os usuários idosos. Para atender o objetivo geral, que é analisar pesquisa diagnóstica com usuários idosos residentes em Recife-PE, quanto sua percepção das condições de acolhimento do município, no que tange aos domínios propostos pela Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI). Para isto, necessita portanto, da concordância e autorização institucional para a realização da etapa de coleta de dados, com os usuários que vão procurar o serviço do referido hospital, e moram na cidade do Recife-PE.

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de acordo com as Resoluções nº 466/2012 ou 510/2016 - Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que tratam da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão somente para realização deste estudo.

Em situações que o projeto submetido seja no âmbito de pesquisas com seres humanos em instituições do Sistema Único de Saúde - SUS, deve-se respeitar a Resolução 580/2018 (Art. 5º do CAPÍTULO II). Nesses casos, inserir na Carta de Anuência um dos parágrafos abaixo.

- 1- Destacamos que de acordo com a Resolução 580/2018 no Art. 5º do CAPÍTULO II (Dos aspectos éticos das pesquisas com seres humanos em instituições do SUS), os procedimentos da pesquisa **NÃO IRÃO INTERFERIR** na rotina dos serviços de assistência à saúde bem como nas atividades profissionais dos trabalhadores.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO
Data: 11/08/2025 17:50:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Manoel Raymundo de Carvalho Neto
CPF: 042.711.984-71
Pesquisador Responsável



CARTA DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL

Esclarecimentos

Esta é uma solicitação para realização da pesquisa intitulada **"LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE: diagnóstico para uma urbe acolhedora a pessoa idosa"**, pelo pesquisador **MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO**, que utilizará da metodologia da pesquisa diagnóstica, conduzida por uma abordagem exploratória de campo e descritiva, com coleta de dados primários, mediante aplicação de instrumento quantitativo previamente validado, a ser utilizado em entrevistas face a face com os usuários idosos. Para atender o objetivo geral, que é analisar pesquisa diagnóstica com usuários idosos residentes em Recife-PE, quanto sua percepção das condições de acolhimento do município, no que tange aos domínios propostos pela Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI). Para isto, necessita portanto, da concordância e autorização institucional para a realização da etapa de coleta de dados, com os usuários que vão procurar o serviço do referido hospital, e moram na cidade do Recife-PE.

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de acordo com as Resoluções nº 466/2012 ou 510/2016 - Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que tratam da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão somente para realização deste estudo.

Em situações que o projeto submetido seja no âmbito de pesquisas com seres humanos em instituições do Sistema Único de Saúde - SUS, deve-se respeitar a Resolução 580/2018 (Art. 5º do CAPÍTULO II). Nesses casos, inserir na Carta de Anuência um dos parágrafos abaixo.

- 1- Destacamos que de acordo com a Resolução 580/2018 no Art. 5º do CAPÍTULO II (Dos aspectos éticos das pesquisas com seres humanos em instituições do SUS), os procedimentos da pesquisa **NÃO IRÃO INTERFERIR** na rotina dos serviços de assistência à saúde bem como nas atividades profissionais dos trabalhadores.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO
Data: 11/08/2025 17:50:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Manoel Raymundo de Carvalho Neto
CPF: 042.711.984-71
Pesquisador Responsável



**INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS DA
TERCEIRA IDADE RECIFE-PE - IPETI**

CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos, para os devidos fins, que concordamos em colaborar com a realização da pesquisa intitulada **“LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE: diagnóstico para uma urbe acolhedora a pessoa idosa”**, a ser realizada em nossas atividades, desenvolvidas na Biblioteca Estadual de Pernambuco, no período de julho e agosto de 2025, pelo pesquisador **MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO**, CPF: 042.711.984-71.

Será utilizada uma metodologia da pesquisa diagnóstica, conduzida por uma abordagem exploratória de campo e descritiva, com coleta de dados primários, mediante aplicação de instrumento quantitativo previamente validado, a ser utilizado com os usuários idosos, para atender o objetivo geral, que é analisar pesquisa diagnóstica com usuários idosos residentes em Recife-PE, quanto sua percepção das condições de acolhimento do município, no que tange aos domínios propostos pela Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI).

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de acordo com as Resoluções nº 466/2012 ou 510/2016 - Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que tratam da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão somente para realização deste estudo e que esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por um Comitê de Ética em Pesquisa.

O descumprimento desses condicionamentos assegura o direito de retirar minha anuência a qualquer momento da pesquisa.

Recife, 22 de agosto de 2025.


Marilúcia Cordeiro de Souza
Presidente da Instituição

Secretaria
de Saúde



GOVPE - Declaração

Processo SEI nº 2300002499.000012/2025-40

CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos ciência da realização da pesquisa intitulada **"LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE: diagnóstico para uma urbe acolhedora ao envelhecimento"**, pesquisador responsável **Manoel Raymundo de Carvalho Neto**, sob a orientação da Profa. Dra. **Lúcia Leitão Santos.**, na Secretaria Estadual de Saúde/PE, e afirmamos que o desenvolvimento deste projeto está condicionado à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

O mesmo deverá cumprir os requisitos da Resolução CNS N°466/12 e suas complementares, e Resolução N°510/16, comprometendo-se, dentre outras coisas, a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para os fins de pesquisa.

Atenciosamente

SES - Gerência de Educação Permanente em Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Emanuela de Oliveira Silva Souza**, em 16/09/2025, às 11:36, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **73528144** e o código CRC **1D9C9A67**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone:

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Direitos Humanos e Juventude
Cais do Apolo, nº 925 – 6º andar - Bairro do Recife – CEP: 50.030-903
Fone: 3355.9291



CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos, para os devidos fins, que **MANOEL RAYMUNDO DE CARVALHO NETO**, da Instituição **UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**, discente do DOUTORADO do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (PPGDU), sob orientação da Profa. Dra. **LUCIA LEITÃO SANTOS**, pesquisador responsável do projeto intitulado “**LONGEVIDADE NO ESPAÇO URBANO DO RECIFE-PE: diagnóstico para uma urbe acolhedora a pessoa idosa**”, que tem por objetivo geral: analisar pesquisa diagnóstica com usuários idosos residentes em Recife-PE, quanto sua percepção das condições de acolhimento do município, no que tange aos domínios propostos pela Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI), tem autorização para aplicar sua pesquisa nos Grupos de Convivência de Pessoas Idosas das Regiões Político Administrativas (RPAs) do município do Recife-PE. Esta autorização está condicionada ao cumprimento do pesquisador aos requisitos das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, comprometendo-se utilizar os dados pessoais dos participantes da pesquisa, exclusivamente para os fins científicos, mantendo o sigilo e garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades. Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá apresentar a esta Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP.

Documento assinado digitalmente
JULIANA LUCENA DE ARAÚJO
Data: 19/03/2026 11:57:53-0100
Verifique em <https://validar.r6.gov.br>

JULIANA LUCENA DE ARAÚJO
GERENTE DA PESSOA IDOSA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE